



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULAN JULI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 1

Bab II Gambaran Umum Rumah Sakit Prima Husada Malang 2

2.1 Visi 2

2.2 Misi 2

2.3 Motto 2

2.4 7 Nilai Budi Utama 2

2.5 Struktur Organisasi 3

Bab III Laporan Kinerja Pelayanan 4

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI) 4

3.1.1 Tabel Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.2 Grafik Capaian BOR,LOS,TOI,BTO 4

3.1.3 Analisa dan Tindak Lanjut 4

3.1.4 Terkait BPJS Kesehatan 5

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada 6

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan 16

3.3.1 Rawat Jalan Poliklinik 16

3.3.2 Rawat Inap 19

3.3.3 Intensive Care Unit (ICU) 29

3.3.4 High Care Unit (HCU) 30

3.3.5 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 31

3.3.6 Instalasi Kamar Operasi (IKO) 32

3.4 Kinerja Bidang Penunjang 33

3.4.1 Instalasi Farmasi 33

3.4.2 Laboratorium 58

3.4.3 Rekam Medis - Pendaftaran 64

3.4.4 Radiologi 73

3.4.5 Gizi 80

3.4.6 CSSD - Laundry 85

3.5 Kinerja Bidang Umum 90

3.5.1 SDM 90

3.5.2 IPSRS 99

3.5.3 Security 108

3.5.4 Parkir 113

3.5.5 Humas Marketing 113

3.5.6 Penjaminan 144

3.5.7 PIPP – MOD – MPP 144

3.5.8 *Cleaning Service* 153

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum 153

3.5.10 IT - SIMRS 155

3.5.11 Driver 166

3.5.12 PRIMANTARA 166

3.6 Komite dan Tim 168

3.6.1 Komite Mutu 168

3.6.2 Komite PPI 244

3.6.3 Tim PKRS 264

3.6.4 Tim Prognas 265

3.6.5 Tim PPRA 307

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT 313

3.7 Permasalahan Rumah Sakit 316

3.8 Profil SDM 324

Bab IV Kesimpulan dan Saran 328

Bab V Penutup 329

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja rumah sakit dalam hal ini Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi Rumah Sakit Prima Husada Malang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga sebagai alat ukur keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama yang dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan dan sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan berkelanjutan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, penunjang dan tindakan medik.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Bulan Juli Tahun 2026 adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan pelayanan antar unit untuk meningkatkan kinerja rumah sakit

BAB II

GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilhan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan dengan Aman, Tepat, Cepat dan Akurat
2. Mengutamakan Kepuasan dan Keselamatan Pasien
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Berkelanjutan

2.3 MOTTO

Sahabat Menuju Sehat

2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur Dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan struktur Organisasi Rumah Sakit Prima Husada Malang sebagai berikut :



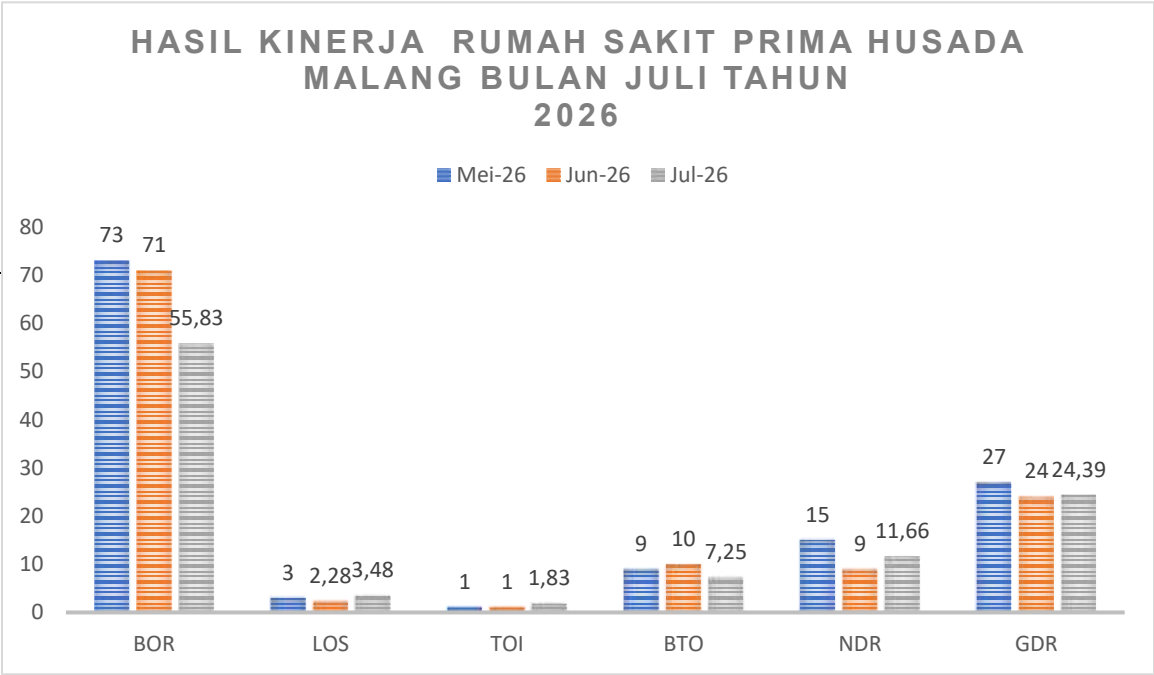
BAB III
LAPORAN KINERJA PELAYANAN

3.1 Kinerja RS Prima Husada (TT, BOR, ALOS, BTO, TOI)

Tabel Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

INDIKATOR	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026
BOR	73	71	56
LOS	3 hari	2,28 hari	3,48 hari
TOI	1 hari	1 hari	1,83 hari
BTO	9 hari	10 hari	7,25 hari

Grafik Capaian BOR, LOS, TOI, BTO

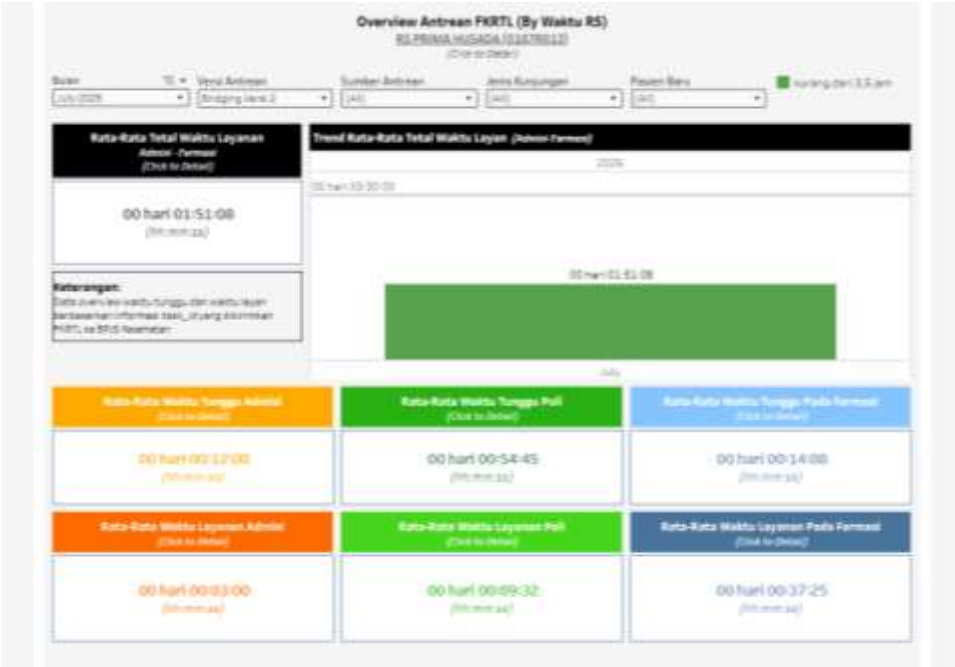


3.1.1 Tabel Analisa, Masalah dan Tindak Lanjut

Indikator	Analisis	Masalah	RTL (Rencana Tindak Lanjut)
BOR	Nilai BOR sebesar 55,83% masih berada di bawah standar ideal (60–85%). Tingkat pemanfaatan tempat tidur belum optimal.	Pemanfaatan tempat tidur belum maksimal.	Melakukan evaluasi tingkat hunian tempat tidur, meningkatkan koordinasi antarunit, dan mengoptimalkan pelayanan pasien rawat inap.
ALOS	Nilai ALOS sebesar 3,48 hari masih berada dalam rentang standar ideal.	Belum ditemukan kendala yang signifikan.	Mempertahankan mutu pelayanan dan melakukan evaluasi secara berkala.
TOI	Nilai TOI sebesar 1,83 hari menunjukkan waktu kosong tempat tidur masih sesuai dengan standar.	Distribusi pasien pada beberapa ruangan belum merata.	Melakukan evaluasi distribusi pasien dan optimalisasi penggunaan tempat tidur.
BTO	Nilai BTO sebesar 7,25 kali menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur cukup baik.	Terdapat perbedaan tingkat penggunaan tempat tidur pada setiap unit.	Meningkatkan koordinasi antarruang perawatan dan melakukan evaluasi kapasitas tempat tidur.

NDR	Nilai NDR sebesar 11,66% masih berada dalam batas yang dapat diterima.	Masih terdapat kasus kematian pasien setelah perawatan lebih dari 48 jam.	Melakukan audit medis dan evaluasi mutu pelayanan secara berkala.
GDR	Nilai GDR sebesar 24,39% memerlukan evaluasi lebih lanjut, terutama pada ruang perawatan intensif.	Angka kematian pasien masih cukup tinggi pada unit tertentu.	Melakukan analisis penyebab kematian, meningkatkan koordinasi antartenenaga kesehatan, dan memperkuat penerapan keselamatan pasien.

3.1 Terkait BPJS Kesehatan



NO	KETERANGAN		BULAN (2026)							
	Waktu Rata-Rata	Rata-Rata Tahun 2024	Rata - rata Tahun 2025	1	2	3	4	5	6	7
1	Total Waktu Layanan	2:12:37	01:46:32	1:46:40	1:41:56	1:43:59	1:32:41	1:56:26	1:45:20	1:51:08
2	Waktu Tunggu Admisi	0:11:52	0:08:14	0:12:00	00:12:00	0:12:00	0:12:00	0:12:00	0:12:00	0:12:00
3	Waktu Layanan Admisi	0:07:49	0:06:01	0:03:00	0:03:00	0:03:00	0:03:00	0:03:00	0:03:00	0:03:00
4	Waktu Tunggu Poli	1:03:51	0:58:16	00:56:31	00:53:52	00:50:51	00:55:59	00:55:53	00:53:25	00:54:45
5	Waktu Layanan Poli	0:14:56	0:09:55	0:10:13	0:10:01	0:09:30	0:10:20	0:10:33	0:09:10	0:09:32
6	Waktu Tunggu Farmasi	0:14:47	0:09:02	0:09:57	0:14:48	0:16:30	0:17:06	0:16:04	0:12:37	0:14:08
7	Waktu Layanan Farmasi	0:54:42	0:36:47	0:32:48	0:36:36	0:31:05	0:33:49	0:39:30	0:34:48	0:37:25

Analisis :
Pada bulan ini masih Lebih rendah dari rata-rata tahun 2024 dan namun tinggi dari tahun 2025.

Plan	Menyampaikan hasil evaluasi ke programmer PT Disa Prima Medika
Do	Koordinasi dengan unit terkait dan factor yang mempengaruhi.hasil dari identifikasi programmer
Study	Data rekap bulan sebelumnya yang menjadi acuan dalam perbandingan perbaikan.
Action	1. Menghubungi programmer 2. Monitoring evaluasi 3. Lakukan Tindak lanjut sesuai hasil Monev

3.2 Pengembangan Pelayanan RS Prima Husada

3.2.3 Bidang Pelayanan dan Keperawatan

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
BIDANG PELAYANAN DAN KEPERAWATAN				
1	IRJA	MCU premium	1. Mengidentifikasi pasien Perusahaan atau mandiri yang berencana MCU dengan dokter spesialis dan paket pemeriksaan lengkap 2. Menjaring Kerjasama koordinasi dengan Humas untuk MCU ditawarkan menggunakan dokter spesialis bukan dokter umum dengan harga terjangkau	1. Kunjungan pasien masih sedikit 2. Dengan standart harga yang cukup tinggi, dibutuhkan untuk marketing lebih konsisten dan mengenalkan ke masyarakat luas tidak hanya lewat sosmed atau door to door ke perusahaan.
2	IRJA-Poli MCU	Penerimaan MCU corporate	1. Humas menghubungi Perusahaan untuk penawaran MCU 2. Surat penawaran untuk Perusahaan sudah di acc PT dengan tarif margin yang paling rendah	1. MCU Perusahaan BSI masih belum bisa terlaksana karena ada kendala IKS dengan Mandiri Inhealth. 2. BSI menggunakan Mandiri inhealth untuk general check up 38 karyawannya 3. Karena di malang hanya ada 3 RS yang di tetapkan untuk MIH, sehingga PHM belum bisa menerima MCU

				tsb tahun ini, bisa pengajuan untuk tahun depan 4. Koordinasi dan follow up kembali terkait pengajuan RSPHM sebagai RS penerima layanan MCU Perusahaan
4	IRJA-IRNA	Meningkatkan kewaspadaan pelaporan kasus PD31	1. Karena wabah KLB campak di berbagai daerah, dinkes menghimbau RS untuk waspada terhadap peningkatan kasus campak 2. Pelaporan dan pengambilan sampel harus real time dan dilaporkan ke puskesmas agar dipantau dan di petakan daerah yang positif terpapar 3. Meningkatkan komunikasi dengan puskesmas baik di grup maupun tata laksana pelaporan kasus	1. Kasus pelaporan yang sulit ada di rawat jalan, karena pasien sudah KRS dan kesulitan dalam pengambilan sampel 2. Koordinasi dengan PKM agar diteruskan ke Perawat desa untuk ditindaklanjuti
5	IRJA	Absensi fingerprint DPJP	1. Mitigasi resiko untuk kepatuhan DPJP terhadap HFIS, setiap praktek poli atau yang terdaftar di HFIS wajib melakukan absensi datang dan pulang 2. Membuat surat edaran terkait pelaksanaan dan pendaftaran fingerprint 3. Pendaftaran fingerprint dilakukan oleh SDM, yanmed, karu irja dan dibantu IT	1. Pelaksanaan fingerprint dimulai tanggal 4 Juni 2026 2. Kendala ada beberapa DPJP yang kesulitan absen karena dengan sidik jari tidak terdetect 3. Untuk tindaklanjut dilakukan pendaftaran finger

3.2.2 Bidang Penunjang

NO	UNIT	PENGEMBANGAN PELAYANAN	PROGRESS PENGEMBANGAN	KENDALA
INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT				
1.	Depo Farmasi	1. KPO Elektronik (E-KPO)	a. Fitur cetak KPO sudah terlaksana pada tanggal 17 Desember 2025. b. Belum tersedia cover untuk arsip KPO pasien. c. Jumlah KPO tertinggal : 151.	Cover KPO tidak acc oleh managemen. Rencana menggunakan scan barcode untuk melihat data e-kpo.
		2. Perluasan ruang Depo Farmasi sesuai standart	a. Pengajuan perluasan ruangan di depo farmasi untuk penggantian lemari pendingin yaitu penyimpanan obat ke lemari pendingin yang lebih besar dan vaksin di letakkan dalam vaccine refirigerator disertai Log tag. b. Tersedia cctv dan smart door lock.	Koordinasi dengan kepala bidang terkait rencana lokasi penyimpanan showcase 2 pintu (785 liter) dan vaccine refirigerator.
		3. Pendaftaran pengantaran obat primantara di Farmasi	Fitur “antar obat” di SIMRS sudah tersedia dan ada laporan penjualan obat diantar. Namun kekurangannya tidak ada kolom asal poli, jam pemesanan, obat selesai, biaya, cara bayar, jarak pengiriman dan serah terima farmasi dan kurir primantara sehingga pendataan pasien menggunakan google spreadsheet primantara.	Pendataan secara manual, belum bridging dengan SIMRS. Sementara menggunakan spreadsheet.
		4. Rencana pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis	a. Sudah dilakukan pemisahan penyiapan obat kronis dan non kronis namun masih terkendala tenaga vokasi farmasi kurang (jika ada staf yang sakit). b. Meminimalisir waktu tunggu pasien non kronis dengan obat yang tidak banyak. c. Belum ada fitur pemisahan resep	Pengajuan fitur ke progamer.

			masuk kronis dan non kronis.	
		5. Pengambilan obat dengan TTD elektronik	a. TTD elektronik pengambilan obat rawat jalan sudah berjalan dan memudahkan untuk mengecek retriaksi kelengkapan obat kronis. b. TTD elektronik pengambilan obat IGD rawat jalan dan pasien rawat inap pulang masih belum bisa dan tahap koordinasi dengan progamer.	Dalam antrian progamer. Monitoring dan evaluasi sistem elektronik.
		6. Pelayanan retriaksi obat kronis: penambahan fitur Centang “Perlu Hasil Pemeriksaan Lab di Fitur Penjualan Farmasi.	Pengajuan form penambahan fitur agar DPJP input resep dan penjaminan pelayanan obat bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan retriaksi dan/atau peresepan maksimal obat, memudahkan Farmasi mengecek kesesuaian hasil penunjang dan obat yang diresepkan sesuai retriaksi obat kronis.	Pengajuan fitur ke progamer.
		7. Penambahan Fitur Laporan Rekap Penjualan Obat Kronis Per Nota, Laporan Resep Iter, Dan Laporan Resep PRB Di SIMRS	Pengajuan form penambahan fitur laporan di SIMRS yaitu: a. Format “Laporan Rekap Penjualan Obat Kronis Per Nota”, berisi: nomor, nomor registrasi, tanggal registrasi, no. rm, nama pasien, nama dokter unit asal, no. kartu, no. sep, no. nota, tgl. Nota, nama obat, jumlah obat, hasil pemeriksaan penunjang. b. Format laporan resep iter, berisi: nomor, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, unit asal, nama dokter, jumlah iter, nama obat, aturan pakai, jumlah	Pengajuan fitur ke progamer.

			obat, tanggal kunjungan berikutnya, status iter (terlayani/belum). Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep iter dan target iter. c. Format laporan resep PRB, berisi: nomor, nama dokter, tanggal kunjungan, nama pasien, no. rm, no. kartu, no. SEP, alamat, no. telp, diagnosa PRB, asal FKTP perujuk, asal SRB (FKRTL/RS), nama obat, aturan pakai, jumlah obat. Tujuan untuk memudahkan farmasi, verifikator, DPJP untuk melihat laporan resep PRB dan target PRB.	
		8. Rekam medis beralih ke E-RM	Fitur E-RM yang sudah tersedia di SIMRS : - Rekonsiliasi obat - Daftar pemberian obat - Catatan Riwayat Penggunaan Obat - Daftar Tilik Serah Terima Obat Farmasi - Rawat Inap Fitur E-RM yang belum tersedia di SIMRS : - Pemantauan Terapi Obat	Fitur E-RM yang belum tersedia di SIMRS : Pemantauan Terapi Obat. Dalam antrian progamer.
		9. ERM :Pemberian edukasi penggunaan obat pulang (Pasien rawat inap)	Penambahan fitur Pemberian Edukasi Penggunaan Obat Pulang. Data “Resep Final” langsung muncul sesuai obat yang ada di “Ringkasan Pulang” bagian “Obat Pulang” sehingga farmasi bisa langsung ttd serah terima obat di depo farmasi.	Pengajuan fitur ke progamer.
		10. Pemberian informasi tentang obat yang akan diberikan kepada pasien rawat jalan	Pemberian informasi tentang obat yang akan diberikan kepada pasien rawat jalan sudah tersedia di resep namun belum ada	Pengajuan fitur ke progamer.

			keterangan di kolom penerima obat "Pasien telah menerima KIE serta instruksi obat oleh petugas farmasi". Mengajukan fitur di SIMRS agar langsung tercetak di kolom penerima obat	
		11. Penambahan fitur potensi PRB	Belum tersedia fitur identifikasi obat-obatan rutin dinotifikasi dalam SIMRS farmasi untuk dijadikan data potensi PRB dan disampaikan ke DPJP.	Pengajuan fitur ke progamer.
		12. Penambahan fitur validasi resep di poli untuk obat yang ditinggal dan ditunggu	a. Belum tersedia fitur validasi resep di poli untuk obat yang ditinggal dan ditunggu b. Meminimalisir waktu tunggu pasien yang menunggu di farmasi dan mengurangi complain pasien.	Pengajuan fitur ke progamer.
		13. Penambahan fitur obat near ed muncul di SIMRS saat dokter input resep	Belum tersedia fitur obat near ed muncul di SIMRS saat dokter input resep, agar DPJP mengetahui obat yang akan habis kurang dari 6 bulan	Pengajuan fitur ke progamer.
		14. Penambahan fitur kelas terapi/ golongan obat saat input resep	Belum tersedia fitur kelas terapi/ golongan obat saat input resep untuk memudahkan DPJP jika terjadi kekosongan obat bisa langsung substitusi obat yang lain sesuai kelas terapi tanpa perlu konfirmasi ke farmasi.	Pengajuan fitur ke progamer.
		15. Penambahan fitur warning di SIMRS saat DPJP input resep yang sama	a. Tersedia fitur warning di SIMRS saat DPJP input resep yang sama. b. Memudahkan DPJP saat input resep agar tidak terjadi input resep yang sama dan mempercepat farmasi proses resep.	Pengajuan fitur ke progamer.
2.	Gudang Farmasi	1. Pengembangan fitur scan barcode gudang farmasi dan depo farmasi untuk pemasukan dan pengeluaran stok.	a. Proposal scan barcode sudah diajukan ke PT pada tanggal 01/10/2024. b. Sudah dilakukan presentasi pada tanggal 04/10/2024.	Monitoring dan evaluasi system elektronik

			c. Alat scanner barcode, barcode printer, thermal paper sudah tersedia pada tanggal 16/11/2024. d. Scan barcode di SIMRS sudah di trial. Hasil evaluasi : - Penerimaan barang memerlukan waktu lama karna scanning hanya untuk pencarian nama barang namun jumlah, no. batch dan expired data di ketik manual. - Penyiapan barang memerlukan waktu lama dan meningkatkan kebutuhan tenaga. - Penggunaan sistem barcode menambah tahapan kerja karena petugas harus melakukan scanning satu per satu pada item yang disiapkan sehingga proses penyiapan menjadi lebih panjang dan memperlambat alur kerja. - Proses terhambat karena harus menambah master barcode terlebih dahulu. - Membutuhkan waktu lebih lama dalam pencarian item. Petugas harus melakukan pencarian manual dengan scroll daftar item sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan	
--	--	--	--	--

			dan menambahkan master barang. - Monitoring barang yang belum disiapkan menjadi sulit/kurang efektif karena petugas harus mengklik nama barang terlebih dahulu untuk melihat jumlah keluar, sehingga menyulitkan monitoring barang yang: • sudah disiapkan, • belum disiapkan, • maupun yang masih kurang. - Proses scanning terhambat, membutuhkan input manual, dan memperlambat penyiapan barang. - Efisiensi operasional belum tercapai. Proses masih membutuhkan tambahan tenaga dan waktu dibandingkan metode sebelumnya. - Menyebabkan ketidaksesuaian data, kebingungan dalam monitoring stok, dan potensi kesalahan pencatatan distribusi barang.	
		2. Perluasan Gudang Farmasi	a. Pengajuan katrol untuk penurunan buffer dari lantai 2.	Follow up pengadaan katrol.
Instalasi Rekam Medis				
1.	Rekam Medis	1. Aplikasi ERM IRJA	1. Poli Gizi dan Poli KIA belum menjalankan ERM 2. Kendala teknis sistem 3. Keterbatasan SDM	Sebagian besar poli telah menggunakan ERM, namun Poli Gizi dan Poli KIA belum menjalankan

			dan adaptasi pengguna	ERM
		2. Pengiriman data kunjungan dan diagnosis pasien rawat jalan (ERM maupun non-ERM) ke SATU SEHAT	Pengiriman data ke satu sehat (untuk data kunjungan dan diagnosis) dilakukan setiap hari. Temuan dan TL : a. ERM yang belum lengkap dan valid. TL : Koordinasi dengan Tim Pendaftaran terkait identitas pasien yang tidak lengkap. b. Bayi baru lahir yang belum mempunyai NIK. TL : Kie ke keluarga pasien agar segera pengurusan KK. c. Pasien yang tidak membawa identitas dengan lengkap. TL : KIE ke keluarga pasien untuk mengirimkan identitas melalui chat WA.	Monitoring dan Evaluasi.
		3. APM (Pendaftaran pasien BPJS yang sudah reservasi melalui mobile JKN)	Pasien BPJS yang sudah reservasi Mobile JKN tidak dapat diproses di APM masih harus diarahkan ke loket. TL: Memaksimalkan petugas menjaga APM dan memberikan arahan pada pasien.	Sebagian pasien BPJS sudah menggunakan APM, namun masih terdapat kegagalan proses pendafataran. Sosialisasi ulang kepada pasien terkait alur APM dan Mobile JKN.
		4. Retensi dan Pemusnahan Berkas DRM	1. Masih terdapat penumpukan DRM inaktif 2. Keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan 3. Proses digitalisasi (scan) belum seluruhnya selesai	1. Melanjutkan pemilahan DRM sesuai jadwal retensi 2. Prioritas penyelesaian DRM kematian dan DRM inaktif lama 3. Penjadwalan kegiatan scanning sebelum pemusnahan
Unit Laboratorium				
1	Laboratorium	1. Pengembangan Pelayanan LIS	Pemasangan server dan proses dari vendor sudah slesai, menunggu proses blicing dari SIMRS Rumah sakit.	Proses Blicing SIMRS
Unit Gizi				

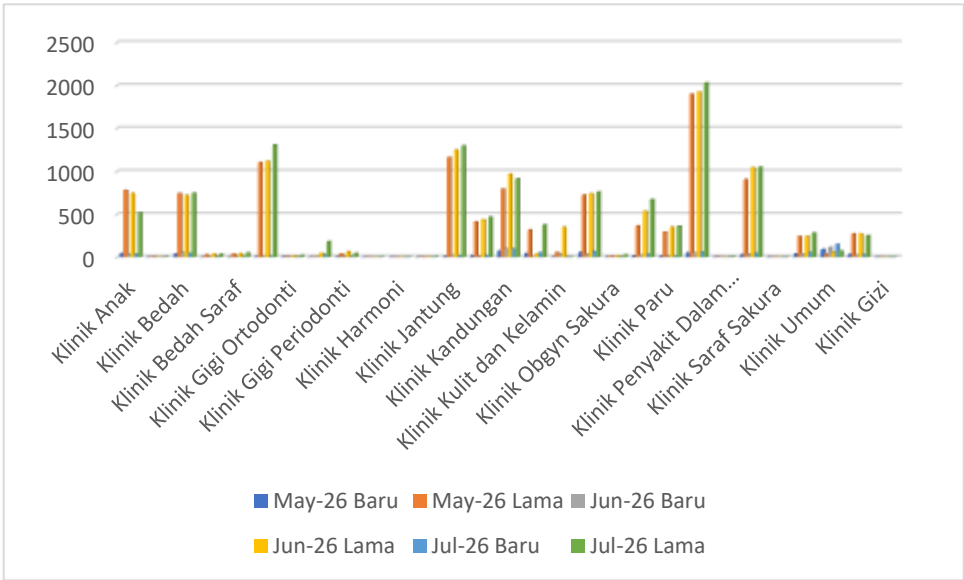
1	Gizi	Pemesanan diet dari klinik Mitra (luar).	-Sudah ada kerjasama terkait pemesanan diet dari klinik luar. -Sudah dibuatkan SPO dan alur pemesanan diet melalui spreadsheet dan whatsapp. -Sudah dilakukan pengajuan tarif pelayanan pemesanan diet pada PT. -Sudah berjalan mulai awal Juni 2026.	- Tarif pelayanan pemesanan diet dari PT sudah disetujui dan dijalankan.
CSSD-LAUNDRY				
1	CSSD-Laundry	Monitoring pelayanan berbasis elektronik	-Sudah dilakukan dokumentasi indikator steril digital dengan spreadsheet. -Sudah dilakukan pencatatan serah terima paper less dengan spreadsheet.	-Monitoring kepatuhan pengisian
2	CSSD	Optimalisasi Tata Ruang dan Alur Kerja (Workflow)	-Penerapan Alur Satu Arah (One-Way Flow) -Sistem Transportasi Tertutup -Sekat Fisik yang Tegas -Sistem Tekanan Udara Sederhana	-Memastikan batas fisik yang tegas antara area kotor (Decontamination), area bersih (Packing/Assembly), dan area steril (Storage) -Menggunakan kontainer atau troli tertutup khusus untuk distribusi instrumen kotor dan instrumen steril demi menjaga sterilitas selama perjalanan -Sudah terpasang exhaust fan di area bersih.
RADIOLOGI				
1	Radiologi	Pengadaan upgrade system IT (SIMRS/PACS)	-Sudah dilakukan pengajuan bulan Maret 2026 -Sudah dilakukan penerapan PACS di pelayanan rontgen.	- Masih proses penambahan jaringan ke USG dan CT-Scan.

3.3 Kinerja Bidang Pelayanan
3.3.3 Rawat Jalan Poliklinik

3.3.3.1 Kunjungan Pasien Lama dan Baru (Mei-Juli 2026)

Nama Unit	Mei-26			Jun-26			Jul-26		
	Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total	Baru	Lama	Total
Klinik Anak	43	779	822	37	742	779	34	517	551
Klinik Anak Sakura	1	5	6	0	1	1	1	2	3
Klinik Bedah	37	742	779	52	719	771	43	744	787
Klinik Bedah Plastik	0	25	25	2	34	36	2	33	35
Klinik Bedah Saraf	0	34	34	2	40	42	2	49	51
Klinik Fisioterapi	2	1104	1106	2	1117	1.119	4	1307	1311
Klinik Gigi Ortodonti	5	7	12	2	13	15	0	19	19
Klinik Gigi Pedodontis	0	0	0	6	44	50	25	182	207
Klinik Gigi Periodonti	6	36	42	8	63	71	3	43	46
Klinik Gigi Umum	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Klinik Harmoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klinik Ibu dan Anak	0	3	3	0	3	3	0	3	3
Klinik Jantung	9	1159	1168	21	1246	1.267	16	1295	1311
Klinik Jiwa	17	411	428	14	437	451	16	464	480
Klinik Kandungan	72	791	863	94	967	1.061	94	913	1007
Klinik Konservasi Gigi	44	318	362	1	39	40	50	375	425
Klinik Kulit dan Kelamin	2	52	54	38	350	388	0	0	0
Klinik Mata	54	723	777	35	739	774	62	760	822
Klinik Obgyn Sakura	3	12	15	3	13	16	4	25	29
Klinik Orthopedi	13	364	377	24	533	557	31	670	701
Klinik Paru	10	292	302	8	348	356	9	361	370
Klinik Penyakit Dalam	48	1897	1945	50	1924	1.974	58	2030	2088
Klinik Penyakit Dalam Sakura	1	2	3	1	0	1	2	5	7
Klinik Saraf	29	902	931	36	1042	1.078	42	1049	1091
Klinik Saraf Sakura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klinik THT	36	240	276	38	242	280	51	279	330
Klinik Umum	88	35	123	114	59	173	148	73	221
Klinik Urologi	32	271	303	23	272	295	30	250	280
Klinik Gizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grafik Pasien Lama dan Baru Bulan (Mei - Juli 2026)



Analisis :

1	Jumlah kunjungan rawat jalan pada bulan Juli 2026 menunjukkan peningkatan pada sebagian besar poliklinik, terutama Klinik Penyakit Dalam (2.090 kunjungan), Klinik Jantung (1.311 kunjungan), Klinik Fisioterapi (1.311 kunjungan), dan Klinik Saraf (1.091 kunjungan).
2	Kunjungan di Klinik Orthopedi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 557 kunjungan pada Juni menjadi 700 kunjungan pada Juli.
3	Kunjungan di Klinik Anak mengalami penurunan dari 779 kunjungan pada Juni menjadi 551 kunjungan pada Juli.
4	Klinik Gigi Pedodontis mengalami peningkatan yang sangat tinggi, dari 50 kunjungan pada Juni menjadi 207 kunjungan pada Juli.
5	Kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) mengalami penurunan dari 878 kunjungan pada Juni menjadi 835 kunjungan pada Juli.
6	Klinik Konservasi Gigi tidak memiliki kunjungan pada bulan Juli 2026, sedangkan pada bulan Juni terdapat 40 kunjungan.
7	Secara keseluruhan, jumlah kunjungan rawat jalan masih didominasi oleh layanan penyakit dalam, jantung, saraf, dan fisioterapi.

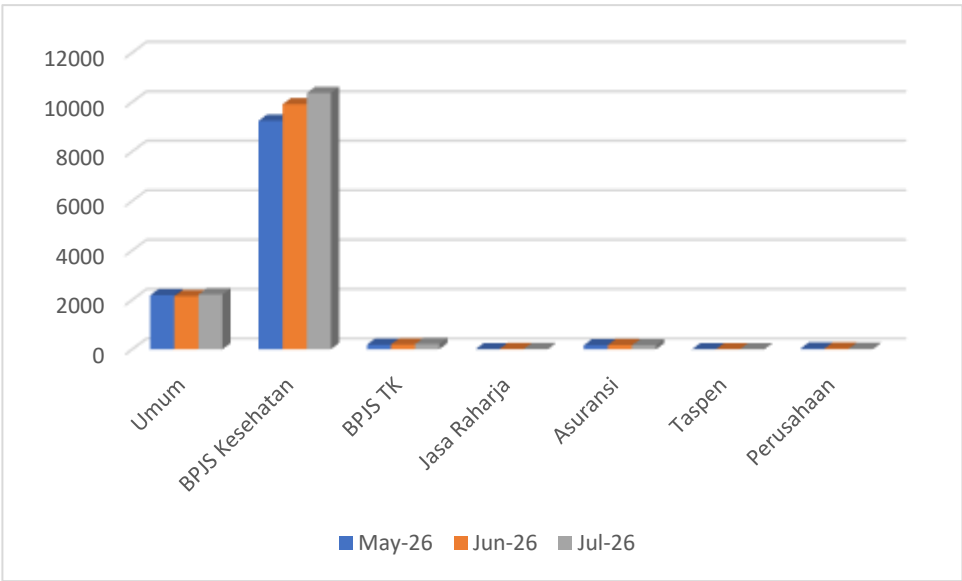
Rencana Tindak Lanjut :

1. Koordinasi dengan pendaftaran penjangkaran pasien umum dan asuransi untuk memperkenalkan pelayanan poli Sakura
2. Menginformasikan kepada seluruh unit rawat inap wajib edukasi saat krs untuk pasien umum, asuransi tentang pelayanan poli Sakura
3. Memisahkan pasien BPJS dengan pasien non BPJS. Pasien Non BPJS di daftarkan di poli Sakura.
4. Koordinasi dengan Humas dan Marketing untuk penjangkaran asuransi dan perusahaan.
5. Sosialisasi pada faskes dengan pelayanan baru yang ada di rumah sakit prima husada
6. Koordinasi dengan humas marketing untuk rutin menampilkan promo di media sosial
7. Koordinasi dengan pendaftaran untuk sellau menanyakan pasien yang mendaftar apakah memiliki asuransi komersil.

1.3.1.2 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status Pembayaran Mei
- Juli 2026

No	Jenis Pembayaran	Mei-26	%	Jun-26	%	Jul-26	%
1	Umum	2189	18,52%	2146	17,20%	2219	17,07%
2	BPJS Kesehatan	9243	78,19%	9911	79,44%	10364	79,73%
3	BPJS TK	188	1,59%	195	1,56%	213	1,64%
4	Jasa Raharja	2	0,02%	10	0,08%	9	0,07%
5	Asuransi	167	1,41%	173	1,39%	161	1,24%
6	Taspen	0	0,00%	8	0,06%	8	0,06%
7	Perusahaan	32	0,27%	33	0,26%	25	0,19%
TOTAL		11821	100%	12476	100,00%	12999	100,00%

1.3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Status
Pembayaran Mei-Juli 2026



Analisis :

1	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan pada bulan Juli 2026 mencapai 12.999 kunjungan. Sebagian besar pasien berasal dari kelompok peserta BPJS Kesehatan, yaitu sebanyak 10.364 kunjungan (79,73%).
2	Jumlah pasien lama (11.804 kunjungan) jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah pasien baru (995 kunjungan). Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kesinambungan pelayanan yang baik.
3	Klinik Penyakit Dalam menjadi poliklinik dengan jumlah kunjungan tertinggi, yaitu sebanyak 2.088 kunjungan, diikuti oleh Klinik Jantung dan Klinik Fisioterapi yang masing-masing mencapai 1.311 kunjungan.
4	Pasien umum paling banyak ditemukan pada Instalasi Gawat Darurat (835 kunjungan), Klinik Kandungan (1.007 kunjungan), dan Klinik Umum (221 kunjungan).
5	Beberapa poliklinik, seperti Klinik Harmoni, Klinik Konservasi Gigi, Klinik Saraf Sakura, dan Klinik Gizi, tidak memiliki kunjungan pasien selama periode pelaporan.
6	Instalasi Gawat Darurat menerima pasien dari berbagai jenis pembiayaan, seperti pasien umum, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, asuransi swasta, dan perusahaan.

Rencana Tindak Lanjut :

Untuk meningkatkan kunjungan pasien rawat jalan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik serta berkoordinasi dengan marketing untuk melakukan kunjungan dan menawarkan beberapa pelayanan baru seperti poli sakura yang bisa bekerjasama dengan berbagai asuransi, poli bedah saraf dan poli gigi anak. bekerjasama dengan humas marketing terutama MCU haji dan vaksin internasional (meningitis, polio dan influenza)

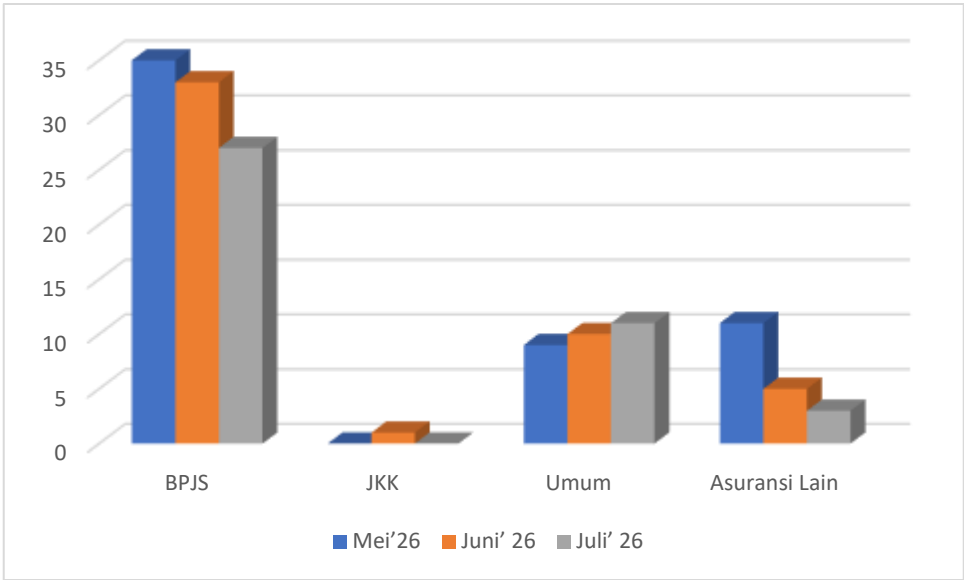
3.1.3 Rawat Inap

3.1.3.1 Kunjungan Rawat Inap 2C

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Mei-Juli 2026)

NO	Hal	Mei'26	Juni' 26	Juli' 26	Persentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	35	33	27	18,18%
2	JKK	0	1	0	100%
3	Umum	9	10	11	100%
4	Asuransi Lain	11	5	3	40%
Total Pasien		55	48	41	14,58%

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2026)



1.3.2.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	Bulan	RAWAT INAP				Total Pasien
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Mei 2026	35	9	0	11	55
	Analisa	Bulan Mei pasien BPJS mengalami penurunan dari 39 menjadi 35	Bulan Mei pasien umum mengalami penurunan dari 10 menjadi 9	Pasien JKK bulan Mei tidak ada	Untuk pasien asuransi di bulan Mei naik sedikit dari 10 ke 11	Total bulan Mei jumlah pasien mengalami penurunan lagi dari 60 menjadi 55
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
2	Juni 2026	33	10	1	5	48

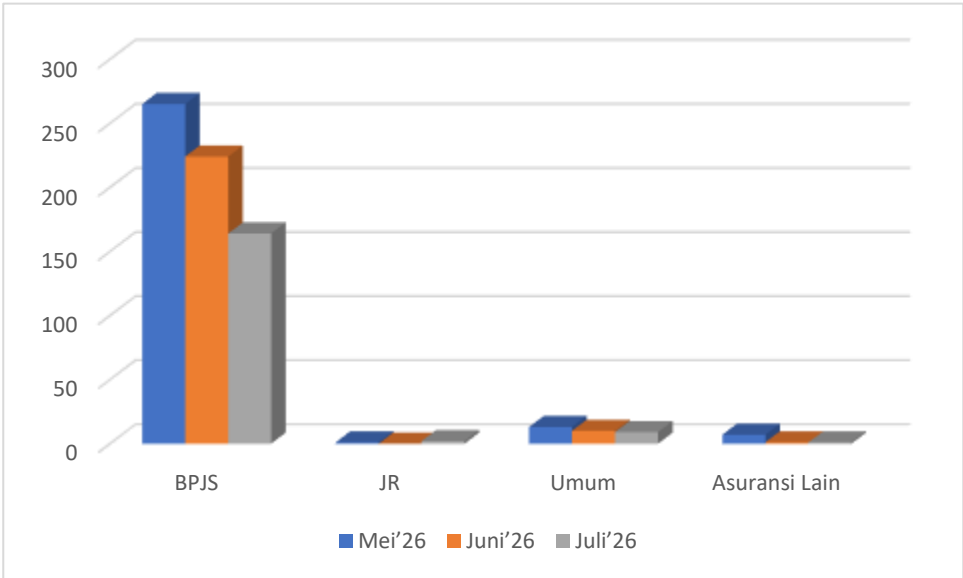
	Analisa	Bulan Juni pasien BPJS mengalami penurunan dari 35 menjadi 33	Bulan Juni pasien umum mengalami penurunan. Dari 9 menjadi 10	Pasien JKK bulan Juni ada 1 dikarenakan px JKK naik kelas ke VIP	Untuk pasien asuransi di bulan Juni turun dari 11 menjadi 5	Total bulan Juni jumlah pasien mengalami penurunan lagi dari 55 menjadi 48
	RTL	Meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				
3	JULI 2026	27	11	0	3	41
	Analisa	Bulan Juli pasien BPJS mengalami penurunan dari 35 menjadi 27	Bulan Juli pasien umum mengalami kenaikan dari 9 menjadi 11	Pasien JKK bulan Juli 0	Untuk pasien asuransi di bulan Juli turun drastis dari 5 jadi 3	Total bulan Juli jumlah pasien mengalami penurunan lagi dari 48 menjadi 41
	RTL	Mempertahankan dan meningkatkan capaian dengan memperbaiki alur proses naik kelas ke VIP/VVIP yg dilakukan di awal pendaftaran, memperbaiki sarana prasarana VIP/VVIP dengan memberikan fasilitas tambahan seperti baju pasien khusus VIP/VVIP dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kelanjutan perawatan pasca rawat inap				

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 3C Anak

3.1.1.1.3 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar Bayar (Mei-Juli 2026)

NO	Hal	Mei'26	Juni'26	Juli'26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	265	224	164	↓36,5%
2	JR	1	0	2	↑100%
3	Umum	13	10	9	↓11%
4	Asuransi Lain	7	1	1	0%
Total Pasien		286	235	176	↓0,3%

Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2026)



3.3.2.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR	Asuransi	
1.	Analisis capaian 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami peningkatan di bulan februari dan mengalami penurunan sebesar 7% di bulan maret, serta meningkat lagi sebebsar 15% di bulan April Mengalami peningkatan 10% di bulan Mei, Pada bulan Juni kepesertaan BPJS mengalami penurunan 18%, Pada bulan Juli jumlah pasien BPJS mengalami penurunan, sebesar 36,5% dikarenakan semakin ketatnya kriteria Rawat inap	Pasien umum mengalami peningkatan sebesar 66%pada Maret dan mengalami penurunan sejumlah 71% di bulan April, dikarenakan semua orang mempunyai BPJS, dan mengalami peningkatan sebesar 46% di bulan mei, di bulan juni pasien umum mengalami penurunan sebesar 30%, pada bulan Juli jumlah pasien umum mengalami penurunan sebesar 11%	Pasien JR mengalami penurunan 200% pada bulan maret dan mengalami penurunan lagi di bulan April sebanyak 100%, serta di bulan mei menglamai peningkatan sebesar 100%, pada bulan juni pasien JR mengalami penurunan 100%, pada bulan Juli pasien JR mengalami kenaikan sebesar 100%	Pasien Asuransi sama dengan bulan sebelumnya dan mengalami penurunan 100% di bulan April karena hanya beberapa orang saja yang mempunyai jaminan asuransi, di bulan mei pasien asuransi mengalami peningkatan sebesar 85%, pada bulan juni pasien Asuransi ,mengalami penurunan 60%, karena rata-rata pasien Asuransi semuanya naik kelas VIP, pasien asuransi pada bulan juli sama dengan bulan sebelumnya	umlah pasien di aBPJS di bulan Februari mengalami peningkatan sebanyak 6% dan mengalami penurunan di bulan maret sebesar 7% dan penurunan 200% pada pasien umum pada bulan februari dan mengalami peningkatan 66% di bulan maret dan kenaikan 66% pasien JR pada bulan februari serta mengalami penurunan sebesar 200% di bulan maret Dan pada bulan April pasien BPJS mengalami peningkatan sebebsar 15% serta jumlah keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 13% Pada bulan Mei jumlah keseluruhan pasien mengalami peningkatan sebebsar 14% yaitu sejumlah 286 Pada bulan Juni jumlah pasien di ruang anak mengalami penurunan sebesar 21%, pada bualan Juli jumlah keseluruhan pasien
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya Mempromosikan RS prima Husada Melalui media Sosial				

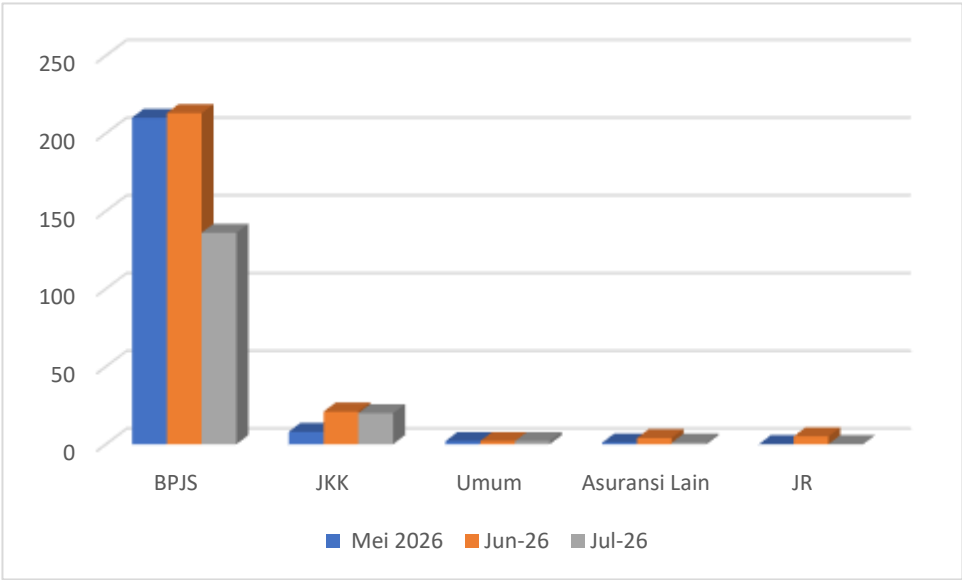
			mengalami penuruna sebsar 0,3%
--	--	--	--------------------------------------

3.1.1.1 Kunjungan Rawat Inap 2,3,4 A

3.1.1.1.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2026)

NO	Hal	Mei 2026	Jun 2026	Jul 2026	Persentase 2026
1	BPJS	210	213	136	↓ 36,15 %
2	JKK	8	21	20	↓ 4,76 %
3	Umum	2	2	2	0 %
4	Asuransi Lain	1	4	1	↓75 %
5	JR	0	5	0	↓100 %
Total Pasien		221	245	159	↓ 35,10 %

3.1.1.1.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2026)



3.1.1.1.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian Juni 2026	Pasien BPJS mengalami peningkatan pada bulan Juni 2026 sebanyak 213 (1,42%) pasien dibandingkan	Pasien Umum pada bulan Juni 2026 sama/ tetap dengan bulan Mei yaitu 2 pasien	Jumlah Pasien JKK pada bulan Juni 2026 meningkat sebanyak 21 pasien (162,5%) dibandingkan bulan Mei	Jumlah pasien JR bulan Juni 2026 naik 100% (5 pasien) mengg unakan penjamin JR dibandingkan bulan Mei,	Jumlah pasien di bulan Juli 159 dengan prosentase (↓ 35,10 %) mengalami penurunan dibandingkan

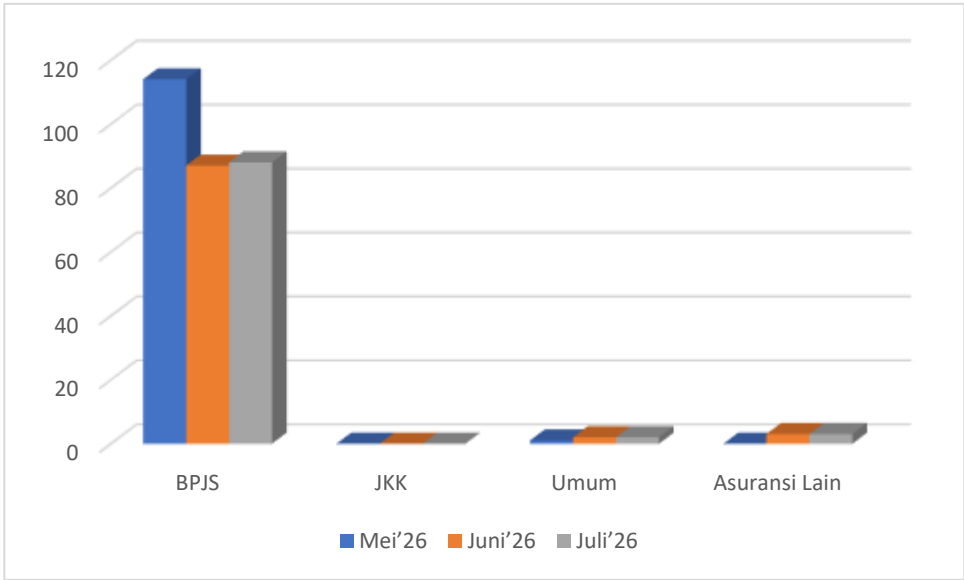
		bulan Mei			Untuk pasien Asuransi naik 4 pasien (100%) dibulan Juni 2026 ini	bulan Juni kemarin sebanyak 245 pasien
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Untuk Irna 3A sementara tutup dan dialihkan ke Irna 2A dikarenakan TT dilantai 2A 15 TT serta terdapat ruang transit 6. Lantai 3A dibuka jika memang disemua lantai penuh.				

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap 5C

3.1.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2026)

NO	Hal	Mei'26	Juni'26	Juli'26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	114	87	88	↑1,13%
2	JKK	0	0	0	0%
3	Umum	1	2	2	0%
4	Asuransi Lain	0	3	3	0%
Total Pasien		115	92	93	↑1,07%

3.1.1.2.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei – Juli 2026)



3.1.1.2.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

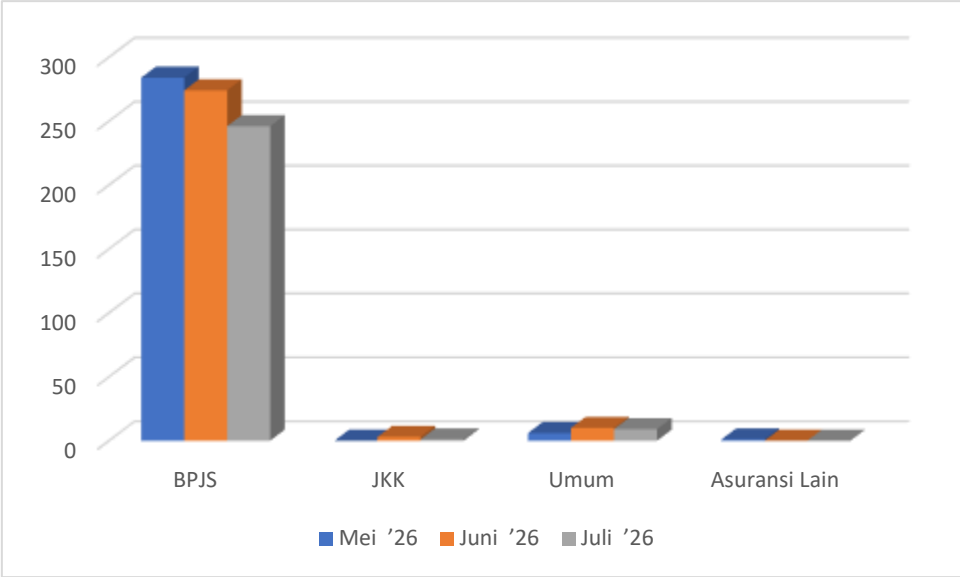
No	Bulan	RAWAT INAP				Kesimpulan
		BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
1	Analisis capaian Mei 2026	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↑0,87% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami penurunan sebanyak ↓80% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK sama mengalami penurunan sebanyak ↓100% dengan kunjungan bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR mengalami penurunan sebanyak ↓100% dari bulan sebelumnya	Pada bulan Mei 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebesar ↓3,36%
	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
2	Analisis capaian Mei 2026	Analisis capaian Juni 2026	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↑23,40% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum mengalami peningkatan sebanyak ↑87,5% dari bulan sebelumnya	Pasien JKK sama mengalami peningkatan sebanyak ↑100% dengan kunjungan bulan sebelumnya.	Pada bulan Juni 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑43%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				
3	Analisis capaian Juni 2026	Total Pasien BPJS mengalami peningkatan sebanyak ↑1,13% dari bulan sebelumnya	Total Pasien Umum tidak ada peningkatan ataupun penuruanan, kunjungannya sama dengan bulan sebelumnya	Pasien JKK selama bulan juli tidak ada kunjungan sama dengan bulan sebelumnya.	Pasien Asuransi / JR Umum tidak ada peningkatan ataupun penuruanan, kunjungannya sama dengan bulan sebelumnya	Pada bulan Juli 2026 untuk total kunjungan pasien mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebesar ↑1,07%
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya				

3.1.1.3 Kunjungan Rawat Inap 6, 7, 8 A

3.1.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2026)

NO	Hal	Mei '26	Juni '26	Juli '26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	284	274	246	↓ 10,21%
2	JKK	0	3	1	↓ 100%
3	Umum	6	10	9	↓ 10%
4	Asuransi Lain	1	0	0	0 %
Total Pasien		291	287	256	↓10,8%

3.1.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2026)



3.1.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

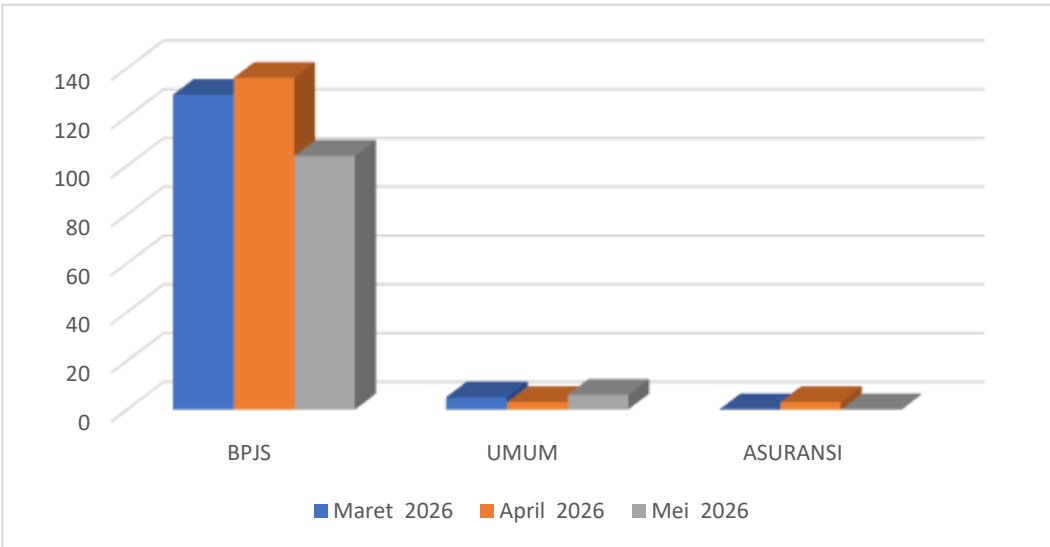
Bulan	Rawat Inap				Kesimpulan
	BPJS	Umum	JKK	JR/Asuransi	
Analisis pencapaian jumlah pasien 3 bulan terakhir	Analisis pencapaian jumlah pasien 3 bulan terakhir	Pasien BPJS mengalami terjadi penurunan pada bulan juli 2026 yaitu sebanyak 28 pasien disebabkan banyaknya kunjungan pasien di IGD dengan penjamin kelas 3 sedang menurun	Pasien Umum mengalami penurunan pada bulan juli 2026 yaitu sebanyak p asien, yang datang ke IGD rata rata menggunakan penjamin BPJS untuk kelas 3	Pasien JKK mengalami penurunan pada bulan juli 2026 yaitu sebanyak 2 pasien	Berdasarkan grafik, produktivitas pelayanan mengalami penurunan pada bulan Juli . Jumlah pasien didominasi oleh pasien BPJS , yang menjadi kontributor utama terhadap total produktivitas. Jumlah pasien BPJS turun dari 282 pasien pada Mei menjadi 245 pasien pada Juli . Pada bulan Juni, terdapat peningkatan pasien JKK menjadi 3 pasien dan pasien umum meningkat menjadi 10 pasien, sehingga total pasien tetap berada pada angka 287. Namun pada Juli, jumlah pasien BPJS dan pasien umum mengalami penurunan sehingga total pasien turun menjadi 256 pasien
RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap 3. Evaluasi antrian operasi elektif 4. Mempercepat waktu antrian operasi elektif 5. Meningkatkan MOU dengan perusahaan				

3.1.1.4 Kunjungan Rawat Inap Maternitas

3.1.1.4.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2026)

NO	HAL	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)
1	BPJS	104	130	146	↑10%
2	UMUM	6	2	3	↑33,3%
3	ASURANSI	0	1	0	↑0,01%
Total Pasien		110	133	149	↑10,7%

3.1.1.4.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2026)



3.1.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

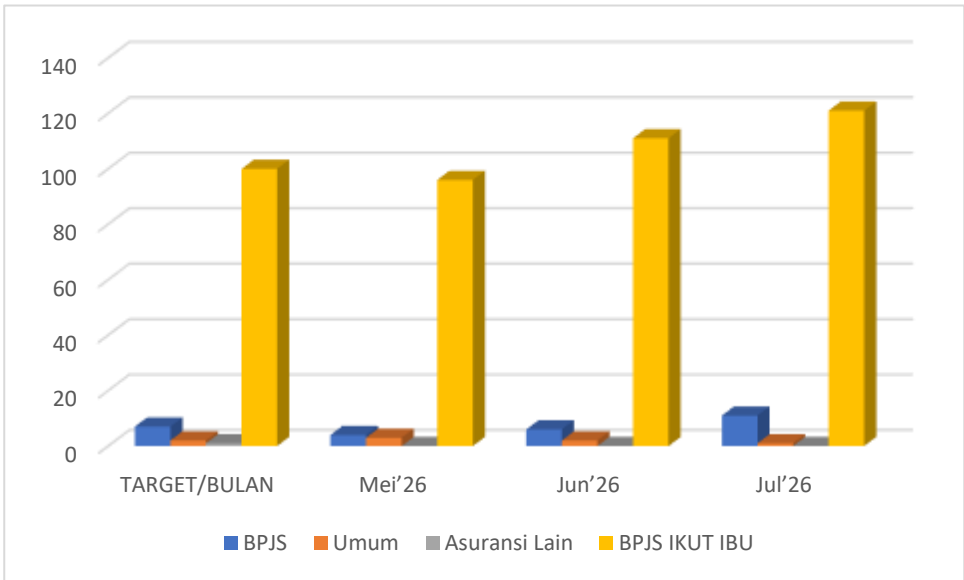
No	Bulan	RAWAT INAP			Kesimpulan
		BPJS	Umum	JR/Asuransi	
	Analisis capaian Bulan Mei-Juli	Pasien BPJS pada bulan Juli mengalami Kenaikan 10 %	Pasien umum pada bulan Juli mengalami kenaikan 33.3%	Tidak ada pasien Asuransi pada bulan Juli	Kunjungan turun dengan bulan sebelumnya. Selalu melakukan Upaya peningkatan dan evaluasi program telusur sederhana
	RTL	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target disetiap bulan	Meningkatkan pelayanan serta koordinasi dengan tim IGD	

3.1.1.2 Kunjungan Rawat Inap Neonatologi

3.3.2.7.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2026)

NO	HAL	TARGET/BULAN	Mei'26	Jun'26	Jul'26	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	7	4	6	11	↑8,27%
2	Umum	2	3	2	1	↓0,75%
3	Asuransi Lain	1	0	0	0	0
4	BPJS IKUT IBU	100	96	111	121	↑0,76%
Total Pasien		110	104	121	133	↑9,92%

1.3.2.7.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar
(Mei – Juli 2026)



3.3.2.7.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No	Bulan	Rawat Inap				Total Pasien
		BPJS	UMUM	ASURANSI	BPJS IKUT IBU	
1	Mei 2026	4	3	0	96	104
		Untuk pasien BPJS mengalami penurunan dari bulan sebelumnya sebanyak 3,85%	Untuk pasien Umum mengalami kenaikan dengan bulan sebelumnya sebanyak 2,89%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami penurunan sebanyak 4,95%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	
2	Juni 2026	6	2	0	111	121
		Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebanyak 4,96 %	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 1,6%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan sebanyak 91,7%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	

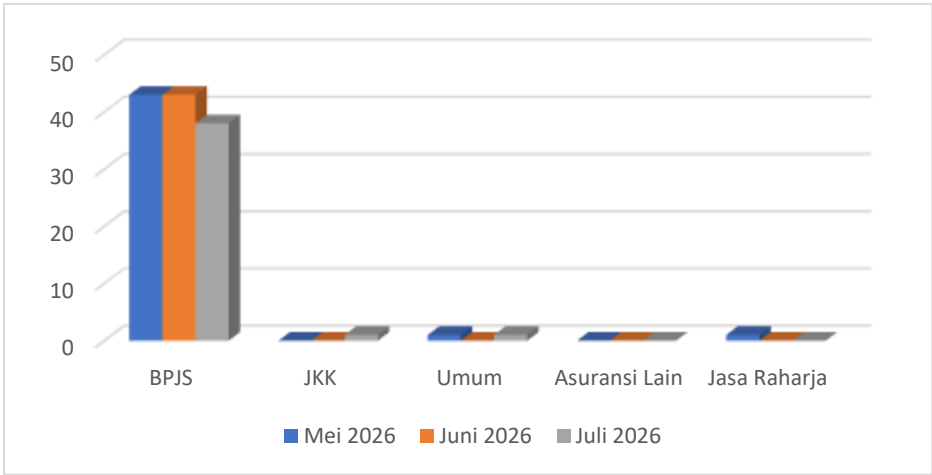
3		11	1	0	121	133
	Juli 2026	Untuk pasien BPJS mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya sebanyak 8,27 %	Untuk pasien Umum mengalami penurunan dengan bulan sebelumnya sebanyak 0,75%	Tidak ada pasien asuransi	Pasien BPJS Ikut Ibu mengalami kenaikan sebanyak 0,76%	
		Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Meningkatkan pelayanan agar bisa mencapai peningkatan di setiap bulannya	Bekerjasama dengan IGD untuk promosi kesehatan	Meningkatkan pelayanan khususnya pada pasien bayi baru lahir, Koordinasi dengan tim Maternitas dan poli untuk promosi Kesehatan ibu dan bayi melalui senam hamil.	

3.1.2 Intensive Care Unit (ICU)

3.1.2.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2026)

NO	Cara Bayar	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	43	43	38	↓0,11%
2	JKK	0	0	1	↑100%
3	Umum	1	0	1	↑100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	Jasa Raharja	1	0	0	Tetap
Total Pasien		45	43	40	↓0,06%

3.1.2.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2026)



3.1.1.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

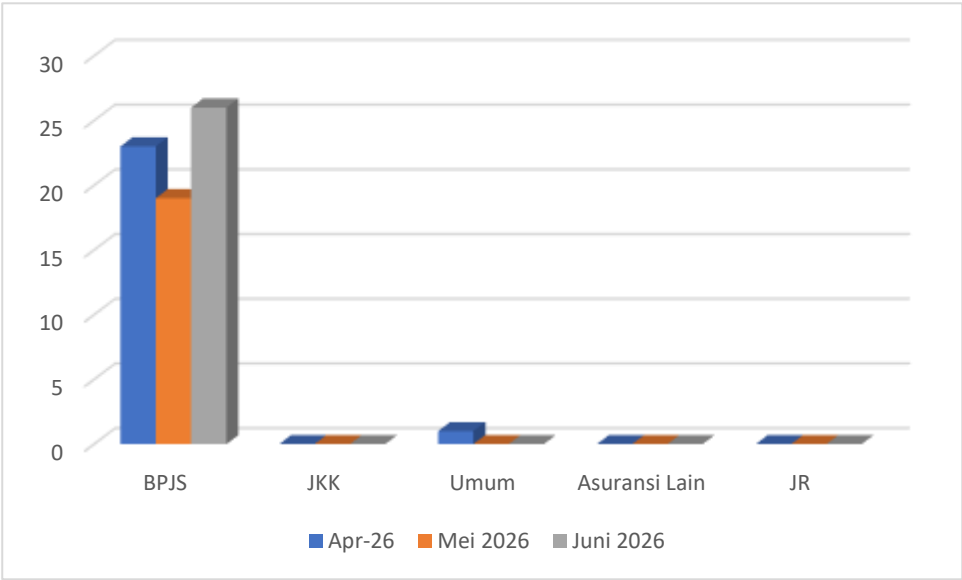
NO.	BULAN	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan Juli 2026 turun 0,11% dari bulan sebelumnya	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir jumlahnya 1 orang untuk bulan Juli 2026	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir jumlahnya 1 orang untuk bulan Juli 2026	ada 1 pasien penjamin JR di bulan Mei 2026	Kunjungan pasien rawat inap ICU RS Prima Husada mengalami penurunan sebesar 0,06 % dibandingkan dari bulan sebelumnya.
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama ICU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat 5. Meningkatkan kualitas SDM yang ada di ICU				

3.1.2 High Care Unit (HCU)

3.1.2.2 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2026)

NO	HAL	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	BPJS	19	26	30	↑0,36%
2	JKK	0	0	0	Tetap
3	Umum	0	0	1	↑100%
4	Asuransi Lain	0	0	0	Tetap
5	JR	0	0	0	Tetap
Total Pasien		19	26	31	↑0,19%

3.1.1.1 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2026)



3.1.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

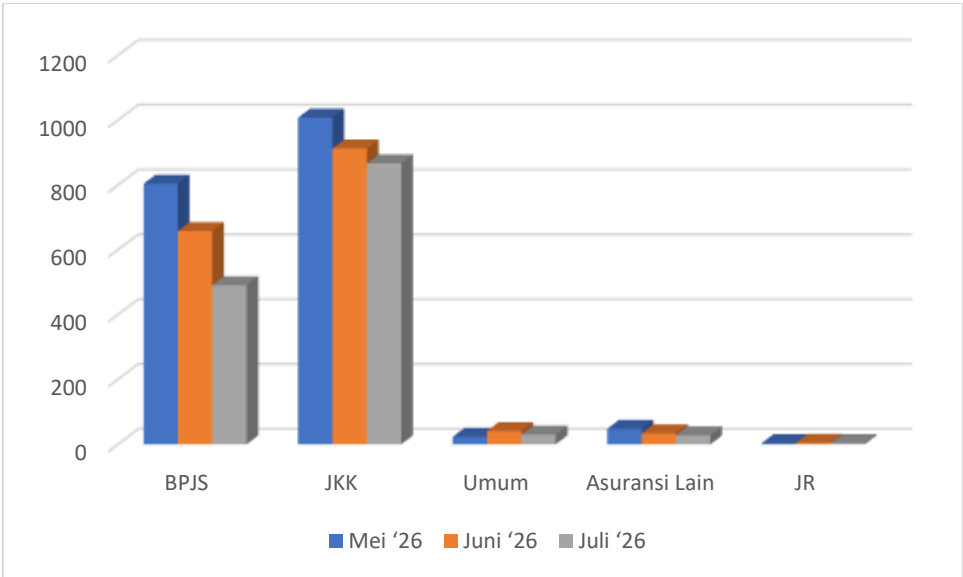
NO.	BULAN AGUSTUS	RAWAT INAP				KESIMPULAN
		BPJS	UMUM	JKK	JR/ASURANSI	
1	Analisis 3 bulan terakhir	Pasien BPJS dalam 3 bulan terakhir belum stabil, untuk bulan juli 2026 mengalami peningkatan 0,36%diban dingkan bulan lalu	Pasien umum dalam 3 bulan terakhir belum stabil untuk bulan Juli 2026 kunjungan 1	Tidak ada pasien JKK selama 3 bulan terakhir	Tidak ada Pasien JR/ Asuransi bulan Juli 2026	Kunjungan pasien rawat inap HCU RS Prima Husada meningkat 0,19% dari bulan sebelumnya
2	RTL	1. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas agar bisa mencapai target setiap bulannya 2. Meningkatkan kunjungan IGD terutama untuk pasien rawat inap terutama HCU 3. Meningkatkan kualitas fasilitas di unit 4. Menerima pasien dari IGD dengan cepat				

3.1.3 Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.1.3.1 Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei - Juli 2026)

NO	HAL	Mei '26	Juni '26	Juli '26	Hasil prosentase kunjungan pasien
1	BPJS	804	658	491	↓25%
2	JKK	1.008	913	867	↓ 5 %
3	Umum	23	41	30	↓26,8%
4	Asuransi Lain	48	34	28	↓17,64 %
5	JR	4	5	4	↓20 %
Total Pasien		1.887	1.651	1.420	↓13,99 %

3.1.3.2 Grafik Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Bayar (Mei-Juli 2026)



3.1.3.3 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

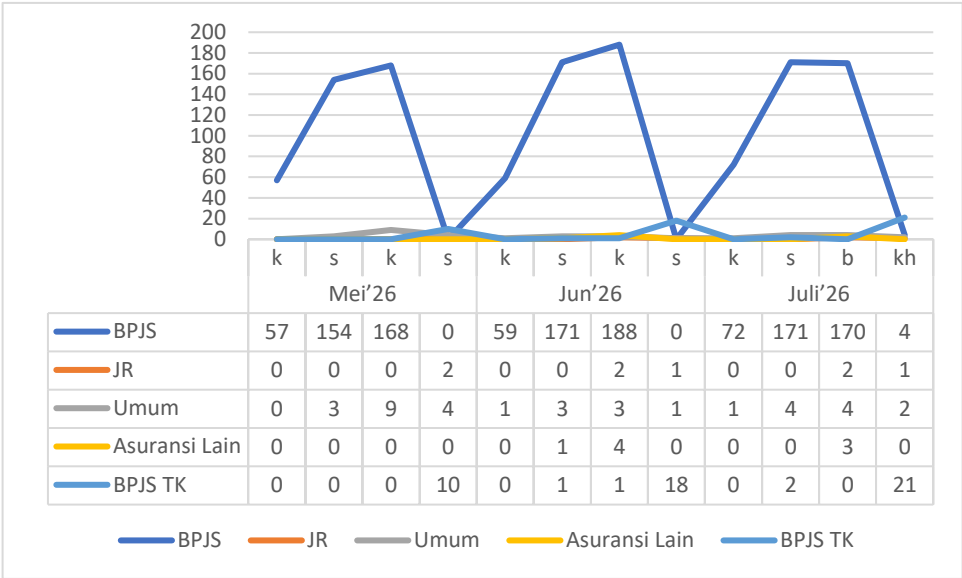
No	BULAN	INSTALASI GAWAT DARURAT					
1	Juli	BPJS	UMUM	JKK	ASURANSI	JR	TOTAL PASIEN
	Analisis	Kunjungan pasien BPJS di bulan Juli mengalami penurunan 25%	Kunjungan pasien UMUM dari bulan Juli mengalami penurunan 5%	Kunjungan pasien dengan jaminan JKK mengalami penurunan pada bulan Juli sebanyak 26,8%	Kunjungan pasien dengan jaminan Asuransi lain pada bulan Juli mengalami penurunan 17,64%	Kunjungan pasien dengan jaminan JR bulan Juli menurun 20%	Total kunjungan pasien IGD semua jaminan di bulan Juli 2026 mengalami penurunan 13,99%
	RTL	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan pasien BPJS IGD bekerjasama dengan marketing untuk menambah kerja sama dengan beberapa faskes I area kabupaten Malang	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan jaminan UMUM dengan memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan maksimal	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kunjungan IGD jaminan JKK dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan beberapa Perusahaan Kabupaten Malang	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan Asuransi swasta IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan jaminan JR IGD bekerjasama dengan marketing untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan asuransi	Meningkatkan capaian kunjungan IGD dengan memperbaiki pelayanan dan bekerjasama dengan pihak terkait (marketing, asuransi centre)

3.1.4 Instalasi Kamar Operasi (IKO)

3.1.4.1 Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Mei-Juli 2026)

NO	HAL	Mei'26				Jun'26				Juli'26			
		k	s	k	s	k	s	k	s	k	s	b	kh
1	BPJS	57	154	168	0	59	171	188	0	72	171	170	4
2	JR	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	2	1
3	Umum	0	3	9	4	1	3	3	1	1	4	4	2
4	Asuransi Lain	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	3	0
5	BPJS TK	0	0	0	10	0	1	1	18	0	2	0	21
	Total Pasien	413				454				457			

Grafik Jumlah Operasi Berdasarkan Jenis Operasi dan Penjamin (Mei - Juli 2026)



3.1.4.2 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

No.	BULAN	Instalasi Kamar Operasi			
1	Juni	Kecil	Sedang	Besar	Khusus
	Analisis	Jumlah pasien ODC Pacho meningkat	Jumlah pasien meningkat karena jumlah pasien orthopedi meningkat	Operasi besar menurun karena jumlah pasien orthopedic meningkat	Operasi khusus menurun karena banyak yang turun menjadi kategori operasi besar atau sedang
	RTL	Tingkatkan capaian dengan meningkatkan jumlah pasien operasi	Meningkatkan capaian dengan sosiali ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM	Meningkatkan capaian dengan sosiali ke pihak luar tindakan apa saja yang dapat di lakukan di IKO RSPHM	Tingkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.

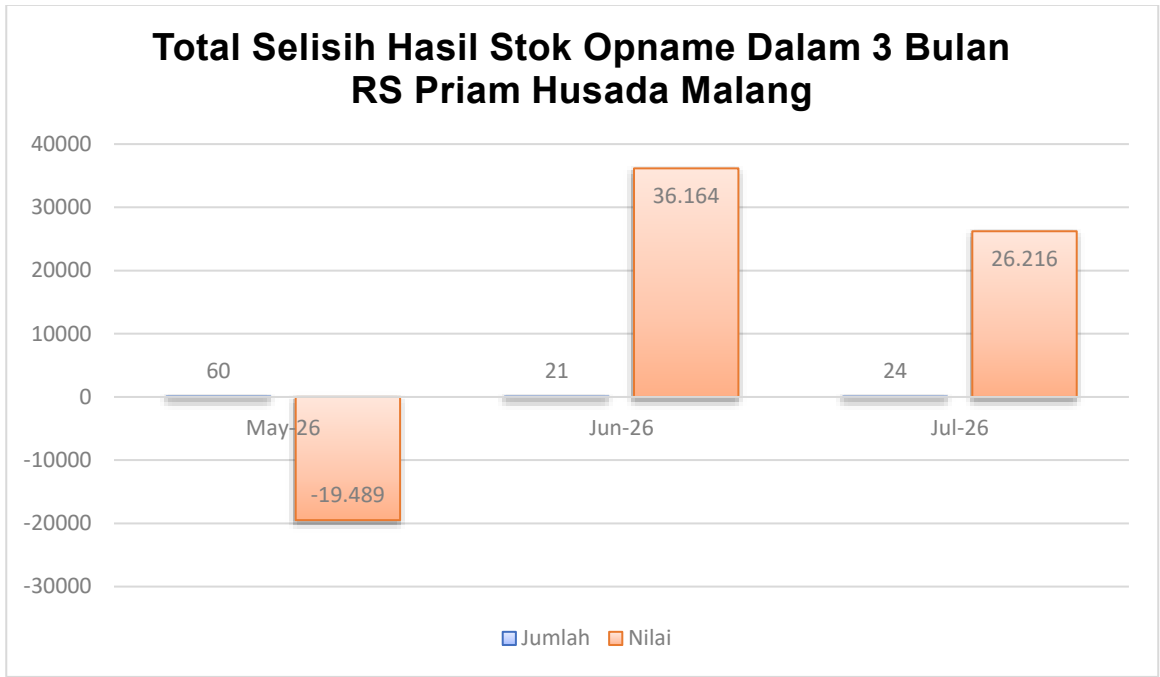
3.2 Kinerja Bidang Penunjang

3.2.1 Instalasi Farmasi

3.2.1.1 Tabel Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Mei - Juli 2026

Unit	Stok	Mei 2026		Juni 2026		Juli 2026	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
GUDANG	Fisik	590.337	1.223.051.252,46	630.948	1.183.344.389,15	493.547	1.154.624.911,99
	Sistem	590.337	1.223.051.252,46	630.948	1.183.344.389,15	493.547	1.154.624.911,99
	Selisih	0	0	0	0	0	0
DEPO FARMASI	Fisik	225.240	598.610.614,39	242.640	629.752.776,95	202.746	547.440.724,48
	Sistem	225.276	598.630.103,01	242.629	629.716.612,03	202.722	547.414.508,64
	Selisih	60	-19.489	21	36.164,92	24	26.215,84
IKO	Fisik	2.870	83.093.295,68	3.349	87.660.000,65	3.226	89.840.973,74
	Sistem	2.870	83.093.295,68	3.349	87.660.000,65	3.226	89.840.973,74
	Selisih	0	0	0	0	0	0
Total Selisih		60	-19.489	21	36.164	24	26.216

3.2.1.2 Grafik Hasil Stok Opname Instalasi Farmasi Mei - Juli 2026



No	Analisa	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut
Gudang Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0). Analisa :			
1	Penandaan nama pada rak sudah tertata dan kartu stok sudah berjalan.	-	Supervisi secara berkala
Depo Farmasi : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname masih jauh dari target (0) yaitu sebesar Rp 26.216 , hal ini disebabkan karena :			
1	Ketidaksesuaian antara jumlah obat yang di input dan jumlah obat yang disiapkan.	Staf Farmasi tidak melakukan double check terkait ketepatan obat dan jumlah obat sebelum di serahkan pada petugas kie atau perawat.	1. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan. 2. Supervisi oleh kains farmasi terkait penyiapan obat hingga alur penyerahan secara berkala. 3. Monitoring dan evaluasi oleh Kabid terkait dengan proses Input hingga penyerahan obat. Jika ada kesalahan dalam proses langsung di tegur dan langsung diperbaiki.
2	Ketidaksesuaian antara barang yang diambil perawat IGD dan inputan resep di SIMRS.	1. Staf Farmasi tidak melakukan double check dengan perawat 2. Siap obat dan bmhp hanya menggunakan etiket tanpa	1. Petugas farmasi wajib double crosscheck sebelum obat atau BMHP di serahkan → supervisi oleh kains farmasi. 2. Perbaiki alur ERM khususnya peresepan IGD diinput terlebih dahulu dan resep manual hanya untuk pasien KLL (case emergency) jika ada yang belum terinput maka akan dishare di Grup

		melihat resep	dan meminta bukti inputan.
3	Hutang input resep saat SO berjalan.	Kurang pencatatan saat pelaksanaan SO.	1. PJ shift rekap pengeluaran saat stok opname berlangsung. 2. Double check wajib di lakukan dengan alur kerja ISEP obat yang sudah di tentukan.
IKO : Dari tabel 3.1 tampak bahwa hasil stok opname mencapai target (0). Analisa :			
1	1. Perawat patuh melakukan input resep; 2. Retur penjualan barang yang tidak terpakai sudah rutin dilakukan; 3. Stok opname harian IKO	-	Supervisi secara berkala

3.1.1.1 Tabel Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Bulan Jul 2026 – Januar 2027)

No	Kode>Nama Obat	Satuan	Lokasi	Jumlah Stok Saat Pendataan	Nilai Stok/pcs	Nilai Near ED berdasarkan jmlh stok saat pendataan	Tanggal ED	Bulan ED	Sisa Hari ED	Kategori ED	Status TL	Keterangan
1	CAIRAN INF GELAFUSAL 500 ML - DEXA MEDICA	FLASH	Depo Farmasi	1	161,500	161,500	12/31/2026	12/2026	148	91–180 hari	Dikeluarkan dari box emergency dan di keluarkan terlebih dahulu	Faktur pembelian terakhir tanggal 12/05/2025 dari distributor sejumlah 20 flash
2	CENDO TONOR MDS - CENDO	PCS	Depo Farmasi	245	6,934	1,698,830	10/30/2026	10/2026	86	31–90 hari	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP	Faktur pembelian terakhir tanggal 13/08/2025 dari distributor sejumlah 200 pcs.
3	ICUNES INJ 100 MCG 2 ML - NOVELL	VIAL	Depo Farmasi	1	382,500	382,500	12/31/2026	12/2026	148	91–180 hari	Jual ke PHS	Pembelian terakhir tanggal 24/03/2026 dari RS PHS sejumlah 2 vial.
4	ONBREZ BREEZHALER INH 150 MCG - NOVARTIS	CAPS	Depo Farmasi	150	11,564	1,734,600	11/30/2026	11/2026	117	91–180 hari	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP	Faktur pembelian terakhir tanggal 09/08/2025 dari distributor sejumlah 300 caps.
5	PROFERRO TAB - FAHRENHEIT	TAB	Depo Farmasi	144	8,000	1,152,000	10/30/2026	10/2026	86	31–90 hari	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP	Faktur pembelian tanggal 23/04/2025 dari distributor sejumlah 450 tab (ED 30/10/2026). Penataan tidak FEFO di gudang farmasi karna faktur terakhir

												15/01/2026 sejumlah 300 tab ED 30/09/2027.
6	QUETVELL TAB 200 MG - NOVELL	TAB	Depo Farmasi	17	10,640	180,880	10/30/2026	10/2026	86	31–90 hari	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP	Faktur pembelian terakhir tanggal 09/06/2026 dari distributor sejumlah 360 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.
7	REPIMID TAB 100 MG - NOVELL	TAB	Depo Farmasi	166	2,520	418,320	10/30/2026	10/2026	86	31–90 hari	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP	Faktur pembelian terakhir tanggal 21/05/2026 dari distributor sejumlah 200 tablet. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.
8	Skycellflu quadrivalent - dexa medica	VIAL	Depo Farmasi	1	167,200	167,200	08/30/2026	08/2026	25	≤30 hari	Vaksin sudah lunas di bayar dan pasien belum datang untuk suntik.	Faktur pembelian terakhir tanggal 28/04/2026 dari distributor sejumlah 8 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor.
9	SUSU LACTOGEN PRO (6- 12BLN) 180GR - NESTLE	BOX	Depo Farmasi	1	28,285	28,285	11/30/2026	11/2026	117	91–180 hari	Retur ke distributor bulan agustus 2026	Faktur pembelian terakhir tanggal 13/08/2025 dari distributor sejumlah 1 box.
10	VAKSIN PREVENAR 05 ML - PFIZER	VIAL	Depo Farmasi	1	808,835	808,835	12/31/2026	12/2026	148	91–180 hari	Vaksin sudah lunas di bayar dan pasien belum datang untuk suntik.	Faktur pembelian terakhir tanggal 15/07/2026 dari distributor sejumlah 1 vial. Penerimaan obat

												dengan ed < 1 tahun dari distributor
11	VAKSIN VAXIGRIP TETRA - SANOFI	VIAL	Depo Farmasi	1	171,000	171,000	12/31/2026	12/2026	148	91–180 hari	Vaksin sudah lunas di bayar dan pasien belum datang untuk suntik.	Faktur pembelian terakhir tanggal 12/07/2026 dari distributor sejumlah 11 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor
12	Miconazole cr 2% 10 g - kimia farma	TUB	Depo Farmasi	17	3,407	57,919	9/30/2026	09/2026	56	31–90 hari	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP	Faktur pembelian terakhir tanggal 18/12/2025 dari distributor sejumlah 120 tube. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor
13	BENANG VICRYL 1 VCP359H - ETHICON	PCS	Depo IKO	2	161,098	322,196	11/30/2026	11/2026	117	91–180 hari	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP	Faktur pembelian terakhir tanggal 20/08/2024 dari distributor sejumlah 36 pcs.
14	Extension tube 75 cm - terumo	PCS	Depo IKO	2	16,800	33,600	08/30/2026	08/2026	25	≤30 hari	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP	Faktur pembelian terakhir tanggal 09/03/2023 dari distributor sejumlah 11 pcs.
15	Foley cath silicon no 10 - rusch	PCS	Depo IKO	1	110,000	110,000	9/30/2026	09/2026	56	31–90 hari	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP	Faktur pembelian terakhir tanggal 25/01/2025 dari distributor sejumlah 7 pcs.
16	Foley cath silicon no 8 - rusch	PCS	Depo IKO	4	222,000	888,000	08/30/2026	08/2026	25	≤30 hari	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP	Faktur pembelian terakhir tanggal 04/02/2023 dari

												distributor sejumlah 20 pcs.
17	NELATON CATH NO 14 - RUSCH	PCS	Depo IKO	1	16,500	16,500	12/31/2026	12/2026	148	91–180 hari	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP	Faktur pembelian terakhir tanggal 03/07/2024 dari distributor sejumlah 3 pcs.
18	Benang t-plain 4-0 p119 - triton	PCS	Gudang Farmasi	10	60,500	605,000	9/30/2026	09/2026	56	31–90 hari	Retur ke distributor 29/06/2026 10 pcs	Faktur pembelian terakhir tanggal 01/09/2022 dari distributor sejumlah 24 pcs.
22	B FLUID INF 1000 ML - OTSUKA	FLASH	Gudang Farmasi	1	175,232	175,232	01/01/2027	01/2027	149	91–180 hari	SE Obat Near ED di edarkan ke DPJP	Faktur pembelian terakhir tanggal 22/07/2025 dari distributor sejumlah 2 flash
23	FURAMIN INJ - MEPRO	AMP	Gudang Farmasi	10	9,425	94,250	11/30/2026	11/2026	117	91–180 hari	Retur ke distributor 31/07/2026	Faktur pembelian terakhir tanggal 27/08/2025 dari distributor sejumlah 50 ampul (ED 30/11/2026). Penataan tidak FEFO di gudang farmasi karna faktur terakhir 19/05/2026 sejumlah 10 ampul (ED 30/05/2027).
24	ICUNES INJ 100 MCG 2 ML - NOVELL	VIAL	Gudang Farmasi	1	382,500	382,500	12/31/2026	12/2026	148	91–180 hari	Jual ke PHS	Pembelian terakhir tanggal 24/03/2026 dari RS PHS sejumlah 2 vial.
25	NUTRISI LACTOGEN LACTOSE FREE 400 G - NESTLE	KLG	Gudang Farmasi	1	116,036	116,036	31/10/2026	10/2026	87	31–90 hari	Retur ke distributor bulan agustus 2026	Faktur pembelian terakhir tanggal 09/10/2025 dari distributor sejumlah 2 box.

26	Vaksin rotateq - gsk	VIAL	Gudang Farmasi	8	245,395	1,963,160	10/07/2026	07/2026	-26	SUDAH ED	Retur ke distributor tanggal 31/07/2026.	Faktur pembelian terakhir tanggal 12/09/2025 dari distributor sejumlah 10 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor
27	VAKSIN VAXIGRIP TETRA - SANOFI	VIAL	Gudang Farmasi	16	171,000	2,736,000	12/31/2026	12/2026	148	91–180 hari	Vaksin internasional dan vaksin anak	Faktur pembelian terakhir tanggal 12/07/2026 dari distributor sejumlah 11 vial. Penerimaan obat dengan ed < 1 tahun dari distributor

3.2.1 Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

Analisis	Tindak Lanjut
Beberapa penyebab utama obat masuk kategori Near ED yang ditemukan antara lain: • Penerimaan barang dengan masa kedaluwarsa kurang dari 1 tahun dari distributor, misalnya Quetvell, Repimid, Skycellflu, Miconazole, Vaxigrip, Rotateq, dan Prevenar. • Penataan stok belum sepenuhnya menerapkan prinsip FEFO, sehingga stok dengan ED lebih pendek belum digunakan terlebih dahulu (contoh Proferro dan Furamin). • Permintaan penggunaan rendah (slow moving) pada beberapa obat dan BMHP. • Barang merupakan titipan atau sudah dibayar pasien, terutama vaksin, namun pasien belum datang sehingga stok tetap tersimpan. • Pengadaan dalam jumlah relatif besar dibanding kebutuhan aktual pelayanan.	Upaya pengendalian yang telah dilaksanakan meliputi: • Penyebaran Surat Edaran Obat Near ED kepada DPJP untuk meningkatkan penggunaan. • Retur ke distributor pada item yang memenuhi persyaratan. • Penjualan antar fasilitas pelayanan kesehatan (PHS) untuk item tertentu. • Mengeluarkan stok emergency agar digunakan lebih dahulu. • Monitoring khusus terhadap vaksin yang telah dibayar pasien.

3.2.1.6 Tabel Jumlah Pelayanan Resep pada Bulan Juli 2026

No	Instalasi	Umum	BPJS Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan	Asuransi Swasta	Jasa Raharja	Total
1	Instalasi Rawat Inap						
	Jumlah Resep Obat Racikan	11	248	0	0	0	259
	Jumlah Resep Obat Jadi	531	6466	0	24	24	7045
	Jumlah Resep Obat	542	6714	0	24	24	7304
2	IGD						
	Jumlah Resep Obat Racikan	85	12	0	0	0	97
	Jumlah Resep Obat Jadi	1271	1798	0	8	8	3085
	Jumlah Resep Obat	1.356	1.810	0	8	8	3.182
3	Instalasi Rawat Jalan						
	Jumlah Resep Obat Racikan	271	1752	0	0	0	2.281
	Jumlah Resep Obat Jadi	1050	7398	0	9	9	8.526
	Jumlah Resep Obat	1321	9150	0	9	9	10.489
4	IKO						
	Jumlah Resep Obat Racikan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Resep Obat Jadi	43	1.116	0	14	14	1.187
	Jumlah Resep Obat	43	1.116	0	14	14	1.187
TOTAL		3.071	18790	0	55	55	22162

Analisis:

Pada periode pelaporan, Instalasi Farmasi melayani 22.162 resep obat. Berdasarkan jenis penjamin, pelayanan didominasi oleh BPJS Kesehatan sebanyak 18.790 resep (84,8%), diikuti pasien Umum sebanyak 3.071 resep (13,9%), Asuransi Swasta sebanyak 55 resep (0,2%), dan Jasa Raharja sebanyak 55 resep (0,2%), sedangkan BPJS Ketenagakerjaan tidak terdapat pelayanan resep.

Berdasarkan instalasi, pelayanan resep terbanyak berasal dari Instalasi Rawat Jalan sebanyak 10.489 resep (47,3%), diikuti Instalasi Rawat Inap sebanyak 7.304 resep (33,0%), IGD sebanyak 3.182 resep (14,4%), dan IKO sebanyak 1.187 resep (5,3%). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan farmasi masih didominasi oleh pasien rawat jalan.

Dari sisi jenis resep, obat jadi masih mendominasi pelayanan yaitu sebanyak 19.843 resep (89,5%), sedangkan obat racikan sebanyak 2.637 resep (11,9%). Tingginya penggunaan obat jadi mencerminkan sebagian besar terapi pasien telah dapat dipenuhi dengan sediaan siap pakai sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Resep racikan masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan terapi individual pada kondisi klinis tertentu.

Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Melakukan evaluasi tren jumlah resep per instalasi setiap bulan sebagai dasar perencanaan kebutuhan obat.
- 2. Memastikan ketersediaan stok obat jadi sesuai pola penggunaan, terutama di Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap.

- Mengoptimalkan pengelolaan bahan baku obat racikan agar kebutuhan pelayanan tetap terpenuhi tanpa terjadi kelebihan stok.
- Melakukan monitoring waktu tunggu pelayanan resep pada instalasi dengan volume pelayanan tinggi sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan.
- Mendorong penggunaan obat sesuai Formularium Rumah Sakit melalui koordinasi dengan DPJP untuk meningkatkan efisiensi penggunaan obat.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap pola pelayanan berdasarkan jenis penjamin sebagai dasar perencanaan anggaran dan pengadaan farmasi.

3.2.1.7 Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Bulan Mei - Jul 2026

No	Kegiatan	Standard	Pencapaian			Keterangan
			Mei 26	Juni 26	Juli 26	
1	Pengkajian resep	100%	99,47%	99,54%	99,55%	Jumlah pengkajian resep yaitu: Mei 2026 = 24.043 Juni 2026 = 23.956 Juli 2026 = 22.162 Jumlah ketidaklengkapan penulisan resep yaitu: Mei 2026 = 127 Juni 2026 = 110 Juli 2026 = 109
2	Dispensing Sediaan Steril	100%	100%	100%	100%	Dispensing sediaan steril dilakukan oleh apoteker di ruang pencampuran obat steril.
3	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	100%	100%	100%	100%	Form PTO sudah terlaksana dimana apoteker melakukan seleksi pasien berdasarkan kriteria PTO. Form PTO diletakkan dalam RM.
4	Kejadian Efek Samping Obat	0	0	0	0	Terdapat kejadian pelaporan efek samping obat
5	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan rekam medis dan resep yang di ttd penerima obat
6	Konseling	100%	100%	100%	100%	Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan)
7	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah	TDD	TDD	TDD	TDD	Tidak punya alat untuk pemantauan kadar obat dalam darah. TTD RS tipe C tidak wajib.
8	Visite Ronde Besar	100%	0%	0%	0%	Tidak ada visite ronde besar
9	Visite Pasien/ Farmasi Klinik	100%	100%	100%	100%	Seluruh pasien rawat inap dilakukan visite mandiri dibuktikan dengan pengisian CPPT oleh apoteker di RM.

10	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	100%	100%	100%	100%	Data berdasarkan map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape
11	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien	0	35	31	20	Obat tertinggal yang tidak diambil pasien dilakukan Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur

Analisa :

- Pengkajian resep :
 - Berdasarkan hasil monitoring periode Mei–Juli 2026, indikator pengkajian resep menunjukkan capaian yang stabil dan mendekati standar 100%, yaitu 99,47% pada Mei, meningkat menjadi 99,54% pada Juni, kemudian sedikit menurun menjadi 99,51% pada Juli. Meskipun terjadi penurunan tipis sebesar 0,03% dibanding bulan sebelumnya, jumlah ketidaklengkapan penulisan resep tetap mengalami perbaikan dari 127 kasus pada Mei, menjadi 110 kasus pada Juni, dan 109 kasus pada Juli. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan penulisan resep oleh tenaga medis, meskipun masih diperlukan upaya untuk mencapai target 100%.
- Dispensing Sediaan Steril
 - Staf yang melakukan dispensing sediaan obat steril non sitostatika terlatih dan kompeten. Apoteker yang memiliki sertifikat pelatihan prinsip penyiapan obat dan teknik aseptik tersertifikasi kemenkes yaitu 1 orang. Sedangkan Apoteker, TVF, bidan, dan perawat sudah memiliki sertifikat pelatihan dispensing sediaan obat steril non sitostatika di pelatihan internal.
 - Tersedia bukti hasil pemantauan suhu, kelembaban, tekanan ruang, pemeliharaan LAF. Fasilitas dispensing sesuai standar praktik kefarmasian sesuai dengan perundang-undangan.
 - Kebersihan ruangan dispensing sediaan obat non steril dan obat steril selalu terjaga. Petugas melakukan desinfeksi sebelum melakukan dispensing obat non steril dan obat steril. Renovasi Pencampuran Obat (LAF) sesuai standart selesai tanggal 20/03/2025, ruangan steril dilapisi vinyl. Tata letak ruang sudah di sekat dimana terdapat ruang persiapan dan ruang ganti APD, ruang antara, dan ruang steril (ada alat UV ruangan, pass box, LAF).
 - Pencampuran obat IV dilakukan di LAF dengan dilengkapi APD sesuai ketentuan setiap pukul 13.00 WIB, untuk resep obat injeksi sore dan malam. Tidak ditemukan keterlambatan pengiriman obat ke ruangan.
- Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Tersedia bukti pelaksanaan Pemantauan Terapi Obat dan sudah terisi lengkap oleh apoteker sesuai kriteria PTO.
- Kejadian Efek Samping Obat
 - Hasil monitoring pelaporan MESO bulan Juni 2026 tidak ditemukan kejadian efek samping obat.
 - Kurangnya pelaporan kejadian efek samping obat oleh tenaga kesehatan.
- Edukasi Obat pada pasien dan keluarga
 - Hasil supervisi dari rekam medis di rawat inap pada form edukasi bahwa apoteker sudah melakukan edukasi dibuktikan dengan ttd pasien/ keluarga di form edukasi.
 - Hasil supervisi dirawat jalan petugas farmasi sudah melakukan edukasi ke pasien dibuktikan dengan ttd penerima obat beserta KIE.
- Konseling

Pelaksanaan konseling sudah dilakukan pada pasien di rawat jalan dan/ataupun rawat inap yang mendapatkan terapi polifarmasi dan penyakit kronis. Apoteker memanggil pasien, identifikasi, menyerahkan obat dan edukasi. Konseling sudah dilakukan apoteker dibuktikan dengan bukti edukasi di form edukasi (pasien rawat inap) dan ttd penerima obat di resep (pasien rawat jalan).
- Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah : Tidak ada pelayanan di RS.

8. Visite Ronde Besar

Visite ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat, dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta professional kesehatan lainnya tidak pernah dilakukan, hal ini disebabkan waktu visite DPJP dan tenaga kesehatan lainnya tidak secara bersamaan.

9. Visite Pasien/ Farmasi Klinik

Visite dilakukan kepada setiap pasien rawat inap di RS dan di dokumentasikan di rekam medis pasien. Visite dilakukan untuk meminimalisir terjadinya medication error dan meningkatkan keberhasilan terapi pada pasien rawat inap

10. Pelayanan Informasi Obat (PIO)

PPA dapat mengakses Map informasi obat berisi : daftar dosis maksimal prorenata (jika perlu), daftar obat automatic stop order, daftar obat high alert update, daftar obat resiko jatuh, informasi cara pengenceran obat, informasi pembatasan resep, tabel rekonstitusi untuk pemberian intravena; MIMS; aplikasi Medscape di nurse station atau di poli, dan e-book yang tersedia di SIMRS.

11. Obat tertinggal yang tidak diambil pasien

Pada indikator obat tertinggal yang tidak diambil pasien, terjadi tren penurunan yang positif dari 35 item pada Mei, menjadi 31 item pada Juni, dan 20 item pada Juli atau turun 42,9% dibanding Mei. Penurunan ini menunjukkan semakin baiknya koordinasi antara petugas farmasi dan pasien dalam pengambilan obat. Terhadap obat yang tidak diambil, telah dilakukan pengelolaan sesuai prosedur melalui Penerimaan Hibah Lainnya ke gudang retur, sehingga keamanan dan akuntabilitas pengelolaan sediaan farmasi tetap terjaga.

Tindak Lanjut :

1. Pengkajian resep :

- Melakukan audit kelengkapan penulisan resep secara berkala dan memberikan umpan balik kepada DPJP.
- Mensosialisasikan kembali standar kelengkapan penulisan resep sesuai regulasi dan Formularium Rumah Sakit.
- Mengoptimalkan proses skrining resep oleh apoteker sebelum dispensing untuk memastikan kelengkapan administrasi, farmasetik, dan klinis.
- Memanfaatkan fitur validasi pada ERM/resep elektronik untuk meminimalkan ketidaklengkapan penulisan resep.
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator pengkajian resep setiap bulan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

2. Dispensing Sediaan Steril

- Pelatihan penyiapan obat IV dan teknik aseptik tahun 2025 target peserta Apoteker, TVF, Perawat, Bidan di laksanakan pada tanggal 08 Desember 2025.
- Monitoring dan evaluasi pengisian monitoring suhu dan kelembaban ruangan serta suhu lemari pendingin di depo farmasi, gudang farmasi, dan ruang pencampuran obat (LAF) oleh apoteker setiap hari.
- Supervisi Kains secara berkala dan mempertahankan kinerja yang sudah berjalan dengan baik

3. Pemantauan Terapi Obat (PTO) : supervisi secara berkala

4. Kejadian Efek Samping Obat

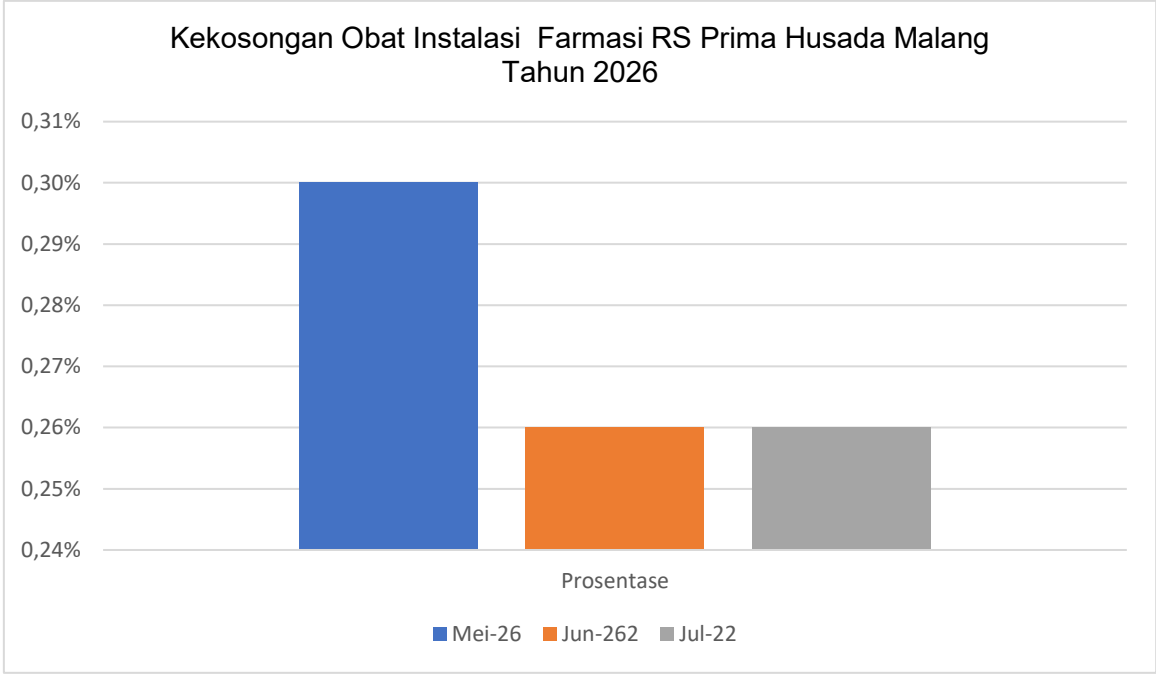
- Kolaborasi dengan komite medik, kepala bidang keperawatan, kepala bidang pelayanan medis untuk sosialisasi pentingnya pelaporan kejadian efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD oleh tenaga kesehatan.
- Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnnya

- 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
- Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
 - Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
 - Menganalisa laporan ESO.
 - Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
 - Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.
5. Edukasi Obat pada pasien dan keluarga : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan edukasi obat di rawat inap dan rawat jalan.
 6. Konseling : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan konseling di rawat inap dan rawat jalan.
 7. Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah : Tidak ada pelayanan di RS.
 8. Visite Ronde Besar
Koordinasi dengan PPA (Professional Pemberi Asuhan) agar dilakukan visite ronde besar.
 9. Visite Pasien/ Farmasi Klinik : Supervisi berjenjang terkait pelaksanaan visite pasien di rawat inap.
 10. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Map informasi obat, MIMS, aplikasi medscape sudah tersedia di unit pelayanan, dan e-book yang tersedia di SIMRS.
 11. Obat tertinggal yang tidak diambil pasien
 - Farmasi tiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
 - Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal yang mengakibatkan retur penjualan.
 - Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru.
 -

Tabel Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada

No	Tanggal	Nama Obat	Golongan Obat	Distributor	Tindak Lanjut
1	01/05/2026-31/05/2026	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	01/05/2026-31/05/2026	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
3	01/05/2026-15/05/2026	Pramivex 0.125 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramifrol 0.375 mg
4	01/05/2026-31/05/2026	Pramivex 0.25 mg	Anti parkinson	PT. Antar Mitra Sembada	Substitusi Pramifrol 0.375 mg
Total prosentase Mei 2026 = 0.30%					
1	01/06/2026-30/06/2026	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	01/06/2026-30/06/2026	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
3	01/06/2026-30/06/2026	Hydrochlorothiazide tab 25 mg	Diuretik (anti hipertensi)	PT. Kimia Farmas	Konsul DPJP substitusi obat lain
Total prosentase Juni 2026 = 0.26%					
1	01/07/2026-31/07/2026	Borraginol-N Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
2	01/07/2026-31/07/2026	Borraginol-S Suppositoria	Hemoroid	PT. United Dico Citas	Substitusi Superhoid suppositoria
3	01/07/2026-31/07/2026	Hydrochlorothiazide tab 25 mg	Diuretik (anti hipertensi)	PT. Kimia Farmas	Konsul DPJP substitusi obat lain
Total prosentase Juli 2026 = 0.26%					

1.2.1.11 Grafik Kekosongan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada Mei - Juli 2026



Analisis :

1. Hasil monitoring ketersediaan obat selama 3 bulan ditemukan kekosongan di distributor karena kekurangan bahan baku, delisting produk (pabrik tidak produksi), stok Hydrochlorothiazide tab 25 mg di distributor habis, kekosongan produk originator, dan kosong nasional seperti Borraginol-N Suppositoria dan Borraginol-S Suppositoria (produk paten originator) sehingga tidak tersedia di pabrik lain dengan kandungan yang sama.
2. RS belum bisa melakukan pembelian lewat e-purchasing sehingga belum bisa order obat fast moving khusus obat kronis.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Evaluasi mutu perjanjian kerjasama dengan distributor untuk memberikan konfirmasi apabila stok barang tidak tersedia di distributor setelah menerima pesanan dari RS.
2. Mencari substitusi obat lain yang isi/ kandungannya sama.
3. Evaluasi stok minimal depo farmasi dan Gudang farmasi serta alur pengadaan.
4. RS sudah mempunyai akun e-purchasing dan koordinasi dengan pengadaan terkait e-purchasing.
5. Memberitahukan info kekosongan obat di distributor ke DPJP melalui surat edaran beserta saran substitusi.

1.2.1.12 Tabel Pemusnahan Obat, BMHP/ Alat Kesehatan Rusak (Substandar), dan Recall Bulan Juli 2026

No	Kegiatan	Nama Obat/ BMHP/ Alat Kesehatan	Jumlah	Alasan	Keterangan
1	Pemusnahan Obat	-	-	-	Tidak terdapat pemusnahan obat pada bulan Juli 2026
2	Perbekalan Farmasi yang Diduga Tidak Stabil	-	-	-	Tidak ada perbekalan farmasi yang tidak stabil
3	Perbekalan Farmasi Terkontaminasi	-	-	-	Tidak ada perbekalan farmasi yang terkontaminasi
4	Perbekalan Farmasi Rusak	Infusion Set Dewasa VYLL	1 pc	Bocor pada bagian injeksi	Form laporan tanggal 09/07/2026 dari perawat IGD di laporkan ke Kepala Bidang dan telah di

					verifikasi oleh IFRS. Kemudian koordinasi dengan Apoteker Gudang Farmasi dan Pengadaan PT. DPM untuk evaluasi produk
5	Perbekalan Farmasi yang Diduga Palsu	-	-	-	Tidak ada perbekalan farmasi yang palsu
6	Recall/ Penarikan	-	-	-	Tidak terdapat produk recall atau penarikan

1.2.2. Laboratorium

Tabel Jumlah Pemeriksaan Laboratorium April-Juli 2026

	Target	Mei 26%	% terhadap bulan sebelumnya	Jun 26%	% terhadap bulan sebelumnya	Jul 26%	% terhadap bulan sebelumnya
HEMATOLOGI	1950	1677	↓2,9%	1578	↓5,1%	1310	↓16,9%
FAAL HEMOSTASIS	716	748	↓9,3%	826	↑10,4%	816	↓1,2%
HEMATOLOGI LAIN	1	0	↓100%	3	↑300%	0	↓300%
URINALISIS	418	252	↓9,3%	241	↓4,4%	234	↓2,9%
ANALISA FEACES	30	15	↓11,7%	12	↓20,0%	17	↑41,5%
FUNGSI HATI	611	311	↓21,6%	323	↑3,9%	337	↑4,1%
LEMAK DARAH	806	956	↑1,1%	776	↓18,8%	782	↑0,76
GINJAL HIPERTENSI	1394	1515	↓3,5%	1320	↓12,9%	1361	↑3,0%
GULA DARAH	1187	2458	↓7,6%	2386	↓2,9%	2223	↓6,8%
JANTUNG	583	716	↑6,5%	670	↓6,4%	624	↓6,8%
ELEKTROLIT DAN BGA	334	242	0%	186	↓23,1%	240	↓22,5%
IMUNO SEROLOGI	481	212	↑22,1%	150	↓29,2%	132	↓12%
REMATIK	6	6	↑50%	6	0%	4	↓33,3%
ENDOKRINOLOGI	60	94	↑13,8	65	↓30,9%	82	↑20,7%
REPRODUKSI	44	52	↑38,4%	56	↓7,7%	86	↑34,7%
MIKROBIOLOGI	32	55	↓1,7%	43	↓21,8%	40	↑6,9%

Jumlah	8654	9303	↓2,5%	8641	↓7,1%	8288	↑4,0%
---------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------

Analisis :

Pada bulan Juli 2026, jumlah pemeriksaan laboratorium sebanyak 8.288 pemeriksaan, mengalami penurunan sebesar 4,0% dibandingkan bulan Juni (8.641 pemeriksaan). Penurunan terutama terjadi pada pemeriksaan Hematologi (-16,9%), Gula Darah (-6,8%), Jantung (-6,8%), Urinalisis (-2,9%), Imuno Serologi (-12%), dan Faal Hemostasis (-1,2%). Sebaliknya, beberapa jenis pemeriksaan mengalami peningkatan, antara lain Analisa Feaces (+41,5%), Reproduksi (+34,7%), Endokrinologi (+20,7%), Fungsi Hati (+4,1%), Ginjal Hipertensi (+3,0%), dan Mikrobiologi (+6,9%). Secara umum, fluktuasi jumlah pemeriksaan mencerminkan perubahan kebutuhan pelayanan dan jumlah kunjungan pasien selama bulan Juli.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan monitoring tren jumlah pemeriksaan laboratorium setiap bulan serta mengaitkannya dengan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap.
2. Berkoordinasi dengan unit pelayanan dan DPJP untuk memastikan pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai indikasi klinis.
3. Mengevaluasi penyebab penurunan pada jenis pemeriksaan yang mengalami penurunan signifikan, khususnya Hematologi dan Gula Darah.

1.2.2.1 Pelaporan Kerusakan Sampel pada Bulan Juli 2026

No	Tanggal	No RM	Unit	Jenis Specimen	Pemeriksaan	Alasan Kerusakan	Tindakan
1	07/07/2026	219427	IGD	DARAH	FAAL HEMOSTASIS	CLOTHING	MINTA SAMPEL ULANG
2	11/07/2026	63660	IGD	DARAH	BGA	SAMPEL VENA	MINTA SAMPEL ULANG
3	12/7/2026	251879	6A	DARAH	DARAH LENGKAP	CLOTHING	MINTA SAMPEL

							ULANG
4	14/7/2026	252278	IGD	DARAH	DARAH LENGKAP	CLOTTING	MINTA SAMPEL ULANG
5	15/07/2026	252354	IGD	DARAH	FAAL HEMOSTASIS	SAMPEL KURANG	MINTA SAMPEL ULANG
6	21/07/2026	159098	ICU	DARAH	ELEKTROLIT	LISIS	MINTA SAMPEL ULANG

Analisis :

Pada bulan Juli 2026 tercatat 6 kasus kerusakan sampel, yang seluruhnya memerlukan permintaan sampel ulang. Kerusakan terbanyak terjadi di IGD (4 kasus), diikuti IRNA 6A (1 kasus) dan ICU (1 kasus). Penyebab kerusakan didominasi oleh clotting/cloting (3 kasus), disusul sampel vena (1 kasus), sampel kurang (1 kasus), dan lisis (1 kasus). Kondisi ini menunjukkan masih diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap prosedur pengambilan, penanganan, dan pengiriman spesimen agar kualitas sampel tetap terjaga dan tidak menghambat pelayanan laboratorium.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan sosialisasi dan refresh training teknik pengambilan serta penanganan spesimen kepada petugas di unit, terutama IGD koordinasi dengan komite keperawatan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kasus kerusakan sampel secara berkala untuk mengidentifikasi tren dan penyebab dominan.
3. Mengingatkan petugas untuk memastikan volume sampel, jenis tabung, serta proses pencampuran dan pengiriman spesimen sesuai SPO.
4. Melakukan koordinasi dengan unit yang memiliki kejadian berulang sebagai upaya pencegahan agar angka kerusakan sampel dapat diturunkan.

1.2.2.2 Jumlah Pemeriksaan Patologi Klinik (Permeriksaan Rujukan)

No	Golongan PA	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026	Prosentase terhadap bulan sebelumnya
1	PA Golongan 1	4	4	5	↑25%
2	PA Golongan 2	5	7	2	↓71,42%
3	PA Golongan 3	84	89	77	↓13,48%
4	Total	93	155	109	↓29,68%

Analisis:

Pada bulan Juli 2026, jumlah pemeriksaan Patologi Anatomi (PA) sebanyak 109 pemeriksaan, mengalami penurunan 29,68% dibandingkan bulan Juni (155 pemeriksaan). Penurunan terutama terjadi pada PA Golongan 2 yang turun dari 7 menjadi 2 pemeriksaan (↓71,42%) dan PA Golongan 3 dari 89 menjadi 77 pemeriksaan (↓13,48%). Sementara itu, PA Golongan 1 meningkat dari 4 menjadi 5 pemeriksaan (↑25%). Secara keseluruhan, penurunan jumlah pemeriksaan PA sejalan dengan fluktuasi jumlah kasus dan permintaan pemeriksaan dari unit pelayanan.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan pemantauan tren pemeriksaan Patologi Anatomi setiap bulan dan mengaitkannya dengan jumlah tindakan maupun kasus klinis.
2. Berkoordinasi dengan unit pengirim untuk memastikan seluruh spesimen yang memerlukan pemeriksaan PA dikirim sesuai indikasi dan prosedur.
3. Memastikan kesiapan sarana, bahan habis pakai, dan jejaring laboratorium agar pelayanan pemeriksaan PA tetap optimal.
4. Melakukan evaluasi berkala terhadap fluktuasi jumlah pemeriksaan sebagai dasar perencanaan pelayanan dan kebutuhan sumber daya.

1.2.2.3 Permintaan Labu Darah pada Bank Darah Rumah Sakit

No	Bulan	Permintaan Labu darah				Total Permintaan Labu darah
	Golda	A	AB	O	B	
1	Januari	21	6	24	29	80
2	Februari	16	27	37	7	87
3	Maret	33	11	57	40	141
4	April	15	32	30	7	84
5	Mei	21	11	24	22	78
6	Juni	20	9	22	25	76
7	Juli	15	10	21	20	66

Catatan: Tidak ada hasil incompatible crossmatch pada Bulan Juli 2026

Tabel Jumlah Permintaan Return Labu Darah Juli 2026

No	Bulan	Permintaan Return Labu darah				Total Permintaan Labu darah
	Golda	A	AB	O	B	
1	Januari	4	1	4	2	11
2	Februari	2	6	0	0	8
3	Maret	14	11	20	20	65
4	April	-	2	4	-	6
5	Mei	2	7	6	5	15
6	Juni	3	8	1	6	18
7	Juli	6	10	3	3	22

Analisis:

Pada bulan Juli 2026, jumlah permintaan labu darah sebanyak 66 kantong, menurun dibandingkan bulan Juni (76 kantong) atau turun 10 kantong (13,16%). Permintaan terbanyak berasal dari golongan darah O (21 kantong), diikuti B (20 kantong), A (15 kantong), dan AB (10 kantong). Selama bulan Juli tidak terdapat hasil incompatible crossmatch, yang menunjukkan proses pemeriksaan kompatibilitas darah berjalan dengan baik. Pada bulan Juli 2026, jumlah return labu darah sebanyak 22 kantong, meningkat dibandingkan bulan Juni (18 kantong) atau naik 4 kantong (22,22%). Return terbanyak terjadi pada golongan darah A (10 kantong), diikuti O (6 kantong), B (3 kantong), dan AB (3 kantong). Peningkatan return menunjukkan masih terdapat darah yang tidak digunakan sehingga diperlukan evaluasi terhadap ketepatan permintaan darah dari unit pelayanan.

Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Melakukan monitoring jumlah permintaan dan return labu darah setiap bulan.
- 2. Berkoordinasi dengan unit pelayanan untuk memastikan permintaan darah sesuai kebutuhan klinis pasien.
- 3. Melakukan evaluasi penyebab return darah guna mengurangi pemborosan dan menjaga efisiensi pengelolaan stok darah.
- 4. Mempertahankan kepatuhan terhadap prosedur pemeriksaan kompatibilitas darah sehingga zero incompatible crossmatch tetap dapat dipertahankan

3.2.3 Rekam Medis – Pendaftaran

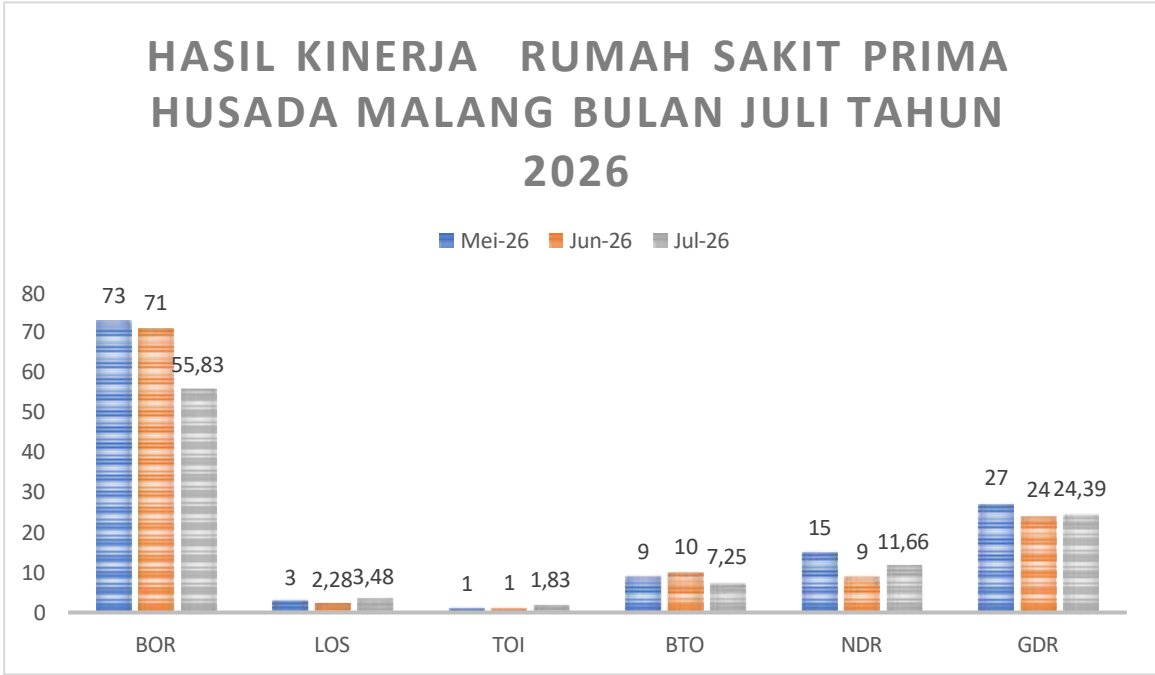
Tabel Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Juli 2026

Indikator	Keterangan	Rumus	Data	Standar Depkes	Laporan	Ruang													
						LT 2C	LT 2A	LT 3A	LT 3 C	LT 4ab	LT 5C	LT 6	LT 7	LT 8	MTS	NICU	HCU	ICU	TOTAL
BOR (Bed Occupancy Rate)	Prosentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu	$(\sum HP/(\sum TT \times \text{jumlah hari dalam satu periode})) \times 100$	Jumlah hari perawatan, jumlah TT, jumlah hari dalam satu periode	60 - 80 %	Mei 26	52	54	0	97	64	62	72	75	76	57	34	34	38	73
					Juni 26	55	64	15	69	70	62	67	76	79	72	27	33	29	71
					Juli 26	49	44	0	43	52	47	63	59	59	78	31	53	31	56
			jumlah		Mei	3	3	0	3	3	3	3	3	3	2	5	3	5	3

ALOS (Average Length of Stay)	Rata-rata lama rawat seorang pasien	$LD / \sum px keluar (H+M)$	lama dirawat, jumlah pasien keluar	6 - 9 hari	Juni 26	2,49	2,51	2,06	2,33	2,25	2,54	2,76	2,6	2,65	1,99	1,67	0,77	1,36	2,28
					Juli 26	3,93	3,85	0	3,04	3,53	3,29	3,58	3,46	3,44	3,05	5,75	8	9,08	3,48
3TOI (Turn Over Interval)	Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati	$((\sum TT \times \sum hari) - HP) / \sum pasien keluar (H+M)$	Jumlah tempat tidur, hari perawatan, pasien keluar	1 - 3 hari	Mei	2	2	0	0	1	1	1	1	1	1	10	5	8	1
					Juni 26	1	1	11	1	1	3	1	1	1	1	3	1	2	1
					Juli 26	2,95	3,47	0	2,67	2,26	2,48	1,47	1,69	1,66	0,57	10,75	4,25	12,25	1,83
BTO (Bed Turn Over)	Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode	$\sum Px keluar (H+M) / \sum TT$	jumlah pasien. Jumlah TT	4 - 5 kali	Mei 26	7	7	0	11	8	8	7	9	9	9	2	4	2	9
				(dalam hitungan bulan)	Juni 26	7	8	2	9	9	7	7	9	9	11	3	13	6	10
					Juli 26	5,38	5	0	6,61	6,56	6,53	7,67	7,5	7,58	11,92	2	4	1,71	7,25
NDR (Net Death Rate)	Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px Mati >48jm) / \sum Px keluar (H+M)) \times 1000\%$	Jumlah pasien meninggal >48jm, jumlah pasien keluar	<25%	Mei 26	0	0	0	0	8	8	45	10	9	0	0	250	438	15
					Juni 26	19	0	0	4	0	9	11	9	0	0	0	0	189	9
					Juli 26	23,26	0	0	0	0	10,2	21,74	11,11	10,99	0	0	0	416,67	11,66

GDR (Gross Death Rate)	Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	$(\sum Px \text{ mati} / \sum Px \text{ keluar} (H+M)) \times 1000\%$	Jumlah pasien keluar mati, jumlah pasien keluar	<45‰	Mei 26	0	13	0	0	8	8	56	19	18	0	0	625	875	27
					Juni 26	19	11	0	4	0	9	11	9	18	0	0	154	454	24
					Juli 26	23,26	0	0	0	0	20,41	21,74	11,11	10,99	0	0	625	916,67	24,39

3.1.1.1 Grafik Kinerja Unit Rawat Inap Bulan Juli 2026



Indikator	Analisis	Masalah	RTL (Rencana Tindak Lanjut)
BOR	Nilai BOR sebesar 55,83% masih berada di bawah standar ideal (60–85%). Tingkat pemanfaatan tempat tidur belum optimal.	Pemanfaatan tempat tidur belum maksimal.	Melakukan evaluasi tingkat hunian tempat tidur, meningkatkan koordinasi antarunit, dan mengoptimalkan pelayanan pasien rawat inap.
ALOS	Nilai ALOS sebesar 3,48 hari masih berada dalam rentang standar ideal.	Belum ditemukan kendala yang signifikan.	Mempertahankan mutu pelayanan dan melakukan evaluasi secara berkala.
TOI	Nilai TOI sebesar 1,83 hari menunjukkan waktu kosong tempat tidur masih sesuai dengan standar.	Distribusi pasien pada beberapa ruangan belum merata.	Melakukan evaluasi distribusi pasien dan optimalisasi penggunaan tempat tidur.
BTO	Nilai BTO sebesar 7,25 kali menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur cukup baik.	Terdapat perbedaan tingkat penggunaan tempat tidur pada setiap unit.	Meningkatkan koordinasi antarruang perawatan dan melakukan evaluasi kapasitas tempat tidur.
NDR	Nilai NDR sebesar 11,66% masih berada dalam batas yang dapat diterima.	Masih terdapat kasus kematian pasien setelah perawatan lebih dari 48 jam.	Melakukan audit medis dan evaluasi mutu pelayanan secara berkala.
GDR	Nilai GDR sebesar 24,39% memerlukan evaluasi lebih lanjut, terutama pada ruang perawatan intensif.	Angka kematian pasien masih cukup tinggi pada unit tertentu.	Melakukan analisis penyebab kematian, meningkatkan koordinasi antartenenaga kesehatan, dan memperkuat penerapan keselamatan pasien.

3.1.1.2 Tabel Diagnosa Terbanyak Rawat Jalan Bulan Juli 2026

NO	CODE ICD 10	DIAGNOSIS	JUMLAH
1	E11.4	With neurological complications	719
2	I25.9	Chronic ischemic heart disease, unspecified	352
3	I11.9	HHD / Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	325
4	I51.9	Decomp Cordis / Heart disease, unspecified	315
5	I63.9	CVA Infark / Cerebral infarction, unspecified	260
6	F41.2	Mixed anxiety and depressive disorder	217
7	K04.1	Necrosis of pulp	199
8	J44.9	COPD / Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified	193
9	K80.8	Other cholelithiasis	187
10	M17.9	Gonarthrosis, unspecified	169

3.1.1.1 Tabel Diagnosa Rawat Inap Bulan Juli 2026

NO	KODE	DIAGNOSA	TOTAL
1.	Cerebrovascular Accident Infark	I63.9	51
2.	Gastroenteritis Acute	A09.9	33
3.	Pneumonia	J18.9	25
4.	Necrotizing Fascitis	M72.6	22
5.	Unstable Angina Pectoris	I20.0	17
6.	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	J44.1	16
7.	Non-ST elevation (NSTEMI) myocardial infarction	I21.4	16
8.	Diabetes Mellitus Hyperglykemia	E14.9	15
9.	Bacterial Infection	A49.9	15
10.	Calculus of the kidney	N20.0	12

Analisis :

No	Analisa	Masalah	RTL (Rencana Tindak Lanjut)
1	Penyakit terbanyak pada rawat inap bulan Juli 2026 adalah Cerebrovascular Accident (CVA) Infark, diikuti penyakit infeksi dan penyakit kronis yang masih mendominasi pelayanan rawat inap.	Tingginya kasus penyakit tidak menular dan penyakit infeksi meningkatkan kebutuhan pelayanan medis, rehabilitasi, serta perawatan berkelanjutan.	Meningkatkan kesiapan SDM, obat, alat kesehatan, pelayanan stroke, serta rehabilitasi medik sesuai pola penyakit terbanyak dan melakukan evaluasi pelayanan secara berkala.
2	Penyakit infeksi seperti Pneumonia, Gastroenteritis Akut, Necrotizing Fasciitis, dan Bacterial Infection masih termasuk dalam kelompok diagnosis terbanyak.	Tingginya kasus infeksi meningkatkan risiko penularan, penggunaan antibiotik, serta beban pelayanan rumah sakit.	Memperkuat Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), kepatuhan kebersihan tangan, penggunaan APD, surveilans infeksi, serta Program

			Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA).
3	Penyakit kronis seperti COPD, Diabetes Mellitus dengan Hiperglikemia, serta penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab utama rawat inap.	Tingginya angka penyakit kronis berpotensi meningkatkan angka rawat inap berulang, komplikasi, dan lama hari perawatan (LOS).	Meningkatkan edukasi pasien, pengendalian faktor risiko, optimalisasi clinical pathway, koordinasi tindak lanjut rawat jalan, serta program manajemen penyakit kronis.
4	Kasus yang memerlukan tindakan operatif seperti Necrotizing Fasciitis dan Batu Ginjal (Calculus of the Kidney) masih cukup tinggi sehingga membutuhkan pelayanan bedah yang optimal.	Kebutuhan ruang operasi, perawatan pascaoperasi, serta pelayanan penunjang harus tetap terjaga untuk menghindari keterlambatan pelayanan.	Melakukan evaluasi kapasitas kamar operasi, ketersediaan tempat tidur, kesiapan SDM, serta koordinasi pelayanan multidisiplin untuk menjaga mutu pelayanan bedah.
5	Dominasi kasus CVA Infark dan penyakit kardiovaskular menunjukkan tingginya kebutuhan pelayanan kegawatdaruratan, diagnostik, dan rehabilitasi.	Risiko kecacatan, komplikasi, dan mortalitas meningkat apabila penanganan tidak dilakukan secara cepat dan sesuai standar.	Mengoptimalkan pelayanan kegawatdaruratan, mempercepat diagnosis dan tata laksana sesuai pedoman klinis, serta meningkatkan koordinasi antar unit pelayanan.
6	Pola 10 besar penyakit rawat inap bulan Juli 2026 masih didominasi oleh penyakit neurologi, infeksi, kardiovaskular, penyakit kronis, dan kasus bedah.	Data pola penyakit belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan pelayanan dan pengembangan layanan rumah sakit.	Melakukan analisis tren penyakit setiap bulan sebagai dasar penyusunan program promotif dan preventif, pengadaan obat dan alat kesehatan, perencanaan SDM, serta pengembangan layanan prioritas rumah sakit.

3.1.1.2 Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Juli 2026

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	-	-	-	-	1090	93,7 0	61	6,30	1080	93,3 7	69	5,16	1147	99,6 6	4	0,34
Februari	-	-	-	-	920	84	119	16	929	86,4	110	13,6	1005	97	34	3
Maret	-	-	-	-	1001	95,3 0	54	16	1000	94,9 3	55	5,07	1031	96,6 7	24	,33
April	1244	99	12	1	1070	88	149	12	1113	89	142	11	1162	93	94	7
Mei	14	100	0	0	996	85	179	15	1039	87	157	13	1087	93	81	7
Juni	1149	99	7	1	790	70	345	30	1007	87	156	13	701	60	462	40
Juli	967	99	10	1	765	77	227	23	925	91	96	9	777	76	244	24
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1013	97,1 8	38	2,82	-	-	-	-	1051	100	0	0	1051	100	0	0
Februari	1008	98	27	2	-	-	-	-	1034	100	2	0,3	1036	100	0	0
Maret	1047	100	7	0	-	-	-	-	1043	100	11	0	1054	100	0	0
April	1148	91	107	9	1203	96	52	4	1203	96	52	4	1220	97	35	3
Mei	1112	93	84	8	1154	96	42	4	1171	98	25	2	1080	90	116	10

Juni	1099	95	62	6	1113	96	48	4	1140	98	21	2	1093	94	68	6
Juli	982	96	39	4	978	96	43	4	988	97	33	3	963	94	58	6
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	556	52	484	48	1040	100	0	0	1133	100	0	0	1010	91	123	9
Februari	528	61	398	39	926	100	0	0	1027	100	0	0	965	94	62	6
Maret	587	65	341	35	927	100	1	0,07	1034	90	13	10	291	33	756	67
April	564	99	99	3	1130	99	11	1	1206	97	42	3	1171	99	13	1
Mei	517	98	8	2	1061	99	14	1	1121	94	72	6	1067	98	21	2
Juni	522	98	12	2	994	96	40	4	1117	96	42	4	1043	97	33	3
Juli	557	99	2	1	867	99	9	1	860	98	16	2	862	98	14	2
Agustus																
September																
Oktober																

Analisis :

1. Kelengkapan Dokumen oleh DPJP

Pada Juli 2026, kelengkapan dokumen DPJP menunjukkan perbaikan dibandingkan Juni, ditandai dengan meningkatnya Pengkajian Awal Medis dari 70% menjadi 77%, CPPT dari 87% menjadi 91%, dan Ringkasan Pulang dari 60% menjadi 76%. Meskipun demikian, Pengkajian Awal Medis dan Ringkasan Pulang masih belum memenuhi target mutu sehingga perlu menjadi fokus perbaikan.

2. Kelengkapan dokumen oleh perawat:

Kelengkapan dokumentasi keperawatan pada Juli 2026 tetap baik dan stabil, dengan seluruh indikator berada pada kisaran 94–97%, menunjukkan kepatuhan pengisian dokumen yang sudah konsisten.

3. Kelengkapan dokumen oleh ahli gizi dan apoteker

Kelengkapan dokumentasi Ahli Gizi dan Apoteker pada Juli 2026 sangat baik, dengan seluruh indikator mencapai 98–99%, menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan telah memenuhi target mutu rumah sakit.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kelengkapan Dokumen oleh DPJP:

- a) Monitoring kelengkapan dokumen setiap hari.
- b) Reminder kepada DPJP sebelum pasien pulang.
- c) Evaluasi hasil audit pada rapat Komite Medis.

2. Kelengkapan dokumen oleh perawat:

- 1) Mempertahankan monitoring harian dokumentasi.
- 2) Memberikan umpan balik atas dokumen yang belum lengkap.
- 3) Melakukan pembinaan kepada petugas yang belum patuh.

3. Kelengkapan dokumen oleh ahli gizi dan apoteker:

- 1) Mempertahankan audit dan monitoring rutin.
- 2) Memberikan umpan balik terhadap ketidaklengkapan dokumen.
- 3) Mempertahankan kepatuhan pengisian sesuai standar.

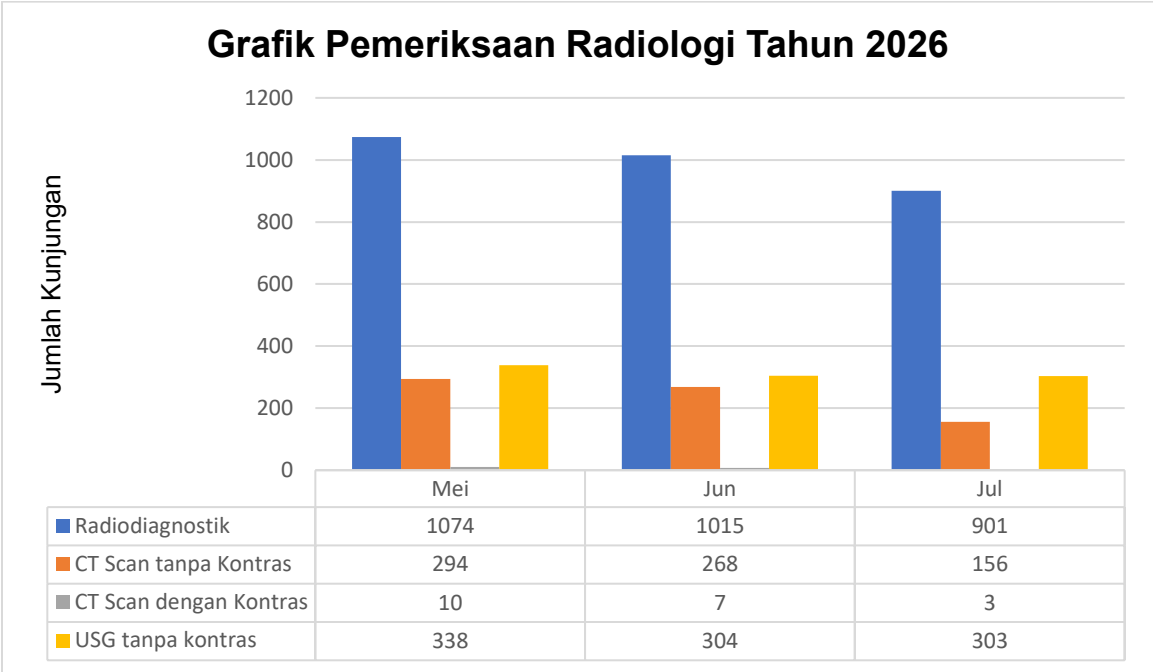
1.2.4 Radiologi

1.2.4.1 Tabel Jumlah Pemeriksaan Radiologi 2026

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PENJAMIN	BULAN		
			MEI	JUNI	JULI
1.	RADIO DIAGNOSTIK	UMUM	324	217	102
		BPJS KESEHATAN	1105	951	716
		BPJS TK	157	50	41
		ASURANSI SWASTA	10	18	12
		JASA RAHARJA	22	8	30
		RSPHS	0	0	0
		RSDH	0	8	0
		TOTAL	1.074	1.015	901
2.	CT SCAN TANPA KONTRAS	UMUM	22	28	0
		BPJS KESEHATAN	195	173	102
		BPJS TK	4	8	0
		ASURANSI SWASTA	4	3	0
		JASARA HARJA	6	2	0
		RS LAWANG MEDIKA	0	0	4
		RSPHS	0	0	50
		TOTAL	294	268	156
3.	CT SCAN DENGAN KONTRAS	UMUM	0	0	0
		BPJS KESEHATAN	6	5	0
		BPJS TK	0	0	0
		ASURANSI SWASTA	0	0	0
		JASARAHARJA	0	0	0
		RSPHS	0	0	3
		TOTAL	10	7	3
4.	USG TANPA KONTRAS	UMUM	1	3	41
		BPJS KESEHATAN	351	280	259
		BPJS TK	1	0	0
		ASURANSI SWASTA	1	0	1

		JASARAHARJA	0	0	2
	TOTAL		338	304	303

1.2.4.2 Grafik Jumlah Pemeriksaan Radiologi Juli 2026



Analisa	Review Hasil Berdasarkan PDSA
Pada bulan Juli 2026, jumlah pemeriksaan radiologi secara umum mengalami penurunan dibandingkan bulan Juni. Penurunan paling besar terjadi pada Radiodiagnostik (1.015 menjadi 901) dan CT Scan Tanpa Kontras (268 menjadi 156), yang terutama dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah pasien BPJS Kesehatan. Sementara itu, CT Scan Dengan Kontras juga menurun menjadi 3 pemeriksaan. Berbeda dengan layanan lainnya, USG relatif stabil dengan 303 pemeriksaan (304 pada Juni), menunjukkan kebutuhan layanan USG masih konsisten. Secara keseluruhan, volume pelayanan radiologi pada Juli masih didominasi oleh pasien BPJS Kesehatan.	P: Melakukan evaluasi terhadap penurunan jumlah pemeriksaan radiologi, khususnya Radiodiagnostik dan CT Scan, serta mengidentifikasi penyebab seperti penurunan kunjungan pasien, pola rujukan, maupun jadwal pelayanan. D: Meningkatkan koordinasi dengan dokter pengirim dan jejaring rujukan, memastikan kesiapan alat radiologi, mempercepat waktu pelayanan dan pembacaan hasil, serta melakukan sosialisasi layanan CT Scan kepada unit internal dan rumah sakit jejaring. S: Membandingkan jumlah pemeriksaan setiap bulan berdasarkan jenis pemeriksaan dan penjamin, mengevaluasi tren rujukan serta utilisasi alat radiologi setelah dilakukan upaya peningkatan pelayanan. A: Menetapkan strategi peningkatan utilisasi layanan melalui penguatan kerja sama rujukan, monitoring rutin volume pemeriksaan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap penyebab penurunan agar target pelayanan radiologi dapat tercapai.

Tabel Jumlah Laporan Pembacaan Ulang Hasil Radiologi Tahun 2026

NO	NAMA DOKTER	NAMA PASIEN	BACAAN AWAL	BACAAN ULANG	TOTAL
Bulan Januari 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Abd Salam	Brain Atrofi Senilis	Brain Atrofi senilis, Infark	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	-	-	-	-
Bulan Februari 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Damiasih / 135744	Infark akut di periventrike	Tambahan bacaan Hydrocefalus obstrukti	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	M Danendra Al Hussien / 201495	Normal	Normal	1
Bulan Maret 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	Asiyo Waga/24520	Fraktur distal ulna dan radius	Tambahan bacaan keterlibatan intra articular (epiphyse)	1
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	Sumarmi/011074	Fractura caput Os Humerus sinistra.Dislokasi sendi(+)	Tambahan bacaan fraktur epiphysis	1
Bulan April 2026					
1	dr. Agung, Sp.Rad (K)	1. Gusti fardi/192214 2. Ummu aimanah/231796 3. Tasir/091111	Normal Normal Susp cerebritis	Infark sub akut Infark sub akut Cerebritis	3
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	1. Ngadinem/125411 2. Rasmini/247707 3. Kasanah/248579	Cardiomegali Normal Bronchitis	Cardiomegali, Pneumonia Atelectasis Paru kiri. Kp Duplex	3
Bulan Mei 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	1. Sugito/245224 2. Sumardji/249022	Prostat enlargement Pneumonia	Vesicolitiasis, Prostat enlargement Tetap pneumonia	2
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	1. Kasanah/248579 2. Romadlon/249845 3. Wisnu attar/206655 4. Sriamah/128436	KP OA Dislokasi Cardiomegali	KP, Infected bronchiectais Fractura os Patela Tidak ada efyphyse Fraktur costae,cardio megali	4
Bulan Juni 2026					
1	dr.	-	-	-	-

	AgungSp.Rad (K)				
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	1. Sulastri/103381 2. Edi/250273 3. Siti yuliasih/123966 4. Nabila Agusandhya/101522	Normal Linier fractura Fractura Os Humerus Fractura os tibia	Fraktur neck femur Close reduction of ephiphysis Efiphysis Efiphysis	4
Bulan Juli 2026					
1	dr. AgungSp.Rad (K)	1. Susiati/241326 2. Ahmad haziq	Cardiomegali Normal	Tetap cardiomegali, tidak ada efusi Bronchopneumonia	2
2	dr. Rumbiyo Yudho Sp.rad	1. Dika Ananda/241415 2. Takim/225016	Normal Cross injury	Fraktura distal Crush injury	2

Analisis :

Pada bulan Juli 2026 terdapat 4 kasus pembacaan ulang hasil radiologi, masing-masing 2 kasus oleh dr. Agung, Sp.Rad (K) dan dr. Rumbiyo Yudho, Sp.Rad. Hasil pembacaan ulang menunjukkan adanya penambahan atau penyempurnaan interpretasi, seperti perubahan dari hasil normal menjadi bronchopneumonia, penegasan fraktura distal, serta koreksi terminologi cross injury menjadi crush injury. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pembacaan ulang masih berperan sebagai mekanisme quality control untuk meningkatkan ketepatan interpretasi hasil pemeriksaan radiologi.

Rencana Tindak Lanjut :

- Plan:
1. Meningkatkan akurasi interpretasi hasil radiologi melalui evaluasi kasus pembacaan ulang dan identifikasi penyebab perbedaan hasil bacaan.
- Do:
1. Melaksanakan diskusi kasus (peer review) pada hasil yang memerlukan pembacaan ulang serta mengoptimalkan penggunaan checklist interpretasi sesuai jenis pemeriksaan.
- Study:
1. Memantau jumlah dan jenis kasus pembacaan ulang setiap bulan serta mengevaluasi penyebab perbedaan interpretasi.
- Action
1. Menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan pembelajaran dan menyusun rekomendasi untuk menurunkan jumlah pembacaan ulang serta meningkatkan konsistensi hasil bacaan radiologi.

1.2.4.3 Tabel Rata-Rata Respon Time Pembacaan Pemeriksaan Radiologi

1. dr.Agung Setyawan, Sp.Rad (K)

JENIS PEMERIKSAAN	Rata-rata bulan Mei		Rata-rata bulan Juni		Rata-rata bulan Juli	
	Selesai Periksa	Selesai Pembacaan	Selesai Periksa	Selesai Pembacaan	Selesai Periksa	Selesai Pembacaan
RO THORAX	00:03:10	00:45:34 (waktu efektif) 04:32:24 (diatas jam 12 malam)	00:01:50	00:40:34 (waktu efektif) 05:40:25 (diatas jam	00:03:50	00:30:34 (waktu efektif) 04:10:25 (diatas jam

				12 malam)		12 malam)
RO VERTEBRAE	-	-	-	-	-	-
RO ABDOMEN	00:08:00	00:28:00(waktu efektif)	-	-	00:06:00	00:04:00 (diatas jam 12 malam)
RO EKSTREMITAS	-	-	-	-	-	-
RO SKULL	-	-	-	-	-	-
USG	00:05:51	00:05:51	00:04:53	00:05:00	00:05:00	00:02:00
CT SCAN NON KONTRAS	00:05:00	01:33:52 (waktu efektif) 05:45:00 (diatas jam 12 malam)	00:06:00	00:45:00 (waktu efektif) 11:37:56 (diatas jam 12 malam)	00:03:40	00:58:00 (waktu efektif) 9:44:46 (diatas jam 12 malam)
CT SCAN KONTRAS	-	-	00:12:02	00:45:00 (waktu efektif) 11:37:56 (diatas jam 12 malam)	00:12:02	09:20:10 (diatas jam 12 malam)
RADIOLOGI CITO	00:10:00	00:04:00 (waktu efektif) 00:20:00 (diatas jam 12 malam)	00:10:00	00:10:00 (waktu efektif) 00:30:00 (diatas jam 12 malam)	00:10:00	00:04:00 (waktu efektif) 00:30:00 (diatas jam 12 malam)

2. dr. Rumbiyo Yudho, Sp.Rad (K)

JENIS PEMERIKSAAN	Rata-rata bulan Mei		Rata-rata bulan Juni		Rata-rata bulan Juli	
	Selesai Periksa	Selesai Pembacaan	Selesai Periksa	Selesai Pembacaan	Selesai Periksa	Selesai Pembacaan
RO THORAX	00:03:00	0:43:38 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:02:00	0:27:26 (pada saat jam praktek) 10:05:00 (diluar jam praktek)	00:01:40	0:30:26 (pada saat jam praktek) 12:42:00 (diluar jam praktek)
RO VERTEBRAE	00:04:00	0:27:26 (pada saat jam praktek) 24:00:00	00:03:45	0:45:08 (pada saat jam praktek)	00:03:45	0:45:08 (pada saat jam praktek) 12:42:00 (diluar jam praktek)

		(diluar jam praktek)		11:10:05 (diluar jam praktek)		
RO ABDOMEN	00:10:00	0:20:48 (pada saat jam praktek) 13:05:25 (diluar jam praktek)	00:05:00	0:20:48 (pada saat jam praktek) 13:05:25 (diluar jam praktek)	00:05:00	0:20:48 (pada saat jam praktek) 12:42:00 (diluar jam praktek)
RO EKSTREMITAS	00:02:00	0:28:37 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	00:02:00	0:26:00 (pada saat jam praktek) 10:05:25 (diluar jam praktek)	00:02:00	0:26:00 (pada saat jam praktek) 12:42:00 (diluar jam praktek)
RO SKULL	03:00	0:23:30 (pada saat jam praktek) 24:00:00 (diluar jam praktek)	03:00	0:50:00 (pada saat jam praktek) 11:20:15 (diluar jam praktek)	03:00	0:20:00 (pada saat jam praktek) 12:42:00 (diluar jam praktek)
USG	00:05:00	00:06.18	00:05:00	00:08:12	00:05:00	00:01:18
CT SCAN NON KONTRAS	-	-	-	-	-	-
CT SCAN KONTRAS	-	-	-	-	-	-
RADIOLOGI CITO	-	0:15:00	-	-	-	-

Analisa :

Pada bulan Juli 2026, rata-rata response time pembacaan hasil radiologi pada jam praktik telah memenuhi target dengan waktu pembacaan berkisar 1–58 menit, tergantung jenis pemeriksaan. Waktu tercepat terdapat pada USG (2 menit oleh dr. Agung dan 1 menit 18 detik oleh dr. Rumbiyo). Namun, masih terdapat waktu pembacaan yang cukup lama di luar jam praktik, terutama pada pemeriksaan CT Scan dan RO Thorax, sehingga total waktu penyelesaian laporan menjadi lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan lebih dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan pemeriksaan di luar jam praktik dokter radiologi, bukan oleh proses interpretasi saat dokter sedang bertugas.

Rencana Tindak Lanjut :

Plan:
Mengoptimalkan response time pembacaan hasil radiologi, terutama untuk pemeriksaan yang dilakukan di luar jam praktik dokter radiologi.

Do:
Meningkatkan koordinasi dengan dokter radiologi untuk pembacaan kasus prioritas, memanfaatkan sistem notifikasi hasil pemeriksaan yang siap dibaca, dan mengatur alur pemeriksaan agar sesuai jadwal praktik apabila tidak bersifat cito.

Study:
Memantau response time pembacaan berdasarkan jenis pemeriksaan, jam praktik, dan di luar jam praktik setiap bulan.

Action
Menyusun tindak lanjut untuk mengurangi keterlambatan pembacaan di luar jam praktik, termasuk evaluasi jadwal layanan dan monitoring kepatuhan terhadap target response time.

1.2.4.4 Tabel PMI dan PME di Radiologi

No	Nama Alat (Merk dan Tipe)	No. Seri	Frekuensi			Terakhir Kalibrasi	PJ	Pihak Ketiga (Kalibrator)
			Mingguan	Bulanan	Tahunan			
1	Rontgen Stationer	-	-	-	√	08/09/2025-08/09/2026	IPSRS	PT Inti Presisi Medica
2	Rontgen Portable				√	08/09/2025-08/09/2026	IPSRS	PT Inti Presisi Medica
3	CT Scan	-	-	-	√	02/09/2025-02/09/2026	IPSRS	PT Inti Presisi Medica
4	USG				√	04/09/2025-04/09/2026	IPSRS	PT Inti Presisi Medica

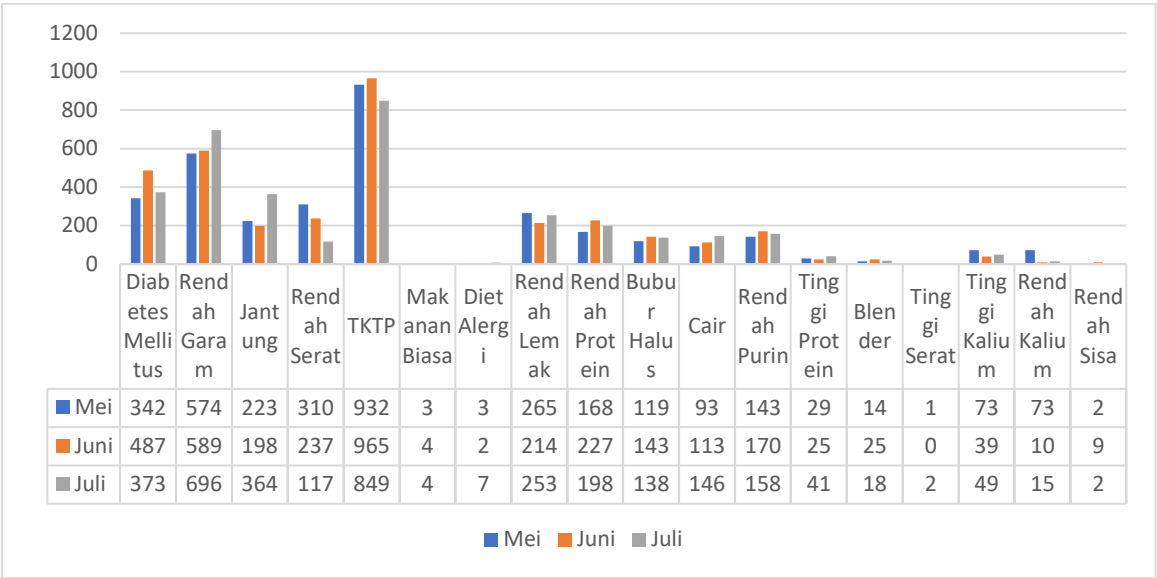
2.4.5 Gizi

2.4.5.1 Tabel Pemesanan Diit 2026

No.	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026	Bulan Juli 2026	
1.	Diabetes Mellitus	342	487	373	↓23,4
2.	Rendah Garam	574	589	696	18,2
3.	Jantung	223	198	364	83,8
4.	Rendah Serat	310	237	117	↓50,6
5.	TKTP	932	965	849	↓12,0
6.	Makanan Biasa	3	4	4	0,0
7.	Diet Alergi	3	2	7	250,0
8.	Rendah Lemak	265	214	253	18,2
9.	Rendah Protein	168	227	198	↓12,8
10.	Bubur Halus	119	143	138	↓3,5
11.	Cair	93	113	146	29,2
12.	Rendah Purin	143	170	158	↓7,1
13.	Tinggi Protein	29	25	41	64,0
14.	Blender	14	25	18	↓28,0
15.	Tinggi Serat	1	0	2	100
16.	Tinggi Kalium	73	39	49	25,6
17.	Rendah Kalium	73	10	15	50,0

No.	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026	Bulan Juli 2026	
18.	Rendah Sisa	2	9	2	↓77,8
	Jumlah	3321	3457	3430	↓0,8

2.4.5.2 Grafik Jumlah Pesanan Diit 2026



Analisis :

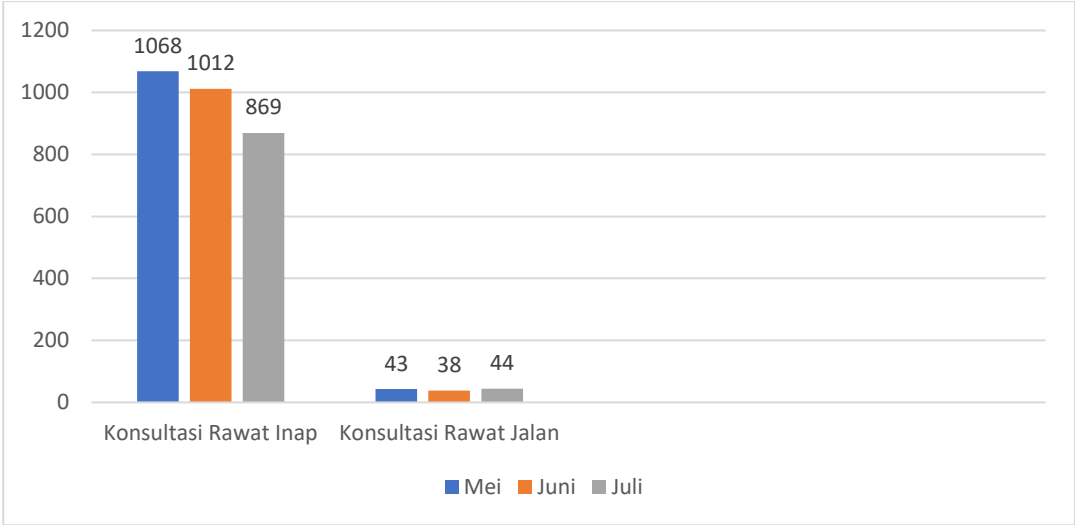
Jumlah pemesanan diet pasien rawat inap menurun seiring dengan menurunnya jumlah pasien di rawat inap. Jumlah pemesanan diet pada bulan Juli menurun 0,8% dibandingkan bulan Juni. Beberapa jenis diet yang menurun pada bulan Juli adalah diet DM, Rendah serat, TKTP, Rendah protein, rendah purin, rendah sisa, blender, dan bubur halus.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- Melakukan pemantauan jumlah pemesanan diet setiap bulan dan membandingkannya dengan tren BOR/pasien rawat inap.
 - Berkoordinasi dengan unit rawat inap dan ahli gizi untuk memastikan pemesanan diet sesuai indikasi dan kebutuhan pasien.
 - Melakukan evaluasi jenis diet yang mengalami penurunan untuk memastikan tidak terdapat kendala dalam proses pemesanan maupun pelayanan.
 - Menjaga ketersediaan bahan makanan sesuai kebutuhan aktual agar penggunaan bahan lebih efisien dan meminimalkan pemborosan.

2.4.5.3 Tabel Jumlah Konsultasi Gizi 2026

No.	Indikasi	Jumlah Pasien Mei 2026	Jumlah Pasien Juni 2026	Jumlah Pasien Juli 2026
1.	Konsultasi Rawat Inap	1068	1012	869
2.	Konsultasi Rawat Jalan	43	38	44

2.4.5.4 Jumlah Konsultasi Gizi pada 2026



Analisis :
Pada bulan Juli 2026, jumlah konsultasi gizi rawat inap sebanyak 869 pasien, menurun 143 pasien (14,13%) dibandingkan bulan Juni (1.012 pasien). Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya jumlah pasien rawat inap.
Sebaliknya, konsultasi gizi rawat jalan meningkat dari 38 pasien pada Juni menjadi 44 pasien pada Juli, atau naik 6 pasien (15,79%). Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan layanan konsultasi gizi di rawat jalan meskipun jumlahnya masih relatif lebih rendah dibandingkan konsultasi rawat inap.
Secara keseluruhan, pelayanan konsultasi gizi pada bulan Juli masih didominasi oleh pasien rawat inap, sementara layanan rawat jalan menunjukkan tren peningkatan.

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Melakukan pemantauan jumlah konsultasi gizi setiap bulan dan mengaitkannya dengan jumlah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan.
 - 2. Meningkatkan koordinasi dengan DPJP, perawat, dan unit pelayanan untuk memastikan pasien yang membutuhkan mendapatkan konsultasi gizi tepat waktu.
 - 3. Mengoptimalkan edukasi dan promosi layanan konsultasi gizi, terutama pada pasien rawat jalan yang berisiko atau memiliki penyakit kronis.
 - 4. Melakukan evaluasi tren konsultasi gizi secara berkala sebagai dasar perencanaan kebutuhan tenaga dan peningkatan mutu pelayanan.

2.4.5.5 Tabel Rekap Data Komplain Pasien Terhadap Gizi Bulan Juli 2026

No	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Mei 2026	Jumlah Komplain Bulan Juni 2026	Jumlah Komplain Bulan Juli 2026
1.	Benda asing dalam makanan pasien	1	0	0
	ISI KOMPLAINAN	(Tidak ada komplain)		
	Analisis	-		
	RTL	-		

2.4.5.6 Tabel Rekap *Food Waste* (Sisa Makanan) 2026

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan	
			Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026		
1.	Karbohidrat	Nasi	74,7	64,8	62,2	75,5% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat. Sisa KH pada bulan April 2026 meningkat 0,5% dari bulan Maret 2026. Perlu adanya evaluasi pemorsian KH pada menu pasien	
		Nasi Tim	91,7	90,6	83,4		
	Total		166,1	155,4	145,6		
2.	Snack	Roti Kukus	0	0	0	Untuk konsumsi snack di Prima Husada Malang pada bulan Juli tidak ada sisa yang kembali dari pasien diakarenakan pasien memindahkan snack yang masih ada kedalam wadah pribadi saat pengambilan alat makan snack pasien	
		Setup Pisang	0	0	0		
		Kacang Hijau	0	0	0		
		Kue Hongkong	0	0	0		
		Terang Bulan	0	0	0		
		Bubur Sagu	0	0	0		
		Kue Lumpur	0	0	0		
		Puding	0	0	0		
		Donat	0	0	0		
		Tahu Fantasi	0	0	0		
		Brule Bomb	0	0	0		
	Total		0	0	0		
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 11,7 Kg pada bulan Maret.	
	Bulan		Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026		
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	4,1	5,1	5,7		
		Rolade Ayam					
	Tambahan VIP	Tempe Goreng	3,8	4,9	5,4		
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)					
		Ayam Kecap					
		Tahu Bumbu Tomat					
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	3,7	3,8	4,2		
	Sore	Sup (Suun, wortel, polong, bakso)					
		Perkedel kentang ayam					
	Tambahan VIP	Ayam fillet panggang teflon	11,6	13,8	15,3		
	Total						
	2.	Menu 2					
		Bulan		Mei 2026	Juni 2026		Juli 2026
Pagi		Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	3,5	4,8	3,4		
		Tahu Rempah (Remet)					
		Abon					
Tambahan VIP		Telur Rebus					

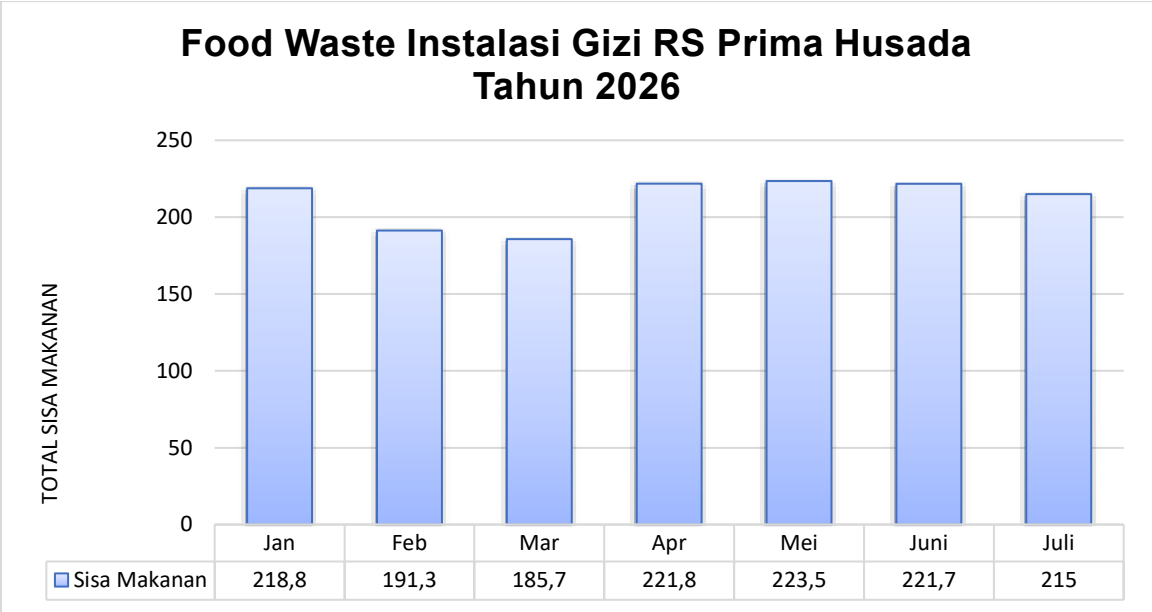
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)	3,7	6	4,1
		Ayam Wijen			
		Bakwan Jagung			
	Tambahan VIP	Telur Gulung			
	Sore	Capjae (wortel, sawi hijau, bunga kol, bakso)	3,3	5,3	3,9
		Telur dadar tebal			
	Tambahan VIP	Tempe goreng			
	Total		10,5	16,1	11,4
3.	Menu 3				
Bulan		Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026	
Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	3,7	6,5	4	
	Tahu Krispy				
	Abon				
Tambahan VIP	Telur Ceplok				
Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)	3,9	4,1	2,9	
	Rolade Ayam				
	Tahu Goreng				
Tambahan VIP	Tempe Bacem				
Sore	Sapo (tahu goreng, wortel, bakso,dedaunan, saos tiram)	3,9	3,7	3,9	
	Telur rebus				
Tambahan VIP	Tempe goreng				
Total		11,5	14,3	10,8	
4.	Menu 4				
Bulan		Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026	
Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	4,8	4,3	3,7	
	Tahu Nugget				
	Abon				
Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar				
Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	3,8	4,2	4,7	
	Ayam Kecap				
	Jamur Krispy				
Tambahan VIP	Tahu Bacem				
Sore	Fuyunghai (telur, wortel,daunan)sasu polong orang	4	3,8	4,6	

		Jamur goreng			
	Tambahan VIP	abon			
	Total		12,6	12,3	13
5.	Menu 5				
	Bulan		Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026
	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	4,5	3,9	3,2
		Opor Tahu			
		Oper Telur			
	Tambahan VIP	Tempe Goreng			
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	3,6	2,9	5,3
		Ayam Bombay			
		Bakwan Jagung			
	Tambahan VIP	Tahu Krispy			
	Sore	Soto ayam	2,8	3	4,5
		Telur rebus			
		VIP= Perkedel ayam			
	Total		10,9	9,8	13
	Total Sisa Menu tanpa KH		54,2	66,3	63,5
	Total Keseluruhan dengan KH		221,8	221,7	215

1.4.5.7 Tabel Rekap Food Waste Tahun 2026

No	Bulan	Total Sisa Makanan (kg)
1.	Januari 2026	218,8
2.	Februari 2026	191,3
3.	Maret 2026	185,7
4.	April 2026	221,8
5.	Mei 2026	223,5
6.	Juni 2026	221,7
7.	Juli 2026	215
8.	Agustus 2026	-
9.	September 2026	-
10.	Oktober 2026	-
11.	November 2026	-

1.4.5.8 Grafik Food Waste pada Bulan Tahun 2026



Analisis :
Pada bulan Juli 2026, total food waste tercatat 215 kg, menurun 6,7 kg (3,02%) dibandingkan bulan Juni (221,7 kg). Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam konsumsi makanan pasien atau peningkatan ketepatan penyajian porsi. Meskipun demikian, jumlah food waste masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan makanan, kesesuaian menu, dan tingkat sisa makanan pasien sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan gizi.

- Rencana Tindak Lanjut :**
1. Melakukan monitoring dan evaluasi food waste setiap bulan pada setiap jenis diet dan waktu makan.
 2. Mengidentifikasi penyebab sisa makanan melalui observasi dan umpan balik pasien terhadap rasa, variasi menu, dan porsi makanan.
 3. Berkoordinasi dengan DPJP, perawat, dan ahli gizi untuk menyesuaikan jenis diet serta porsi sesuai kondisi dan kemampuan makan pasien.
 4. Melakukan perbaikan menu dan penyajian secara berkelanjutan untuk menurunkan jumlah food waste serta meningkatkan kepuasan pasien.

1.4.7 CSSD – Laundry

1.4.7.1 CSSD

1.4.7.2 Tabel Jumlah Pemakaian Alat Sterilisasi 2026

No	Nama Alat	Jumlah Penggunaan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Memert	124	112	121	118	121	118	100					
2	Autoklaf	17	16	15	17	17	19	10					

Analisis:
Penggunaan Memert pada bulan Juni sebanyak 100 kali, sedikit menurun dibandingkan bulan Juni (118 kali) atau turun 15%, namun secara umum masih stabil. Penggunaan Autoklaf juga menurun dari 19 kali menjadi 10 kali (47,4%), menunjukkan penurunan kebutuhan sterilisasi.

Secara keseluruhan, penggunaan kedua alat masih stabil dan operasional alat berjalan dengan baik, namun tetap diperlukan pemeliharaan berkala untuk menjaga kinerja alat dan mencegah gangguan pelayanan.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan evaluasi terhadap penyebab penurunan penggunaan alat sterilisasi pada bulan Juli melalui penelusuran data pelayanan dan log penggunaan alat.
2. Memastikan seluruh kegiatan sterilisasi telah dicatat secara lengkap dan akurat pada buku maupun sistem pencatatan.
3. Melaksanakan pemeliharaan dan kalibrasi alat sterilisasi secara berkala agar alat selalu dalam kondisi optimal dan siap digunakan.

Tabel Jumlah permintaan alat steril dari unit perawatan Tahun 2026

NO	NAMA UNIT	Jumlah Penggunaan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	IKO	445	456	461	480	466	445	455					
2	IRJA	115	106	126	136	130	121	169					
3	IGD	106	121	121	129	101	101	75					
4	IRNA 2 A	1	-	1	1	5	2	7					
5	IRNA 3 A	1	1	1	2	1	0	0					
6	IRNA 4 A	2	3	4	4	5	5	16					
7	IRNA 6 A	5	3	4	5	8	6	3					
8	IRNA 7 A	9	9	9	11	10	6	5					
9	IRNA 8 A	8	7	3	8	5	2	4					
10	IRNA 2 C	2	2	2	3	2	4	1					
11	ICU/HCU	4	3	2	3	2	0	1					
12	IRNA 3 C	4	2	1	0	5	3	5					
13	IRNA 4C/MATER	178	171	189	197	126	110	84					
14	PERINA	65	46	55	57	34	85	52					
15	IRNA 5 C	4	3	3	2	1	2	2					
	JUMLAH	949	933	982	1038	901	892	879					

Analisis :

Jumlah penggunaan pada bulan Juli 2026 sebanyak 879 kali, mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan Juni (892 kali) atau turun 1,5%. Penggunaan tertinggi masih berasal dari IKO (455 kali), diikuti IRJA (169 kali) dan IRNA 4C/Mater (84 kali).

Terdapat penurunan signifikan pada unit Perina, yaitu dari 85 menjadi 52 kali (38,8%), sedangkan beberapa unit mengalami penurunan, terutama IRNA 4C/Mater dan IGD. Secara umum, utilisasi antar unit masih didominasi oleh unit pelayanan dengan jumlah pasien yang tinggi.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Melakukan monitoring rutin terhadap jumlah penyetoran alat dari setiap unit untuk mendeteksi perubahan pola penggunaan secara dini.
2. Berkoordinasi dengan unit yang mengalami penurunan signifikan, terutama IRNA 4C/Mater dan IGD, guna mengetahui penyebab penurunan serta memastikan kebutuhan sterilisasi tetap terpenuhi.
3. Memastikan seluruh unit melakukan pencatatan dan pengiriman alat kotor sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) agar data penggunaan lebih akurat.
4. Melaksanakan pemeliharaan dan uji fungsi alat sterilisasi secara berkala sehingga pelayanan sterilisasi tetap berjalan optimal meskipun terjadi peningkatan maupun penurunan beban kerja.
5. Menyusun laporan evaluasi penggunaan alat sterilisasi berdasarkan unit setiap bulan sebagai dasar perencanaan kebutuhan sumber daya, jadwal operasional, dan peningkatan mutu pelayanan CSSD.

Tabel Rekap Produksi Kassa dan Linen Steril Tahun 2026

No	Nama Produksi	Jumlah Produksi Kassa (Pouches)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
*	BAHAN BJ												
1	Kasa IKO	685	685	690	715	660	577	560					
2	Kasa Deapress	274	270	276	280	220	188	215					
3	Kasa Bigkass	134	166	133	134	132	101	100					
4	Kasa Tampon Hidung	20	20	20	20	20	0	5					
5	Kasa Tampon Roll	15	15	15	15	15	0	5					
*	BAHAN HIDROFIL												
1	Kasa Ruang	1081	1079	1310	1391	995	1515	1339					
*	LINEN STERIL												
1	Linen IKO	206	201	213	221	230	256	239					
2	Linen Mata	11	8	8	11	12	14	14					

Analisis:
Produksi kassa menunjukkan fluktuasi sesuai kebutuhan pelayanan. Kelompok Bahan BJ cenderung mengalami penurunan, terutama pada Kasa IKO, Kasa Deapress, dan Kasa Bigkass. Sebaliknya, Kasa Ruang (Bahan Hidrofil) mengalami peningkatan secara keseluruhan dan tetap menjadi produk dengan volume produksi tertinggi. Produksi Linen Steril juga menunjukkan tren meningkat dan relatif stabil. Secara umum, perubahan produksi masih sejalan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit dan perlu terus dipantau agar stok tetap optimal.
Secara umum, produksi disesuaikan dengan kebutuhan unit pelayanan dan pola penggunaan bahan steril.

- Rencana Tindak Lanjut:
1. Melakukan monitoring kebutuhan kassa steril dari setiap unit pelayanan sebagai dasar penyusunan jadwal produksi.
 2. Memastikan ketersediaan bahan baku dan bahan kemasan agar proses produksi berjalan tanpa hambatan.
 3. Mengevaluasi penyebab penurunan produksi beberapa jenis kassa pada bulan Juni–Juli untuk memastikan tidak disebabkan oleh kendala operasional.
 4. Menyesuaikan jumlah produksi dengan tren penggunaan sehingga tidak terjadi kekurangan maupun penumpukan stok.

1.4.7.2 Laundry

Tabel Jumlah Pencucian Linen 2026

No	Nama Alat	Jumlah Pencucian											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Infeksius	2496	2256	2278	2366	2189	2180	2185					
2	Non infeksius	2402	2309	2443	2480	2568	2374	2376					

Tabel Jumlah linen kotor setiap unit Tahun 2026

No	Nama Unit	Jumlah Penggunaan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AG T	SEP	OKT	NOV	DES
1	IKO	2.030	1869	1812	2005	1847	1712	2013					
2	IRJA	107	100	123	120	147	130	134					
3	IGD	173	175	232	240	224	181	156					
4	IRNA 2 A	155	143	165	193	177	106	146					
5	IRNA 3 A	80	55	14	127	15	27	14					
6	IRNA 4 A	248	247	247	269	261	217	200					
7	IRNA 6 A	172	164	182	167	180	135	146					
8	IRNA 7 A	166	155	187	158	179	160	146					
9	IRNA 8 A	191	168	171	198	170	186	168					
10	IRNA 2 C	280	248	193	201	246	239	239					
11	ICU	202	218	201	198	221	249	264					
12	IRNA 3 C	342	389	400	410	428	377	310					
13	MATERNITAS	425	356	382	390	341	380	470					
14	IRNA 5 C	232	183	195	196	241	256	201					
15	M.S	58	56	28	31	29	24	37					
16	Umum	9	7	24	9	14	41	34					
17	CSSD	13	7	11	11	9	12	9					
18	DAPUR/GIZ	9	7	6	6	5	10	9					
19	RAD	9	11	8	8	6	9	7					
20	LAB	8	7	6	7	7	9	9					

Analisa:

1. Pada bulan Juli 2026, jumlah pencucian linen infeksius sebanyak 2.185 kali, relatif stabil dibanding bulan Juni (2.180 kali) dengan kenaikan 5 kali (0,23%). Sementara itu, pencucian linen non infeksius sebanyak 2.376 kali, juga relatif stabil dibanding bulan Juni (2.374 kali) dengan kenaikan 2 kali (0,08%). Secara keseluruhan, aktivitas pencucian linen pada bulan Juli tetap terjaga dan menunjukkan kapasitas pelayanan laundry mampu memenuhi kebutuhan pencucian linen rumah sakit.
2. Pada bulan Juli, jumlah linen kotor terbanyak berasal dari IKO (2.013), diikuti Maternitas (470), IRNA 3C (310), dan ICU (264). Dibandingkan bulan Juni, terjadi peningkatan jumlah linen kotor di IKO, Maternitas, IRNA 2A, dan ICU, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas pelayanan pada unit tersebut. Sebaliknya, jumlah linen kotor menurun di IRNA 3C, IRNA 5C, IGD, dan IRNA 4A. Secara umum, distribusi linen kotor pada bulan Juli masih didominasi oleh unit dengan volume pelayanan tinggi, sehingga pengelolaan pengumpulan dan proses pencucian perlu tetap dijaga agar tidak terjadi penumpukan linen.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Melakukan monitoring jumlah linen kotor setiap unit secara berkala sebagai dasar perencanaan kapasitas kerja, kebutuhan bahan pencuci, dan pengaturan jadwal petugas laundry.
2. Melakukan evaluasi kesesuaian pemisahan linen infeksius dan non infeksius sejak proses pengumpulan di ruangan hingga pencucian guna mencegah terjadinya kontaminasi silang sesuai pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
3. Meningkatkan kepatuhan petugas terhadap SPO penanganan linen, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pencucian, pengeringan, hingga penyimpanan linen bersih, guna menjaga mutu pelayanan serta menurunkan risiko infeksi.
4. Melakukan analisis tren penggunaan linen pada unit dengan volume tertinggi seperti IKO, Maternitas, IRNA 3 C, dan ICU untuk mengetahui hubungan antara jumlah linen dengan jumlah pasien, tindakan operasi, maupun tingkat hunian tempat tidur (BOR).
5. Mengoptimalkan jadwal pengambilan linen kotor pada unit yang menghasilkan volume

tinggi agar tidak terjadi penumpukan linen di ruangan serta mempercepat proses pencucian dan distribusi linen bersih.

- 6. Melakukan koordinasi rutin dengan kepala ruangan apabila terjadi peningkatan jumlah linen secara signifikan, sehingga kebutuhan linen bersih dapat dipersiapkan tanpa mengganggu pelayanan.

Tabel Pemakaian Chemical Laundry Tahun 2026

No	Nama Chemical	Jumlah Penggunaan											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Clax built lite	1	1	2	2	1	1	1					
2	CLAX 100	1	1	2	2	1	1	1					
3	CLAX sonril	1	1	1	2	1	1	1					
4	CLAX neutral	1	1	1	2	1	1	1					
5	CLAX soft	1	1	1	1	1	1	1					
6	Snapy	15 L	0	5	15 L	20 L	15 L	0					
7	Rapika	14 pcs	28 pcs	20 pcs	15 pcs	0 L	0 L	15 pcs					
8	Bayklin	15 L	17 L	16 L	18 L	14 L	13 L	14 L					
9	Softener	0	0			10 L	10 L	10 L					
10	Liquid matic	30 L	30 L	33 L	20 L	11,2 L	10 L	10 L					

Analisa:
Pada bulan Juli 2026, penggunaan chemical laundry secara umum stabil dibanding bulan sebelumnya. Chemical utama (Clax Built Lite, Clax 100, Clax Sonril, Clax Neutral, dan Clax Soft) masing-masing digunakan 1 kemasan, menunjukkan kebutuhan yang konsisten. Penggunaan Bayklin (14 L) dan Softener (10 L) juga relatif stabil, sedangkan Liquid Matic tetap 10 L. Selain itu, penggunaan Rapika kembali meningkat menjadi 15 pcs setelah tidak digunakan pada bulan Juni, sementara Snapy tidak digunakan pada bulan Juli. Secara keseluruhan, penggunaan chemical masih sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan laundry.

- Rencana tindak Lanjut:
- 1. Melakukan monitoring dan pencatatan penggunaan chemical secara rutin untuk memastikan pemakaian sesuai standar kebutuhan pencucian linen.
 - 2. Melakukan monitoring penggunaan setiap jenis chemical setiap bulan dan membandingkannya dengan jumlah linen yang dicuci untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan bahan kimia.
 - 3. Menyusun rencana pengadaan berdasarkan rata-rata konsumsi bulanan sehingga ketersediaan bahan kimia tetap terjaga tanpa menyebabkan kelebihan stok maupun kekosongan persediaan.
 - 4. Melakukan evaluasi terhadap fluktuasi penggunaan Snapy, Rapika, dan Liquid Matic untuk memastikan perubahan penggunaan disebabkan oleh kebutuhan operasional dan bukan akibat pemborosan atau kesalahan pencampuran.
 - 5. Memastikan penggunaan seluruh bahan kimia sesuai dengan dosis dan petunjuk penggunaan dari produsen serta Standar Operasional Prosedur (SPO) laundry agar kualitas pencucian tetap optimal dan biaya operasional lebih efisien.

4.4 Kinerja Bidang Umum

1.4.1 SDM

Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	Profesi Ners	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Casemix Manager	SMK	1	1	1	0	0
7	Farmasi	Profesi Apoteker	39	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		22	14	8	0
		SMK		0	0	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
8	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0
9	CSSD	D3 Keperawatan	3	2	1	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		0	0	0	0
10	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
11	Gizi	S1 Ilmu Gizi	14	1	1	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		1	1	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
12	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
13	ICU dan HCU	Profesi Ners	10	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		4	2	2	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
14	IGD	Profesi Ners	23	10	8	2	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
15	IKO	Profesi Ners	11	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
16	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
17	IPSRs	S1 Tenik Elektro	6	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0

18	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	0	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
19	IRNA 2C	Profesi Ners	7	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
20	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	17	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		9	6	3	0
21	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	12	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
22	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	1	2	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
23	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	22	9	4	5	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
24	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
25	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
26	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	8	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
27	Laboratorium	D4 Analisis Kesehatan	9	1	0	1	0
		D3 Analisis Kesehatan		8	6	2	0
28	Laundry	SMK	5	2	1	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
29	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
30	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	12	0	0	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		0	0	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	5	1	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
31	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
32	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
33	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
34	SDM	S1 Sosial	1	1	1	0	0
35	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
36	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
37	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0

38	Cleaning Service	SMK	40	12	7	5	1
		SMA		23	18	5	1
		SMP		5	5	0	0
39	Security	SMK	10	4	2	2	0
		SMA		6	6	0	0
40	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
41	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
42	Staf Orientasi	SMK	6	2	0	2	0
		D3 TVF		1	0	1	0
		D3 Perawat Gigi		1	0	1	0
		D3 Gizi		1	0	1	0
		D4 Dizi		1	0	1	0
Total Karyawan			362	362	268	94	2
43	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	1
44	Dokter Casemix	Dokter Umum	2	2	0	2	1
45	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	1	3	0
46	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
47	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
48	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
49	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
50	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
54	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
56	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
57	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
58	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
61	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
62	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
63	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
67	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
68	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total Dokter			64	64	2	62	2
Total Keseluruhan			426	426	270	156	4

Keterangan :
Pada bulan Juli terdapat 2 staf dan 2 dokter resign.

3.5.1.1 Update STR / SIP

NO	NAMA	PROFESI	TANGGAL KEJADIAN	KETERANGAN
1	Najiyyatul Fithriyyah, S.Tr.Gz	Ahli Gizi	17/07/2026	SIP Baru
2	Fella Pancarani, S. Kep., Ns	Perawat	22/07/2026	SIP Perpanjangan
3	Mila Zeni Wulandari, Amd. Kes	Perawat Gigi	20/07/2026	SIP Baru

Keterangan :
Pada bulan April 2026 terdapat 3 SIP baru yang terbit.

3.5.1.2 Rekrutmen

NO	PROFESI	JUMLAH YANG DIBUTUHKAN	TERPENUHI	KEKURANGAN	PENYEBAB	RENCANA TINDAK LANJUT
1	Terapi Okupasi	1	0	1	Sulit mencari kandidat terapis okupasi	Menghubungi sosial media komunitas terapis okupasi, menghubungi kampus dengan jurusan terapis okupasi
2	Dokter Spesialis Bedah Mulut	1	0	1	Sulit mencari kandidat Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	Menghubungi kampus dengan jurusan tersebut
3	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1	Belum mendapatkan kandidat	Dibutuhkan yang Perempuan
5	Security	2	1	1	Sudah mendapatkan dan sudah masuk di awal juli	Rekrutmen pengganti satpam resign sudah dilakukan dan kandidat akan masuk awal Juli.

3.5.1.3 Orientasi Staf Baru

3.5.1.3.1 Orientasi Staf

NO	TANGGAL	JENIS ORIENTASI	NAMA STAF	PENDIDIKAN	PROFESI	SPMJ (TANGGAL MASUK)	KETERANGAN
1	01 Mei 2026 – 31 Juli 2026	Khusus	Putri Sofiana Sari, Amd. Farm	D3	TVF	01 Mei 2026	Penempatan Farmasi
2	01 Juni 2026 – 31 Agustus 2026	Khusus	Mila Zeni Wulandari, Amd. Kes	D3	Perawat Gigi	01 Juni 2026	Penempatan IRJA
3	01 Juni 2026 – 31 Agustus 2026	Khusus	Najiyyatul Fithriyyah, S.Tr. Gz	D4	Ahli Gizi	01 Juni 2026	Penempatan Gizi
4	06 Juni 2026 – 05 September 2026	Khusus	Nurdyna Zahro Latifa, Amd. Gz	D3	Ahli Gizi	06 Juni 2026	Penempatan Gizi
5	01 Juni 2026 – 31 Agustus 2026	Khusus	Rizqi Anugrah Akbar	SMK	Security	01 Juni 2026	Penempatan Security
6	01 Juli 2026 – 30 September 2026	Khusus	M. Verry Hermawan	SMK	Security	01 Juli 2026	Penempatan Security

Keterangan : Pada bulan Juli 2026 ada 6 staf dengan orientasi khusus

3.5.1.4 Diklat

NO	JUDUL DIKLAT	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		TANGGAL PELAKSANAAN	SERTIFIKAT		HASIL EVALUASI DALAM KINERJA SEHARI-HARI	
			HADIR	TIDAK HADIR		ADA	TIDAK	PATUH	TIDAK PATUH
1	BONELS	Eksternal	2		25-30 Juli 2026	v		V	

Keterangan:
Pada bulan Juli 2026 belum ada diklat yang dilaksanakan di RS Prima Husada Malang.

3.5.1.5 Evaluasi Kinerja Staf

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
1	Direktur	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Direktur secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
2	Kabid Pelayanan Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Pelayanan Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
3	Kabid Penunjang Medis	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Kabid Penunjang Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
5	Kabid Umum	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Kabid Umum & Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
6	Casemix Manager	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Satuan Pengawas Internal secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
7	Farmasi	Umum	39	0	7	28	5	0	Unit Farmasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
8	Asuransi Center	Umum	10	0	3	7	0	0	Unit Asuransi Center secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
9	CSSD	Umum	3	0	2	1	0	0	Unit CSSD secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
10	Fisioterapi	Umum	5	0	0	2	3	0	Unit Fisioterapi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
11	Gizi	Umum	14	0	9	5	0	0	Unit Gizi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
12	Humas & Marketing & PKRS	Umum	2	0	0	2	0	0	Unit Humas Markrting & PKRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
13	ICU dan HCU	Umum	10	0	7	3	0	0	Unit ICU & HCU secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
14	IGD	Umum	23	0	10	13	0	0	Unit IGD secara keseluruhan mendapatcatatan baik dalam penilaian kinerja umum.
15	IKO	Umum	11	0	8	3	0	0	Unit IKO secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
16	IPCN	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit IPCNsecara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
17	IPSRS	Umum	6	0	3	3	0	0	Unit IPSRS secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

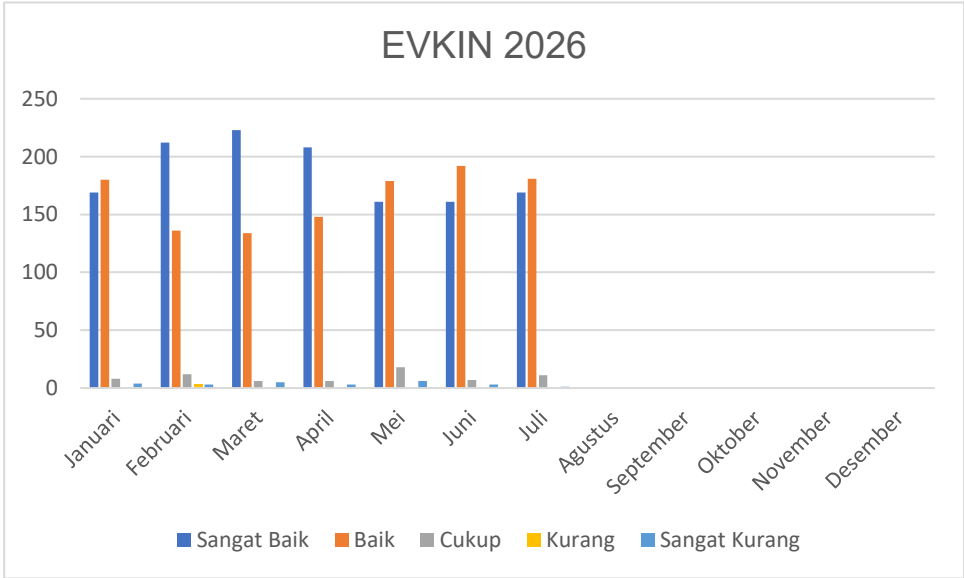
NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
18	IRJA	Umum	27	0	23	4	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
18	IRNA 2C	Umum	7	0	2	5	0	0	Unit IRNA 2C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
19	IRNA 2A, 3A, & 4A	Umum	18	0	11	7	0	0	Unit IRNA 234A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
20	IRNA 3C Anak	Umum	12	0	7	5	0	0	Unit IRNA 3C Anak secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
21	IRNA 5C	Umum	9	0	0	8	1	0	Unit IRNA 5C secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
22	IRNA 6A, 7A, & 8A	Umum	21	0	10	10	1	0	Unit IRNA 6A, 7A & 8A secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
23	Maternitas	Umum	10	0	5	5	0	0	Unit Maternitas secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
24	Neonatologi	Umum	8	0	6	2	0	0	Unit Neonatologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
25	Keuangan & Akuntansi	Umum	8	0	1	7	0	0	Unit Keuangan secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
26	Laboratorium	Umum	8	0	1	7	0	0	Unit Laboratorium secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
27	Laundry	Umum	5	0	2	3	0	0	Unit Laundry secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
28	Rekam Medis	Umum	7	0	3	4	0	0	Unit Rekam Medis secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
29	Pendaftaran	Umum	12	0	2	9	1	0	Unit Pendaftaran secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
30	PIPP & MPP	Umum	4	0	0	2	2	0	Unit PIPP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum. Terdapat 1 staf dengan evaluasi kinerja sangat kurang dikarenakan cuti melahirkan.
31	PMKP	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Mutu & PMKP secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
32	Radiologi	Umum	6	0	5	1	0	0	Unit radiologi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
33	SDM	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit SDM secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
34	Sekretaris	Umum	1	0	1	0	0	0	Unit Sekretaris secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
35	SIMRS & IT	Umum	3	0	0	1	2	0	Unit IT SIMRS secara

NO	UNIT	PENILAIAN KINERJA	CATATAN KHUSUS		HASIL EVALUASI				KESIMPULAN
			Baik	Jelek	SB	B	C	K	
									keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
36	Umum & Rumah Tangga	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit IRJA secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
37	Cleaning Service	Umum	40	0	18	19	3	1	Unit Cleaning Service secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
38	Security	Umum	10	0	8	2	0	0	Unit Security secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
39	Driver	Umum	6	0	4	1	1	0	Unit Driver secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
40	Gudang Umum	Umum	1	0	0	1	0	0	Unit Gudang Umum secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.
41	Staf Orientasi	Umum	6	0	0	6	0	0	Staf orientasi secara keseluruhan mendapat catatan baik dalam penilaian kinerja umum.

Analisis :
 Hampir seluruh unit di RS Prima Husada Malang berada pada kategori Sangat Baik pada penilaian umum periode Juli 2026.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.7.1 Grafik Evaluasi Kinerja Karyawan



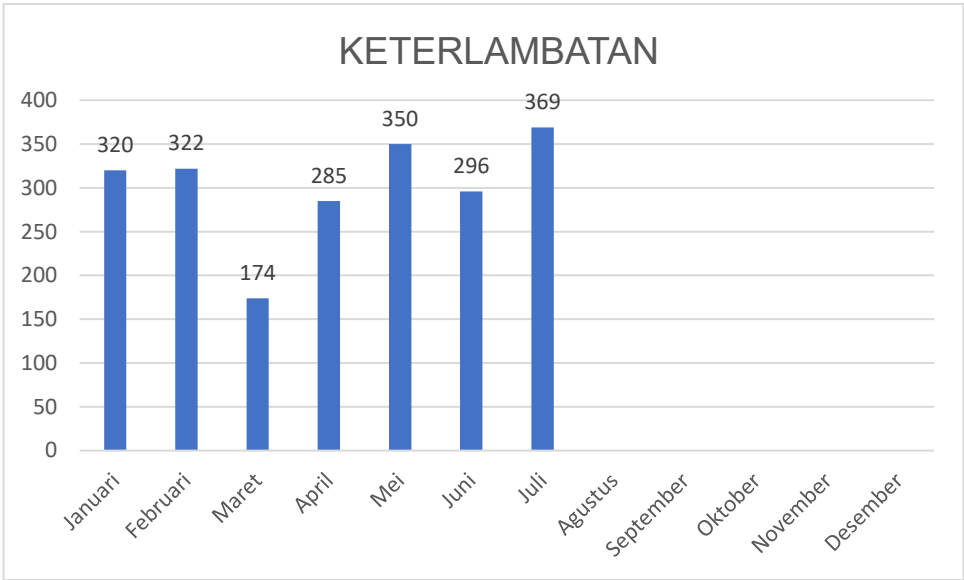
Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Sangat Baik	169	212	223	208	161	161	169					
Baik	180	136	134	148	179	192	181					
Cukup	8	12	6	6	18	7	11					
Kurang	0	3	0	0	0	0	0					
Sangat Kurang	4	3	5	3	6	3	1					
TOTAL	361	366	368	365	364	363	362					

Analisa :
Secara umum terdapat kenaikan kategori sangat baik.

- Rencana Tindaklanjut :**
- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 - 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 - 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.
 - 4. Membuat diklat dengan konsep baru sesuai arahan PT

Tabel Keterlambatan Karyawan

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
KETERLAMBATAN	320	322	174	285	350	296	369					



Analisa :
Secara umum terdapat peningkatan jumlah keterlambatan pada bulan ini

- Rencana Tindak Lanjut :**
- 1. Sosialisasi kepada Karu dan Kabid untuk mengingatkan kembali kepada stafnya.
 - 2. Melakukan tahapan teguran sesuai taat tertib yang berlaku.
 - 3. Mempertahankan kinerja staf terkait kedisiplinan.

3.5.1.6 Konseling

3.5.1.6.1 Tabel Capaian Konseling

NO	UNIT	JUMLAH KONSELING GRUP	JUMLAH KONSELING INDIVIDU					
			KONTRAK N-ED	TERKAIT TATA TERTIB	TERKAIT KETIDAKPATUHAN MUTU	TERKAIT KETIDAKPATUHAN PPI	TERKAIT MANRISK	KARIR
1	Manajerial RS	0	0	0	0	0	0	0
2	SDM	0	0	0	0	0	0	0
3	Asuransi Center	0	0	0	0	0	0	1
4	IRNA 2C	0	0	0	0	0	0	0

5	IRNA 3C Anak	0	0	0	0	0	0	0
6	IRNA 3A & 4A	0	0	0	0	0	0	0
7	IRNA 5C	0	0	0	0	0	0	0
8	IRNA 6A & 7A	0	0	0	0	0	0	0
9	Maternitas	0	0	0	0	0	0	1
10	Neonatologi	0	0	0	0	0	0	0
11	IGD	0	0	0	0	0	0	1
12	ICU	0	0	0	0	0	0	0
13	HCU	0	0	0	0	0	0	0
14	IKO	0	0	0	0	0	0	0
15	Gizi	0	0	0	0	0	0	0
16	Farmasi	0	0	0	0	0	0	1
17	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0
18	Radiologi	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medis	0	0	0	0	0	0	1
20	Pendaftaran	0	0	0	0	0	0	0
21	CSSD	0	0	0	0	0	0	0
22	Laundry	0	0	0	0	0	0	0
23	Keuangan & Akuntansi	0	0	0	0	0	0	0
24	PIPP	0	0	0	0	0	0	0
25	MPP	0	0	0	0	0	0	0
26	Umum Cleaning Service	0	0	0	0	0	0	0
27	SIMRS	0	0	0	0	0	0	0
28	DRIVER	0	0	0	0	0	0	0
29	Security	0	0	0	0	0	0	1
30	IRJA	0	0	0	0	0	0	1
31	Rehab Medik	0	0	0	0	0	0	0
32	Kasir Parkir	0	0	0	0	0	0	0
33	Parkir	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	7

Analisis :
 Konseling staf dilaksanakan sesuai kebutuhan

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi

3.5.1.6.1 Supervisi

Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Supervisi (2x/bulan)	0	0	0	0	0	0	0					

Analisaais:
 Belum dilakukan

Rencana Tindak Lanjut :
 Lebih ditingkatkan supervisi ke tiap unit khususnya unit dengan tingkat temuan banyak.

3.5.1.7 Mutasi

Tabel Daftar Staf Mutasi

NO	NAMA STAF	UNIT ASAL	UNIT BARU
-	-	-	-

Analisis : Pada bulan Juni 2026 tidak terdapat rotasi di unit SDM

3.5.2 IPSRS

3.5.2.1 Pemeliharaan Alat Medis

Perhitungan capaian berdasarkan jumlah kunjungan per unit oleh elektromedis ke unit-unit di rumah sakit (33 unit) dalam satu bulan

3.5.2.1.1 Tabel Capaian Maintenance Alat Medis

	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Capaian Maintenance Ruangan		58,97%	82,05%	64,10%	72%	92.3%	79,49%	74,36%					

BULAN	TOTAL ALAT	CAPAIAN	PROSENTASE
Januari	276	119	43,12%
Februari	276	138	50%
Maret	276	124	44,93%
April	276	112	41%
Mei	276	195	70.65%
Juni	276	134	48,55%
Juli	276	148	53,62%
Agustus			
September			
Oktober			
November			

TOTAL ALAT (PERBAIKAN)	TOTAL ALAT
Januari	8
Februari	16
Maret	13
April	16
Mei	22
Juni	19
Juli	8
Agustus	
September	
Oktober	
November	

Analisa : Pada bulan ini capaian adalah 74,36% untuk ruangan turun dari bulan sebelumnya dan 53,62%untuk capaian per jumlah alat masih relative terkondisikan.

Rencana Tindak Lanjut :
Koordinasi dengan PT untuk rekrutmen ATEM sesuai ABK (tidak ada pemenuhan rekrutmen)

3.5.2.2 Pemeliharaan Alat Non Medis

3.5.2.2.1 Air Conditioner

3.5.2.2.1.1 Tabel Capaian Pemeliharaan AC Split

BULAN	CAPAIAN	TARGET	PROSENTASE
JAN-26	25	64	39.06%
FEB-26	40	64	62.50%
MAR-26	27	64	42.19%
APR-26	2	64	3.13%
MEI-26	45	64	70.03%
JUNI-26	59	64	92.18%
JULI 26	0	64	0%

Analisa :
Pemeliharaan tidak ada pemeliharaan ac di bulan juli,karena alat cuci ac masih dalam proses perbaikan di service center (garansi)

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

1.5.2.2.3 Genset

1.5.2.2.3.1 Tabel Capaian Pemeliharaan Genset

NO	BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	5x/bulan	3x/bulan	60%	Belum mencapai target
2	Februari	5x/bulan	4x/bulan	80%	Belum mencapai target
3	Maret	5x/bulan	3x/bulan	60%	Belum mencapai target
4	April	5x/bulan	4x/bulan	80%	Belum mencapai target
5	Mei	5x/bulan	3x/bulan	60%	Belum mencapai target
6	Juni	5x/bulan	3x/bulan	60%	Belum mencapai target
7	Juli	5x/bulan	3x/bulan	60%	Belum mencapai target
8	Agustus	5x/bulan			
9	September	5x/bulan			
10	Oktober	5x/bulan			
11	November	5x/bulan			

Analisis :
Pada bulan ini, pemeliharaan genset dilakukan 3x dan sudah terdokumentasi dengan baik. Bulan Juni Intensitas kerja genset lebih banyak karena ada 4x pemadaman dengan durasi waktu kisaran 3 jam
Pengecekan dan penggantian part genset di rencana kan bulan juli 2026.
Konfirmasi ulang ke PT DPM untuk renovasi rumah genset.karena sirkulasi udara tidak baik saat genset operasional.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi berkala
Melalui link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/110WG4QS8bLSVMEPsinZvqSZrNmPuELgYBKbs_oUd89Eo/edit?gid=2003963143#gid=2003963143

1.5.2.2.4 Panel Listrik

3.7.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Panel

Bulan	Jumlah Target (satu bulan)	Capaian	Prosentase	Keterangan
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	3x/bulan	75%	Belum mencapai target
Mei	4x/bulan	1x/bulan	25%	Belum mencapai target
Juni	4x/bulan	2x/bulan	50%	Belum mencapai target
Juli	4x/bulan	1x/bulan	25%	Belum mencapai target
Agustus	4x/bulan			
September	4x/bulan			
Oktober	4x/bulan			
November	4x/bulan			
Desember	4x/bulan			

Analisis :

1. Pemeliharaan panel listrik di Gedung A,B,C,D dilakukan 4x dalam satu bulan dan dilakukan rekapan dokumentasi.
2. Seringnya pemadaman pln di bulan Juni,jadi Monitoring panel berkurang karea fokus pada operasional dan monitoring genset.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

1. Link Pemeliharaan Panel Gedung A
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K3AmeFpNj9z9LRM1HECH586kvHODUBC2dxtMaMTx1WQ/edit?gid=1843933243#gid=1843933243>
2. Link Pemeliharaan Panel Gedung B
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wHFESDvzTLN0KBqURQnOMLsTCiqXqpLWCMAG6OMZK7k/edit?gid=1243237048#gid=1243237048>
3. Link Pemeliharaan Panel Gedung C
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg3l7_SLF6JsafyAZHxZKoPBLPgAbgEV92qYIFZj4M/edit?gid=183386497#gid=183386497
4. Link Pemeliharaan Panel Gedung D
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fi662P7GKprEiZdfb8deF4N2QJmVQGokfuJtxTLk8DQ/edit?gid=462403140#gid=462403140>

5. Link Pemeliharaan Panel Gedung E
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pBsP-cAEM1iC5zDKXn4KuGJAYz1vEbGXE73obF9jQ80/edit?gid=0#gid=0>
6. Link Pemeliharaan Panel LVMDP
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HH5lmQzu3mwtuMa1Qj72tGD5eDJHUXIzD63VM4gWdNQ/edit?gid=0#gid=0>

1.5.2.2.5 Liquid Oksigen

1.5.2.2.5.1 Tabel Pencatatan Liquid Harian

Juli 2026							
Tanggal	Stok Liquid	Sebelum pengisian	Penggunaan	Satuan	Keterangan	Pengiriman	Satuan
01/07/2026	2194	1933	261	MMHG			MMHG
02/07/2026	1933	1388	545	MMHG			MMHG
03/07/2026	1388	3388	0	MMHG	sesudah pengisian	2000	MMHG
03/07/2026	3388	3320	68	MMHG			MMHG
04/07/2026	3320	2912	408	MMHG			MMHG
05/07/2026	2915	2773	142	MMHG			MMHG
06/07/2026	2773	2480	293	MMHG			MMHG
07/07/2026	2480	2195	285	MMHG			MMHG
08/07/2026	2195	1898	297	MMHG			MMHG
09/07/2026	1898	1393	505	MMHG			MMHG
10/07/2026	1393	3357	0	MMHG	sesudah pengisian	1064	MMHG
10/07/2026	3357	3289	68	MMHG			MMHG
11/07/2026	3289	2964	325	MMHG			MMHG
12/07/2026	2964	2670	294	MMHG			MMHG
13/07/2026	2670	2387	283	MMHG			MMHG
14/07/2026	2387	1995	392	MMHG			MMHG
15/07/2026	1995	1412	583	MMHG			MMHG
16/07/2026	1412	3334		MMHG	sesudah pengisian	1922	MMHG
16/07/2026	3334	3320	14	MMHG			MMHG
17/07/2026	3320	2956	364	MMHG			MMHG
18/07/2026	2956	2773	183	MMHG			MMHG
19/07/2026	2773	2460	313	MMHG			MMHG
20/07/2026	2460	2176	284	MMHG			MMHG
21/07/2026	2176	1903	273	MMHG			MMHG
22/07/2026	1903	1606	297	MMHG			MMHG
23/07/2026	1606	1306	300	MMHG			MMHG
24/07/2026	1306	3339	0	MMHG	sesudah pengisian	2033	MMHG
24/07/2026	3339	3154	185	MMHG			MMHG
25/07/2026	3154	2875	279	MMHG			MMHG
26/07/2026	2875	2602	273	MMHG			MMHG
27/07/2026	2602	2333	269	MMHG			MMHG
28/07/2026	2333	1770	563	MMHG			MMHG
29/07/2026	1770	1504	266	MMHG			MMHG
29/07/2026	1504	3341		MMHG	sesudah pengisian	1837	MMHG
30/07/2026	3341	3154	187	MMHG			MMHG
31/07/2026	3154	3030	124	MMHG			MMHG

Jumlah total pemakaian oksigen bulan ini			8049	MMHG			MMHG
Jumlah total pengisian liquid oksigen bulan ini						6856	MMHG
Rata-rata penggunaan oksigen per hari			564.3461538	MMHG			
Rata- rata pengisian liquid per bulan ini						2742.4	MMHG

Analisis :
 Kegiatan sudah dilakukan dengan baik sesuai target, setiap hari dilakukan pengecekan. Stok oksigen selalu terjaga.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan Evaluasi

1.5.2.2.6 IPAL

1.5.2.2.6.1 Tabel Capaian Pemeliharaan IPAL

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	1x/bulan			
September	1x/bulan			
Oktober	1x/bulan			
November	1x/bulan			

Analisis :
 Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan. Pencatatan debit IPAL juga dilakukan dan di dokumentasikan.

Rencana Tindak Lanjut :
 Monitoring dan evaluasi melalui link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yuzd_v1pO6Q2IDQr5clmEvCF-S-0EF2VI8LY_e93IQE/edit?gid=342425059#gid=342425059

1.5.2.2.7 Filter Air

3.7.3 Tabel Capaian Pemeliharaan Filter Air

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target

Juli	8x/bulan	8x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus	8x/bulan			
September	8x/bulan			
Oktober	8x/bulan			
November	8x/bulan			

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1utB1tcauU1Xi-rY4On3PymLDuNIIV0egQRdVkhgSayw/edit?gid=392489547#gid=392489547>

1.5.2.2.8 Lift

1.5.2.2.8.1 List Lokasi Lift

NO	LOKASI	KONDISI
1	Lift Gedung A Pasien	Baik
2	Lift Gedung A Pengunjung	Baik
3	Lift Gedung B	Baik
4	Lift Gedung C Umum	Baik
5	Lift Gedung C Karyawan	Baik
6	Lift Gedung D (Garansi)	Baik

1.5.2.2.8.2 Tabel Capaian Pemeliharaan Lift

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	1x/bulan	1x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus				
September				
Oktober				
November				

Desember				
----------	--	--	--	--

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-qMBqK_KT7GLwypkDMOm-X2vb5cPjVV/edit?gid=730491017#gid=730491017

1.5.2.2.9 UPS
1.5.2.2.9.1 Tabel Capaian Pemeliharaan UPS

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Juli	4x/bulan	4x/bulan	100%	sudah mencapai target
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisis :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W11Uen83_wiMyVk-BL2oB4Nc24b7pgBOk6Lufn7skng/edit?usp=sharing

1.5.2.2.10 Air Minum

NAMA	LOKASI	KONDISI
Instalasi Air Minum 1	Lantai 1 Gedung C	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	1x/bulan	25%	sudah mencapai target
Februari	4x/bulan	1x/bulan	25%	sudah mencapai target
Maret	4x/bulan	1x/bulan	25%	sudah mencapai target
April	4x/bulan	1x/bulan	25%	sudah mencapai target
Mei	4x/bulan	1x/bulan	25%	sudah mencapai target
Juni	4x/bulan	1x/bulan	25%	sudah mencapai target
Juli	4x/bulan	1x/bulan	25%	Belum mencapai target
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisa :
Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
RTL :
monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.11 Filter Air Bersih Poli Gigi 1 dan Poli Gigi 2

NAMA	LOKASI	KONDISI
Filter Air Bersih Poli Gigi 1	Lantai 2D	Baik
Filter Air Bersih Poli Gigi 2	Lantai 2D	Baik

BULAN	JUMLAH TARGET (SATU BULAN)	CAPAIAN	PROSENTASE	KETERANGAN
Januari	4x/bulan	100%	sudah mencapai target	4x/bulan
Februari	4x/bulan	100%	sudah mencapai target	4x/bulan
Maret	4x/bulan	100%	sudah mencapai target	4x/bulan
April	4x/bulan	100%	sudah mencapai target	4x/bulan
Mei	4x/bulan	100%	sudah mencapai	4x/bulan

			target	
Juni	4x/bulan	100%	sudah mencapai target	4x/bulan
Juli				
Agustus				
September				
Oktober				
November				
Desember				

Analisa :
 Pelaksanaan sudah sesuai target dan di dokumentasikan
 RTL :
 monitoring dan evaluasi melalui link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aMBnSKVuoMC4Z1Wj1dya_t19f-XM272Mf0hcWAsBak4/edit?gid=0#gid=0

1.5.2.2.12 Rekapn Kegiatan External

Bulan	Jumlah Kegiatan	Waktu yang Dibutuhkan
Januari	19	47 jam 27 menit
Februari	12	37 jam 7 menit
Maret	15	33 jam 47 menit
April	12	24 jam 9 menit
Mei	6	14 jam 14 menit
Juni	14	38 Jam 9 Menit
Juli	27	63 jam 31 menit
Agustus		
September		
Oktober		
November		
Desember		

DATE	TIME	URAIAN PEKERJAAN	UNIT AREA	PETUGAS	SELESAI	HASIL	JAM	MENIT
02/07/2026	14:30	instalasi listrik untuk pompa air di rumah dr endi	Rumah dr. Endi	Dian T	15:30	selesai	1	
04/07/2026	10:30	pengambilan closet dana lampu taman di kri batu	Rumah dr. Endi	Dian T	13:30	selesai	3	
03/07/2026	07:36	perbaikan mikroskop	kllinik ptp	Salma GP	08:30	progres lanjutan	1	6
04/07/2026	08:30	perbaikan mikroskop	kllinik ptp	Salma GP	09:45	selesai	1	15
06/07/2026	18:21	tambal ban sepeda listrik pak dokter sadi			19:30	selesai		29
07/07/2026	10:31	regulator gas roster ngewes			13:38	ganti regulator baru	2	
07/07/2026	11:23	highdpeed tidak berputar	kllinik bedali	M Arifin	13:00	service kerak	1	17
07/07/2026	14:15	perbaikan pipa ac yg pecah	kllinik ptp	Dian T, Yonatan d	15:13	perbaikan shok pipa	1	12
07/07/2026	15:45	perbaikan pompa air rumah dr endi			17:00	selesai	2	
10/07/2026	08:00	pengembalian mobile xray	rsphs	Dian T	12:00	selesai	4	

10/07/2026	12:00	kirim scaffolding, pemasangan lampu, pemasangan panel pompa set rumah dr endi		Dian T	17:00	selesai	5	
11/07/2026	08:41	pemasangan lampu lt 2 dan pompa rumah dr endi		Dian T, Yonatan d	16:30	selesai	8	30
14/07/2026	15:00	pemasangan 2 unit heater dan showcase	Gudang upi	Dian T, Yonatan d	17:45	selesai	2	45
14/07/2026	19:00	kirim bed tindakan dan sketsel	klinik karlos	Dian T, Yonatan d	21:00	selesai	2	
17/07/2026	14:30	perbaikan lampu dan saklar dental	klinik ptp	M Arifin	16:30	selesai	2	
17/07/2026	16:45	perbaikan highspped, treway dan scaller	klinik bedali	M Arifin	20:00	selesai	3	45
21/07/2026	16:00	instalasi listrik pompa baru	Gudang upi	Dian T	17:00	selesai	1	
22/07/2026	16:20	kirim perlengkapan ac dan pompa	Gudang upi	Dian T	17:30	selesai	1	10
23/07/2026	12:50	pengambilan bbarang dan tukar mobil traga	rsphs	Dian T	13:30	selesai	1	20
23/07/2026	13:45	kirim barang dari phs ke upi	Gudang upi	Dian T	15:30	selesai	2	
23/07/2026	18:57	menurun barang dari rsdh	Gudang upi	Tulus j, Yonatan d	19:33	selesai	2	
24/07/2026	09:00	pemasangan pompa dan kabel sensor	Gudang upi/mbg	Dian T	14:00	selesai	5	
28/07/2026	14:30	pengecekan pompa ro dan ganti filter ro	Gudang upi/mbg	Dian T, Yonatan d	15:30	selesai	1	
29/07/2026	15:30	perbaikan ac poli gigi, hall ptp, tindakan poli	klinik ptp	Dian T, Yonatan d	19:30	selesai	4	
29/07/2026	19:45	perbaikan ac server, poli kia,	klinik bedali	Dian T, Yonatan d	20:30	selesai		45
30/07/2026	08:30	perbaikan highspped poli gigi	klinik bedali	M Arifin	10:30	selesai	2	
30/07/2026	10:45	pengecekan kompresor poli gigi	klinik ptp	M Arifin	12:30	selesai	1	274
TOTAL JAM DINAS LUAR							58	319
PEMBULATAN							63	31
ENAM PULUH TIGA JAM 31 MENIT								

Keterangan :
Total 63 jam 31 menit untuk perbantuan eksternal.

Rekapan link : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9Y3r4WUcch1rpMPxi3-kN2P5nlyuxZi/edit?gid=1966879934#gid=1966879934>

1.5.3 Security

3.5.3.1 Tabel Angka Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	1	1	0	0	0					

3.5.3.2 Grafik Kejadian Kehilangan Barang



Analisa :
Tidak ada kehilangan barang bulan ini

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.7.4 Tabel Angka Potensi Kejadian Kehilangan Barang

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1	Angka kejadian kehilangan barang	0	0	1	1	0	0	0				

3.7.5 Grafik Angka Kejadian Kehilangan Barang



3.7.6 Tabel Angka Kejadian Berpotensi Kehilangan Barang

Jenis Aktivitas	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
Angka kejadian kehilangan barang	6	1	4	0	4	3	4				

Grafik Kejadian Berpotensi Kehilangan Barang

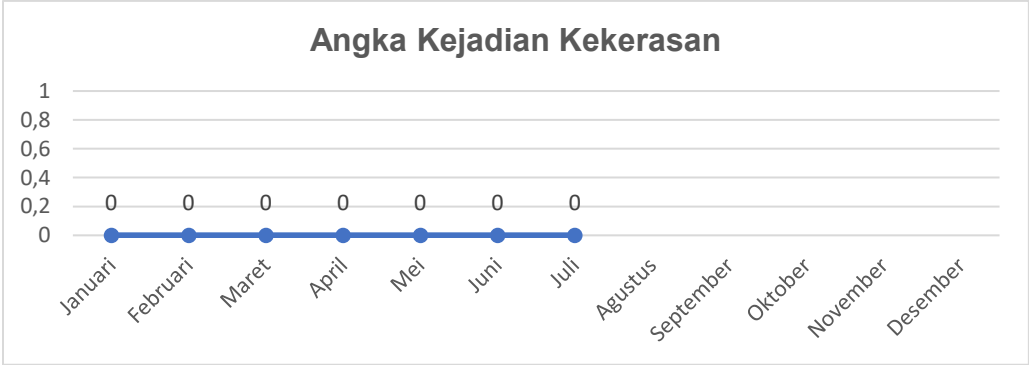


TANGGAL	KETERANGAN	RTL
28 – 07 – 2026	Ditemukan hp milik pasien di ruang tunggu poli lt2 , hp diamankan di pos IGD	Sudah diambil pemilik
30 – 07 – 2026	Ditemukan kunci motor milik karyawan tertancap di kendaraan , untuk kunci diamankan di pos IGD	Sudah diambil pemilik
30 – 07 – 2026	Ditemukan obat pasien poli paru di area gedung poli paru , diamankan oleh team cs	Sudah diambil pemilik
31 – 07 – 2026	Ditemukan hp milik karyawan perawat poli , diamankan di pos IGD	Sudah diambil pemilik

3.5.3.3 Tabel Angka Kekerasan di Lingkungan Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV
1.	Angka kejadian kekerasan	0	0	0	0	0	0	0				

3.5.3.4 Grafik Angka Kejadian Kekerasan

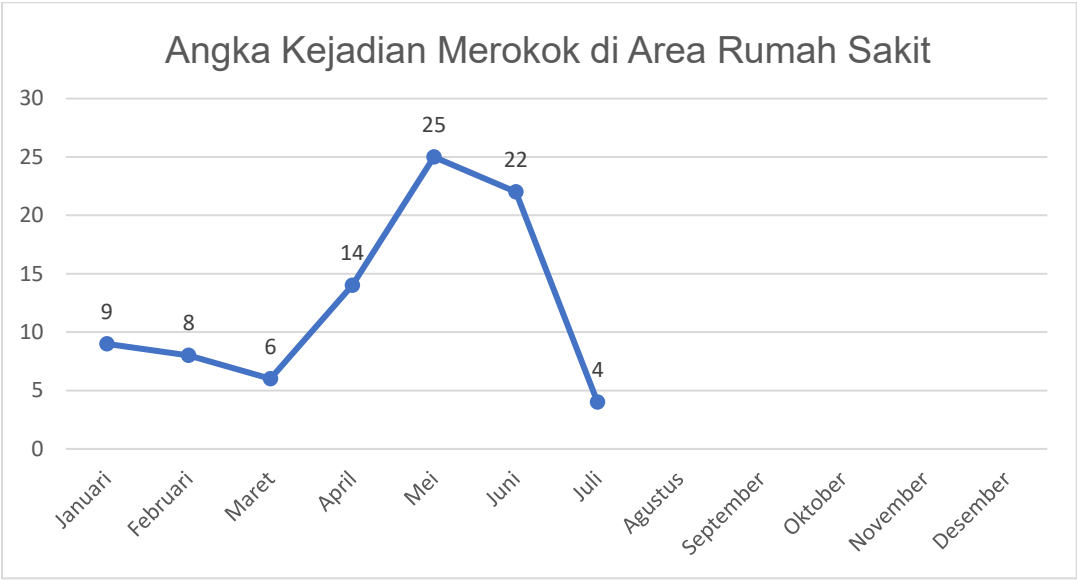


Analisis :
Tidak terdapat kejadian kekerasan karena pelayanan dilakukan dengan baik oleh seluruh karyawan dan tidak ada oknum yang menciptakan kerusakan.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.3.5 Tabel Angka Kejadian Merokok di Area Rumah Sakit

NO	JENIS AKTIVITAS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1	Angka kejadian merokok di area Rumah Sakit	9	8	6	14	25	22	4					



Analisis :

Angka 4 ini ditemukan karena peningkatan keaktifan patroli

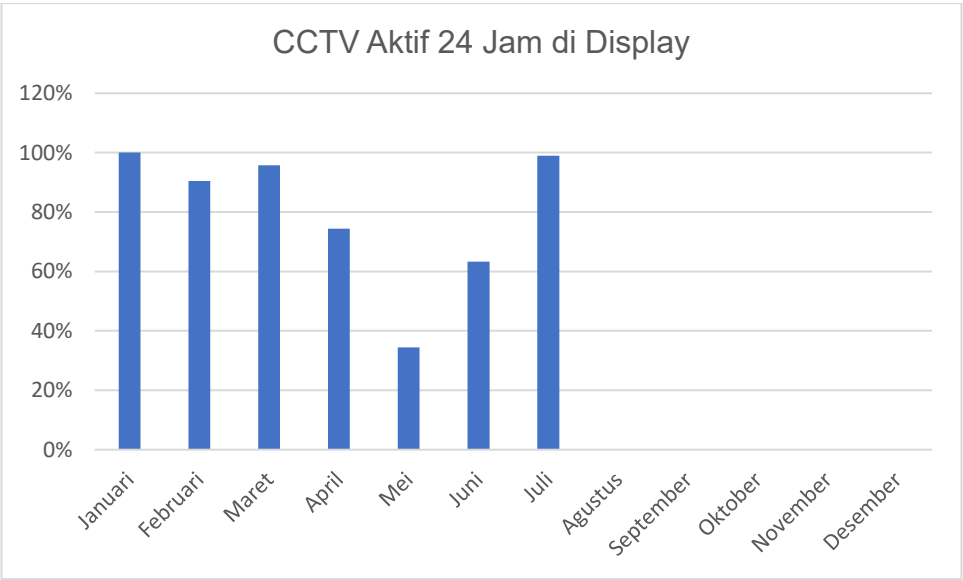
Rencana Tindak Lanjut :

Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.3.6 CCTV Aktif 24 Jam di Display

Tabel Angka CCTV Aktif 24 Jam di Display

Jenis Aktivitas	Jan	Febr	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
CCTV Aktif 24 Jam di displaySakit	100%	90.48%	95,70%	74.44%	34,41%	63,33%	98.82%					



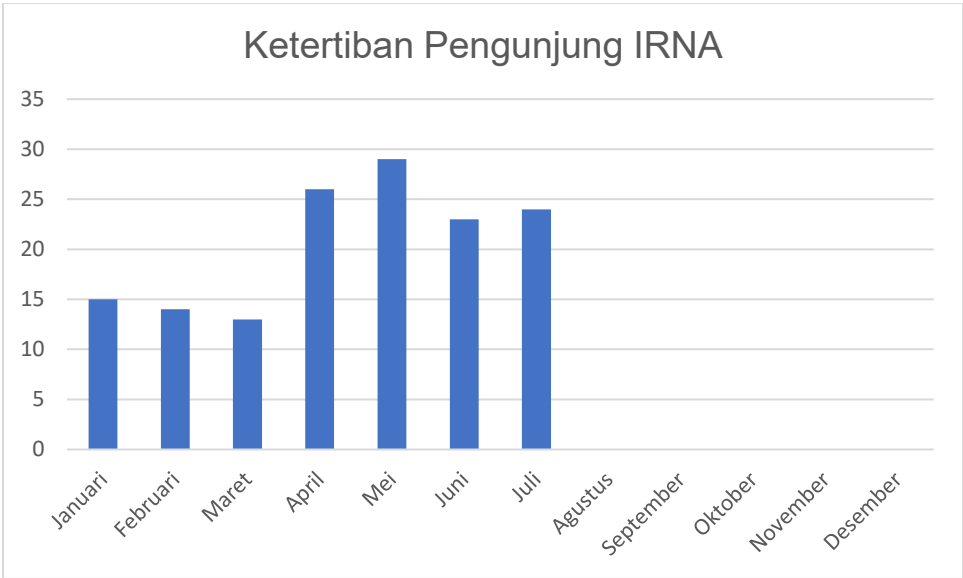
Analisa :

Pada bulan Juli pengecekan cctv dalam 1 bulan masih belum tercapai 100% dikarenakan beberapa kendala teknis dan kelayakan sarana prasarana

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring evaluasi. Pencatatan melalui WA grup dan operan shift dengan instrument dashboard spreadsheet.

3.5.3.7 Ketertiban Pengunjung IRNA

Tabel Ketertiban Pengunjung IRNA												
Jenis Aktivitas	Jan	Febr	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Ketertiban Pengunjung IRNA	15	14	13	26	29	23	24					

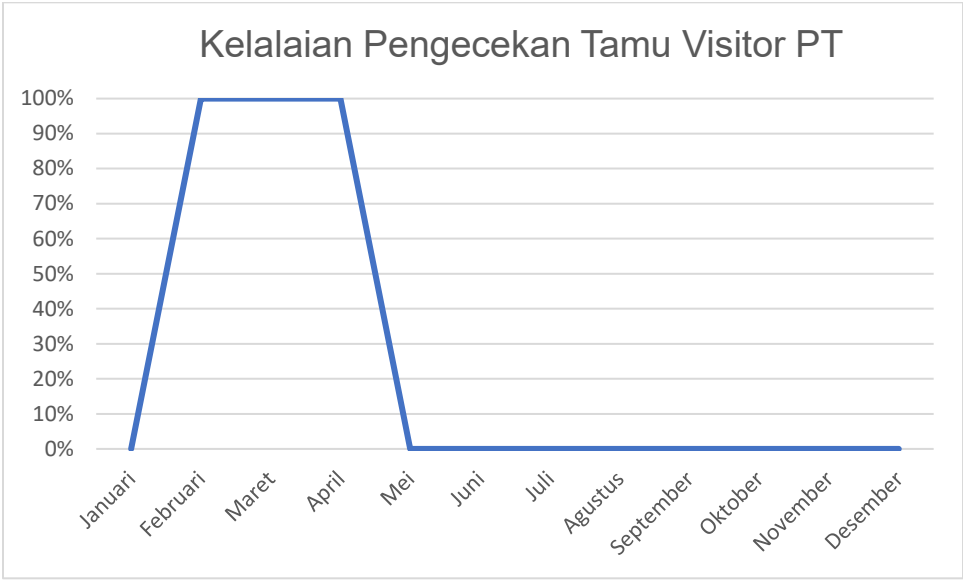


Analisa :
Sudah di TL oleh Tim security. Analisa tidak adanya one gate system untuk IRNA.

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring evaluasi.

3.5.3.8 CCTV Kelalaian Pengecekan Tamu Visitor PT

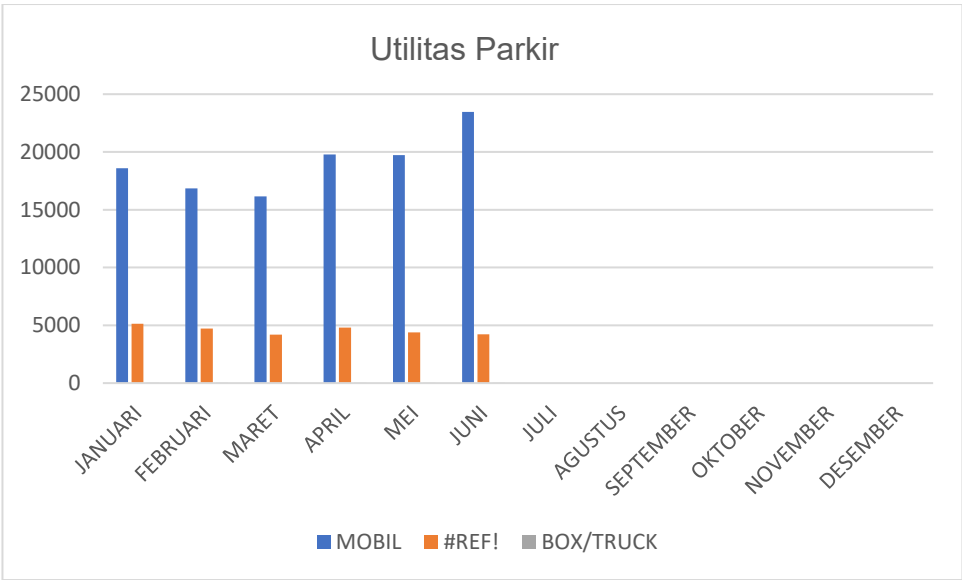
Jenis Aktivitas	Jan	Febr	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Kelalaian pengecekan tamu visitor PT	0	1	0	0	0	0	0					



Analisa : Minim kesalahan dalam petugas security di IGD.

Rencana Tindak Lanjut : Monitoring evaluasi.

3.5.4 Parkir



Analisis :
Progres parkir fluktuatif sesuai dengan kunjungan pasien dan jumlah hari libur

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan evaluasi

3.5.5 Humas Marketing

3.5.5.1 Perjanjian Kerjasama (PKS)

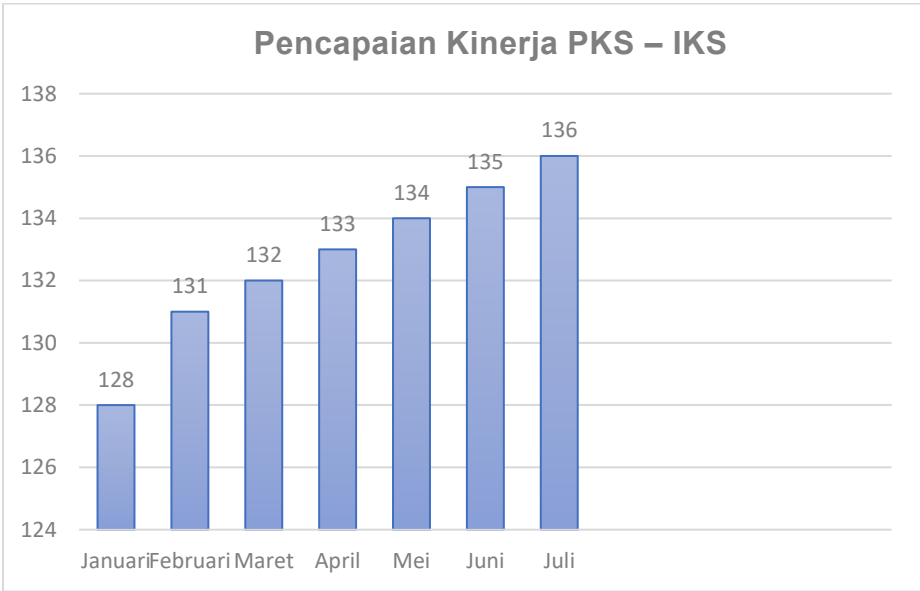
3.5.5.1.1 Pencapaian Kinerja PKS – IKS Februari 2026

No	Bulan	Target	Jumlah					
			Berlaku	ED	Baru	Kurang Baru	Progres	Total Kurang
1	Januari	1 IKS baru	128	1	1	0	1 (Proses review)	1
2	Februari	1 IKS baru	131	2	1	2	1 (Proses Perpanjangan 2)	2
3	Maret	1 IKS baru	132	1	1	2	2 (Proses perpanjangan)	2
4	April	1 IKS baru	133	2	1	0	2 (Proses Perpanjangan)	1
5	Mei	1 IKS baru	134	1	1	0	2 (Proses Perpanjangan, 1 Proses Review)	3
6	Juni	1 IKS baru	135	2	1	0	1 Proses Perpanjangan	2
7	Juli	1 IKS baru	136	1	2	1	1 Proses Perpanjangan, 2 Proses Review	3
Analisis ; 1. Pada bulan Juli 2026, Perpanjangan MOU dengan Taspen selesai, MOU Baru dengan Klinik Rawat Inap Sidodadi Warase tahap Review, MOU Baru dengan PT Etira dalam proses tanda tangan pihak ke-1, dan Perpanjangan dengan Harris Hotel masih dalam tahap review.								
Rencana Tindak Lanjut : 1. Memfollow up PKS yang sudah dikirim ke pihak kedua								

3.5.5.1.2 Tabel Progres IKS

No	Nama PKS	Progres Pengurusan	Kendala
1	PT Global Excel	Review	Perbedaan template draft PKS
2	PT Malang Intermedia Pers	Review	Proses Review
3	Dispenduk Kab. Malang Ketan Ireng	TTD Pihak ke-2	Selesai
4	PT Mane Indonesia	Review	Proses Pihak Kedua
5	TPA Halodoc	Review	Proses Tanda Tangan
6	Klinik Waras Wiris	Review	Selesai
7	SLB tingkat Nasional Bagian C	Review	Selesai
8	PMI Kota Malang	Review	Selesai
9	PMI Kabupaten Malang	TTD Pihak ke-2	Menunggu TTD
10	SK dan PKS Tim Penerjemah untuk Akreditasi	Review	Selesai
11	MOU Kementrian Agama Kabupaten Malang	Review	Selesai
12	MOU Klinik Muslimat Singosari	Review	Proses Pihak Kedua
13	MOU klinik BLK Singosari	Review	Proses Pihak Kedua
14	RSUD Lawang	TTD Pihak ke-2	Menunggu TTD

15	Asuransi Astra Life	Review	Selesai
16	Panti Nirmala	TTD Pihak ke-2	Menunggu TTD
17	Panglima Sudirman	Review	Proses Review
18	Klinik Muslimat Singosari	TTD Pihak ke-2	Selesai
19	Klinik Wijaya Husada	Review	Proses Review
20	PT CV Kurnia Edi Peni (KEP)	Selesai	Selesai
21	PT Indiratex Spindo	Review	Proses TTD PT
22	Hotel Harris	Review Pihak ke-2	Review
23	Taspen	Review Pihak ke-2	Review
24	Laboratorium Pangsud	Selesai	Selesai
25	PKM Ardimulyo	Selesai	Selesai
26	Klinik Rawat Inap Sidodadi Warase	Review	Proses Review
27	PT Etira	Review	Proses TTD PT



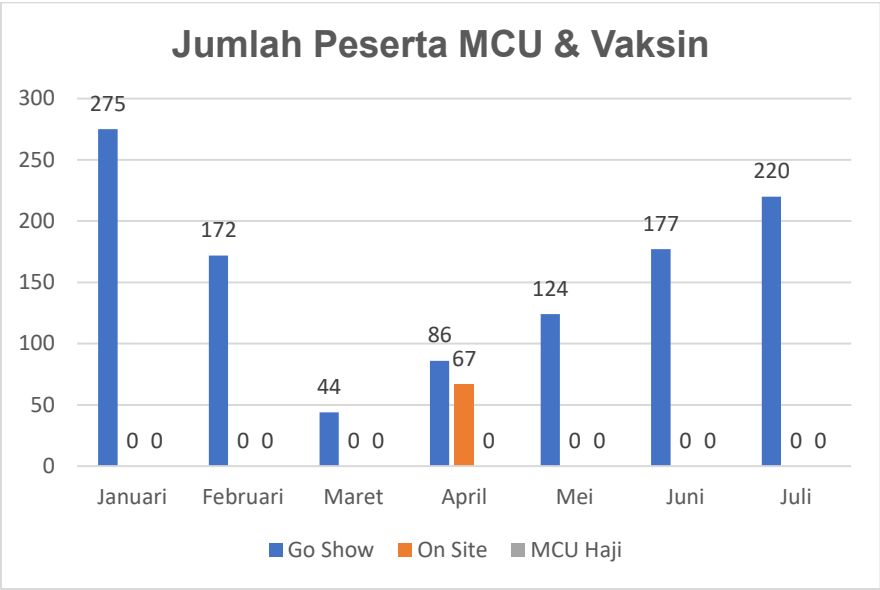
3.5.5.2 Medical Check Up (MCU)

1.5.5.2.1 Pencapaian Hasil Kinerja MCU dan Vaksin Tahun 2026

No	Bulan	Target	Jumlah Pasien GOSHOW	ON SITE
1	Januari	150	275	-
2	Februari	150	172	-
3	Maret	150	44	-
4	April	150	86	67
5	Mei	150	124	-
6	Juni	150	177	-
7	Juli	150	220	-

Analisis ;
 Jumlah peserta MCU dan Vaksin bulan Mei mengalami penurunan kunjungan sebesar 43 pasien atau sekitar 24,29% dari periode sebelumnya.

- Rencana Tindak Lanjut :
- Melakukan Promosi kesehatan kembali melalui Social Media
 - Kunjungan Perusahaan dan sekolah untuk menawarkan program MCU



1.5.5.2.2 Tabel Evaluasi Hasil Penawaran MCU Tahun 2026

NO	BULAN	INSTANSI	HASIL
1	Januari	PT Sinergi Pangan	Sudah terlaksana MCU dengan 12 Orang di Rumah Sakit
		Travel Kbih Al Muchsinin	Sudah dilaksanakan Vaksin dengan 24 Jamaah di RSPHM
		Travel King Salman	Sudah dilaksanakan Vaksin dengan 5 Jamaah di RSPHM
2	Februari	PT Pangan Lestari Malang	Sudah terlaksana MCU dengan 12 Orang di Rumah Sakit
		PT Riset Perkebunan Nusantara	Sudah terlaksana MCU dengan 1 Orang di Rumah Sakit
3	Maret	PT Multi Daya Mitra	Tidak berhasil karena Harga Tinggi
		PT Bangun Sarana Wreksa	Belum terlaksana karena perubahan Pimpinan dan Penawaran masih diajukan kembali
4	April	PT Bangun Sarana Wreksa	Pimpinan belum ingin melaksanakan MCU
		PT Indonesian Tobacco Tbk	Sudah Terlaksana dengan 2 Peserta di Rumah Sakit
		PT Arthawena	Pelaksanaan MCU ikut dengan kegiatan Skrining Klinik Mutiara Sehat
		PT Green Mountains Natural Foods	Sudah terlaksana MCU Onsite dengan 67 Peserta di Perusahaan
		Penelitian FK UMM	Sudah Terlaksana dengan 11 Peserta di Rumah Sakit
5	Mei	Bank BSI	Belum terlaksana karena adanya prosedur penjaminan dengan asuransi MIH dan masih tahap koordinasi kembali
6	Juni	Travel Ibu Dewi Latifah	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 3 Peserta di Rumah Sakit
		Travel Malika	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 7 Peserta di Rumah Sakit
		Travel Al Bakkah Syifaul Qulub	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 13 Peserta di Rumah Sakit
		PT Puninar Jaya Logistics	Sudah terlaksana MCU Onsite dengan 5 Peserta di Rumah Sakit
		PT Indonesian	Sudah terlaksana MCU Onsite

		Tobacco Tbk	dengan 1 Peserta di Rumah Sakit
7	Juli	Travel KBIH Al Muchsinin	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 28 Peserta di Rumah Sakit
		Travel Lawang Abu Rofiq (Al Bakkah Syifaul Qulub)	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 17 Peserta di Rumah Sakit
		Travel Haramain	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 15 Peserta di Rumah Sakit
		PT Dahana	MCU berkala rencana 16 pasien, tetapi jadwal MCU akan disesuaikan dengan keberangkatan peserta ke site masing - masing, sudah terlaksana 1 pasien di RS

3.5.5.2.3 Kegiatan Kunjungan Eksternal

3.5.5.2.3.1 Tabel Jumlah Kunjungan Eksternal

Tabel Hasil Kinerja Event Eksternal Humas Marketing RSPHM Pada Tahun 2026

Target	No	Tanggal	Instansi	Kegiatan Yang Dilakukan	Hasil Yang Diperoleh	Tindak Lanjut
5 Kunjungan per bulan	1	12/01/2026	PT TENTREM	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	2	12/01/2026	PT KEMAS SUPER INDONESIA (KSI)	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

	3	12/01/2026	PT ARTHAWENA SAKTI GEMILANG	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	4	12/01/2026	PT BANGUN SARANA WREKSA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	5	12/01/2026	CV AUMIRETA ANGGUN	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	6	12/01/2026	PT CIPTA SANDHI DARMA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

	7	12/01/2026	PT INTAN PRAMADITA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu 3. PIC menanyakan untuk paket Pemeriksaan Narkoba dan sudah dijelaskan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	8	12/01/2026	PT INDOMARINE	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu 3. PIC menyampaikan penawaran akan menjadi bahan referensi	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	9	12/01/2026	PT LAWANGMAS PRIMAPACK INDONESIA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	10	12/01/2026	PT MALINDO INTITAMA RAYA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan mempelajari penawaran terlebih dahulu	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

	11	12/01/2026	PT UNGGUL ANUGRAH SEJAHTERA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. PIC akan menanyakan kepada pimpinan dan bila pimpinan mengadakan program MCU akan di arahkan ke RS	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
	12	15/01/2026	PT OTSUKA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

	13	15/01/2026	PT RAGAM RAYA RASA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan
	14	15/01/2026	PT KHARISMA SELARAS	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan

	15	15/01/2026	PT ADI PUTRO	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan
	16	15/01/2026	PT USTEGRA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Mendapatkan Respon positif terkait penawaran	Follow up ulang akhir bulan

	17	15/01/2026	PT INDOSTAR BUILDING MATERIAL	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	18	15/01/2026	PT SUMBER ALFARIA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU

19	15/01/2026	PT WIM (KTG)	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, dan akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up kembali untuk Kegiatan MCU
20	20/01/2026	PT SINAR TAMAN PLASTINDO	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan

	21	20/01/2026	PT PADMA INDAH PRIMA PERKASA	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	Belum ada respon	Follow up ulang akhir bulan
	22	31/01/2026	Kegiatan Senam Yoga Lansia	1. Program dengan komunitas Lansia geriatri berupa Yoga 2. Jumlah peserta 56 orang 3. Peserta aktif mengikuti seluruh kegiatan	Kegiatan berjalan dengan baik, peserta sangat antusias mengikuti kegiatan	Koordinasi dengan PKRS untuk agenda selanjutnya
	23	03/02/2026	PT Pangan Lestari	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru 4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up untuk Agreement Letter

	24	06/02/2026	PT Multi Daya Mitra	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru 4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up ulang
	25	09/02/2026	PT Bangun Sarana Wreksa	1. Menyampaikan Penawaran Paket MCU RS Prima Husada by Phone 2. Harga yang dapat di negosiasikan, 3. Penyampaian untuk Pemeriksaan dapat dilakukan di RS maupun Onsite 4. Jadwal pemeriksaan dapat disesuaikan dengan jadwal dari Perusahaan	1. Hasil FU Mendapatkan Respon positif, 2. PIC tertarik dalam program MCU, 3. Pembahasan Kebutuhan MCU dan Harga Penawaran Terbaru 4. PIC menyampaikan untuk penawaran tersebut akan disampaikan kepada pimpinan Perusahaan	Follow up ulang akhir bulan
	26	11/02/2026	Puskesmas Lawang	1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya. 2. Diskusi kendala pelayanan pasien. 3. Informasi program Vaksinasi dan MCU	1. Puskesmas menyampaikan koordinasi dengan tim pelayanan sudah baik dan bagus karena selalu direspon dengan cepat 2. Puskesmas menyampaikan bahwa adanya beberapa	1. Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik 2. Melakukan koordinasi

					pasien yang sudah tidak aktif BPJSnya, walaupun pemberitahuan Program BPJS baru dinformasikan tetapi dari bulan januari sudah ada peserta BPJS yang dinonaktifkan dan harus melakukan konfirmasi ke pihak desa menerima informasi layanan terbaru. Kritik dan Saran : 1. Puskesmas menyampaikan untuk ltr pasien yang mendapatkan obat yang bisa didapatkan di Faskes apakah bisa jika di PRBkan saja 2. Puskesmas menyampaikan mohon dibantu untuk menginformasikan kepada pasien terkait SRB diberikan ke Puskesmas dan pasien tidak perlu membawa SRB ketika menuju ke RS	dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala
	27	11/02/2026	Klinik Garuda	1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya. 2. Diskusi kendala pelayanan pasien. 3. Informasi program Vaksinasi dan MCU	1. Klinik menyampaikan koordinasi dengan tim RS sudah baik dan selalu direspon dengan cepat 2. Klinik menyampaikan bahwa adanya perubahan jadwal di	1. Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

					klinik dari yang biasanya buka sampai dengan jam 20.00, berubah hanya sampai jam 15.00, sehingga beberapa peserta klinik ada yang berganti ke faskes lain. Kritik dan Saran : 1. Klinik menyampaikan bahwa ada satu pasien yang diminta untuk kembali ke klinik dengan memberikan surat pemeriksaan dari IGD dan meminta untuk dibuatkan rujukan, apakah bisa dibantu untuk pemeriksaan dari IGD diberikan surat keterangan bila memang hasil pemeriksaan di IGD menyatakan Perlu untuk dibuatkan rujukan maka pasien diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan agar klinik bisa mengkonfirmasi dengan data tersebut 2. Melakukan koordinasi dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala
--	--	--	--	--	---

	28	11/02/2026	Puskesmas Singosari	1. Monitoring jumlah rujukan bulan sebelumnya. 2. Diskusi kendala pelayanan pasien. 3. Informasi program Vaksinasi dan MCU	1. Klinik menyampaikan koordinasi dengan tim RS cukup baik dan selalu direspon dengan cepat Kritik dan Saran : 1. Puskesmas menyampaikan untuk PRB pasien dari RS PHM masih sedikit sedangkan rapot puskesmas di BPJS merah di RS PHM 2. Puskesmas menyampaikan ada satu pasien dengan 2 rujukan yang aktif dan 1 rujukan tersebut obatnya di PRB kan, tetapi dari RS memberikan Obat untuk 2 rujukan sehingga ketika Puskesmas memberikan klaim ke Kimia Farma, mereka meminta untuk obat tersebut dikembalikan karena pihak kimia farma tidak bisa mengklaim obat PRB yang diberikan oleh RS 3. Pihak Puskesmas meminta tolong untuk ketika ada pasien yang membutuhkan dua rujukan apakah bisa jika diselanggi untuk jadwal	
--	----	------------	---------------------	--	--	--

					kontrolnya sehingga habisnya berbeda 4. Puskesmas menyampaikan untuk diagnosa dokter dicky masih dibuat berbeda dengan kondisi asli pasien, seperti cholelithiasis dibuat ulcerative 5. Pihak Puskesmas meminta saran untuk Print Out resume pulang pasien karena data tersebut digunakan jika ada audit dari BPJS 6. Adapun penolakan dari IGD untuk rujukan jantung dari Puskesmas Singosari di bulan Desember rujukan jantung dengan hasil EKG SVT, dari RS Prima husada menginformasikan bahwa tindakan PCI belum ada dan pasien hanya bisa ditindak rawat inap saja sedangkan ketika puskesmas konfirmasi ke marsudi rujukan langsung diterima dengan tindakan kejut jantung sesuai dengan SOAP yg diberikan oleh tim puskesmas	
--	--	--	--	--	--	--

	29	16/02/2026	PMI Kabupaten Malang	Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS dengan PMI Kabupaten Malang	Sudah diterima oleh PIC PMI Kabupaten Malang	Follow up MOU
	30	16/02/2026	PMI Kota Malang	Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS dengan PMI Kota Malang	Sudah diterima oleh PIC PMI Kota Malang	Follow up MOU
	31	24/02/2026	SLB Tingkat Nasional Bagian C	Menyampaikan dokumen MOU dengan SLB Tingkat Nasional Bagian C untuk kebutuhan Penerjemah Bahasa Isyarat	Sudah diterima oleh PIC SLB Tingkat Nasional Bagian C	Follow up MOU
	32	24/02/2026	PMI Kota Malang	Pengambilan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	33	24/02/2026	Kementrian Agama Kabupaten Malang	Menyampaikan dokumen MOU dengan Kementrian Agama Kabupaten Malang untuk kebutuhan Bimbingan kerohanian	Sudah diterima oleh PIC Kementrian Agama Kabupaten Malang	Follow up MOU
	34	27/02/2026	Kementrian Agama Kabupaten Malang	Pengambilan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	35	27/02/2026	SLB Tingkat Nasional Bagian C	Pengambilan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	36	10/03/2026	Klinik Waras Wiris	Mengantarkan MOU yang sudah selesai	Sudah diterima oleh Ibu Kholifa	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	37	10/03/2026	Fitness Plus Singosari	1. Mengantarkan MOU yang sudah selesai	1. Sudah diterima oleh Mba Nanda	Menginformasikan hal tersebut kepada Kepala

				2. Koordinasi terkait Cross selling yang akan terjadi antara Fitness Plus Singosari dengan RS PHM	2. Koordinasi dilakukan terkait kerjasam Flyer Membership Fitness Plus 3. Voucher MCU RSPHM 4. Penempatan desain Banner untuk diletakkan di Fitness Plus	Bidang dan Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	38	14/03/2026	Klinik Losari Medika	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran atas nama wahyu	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	39	14/03/2026	Bidan Indi (KRI Putra Husada)	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran atas nama diandra	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	40	14/03/2026	Klinik BLK	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Ria	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	41	14/03/2026	Klinik Mitra Prima Care	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Dokter tari	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	42	14/03/2026	Puskesmas Lawang	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Reni	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	43	16/03/2026	CV Aumireta Anggun	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Team Security	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	44	16/03/2026	PT Kemas Super Indonesia	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Pak Suryono	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang

						baik
	45	16/03/2026	PT Malindo Intitama Raya	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Pak Gunawan	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	46	16/03/2026	PT Molindo Raya Industri	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Pak Yudi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	47	16/03/2026	PT Bangun Sarana Wreksa	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Bapak Nanda	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	48	16/03/2026	PT Pesta Pora Abadi	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Reni	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	49	16/03/2026	PT Kencana Tiara Gemilang	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Andik	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	50	16/03/2026	PT Lawangmas Primapack Indonesia	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Bapak Dian	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	51	16/03/2026	Puskesmas Ardimulyo	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Mailing Ibu Vale	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	52	16/03/2026	Klinik Garuda	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Dinda	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

	53	16/03/2026	Klinik Brawijaya Lawang	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC TU Pak Rizza	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	54	16/03/2026	DPM Lidya Putri	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh ibu resi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	55	16/03/2026	DPM Suhariningsih	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran Rosia	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	56	16/03/2026	DPM Farida Rusniah	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Bapak Setiani	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	57	16/03/2026	KRI Muslimat Singosari	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu devi putri	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	58	16/03/2026	Klinik Wijaya Husada	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Ibu Yeni	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	59	16/03/2026	DPM Wulandarti Wien	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Anak atas nama Ibu Nastiti	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	60	17/03/2026	PT Jasa Raharja	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC bapak Hari	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	61	17/03/2026	Klinik Kartini Medika	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Security Rendy	Bina komunikasi untuk menjalin

						kerjasama yang baik
	62	17/03/2026	Klinik Nayaka 02	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Dokter Virda	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	63	17/03/2026	DPM Arry Budiarti	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Suami	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	64	18/03/2026	DPM Ida Bagus D.	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh dr Ida Bagus	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	65	18/03/2026	PKM Singosari	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Dokter syamsu	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	66	18/03/2026	DPM Yosephine Pratiwi	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh PIC Pendaftaran Novi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	67	18/03/2026	PT Kharisma Selaras	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Ibu Lina	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	68	18/03/2026	PT Indostar Building Material	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Ibu Riri	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	69	18/03/2026	Relawan Siaga Utara (RESITA)	Mengantarkan Parcel Lebaran Tahun 2026	Sudah diterima oleh Istri	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

	70	07/04/2026	Nestle Bear Brand	Mengantarkan kiriman Susu Kloter pertama untuk RS Prima Husada Malang Tahun 2026	Sudah diterima dan sudah diinformasikan untuk bukti penerimaan kepada pihak Bear Brand	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	71	15/04/2026	Fitness Plus Singosari	1. Mengantarkan Banner dan Voucher diskon untuk membership dan Karyawan dari Fitness Plus 2. Koordinasi terkait dengan promo membership Fitness Plus kepada Staff RS Prima Husada Malang	1. Sudah disampaikan terkait dengan mekanisme penggunaan voucher dan diterima dengan baik oleh pihak Fitness Plus Singosari 2. Permintaan Promo untuk karyawan RS Prima Husada Malang sudah di proses, jika ada peserta yang akan daftar membership maka akan dibantu daftar dari Humas	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	72	22/04/2026	Klinik Muslimat Singosari	Mengirimkan Perpanjangan MOU dengan Klinik	Sudah diterima oleh ibu Devi	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	73	27/04/2026	Relawan Ambulance (Resita)	Menyerahkan MOU dan Susu Bear Brand serta monitoring apakah ada kesulitan ketika mengantarkan pasien ke RS Prima Husada	1. Susu Bear Brand sudah diterima, MOU sudah diterima langsung dengan Pak Jali 2. Evaluasi sudah baik, tidak ada kesulitan dan pasien yang diantarkan juga diterima dengan baik	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	74	27/04/2026	Indonesian Tobacco Tbk.	Menyerahkan Hasil MCU dan Tagihan MCU kepada Perusahaan	Sudah diterima oleh bapak Bryllian	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	75	27/04/2026	Shanaya Resort	Menyerahkan Hasil MCU dan Tagihan MCU kepada Shanaya Resort	Sudah diterima oleh mba Stefani	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

	76	27/04/2026	PT Green Mountains Natural Foods	1. Menyerahkan Tabung Sampling untuk pemeriksaan FL dan penyampaian terkait alur dan tata cara sampling 2. Cek Lokasi untuk bis MCU	1. Sudah diterima oleh Ibu Harnanik. 2. Sudah dilakukan pengecekan terakit dengan Lokasi Bis MCU dan semua aman	Bina komunikasi untuk Koordinasi pelaksanaan MCU
	77	28/04/2026	CV Karunia Edi Peni	Menyerahkan MOU serta monitoring apakah ada kesulitan ketika Koordinasi dengan RS Prima Husada	1. MOU sudah diterima oleh tim Humas RS 2. Evaluasi sudah baik, tidak ada kesulitan dan pasien yang diantarkan juga diterima dengan baik	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	78	07/05/2026	Mandiri InHealth	1. Koordinasi layanan MCU untuk penjaminan karyawan BSI Malang 2. Koordinasi terkait pergantian E-PKS Mandiri InHealth dan New Branding Mandiri InHealth menjadi InHealth	1. Sudah disampaikan bahwa kebutuhan RS adalah pembuatan portal MCU untuk karyawan BSI 2. Pihak Mandiri InHealth menjelaskan bahwa permintaan MCU terlalu mendadak dan akses untuk portal MCU harus dengan approval terlebih dahulu menggunakan BA MCU dan BA itu tidak melekat dengan MOU, 3. permintaan reimburse sendiri harus berasal dari Perusahaan atau Bank BSI kemudian akan disampaikan ke HO, karena peraturan untuk industri besar harus terorganisir dengan cabang" yg lain, jika portal dibuka dan karyawan datang hanya sedikit dan tidak ada	1. Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik 2. Melakukan koordinasi dengan Kabid untuk tindak lanjut terkait kendala

					kepastian jumlah karyawan setiap tahunnya, maka pihak Mandiri juga tidak mau membuka portal GCU/MCU 4. E-PKS sudah harus diisi dengan template sesuai portal PROVEN	
	79	12 Mei 2026	Pocari Sweat	Penyampaian dan pemberian Pocari Sweat untuk kegiatan Futsal Karyawan RS Prima Husada Malang oleh pihak Pocari Sweat.	Telah diterima oleh Pihak RS Prima Husada Malang yaitu 1 box Pocari Sweat untuk kegiatan Futsal Karyawan RS Prima Husada Malang	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	80	21 Mei 2026	PT Djojonegoro C-1000	Penyampaian dan pemberian You-C1000 untuk Karyawan RS Prima Husada Malang oleh pihak Pocari Sweat.	Telah diterima oleh Pihak RS Prima Husada Malang yaitu 270 pcs You-C1000 untuk Karyawan RS Prima Husada Malang	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	81	25 Mei 2026	PT Lucky Mom Indonesia (Makuku)	Penyampaian produk Makuku, dan keinginan untuk masuk kedalam program PKRS yaitu Senam Hamil	Sudah disampaikan bahwa untuk proses masuk ke RS bisa dengan bersurat terlebih dahulu agar dapat didisposisikan kepada pimpinan	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	82	29 Mei 2026	Jasa Raharja Malang	Menyampaikan dokumen Pembaruan PKS dengan PT Jasa Raharja Malang	Sudah diterima oleh PIC PT Jasa Raharja Malang	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	83	3 Juni 2026	PT Jasa Raharja	Mengirimkan Revisi MOU kepada pihak PT Jasa Raharja	Sudah diterima oleh CS	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	84	12 Juni 2026	Mandiri InHealth	Mengirimkan MOU terbaru Tahun 2026 PROVEN	Sudah diterima oleh team Customer Service	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik

	85	22 Juni 2026	Klinik Kendedes	1. Konfirmasi dari klinik bahwa rujukan menuju RS tidak muncul pada aplikasi P-CARE	1. Menyampaikan permohonan maaf karena kendala yang terjadi 2. Memberikan informasi kepada PIC BPJS untuk segera tindak lanjut, dan sudah teratasi di hari yang sama	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	86	22 Juni 2026	Puskesmas Pakis	RS melakukan Konfirmasi kepada Puskesmas apakah ada kendala rujukan menuju RS tidak muncul pada aplikasi P-CARE	1. Menyampaikan permohonan maaf karena kendala yang terjadi 2. Memberikan informasi kepada PIC BPJS untuk segera tindak lanjut, dan sudah teratasi di hari yang sama	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	87	22 Juni 2026	Puskesmas Polowijen	RS melakukan Konfirmasi kepada Puskesmas apakah ada kendala rujukan menuju RS tidak muncul pada aplikasi P-CARE	1. Menyampaikan permohonan maaf karena kendala yang terjadi 2. Memberikan informasi kepada PIC BPJS untuk segera tindak lanjut, dan sudah teratasi di hari yang sama	Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang baik
	88	25 Juni 2026	Pitstop Akreditasi All PJ 2026	Memberikan diklat KE kepada seluruh staff RS Prima Husada	Sudah terlaksana, pendataan nilai dan hasil pitstop sudah diberikan	-
	89	30 Juni 2026	PKM Ardimulyo	1. Bina Rujukan stunting dengan PIC 2. Koordinasi dengan PIC terkait kendala rujukan 3. Koordinasi tanda tangan proses MOU terkait stunting wasting	1. Selama ini belum ada kendala ketika merujuk ke RS 2. Tambahan dari pihak PIC bahwa pihak RS bisa memberikan informasi untuk ibu Hamil yang wilayah rumah berada di daerah Puskesmas	Menyampaikan informasi kepada PIC Maternitas, Karu dan Kabid, Bina komunikasi untuk menjalin kerjasama yang

					Ardimulyo bisa menghubungi Kader bidan setempat agar mendapatkan vitamin A 3. MOU sudah ditandatangani oleh Kepala Puskesmas	baik
	90	04 Juli 2026	Fitness Pluss Singosari	1. Koordinasi seminar oleh team Fitness Plus Singosari kepada Komunitas Yoga Lansia RS Prima Husada 2. Pembahasan teknis pelaksanaan seminar. 3. Evaluasi dan tindak lanjut setelah pelaksanaan seminar	1. Acara berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik dan peserta memperoleh edukasi kesehatan dari team Fitness Plus Singosari 2. Jika ada kebutuhan untuk event selanjutnya Fitness Plus Singosari berkenan untuk dihubungi	Bina Kerjasama yang baik dengan Fitness Pluss Singosari
	91	06 Juli 2026	KBIH AI - Muchsinin	1. Koordinasi Humas dengan PIC KBIH AI Muchsinin ummi jannah terkait kebutuhan vaksinasi peserta 2. Koordinasi jumlah dan data peserta yang akan mengikuti vaksinasi 3. Koordinasi jadwal dan waktu pelaksanaan vaksinasi 4. Penyampaian informasi persyaratan dan ketentuan vaksinasi kepada PIC KBIH AI Muchsinin 5. Koordinasi teknis pelaksanaan vaksinasi dengan PIC KBIH AI Muchsinin	1. Diperoleh informasi terkait kebutuhan vaksinasi peserta yaitu vaksin Meningitis dan Polio untuk 26 Peserta 2. Disepakati jadwal pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan kebutuhan peserta yaitu tanggal 9 Juli 2026 3. Pelaksanaan vaksinasi dapat dipersiapkan dengan baik	Bina Kerjasama yang baik dengan KBIH AI - Muchsinin
	92	07 Juli 2026	Laboratorium Panglima Sudirman	Menyampaikan dokumen MOU dengan Laboratorium Panglima Sudirman yang telah selesai	Sudah diterima oleh PIC Laboratorium Panglima Sudirman bagian pendaftaran	Bina Kerjasama yang baik

	93	14 Juli 2026 – 16 Juli 2026	Akreditasi RS Prima Husada Malang Tahun 2026	1. Melaksanakan tugas sebagai Master of Ceremony (MC) pada kegiatan rumah sakit 2. Melakukan koordinasi dengan panitia dan pihak terkait sebelum pelaksanaan kegiatan 3. Menyiapkan kebutuhan data untuk Bab Komunikasi Efektif (KE) dalam Akreditasi Rumah Sakit 4. Melakukan koordinasi dengan unit/PIC terkait pemenuhan elemen penilaian Komunikasi Efektif 5. Menjadi PIC Dokumentasi Management dalam Akreditasi Rumah Sakit 6. Mendampingi proses telusur Akreditasi 7. Menjadi PIC Narator Code Red dalam Simulasi Akreditasi Rumah Sakit	1. Kegiatan berjalan dengan tertib, terarah, dan sesuai dengan susunan acara yang telah ditetapkan 2. Persiapan telusur dan pemenuhan dokumen terkait Komunikasi Efektif dapat terkoordinasi dengan unit terkait 3. Kesiapan dokumen dan implementasi KE dapat dipantau serta dilakukan tindak lanjut terhadap temuan yang masih belum terpenuhi 4. Proses telusur berjalan dengan baik dan bukti implementasi dapat disampaikan sesuai kebutuhan akreditasi 5. Kegiatan Simulasi berjalan dengan baik, terarah, dan sesuai dengan skrip	Bina Kerjasama yang baik
--	----	-----------------------------------	--	---	--	-----------------------------

Tabel Hasil Kinerja Event Eksternal Humas Marketing RSPHM Pada Tahun 2026

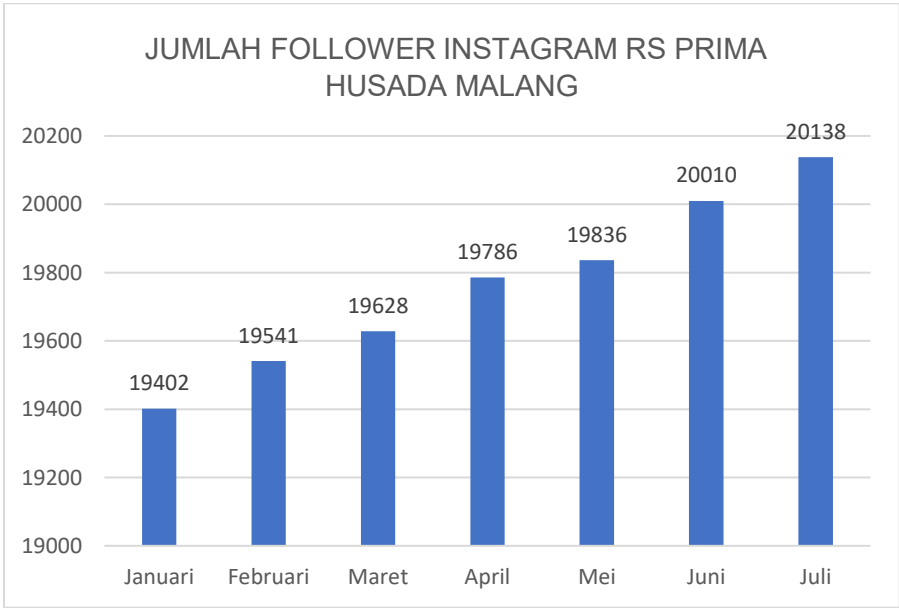
Target	No	Tanggal	Instansi	Kegiatan Yang Dilakukan	Hasil Yang Diperoleh	Tindak Lanjut
MCU dan Vaksin	1	09/01/2026	PT Sinergi Pangan Gemilang	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Sinergi Pangan Gemilang	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 12 Orang	Hasil Pemeriksaan telah diberikan
MCU dan Vaksin	2	14/01/2026	KBIH AI Muchsinin	Program Vaksin 24 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan vaksin untuk 24 orang di tanggal 14 Januari 2026	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	3	26/01/2026	KBIH Alfattah Singosari	Program Vaksin 9 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan Vaksin untuk 6 Orang di tanggal 14 Januari 2026	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	4	26/01/2026	Travel King Salman	Program Vaksin 5 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan untuk vaksin sesuai ketentuan penawaran dengan 6 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	5	04/02/2026	PT Riset Perkebunan Nusantara	Program MCU Karyawan Baru di RS dengan PT Riset Perkebunan Nusantara	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 1 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	6	19/02/2026	PT Pangan Lestari Malang	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Pangan Lestari Malang	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 12 Orang	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	7	29/04/2026	PT Green Mountains Natural Foods	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Green Mountains Natural Foods	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 67 Orang	Sudah Selesai
MCU dan Vaksin	8	04/05/2025	Shanaya Resort	Program MCU Karyawan baru di RS dengan Shanaya Resort	Sudah dilaksanakan untuk Program MCU sesuai ketentuan penawaran dengan 2 Orang	Sudah Selesai
MCU dan Vaksin	9	06/06/2026	Travel Ibu Dewi Latifah	Program Vaksin 3 jamaah Travel	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 3 Peserta di Rumah Sakit	Sudah Selesai
MCU dan Vaksin	10	18/06/2026	Travel Malika	Program Vaksin 7 jamaah Travel	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 7 Peserta di Rumah Sakit	Sudah Selesai
MCU dan Vaksin	11	20/06/2026	PT Puninar Jaya Logistics	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Puninar Jaya Logistics	Sudah terlaksana MCU Onsite dengan 5 Peserta di Rumah Sakit	Sudah Selesai
MCU dan	12	23/06/2026	PT Indonesian	Program MCU Karyawan baru	Sudah terlaksana MCU Onsite dengan 1	Sudah Selesai

Vaksin			Tobacco Tbk	di RS dengan PT Indonesian Tobacco Tbk	Peserta di Rumah Sakit	
MCU dan Vaksin	13	26/06/2026	Travel Al Bakkah Syifaul Qulub	Program Vaksin 13 jamaah Travel	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 13 Peserta di Rumah Sakit	Sudah Selesai
MCU dan Vaksin	14	09/0/2026	KBIH Al Muchsinin	Program Vaksin 25 jamaah Travel	Sudah dilaksanakan vaksin untuk 25 orang di tanggal 09 Juli 2026	Sudah selesai
MCU dan Vaksin	15	11/07/2026	PT Puninar Jaya Logistics	Program MCU Karyawan di RS dengan PT Puninar Jaya Logistics	Sudah terlaksana MCU Onsite dengan 6 Peserta di Rumah Sakit	Sudah Selesai
MCU dan Vaksin	16	13/07/2026	Travel Al - Haramain	Program Vaksin 15 jamaah Travel	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 15 Peserta di Rumah Sakit	Sudah Selesai
MCU dan Vaksin	17	16/07/2026	Travel Lawang (Al Bakkah Syifaul Qulub)	Program Vaksin 14 jamaah Travel	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 14 Peserta di Rumah Sakit	Sudah Selesai
MCU dan Vaksin	18	21-23/07/2026	Travel Lawang (Al Bakkah Syifaul Qulub)	Program Vaksin 17 jamaah Travel	Sudah terlaksana Vaksinasi dengan 17 Peserta di Rumah Sakit	Sudah Selesai

1.5.5.2.4 Digital Marketing

1.5.5.2.4.1 Daftar Kegiatan Digital Marketing

JUMLAH KONTEN BARU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
FEED FOTO	12	5	16	13	12	5	4					
REELS	4	6	6	8	4	2	5					
STORY	13	31	28	22	57	40	8					
TOTAL	29	41	50	43	73	47	17					0
JUMLAH TOTAL POSTINGAN (BARU + LAMA)	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
FEED FOTO	13	5	16	14	12	5	4					
FEED VIDEO	4	6	6	8	4	2	5					
REELS	4	6	6	8	4	2	5					
STORY	89	85	53	82	58	40	56					
TOTAL	110	102	81	112	78	49	70					
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	19402	19541	19628	19786	19836	20010	20138					
JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	311	242300	177	285	240	229	128					
TARGET	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

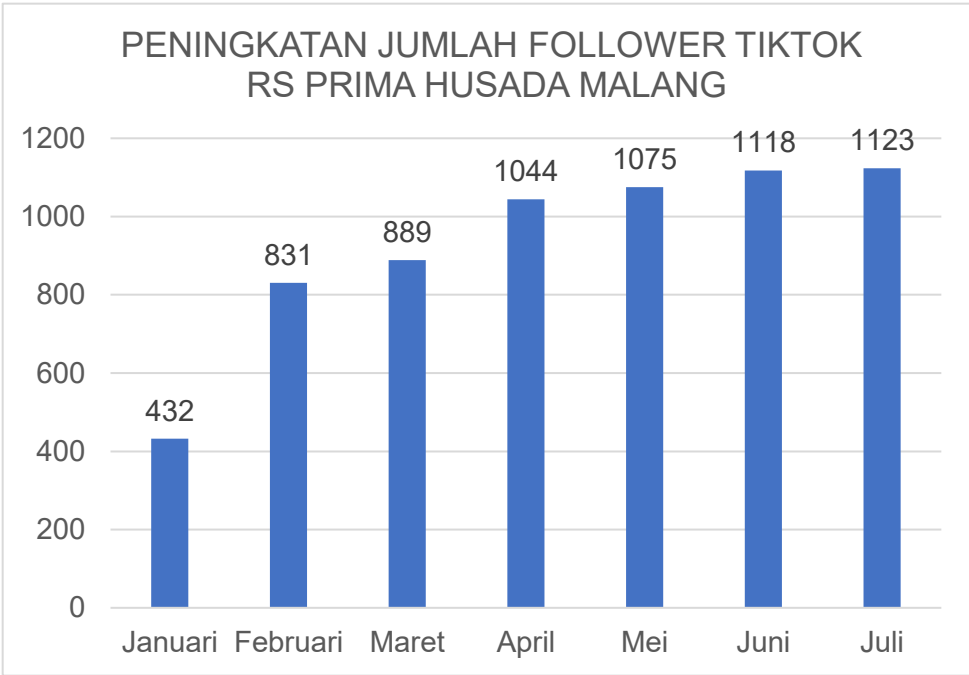


Analisa :
Jumlah Follower Instagram RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebanyak 128 *Followers* atau sebesar 0,64% dari bulan sebelumnya

- Rencana Tindal Lanjut :**
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS setiap harinya
 - 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
 - 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Tik Tok

JENIS	JANUA RI	FEBRU ARI	MARE T	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH KONTEN BARU	2	9	5	5	3	1	3					
TARGET	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
JENIS	JANUA RI	FEBRU ARI	MARE T	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH FOLLOWER (CUT OFF TANGGAL 1)	432	831	889	1044	1075	1118	1123					
JENIS	JANUA RI	FEBRU ARI	MARE T	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH PENINGKATAN FOLLOWER	23	399	58	155	31	43	5					
TARGET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JENIS	JANUA RI	FEBRU ARI	MARE T	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH LIKE	1876	3374	3753	4477	4676	4881	5037					



Analisa :
Jumlah Follower Tiktok RS Prima Husada Malang mengalami peningkatan sebanyak 5 *Followers* atau sebesar 0,45% dari bulan sebelumnya

Rencana Tindal Lanjut :

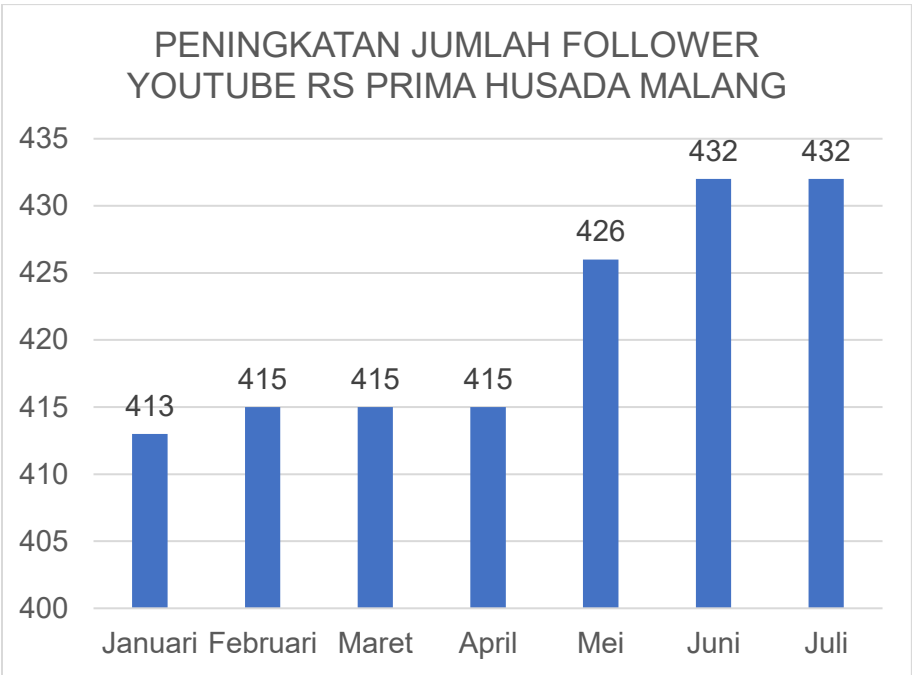
- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
- 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
- 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Platform Youtube

JENIS	JANUA RI	FEBRUA RI	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JU LI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH KONTEN BARU	0	0	0	0	0	0	0					
TARGET	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

JENIS	JANUA RI	FEBRUA RI	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JU LI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH SUBS	413	415	415	415	426	432	432					

JENIS	JANUA RI	FEBRUA RI	MARE T	APRI L	ME I	JUN I	JU LI	AGUST US	SEPTEMB ER	OKTOB ER	NOVEMBE R	DESEMB ER
JUMLAH PENINGKATAN SUBS	5	2	0	0	11	6	0					0
TARGET	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



Analisa :

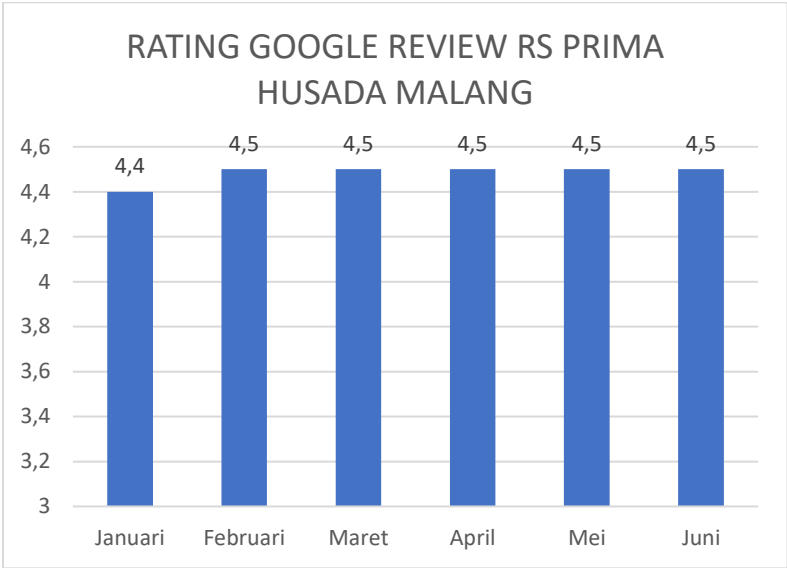
Jumlah Follower Youtube RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan *Followers* dari bulan sebelumnya

Rencana Tindal Lanjut :

- 1. Terus melakukan Konsistensi upload dan posting kegiatan RS kolaborasi dengan PKRS
- 2. Mencari waktu yang tepat untuk memposting agar meningkatkan viewers
- 3. melakukan kolaborasi konten dengan Unit lain untuk memperbarui isi Konten

Google Review

PROGRESS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
JUMLAH RATING	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5					



BULAN	RATE CAPAIAN GOOGLE REVIEW	
	POSITIF	NEGATIF
Januari	122	4
Februari	133	3
Maret	114	5
April	149	9
Mei	111	5
Juni	138	2

- Analisa :
- 1. Progres untuk Rating Google Review RS Prima Husada Malang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari bulan sebelumnya
 - 2. Pengisian Google Review mengalami peningkatan 24 review atau sekitar 20,69% dibanding bulan sebelumnya.
 - 3. Pengisian Google Review dengan Rate Positif mengalami peningkatan 27 review atau sekitar 24,32% dibanding bulan sebelumnya.
 - 4. Pengisian Google Review dengan Rate Negatif mengalami penurunan 3 Review atau sekitar 60% dibanding bulan sebelumnya.

- Rencana Tindal Lanjut :
- 1. Meningkatkan Survei kepuasan pasien dengan melakukan pengisian Google Review

3.5.5 Penjaminan

3.5.5.1 Piutang

3.5.5.1.2 Analisa Progres Penyelesaian Piutang

PERIODE JULI 2026												
Anakak	846.945.890	87.292.781	1.000.407	286.447.584	875.267.488	18.900.389	467.400	87.838.690	393.287.241	109.088.000	6.436.940	8.754.439
Pemrosesan	556.935.256	447.404.659	17.097.710	97.463.449	878.339.625	45.059.000	-	232.460.826	238.823.373	265.971.210	1.239.288	200.860
Mandiri/kehidupan	946.977.100	218.022.071	1000.000	36.829.232	36.239.490	-	-	36.239.490	72.379.782	19.034.000	-	-
Keperawatan	98.723.430	82.808.000	-	2.826.425	46.226.492	1.366.607	-	42.900.877	96.536.382	46.536.000	-	-
OPR/Keperawatan	846.888.479	658.892.600	8.030.078	88.836.589	689.394.888	-	-	889.204.899	829.231.684	833.001.688	-	-
Total Sajian								4.403.553.868	1.560.838.267	2.832.531	1.729.298	6.446.799
											270.165.476	1.431.268.661

Keterangan : Cut off 31 Juli 2026 sebesar Rp 1.431.393.106

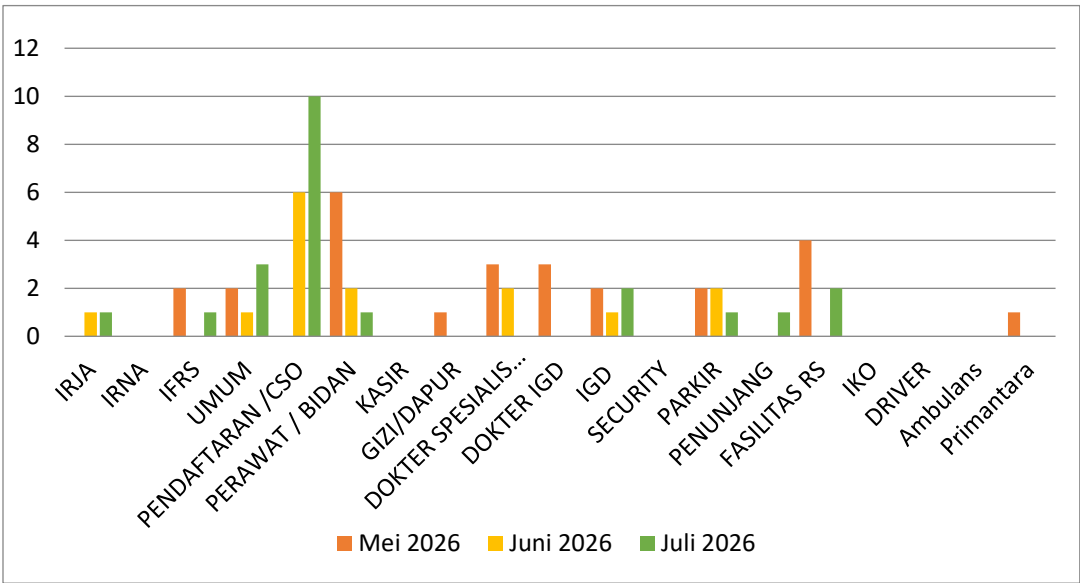
3.5.6 PIPP – MOD – MPP

3.5.6.1 Laporan Komplain Pasien

1.5.6.1.1 Tabel Distribusi Laporan Komplain Pasien Per Unit Bulan Februari 2026

No	Jumlah Komplain Pasien Terhadap Unit	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026
1.	IRJA	0	1	1
2.	IRNA	0	0	0
3.	IFRS	2	0	1
4.	UMUM	2	1	3
5.	PENDAFTARAN /CSO	0	6	10
6.	PERAWAT / BIDAN	6	2	1
7.	KASIR	0	0	0
8.	GIZI/DAPUR	1	0	0
9.	DOKTER SPESIALIS (KOMITE MEDIS)	3	2	0
10.	DOKTER IGD	3	0	0
11.	IGD	2	1	2
12.	SECURITY	0	0	0
13.	PARKIR	2	2	1
14.	PENUNJANG	0	0	1
15.	FASILITAS RS	4	0	2
16.	IKO	0	0	0
17.	DRIVER	0	0	0
18.	Ambulans	0	0	0
19.	Primantara	1	0	0
Total		26	15	22

3.5.7.1.1 Grafik Laporan Komplain Pasien Per Unit Juli 2026



Analisis :

Jumlah pasien complain selama Bulan Juli 2026 mengacu pada complain pasien. Asal complain pasien ditemukan dari beberapa unit yang ada di RS.

- 1. Jumlah complain Pada bulan Juni 2026 mengalami kenaikan dibanding pada bulan sebelumnya. Pada bulan Mei sebanyak 26 pasien. pada bulan Juni sebanyak 16 pasien Sedangkan pada bulan Juli sebanyak 22 pasien. .
- 2. Komplain terbanyak pada bulan Juli 2026 yaitu dari bagian pendaftaran CSO sebayak 10 kasus, UMUM sebanyak : 3 kasus, failitas sebanyak 2 kasus, IGD sebanyak 2 kasus, Parkir, IFRS, perawat, radiologi,IRJA, masing-masing 1 kasus yang disampaikan secara kuesioner, WA maupun tatap muka langsung.
- 3. Pada bulan Juli 2026 terdapat 1 complain yang tidak bisa langsung diselesaikan, diantaranya :
 - Parkir
Terdapat 1 kasus diantaranya terkait tarif parkir rawat inap yang terlalu mahal dan permintaan dilakukan pembayaran 1x untuk rawat inap

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.2 Tabel Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Juli 2026

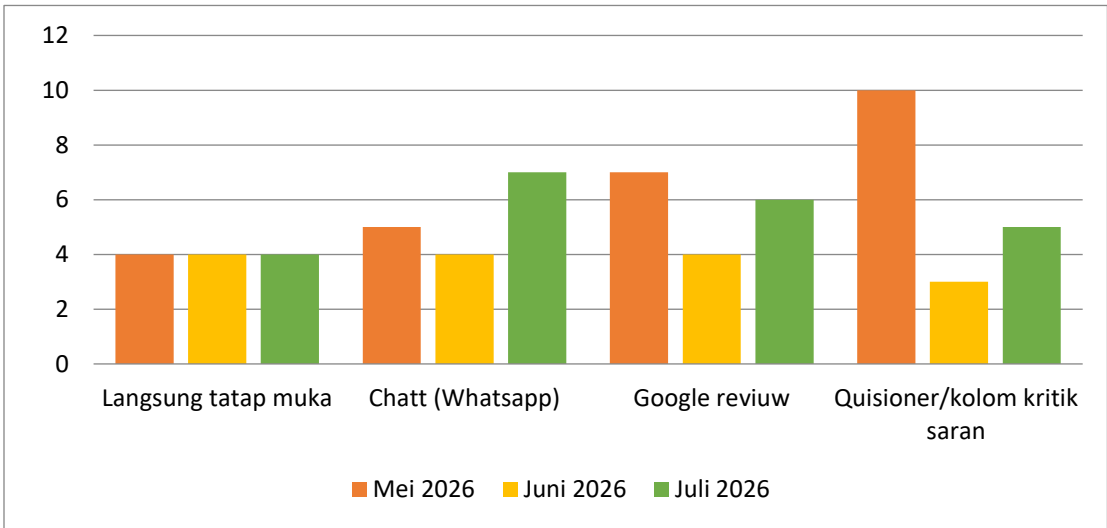
NO	Jenis Pasien Komplain	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026
1.	Langsung tatap muka	4	4	4
2.	Tidak Langsung :			
	a. Chatt (Whatsapp)	5	4	7
	b. Google reviuw	7	4	6
3.	Quisioner/kolom kritik saran	10	3	5

Rincian KESSAN

KESSAN (Kesan dan Pesan Setelah Layanan) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mendorong FKTP dalam meningkatkan layanan bagi peserta JKN-KIS serta memenuhi kewajiban terhadap kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan

KESSAN BPJS	Bintang 1	Bintang 2	Bintang 3	Bintang 4	Bintang 5
	2	0	4	245	703

3.5.7.3 Grafik Media yang Digunakan Pasien Komplain Bulan Juli 2026



Analisis :

Pada bulan Juli 2026 jumlah jenis pasien complain terbanyak didapatkan dari whatsapp sebanyak 4 kasus komplain. Sedangkan dari google riviw sebanyak 6 kasus komplain, dari Quisioner sebanyak 5 kasus complain dan dari Tatap muka sebanyak 4 kasus komplan

Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan evaluasi pada bidang atau bagian yang dikeluhkan pasien agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.4 Tabel Waktu Tanggap dan Penyelesaian Komplain Bulan Juli 2026

NO	Jenis pasien complain	Waktu tanggap		Waktu penyelesaian		< 3 hr Manajerial RS	7 hr ke PT
		Standard < 5 '	Pencapaian (dari waktu total dibagi jml komplai atau rata2 waktu tanggap)	Standard < 60 '	pencapaian		
1.	Langsung tatap muka	100%	100%	100%	100%	0	0
2.	Chatt (WA/Tele/SMS/IG)	100%	100%	100%	100%	0	0
3.	Google reviuw	100%	100%	100%	100%	0	0
4.	Quisioner/kolom kritik saran	100%	100%	100%	90%	0	10%
					4		1

Analisis :

Waktu tanggap dan penyelesaian komplain pasien pada bulan Juli 2026 masih ada yang belum sesuai target 100% yaitu complain melalui Quisioner dengan capaian 90%. hal ini dikarenakan ada beberapa kasus complain yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti fasilitas RS yang memerlukan diskusi dengan manajemen.

Pada bulan Juli 2026 terdapat 1 complain yang tidak bisa langsung diselesaikan, diantaranya:

- Parkir
Terdapat 1 kasus diantaranya terkait tarif parkir rawat inap yang terlalu mahal dan permintaan dilakukan pembayaran 1x untuk rawat inap

Rencana Tindak Lanjut :

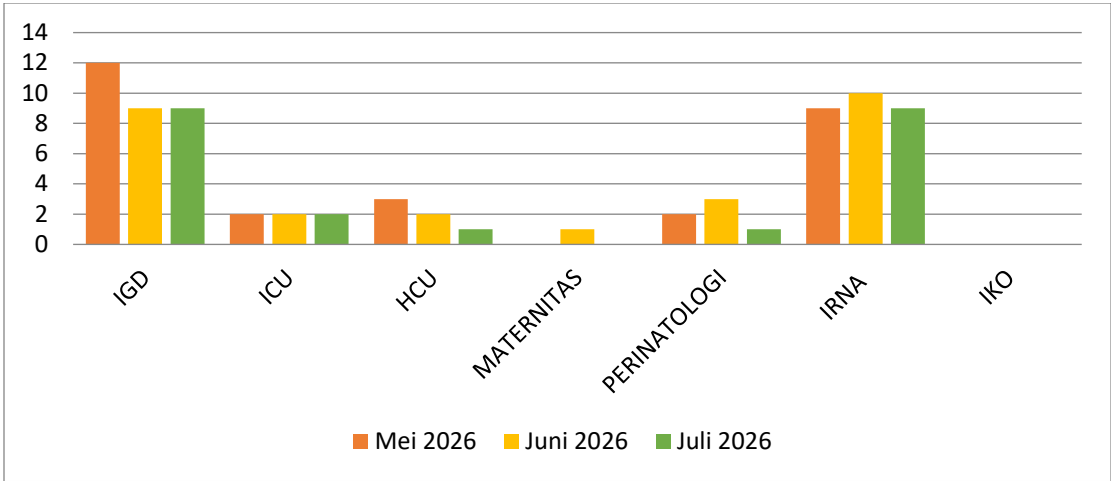
Penyelesaian complain dilakukan dengan melakukan telusur lapangan sederhana dengan kolaborasi dengan unit terkait

3.5.7.5 Laporan Pasien Rujuk
3.5.7.5.1 Tabel Distribusi Pasien Rujuk Per Unit Bulan Juli 2026

No	Unit Perujuk	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026
1.	IGD	12	9	9
2.	ICU	2	2	2
3.	HCU	3	2	1
4.	MATERNITAS	0	1	0
5.	NEONATOLOGI	2	3	1
6	IRNA	9	10	9

7	Iko	0	0	0
Total		28	27	22

3.5.7.5.2 Grafik Jumlah Pasien Rujuk Eksternal Bulan Juli 2026



3.7.7 Tabel Rincian Pasien Rujuk Juli 2026

NO	NO RM	Nama Pasien	UNIT	DIAGNOSIS	DPJP	RS TUJUAN	ALASAN RUJUK	PLAYON HABIS
1	251452	By.Ny. Weni Regita	NEO	HMD, neonatal preterm, NEC	Dr Dicky Faturrachman,Spa,M, Biomed	Rssa	pro subspesialis neonatologi dan bedah anak	Tidak
2	251637	Randhika Putra Pratama	IGD	CF Collum Femur Dextra +Pathological fr proximal femur susp malignancy	Dr Arianto, Sp.Ot	Rssa	pro biopsi guiding usg dan mri	Tidak
3	251770	Agista Putri Salsabilla	IGD	Fr impresi temporal D	Dr Fachry, Sp.Bs	Rst Soepraoen	proop multi trauma	Tidak
4	043891	Siti Aisyah	HCU	uremic encephalopathy + acute on CKD + Septic condition + Diabetic foot + HHD + DM Type II+Hiperkalemia + acidosis metabolik	Dr Ardhi Bustami,Sp.Pd	Rsud Bangil	Pro HD	Total RS: 8,129,498 Ina CBG's: 4,130,700 Minus : 3.998.798
5	203797	Tri Utami	6A	Uremic Encephalopathy, ESRD, DM	Dr Ardhi Bustami,Sp.Pd	Rsub	PRO HD CITO	Tidak
6	252055	Dani Detariadi Surya	4A	Nstemi highrisk, adhf ef 39%, dislipidemia (Idl 147)	Dr Ira Setya Waty Sp Jp	Rssa	PRO PCI	Tidak
7	162944	Solikin	ICU	NSTEMI	Dr Miryanti Cahyaningtias Sp Jp	Rs Umm	PRO PCI	Tidak
8	252146	Tn. Mohammad Edy Sudarto	IGD	STEMI anterior extensive late onset	Dr Miryanti Cahyaningtias Sp Jp	Rsi Aisyah	Pro PCI	Tidak
9	96707	Supriyanto	5C	GBS	Dr Ahmad Farid Wajdi Sp.N	Rssa	pro MRI dan Sub spesialis	Tidak
10	223952	Nurul Wardah	2A	Atrial fibrilasi susp emboli dd ich	Dr Akhmad Syahrir Sp N	Rs Wawa Husada	pro perawatan konsultan neurovascular dan CT Scan	Tidalk
11	252354	Siti Rohmah	2A	cf tibial plateau + kompartment syndrome + susp ruptur arteri/ trombus	Dr Arianto, Sp.Ot	Rssa	ro orif kp fasciotomi + trombectomy join sama btkv	Tidak
12	210639	Atharrazka Fatchur	IGD	Burn injury grade II TBSA 60%	Dr Sigit, Sp.Bp	Rssa	Pro penatalsanaan	Tidak

		Pradana					lebih lanjut	
13	251853	Laminten	IGD	CKD st 5	Dr Zoraida Dwi Wahyuni, Sp. Pd	Rs Lavalette	Pro HD	Tidak
14	252805	Sapuan	5C	efusi pleura kiri, jaundice, sepsis, trombositosis, transaminitis, hipoalbumin, hiponatremia	Dr. Andy Sp. P	Rs Karsa Husada Batu	Rujuknya pro spesialis paru subs infeksi	Tidak
15	129147	Moh Rofikul Wahyudi	4A	Susp. Meningitis Post Status General Seizure	Dr Fahimma, Sp. N	Rs Saiful Anwar	Pro LUMBAL PUNGSI	Tidak
16	88056	Siti Mutmainah	ICU	cva ich	Dr Fahimma, Sp. N	Rs Saiful Anwar	PRO neurovaskuler	Tidak
17	191565	Putri Al Aini Nabila Kulstum	IGD	spinal cord injury susp cauda equina syndrome	Dr Arianto, Sp.Ot	Rssa	pro MRI dan Sub spesialis	tidak
18	252945	Sri Lestari	IGD	CKD stg V	Dr Heri Yatmo Said Sp Pd,M.Kes	Rs Lavallette	PRO SP.PD-KGH	tidak
19	252944	Kumianah	IGD	CKD st 5	Dr Heri Yatmo Said Sp Pd,M.Kes	Rs Ub	PRO SP.PD-KGH	tidak
20	191448	Nurul Hidayati	7A	UREMIC ENCELOPATHY	Dr Ardhi Bustami,Sp.Pd	Rsud Lawang	PRO HD	tidak
21	129147	Moh Rofikul Wahyudi	4A	Susp. Meningitis, Post Status General Seizure	Dr Fahimma, Sp. N	Rssa	Pro LUMBAL PUNGSI	Tidak
22	175062	Martiah	IGD	Susp. ALO dt. non-cardiogenic dd. cardiogenic	Dr Heri Yatmo Said Sp Pd,M.Kes	Rs Karsa Husada Batu	Pro HD	Tidak

Analisis :

- Terjadi penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain dalam bulan Juli 2026.

Pada bulan Mei 2026 sebanyak 28 pasien. pada bulan Juni sebanyak 27 pasien Sedangkan pada bulan juli 2026 sebanyak 22 pasien
- Alasan rujuk karena sarana dan prasarana tidak dimiliki oleh RSPH Malang, seperti :
 - Pro PCI
 - Pro CVCU
 - Pro stroke unit
 - Pro HD
 - MRI
 - Pro bedah saraf lanjutan
 - Membutuhkan alat khusus
 - Membutuhkan pengobatan ARV
 - Alasan rujuk karena plavon habis menurun dari bulan sebelumnya.
- Pada bulan Juni tidak ada pasien plavon minus yang dilakukan rujuk Sedangkan pada bulan Juli 2026 plavon minus sebesar Rp. 3.998.798

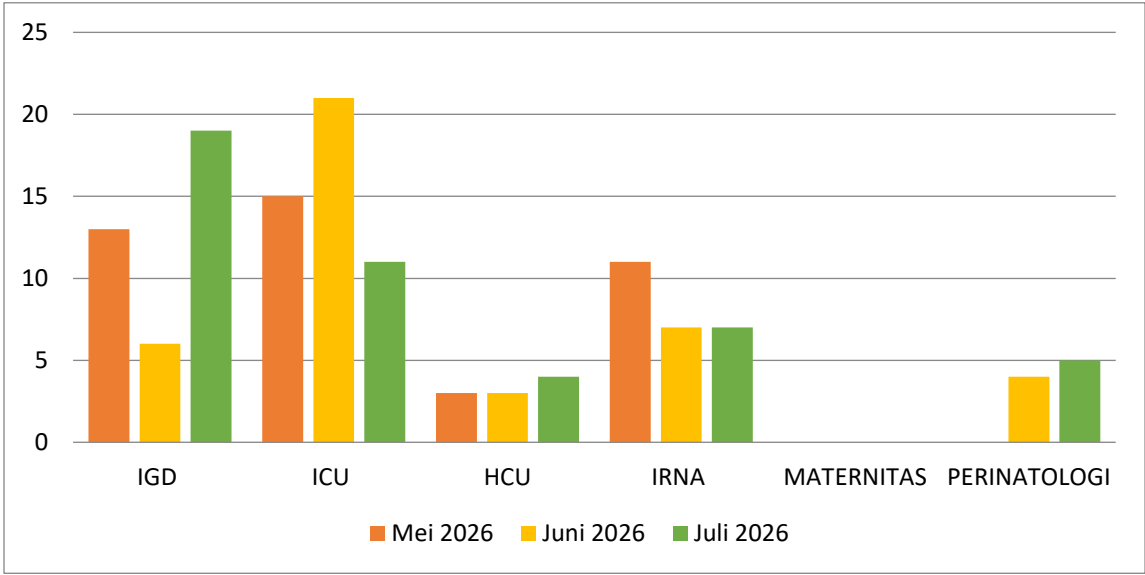
Rencana Tindak Lanjut:

- Dilakukan evaluasi alasan terhadap rujukan pasien keluar yang semakin meningkat
- Dilakukan komunikasi dengan DPJP melalui rapat komdik terkait plavon minus.

3.5.7.5.3 Jumlah Pasien Meninggal Bulan Juli 2026

No.	Unit Asal Pasien Meninggal	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026
1.	IGD	13	6	19
2.	ICU	15	21	11
3	HCU	3	3	4
4.	IRNA	11	7	7
5.	MATERNITAS	0	0	0
6	NEONATOLOGI	0	4	5
Total		42	41	46

Grafik Jumlah Pasien Meninggal Juli 2026



Tabel Rincian Pasien Meninggal Juli 2026

No	NO RM	Nama Pasien	Lama Rawat	Status	Unit	Penyebab Kematian	Diagnosis	DPJP	EWS
1	250964	Tumi	0	Bpjs Kesehatan	IGD	Cardiac Arrest	Dehidrasi Berat, Anemia dt Melena, Jaundice	Dr Heri Yatmo Said Sp Pd,M.Kes	√
2	069015	Djuman	2	Bpjs Kesehatan	HCU	Cardiac Arrest	1. krisis hiperglikemia 2. CVA 3. shock septic 4. hematemesis	Dr Ardhi Bustami,Sp.Pd	√
3		By Ny Helfia Putri Robiatussani	0		NEO	lufd	IUFD	Dr Humairah, Sp.Og	√
4	251664	An. Muhammad Gavin Mahendra	0	Umum	IGD	Cardiac Arest	DOC EC SUSP ASPIRASI	Dr Jhani	√
5	251661	By Ny. Shofia Khoirotuz Zakyya	0	Bpjs Kesehatan	NEO	Gagal Nafas	GAGAL NAFAS	Dr Dicky Faturrachman,Sp a,M,Biomed	√
6	227927	Ny.Hermin Rarasati	7	Bpjs Kesehatan	2C	Cardiac Arest	GAGAL NAFAS	Dr Heri Yatmo Said Sp Pd,M.Kes	√
7	69015	Ny.Djuman	2	Bpjs Kesehatan	HCU	Cardiac Arest	krisis hiperglikemia, CVA, shock septic	Dr Ardhi Bustami,Sp.Pd	√
8	45702	Ny. Lilis Sundari	2	Bpjs Kesehatan	IGD	Cardiac Arest	hock hipovolemik ec susp profuse vomitting	Dr Yoga Waranugraha Sp Jp	√
9	251986	Paining	2	Bpjs Kesehatan	ICU	Cardiac Arest	NSTEMI, ALO, ARDS, DM	Dr Ira Setya Waty Sp Jp	√
10	252099	Satun	0	Umum	IGD	Cardiac Arest	DOA	Dr Arara	√

11	251942	Sugiarto	0	Bpjs Kesehatan	IGD	Cardiac Arest	CARDIAC AREST	Dr Yolanda	√
12	251723	By. Ny. Rinda Rusfira Amelia	1	Bpjs Kesehatan	NEO	Imatur Bblasr	Imatur bblasr	Dr Humairah, Sp.Og	√
13	207184	Teguh Abdar Susilo	1	Bpjs Kesehatan	IGD	Cardiac Arest	CARDIAC AREST	Dr Yeni	√
14	252122	Supriyanto	0	Umum	IGD	Cardiac Arest	DOA	Dr Yolanda	√
15	54488	Iis Rosida	1	Bpjs Kesehatan	ICU	Cardiac Arest	SYOK CARDIOGENIC	Dr Yoga Waranugraha Sp Jp	√
16	252150	By Ny. Orlin Terayuni	1	Bpjs Kesehatan	NEO	Immatur	Neonatal immatur, BBLASR	Dr Humairah, Sp.Og	√
17	252144	Siti Maryam	1	Bpjs Kesehatan	IGD	Cardiac Arest	DOC dt. susp. CVA	Dr Ahmad Farid Wajdi Sp. N	√
18	63660	Tn. AGUNG BRAHMANTYO	1	BPJS KESEHATAN	IGD	Cardiac Arest	Stemi inferior + syok cardiogenik	Dr Miryanti Cahyaningtias Sp Jp	√
19	252182	Ny PAWUAH	1	BPJS KESEHATAN	IGD	Cardiac Arest	CKD stage V	Dr Adhya Aji Pratama, Sp.Pd	√
20	247665	Tn.Buang	1	Bpjs Kesehatan	ICU	Cardiac Arest	COPD AE + ACUTE RESPIRATORY FAILURE + HIPERKALEMIA	Dr. Andy Sp. P	√
21	168592	Tn Jiun	3	Bpjs Kesehatan	5C	Ca	CKD stage 4	Dr Zoraida Dwi Wahyuni, Sp. Pd	√
22	183652	Sokibin	1	Bpjs Kesehatan	7A	Cardiact Arest	gout arthritis , leukositosis , aki dd ackd	Dr Adhya Aji Pratama, Sp.Pd	√
23	252446	Semin	2	Bpjs Kesehatan	5C	Cardiac Arrest	AF RVR new onset+Adhf ef 42 %; Hiperglikemia crisis dd DM T2; ca femur sinistra on radiotx, Anemia normokrom normositer ec chronic disease	Dr Ira Setya Waty Sp Jp	√
24	252470	Nasiami	3	Bpjs Kesehatan	8A	Cardiact Arest	dm type 2	Dr Heri Yatmo Said Sp Pd,M.Kes	√
25	252574	Tiani	1	Bpjs Kesehatan	ICU	Cardiact Arest	AKI + Hematemesis + Illues obstruktif dd paralitik	Dr Ardhi Bustami,Sp.Pd	√
26	252094	Samani	2	Bpjs Kesehatan	ICU	Cardiact Arest	ARDS, susp meningitis TB ,TB Paru on terapi ,syock condition ec Pneumonia	Dr Catur Elvi Purnamawati Sp P	√
27	252684	Nuriman	1	Bpjs Kesehatan	ICU	Cardiact Arest	Pneumothorax	Dr Fachry, Sp.Bs	√
28	252472	Ngatmiatin	8	Bpjs Kesehatan	ICU	Cardiact Arest	CVA INFARK, ARDS, PNEUMONIA,DM HIPERGLIKEMIA	Dr Ahmad Farid Wajdi Sp. N	√
29	1366620	Suhartatik	3	Bpjs Kesehatan	6A	Cardiact Arest	MR, HF	Dr Yoga Waranugraha Sp Jp	√
30	252700	Asmuri	1	Umum	IGD	Cardiact Arest	Pneumonia dd TB	Dr Catur Elvi Purnamawati Sp P	√
31	252622	Magdalena Sri Astuti	0	Umum	IGD	Cardiact Arest	DOA	Dr Rino Rahmatullah	√
32	120009	Abdul Rochim	0	Umum	IGD	Cardiac Arest	DOA	Dr Isrotul	√
33	146843	Nanang Subekti	2	Bpjs Kesehatan	IGD	Cardiac Arest	ARDS, Anemia Gravis	Dr Heri Yatmo Said Sp Pd,M.Kes	√
34	252515	Mochamad Nur Mustofa	1	Umum	IGD	Cardiac Arest	DOA	Dr Rizka	√
35	252486	By Ny Siti Eni	1	Bpjs Kesehatan	NEO	Cardiac Arest	RDS ok neonatal pneumonia dd TTNB , Susp. PJB kritis	Dr Fiona Paramitha Sp.A	√
36	252447	Sugianti	1	Bpjs	IGD	Cardiac Arest	obs seizure	Dr Heri Yatmo	√

				Kesehatan				Said Sp Pd,M.Kes	
37	252857	Erni Susanti	2	Bpjs Kesehatan	ICU	Cardiac Arest	Obs dyspneu susp pneumonia,DM hiperglikemia, Obs dyspneu susp pneumonia,DM hiperglikemia	Dr Yoga Waranugraha Sp Jp	√
38	252882	Suwoto	1	Bpjs Kesehatan	HCU	Cardiac Arest	CARDIAC AREST	Dr Ira Setya Waty Sp Jp	√
39	252946	Nasi'ah	1	Bpjs Kesehatan	ICU	Cardiac Arest	SOP cerebri	Dr Fahimma, Sp. N	√
40	252954	Muhamad Javier Fajar Ramadan	1	Bpjs Kesehatan	ICU	Cardiac Arest	Syok kardiogenik + SUSP pjb	Dr Miryanti Cahyaningtias Sp Jp	√
41	252948	Reman	3	Bpjs Kesehatan	ICU	Cardiac Arest	CVA ICH	Dr Fahimma, Sp. N	√
42	125566	Dzulfikar Khoirul Anwar	1	Bpjs Kesehatan	IGD	Cardiac Arest	DOC	Dr Rino Rahmatullah	√
43	253020	Suprihatin	1	Bpjs Kesehatan	IGD	Cardiac Arest	DOC	Dr Rino Rahmatullah	√
44	252962	Sopi'i	1	Bpjs Kesehatan	IGD	Cardiac Arest	Gagal napas, susp pneumonia	Dr Catur Elvi Purnamawati Sp P	√
45	240824	Kasan	6	Bpjs Kesehatan	6A	Cardiac Arest	cva infark ht emergency	Dr Ahmad Farid Wajdi Sp. N	√
46	253068	Suheriati	1	Bpjs Kesehatan	HCU	CARDIAC AREST	syock septic dd hipovolemik, ckd, anuria	Dr Ardhi Bustami,Sp.Pd	√

- Analisa :**
- Jumlah pasien meninggal dunia pada bulan Juli 2026 sebanyak 46 pasien
 - Jumlah terbanyak yaitu dari IGD : 19 pasien, ICU : 11 pasien IRNA : 7
 - Pada bulan Juli 2026 Jumlah kasus DOA di IGD sebanyak 5 kasus.
 - Pengisian EWS sudah dilakukan di IGD dan IRNA.

Rencana Tindak Lanjut
 Dilakukan evaluasi terhadap pasien datang ke IGD dengan kasus DOA

3.5.7.6 Laporan MPP

Tabel Rekap Berdasarkan Skrining Pasien

NO	IDENTIFIKASI / SKRINING PASIEN	BULAN / JUMLAH		
		Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026
1	Usia lanjut	9	17	15
2	Kasus penyakit kronis / terminal katastropik	9	15	18
3	Riwayat penggunaan alat bantu (kursi roda, walker, tongkat, dll)	0	0	0
4	Perkiraan biaya tinggi	18	23	19
5	Kemungkinan sistem pembiayaan yang kompleks (2 asuransi)	0	0	1
6	Pasien dengan fungsi kognitif rendah	2	0	5
7	Potensial komplain tinggi	7	9	8
8	Kasus yang melebihi rata-rata lama rawat	1	0	7
9	Kasus yang diidentifikasi rencana pemulangnya	2	5	2
10	Berisiko membutuhkan kontinuitas pelayanan	3	4	10
11	Berpotensi masalah hukum	1	1	0
12	Naik kelas pelayanan	2	9	5
13	Lain - lain	27	26	24

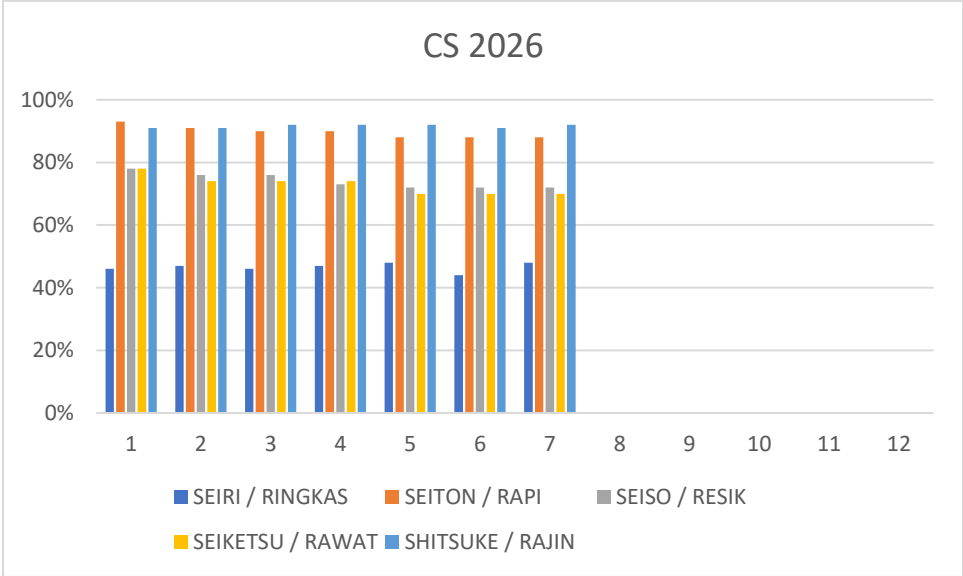
3.5.8 Cleaning Service

3.5.8.1 Indikator Kerja Cleaning Service

KATEGORI	DESKRIPSI
Seiri	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
	Penempatan Alat Kebersihan Di Janitor/ Trolly
Seiton	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas Cs
	Kerapian Baju Dan Kebersihan, Penampilan Petugas CS
Seiso	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
	Membersihkan Area Kerja Secara Rutin Sesuai Jadwal
Seiketsu	Mematuhi Sop Kebersihan
	Mematuhi SOP Kebersihan
Shiketsu	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan
	Konsistensi Dalam Menjalankan 5S Secara Mandiri Tanpa Pengawasan

3.5.8.2 Tabel Produktifitas Cleaning Service

NO	JENIS SPV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEIRI / RINGKAS	46%	47%	46%	47%	48%	44%	48%					
2	SEITON / RAPI	93%	91%	90%	90%	88%	88%	88%					
3	SEISO / RESIK	78%	76%	76%	73%	72%	72%	72%					
4	SEIKETSU / RAWAT	78%	74%	74%	74%	70%	70%	70%					
5	SHITSUKE / RAJIN	91%	91%	92%	92%	92%	91%	92%					



Analisa :
Terdapat progress pada semua factor penilaian bulan ini. Peningkatan perlu dipertahankan.

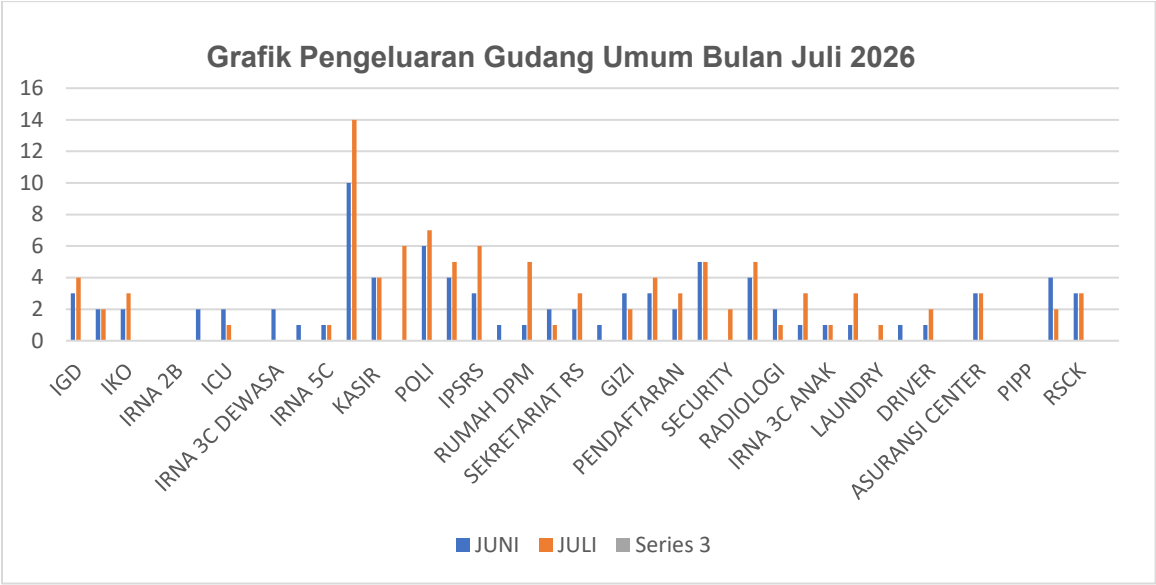
Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.5.9 Pengadaan dan Gudang Umum

3.5.9.1 Tabel Laporan Pencatatan Pengeluaran Barang

NO	UNIT ASAL	JUMLAH BARANG		PERSENTASE
		JUNI	JULI	
1	IGD	3	4	↑25%
2	MATERNITAS	2	2	↑0%
3	IKO	2	3	↑33,33%
4	IRNA 2A	0	0	↓0%
5	IRNA 2B	0	0	↓0%
6	IRNA 2C	2	0	↓100%
7	ICU	2	1	↓-100%
8	IRNA 3A+4A	0	0	↓0%
9	IRNA 3C DEWASA	2	0	↓100%
10	IRNA 4A	1	0	↓ 0 0%
11	IRNA 5C	1	1	↑0%
12	MS PTP , MS LAWANG,MS KARLOS	10	14	↑28,57%
13	KASIR	4	4	↑0%
14	DAPUR	6	6	↑0%
15	POLI	6	7	↑14,28%
16	CLEANING SERVICE	4	5	↑20%
17	IPSRS	3	6	↑50%
18	GUDANG FARMASI	1	0	↓0%
19	RUMAH DPM	1	5	↑80%
20	SEKRETARIAT PT	2	1	↓-50%
21	SEKRETARIAT RS	2	3	↑33.33%
22	CSSD	1	0	↓0%
23	GIZI	3	2	↓-50%
24	REKAM MEDIS	3	4	↑25%
25	PENDAFTARAN	2	3	↓33,33%
26	DEPO FARMASI	5	5	↑0%
27	SECURITY	0	2	↑100%
28	LABORATORIUM	4	5	↑20%
29	RADIOLOGI	2	1	↓-100%
30	FISIOTERAPI	1	3	↑66,66%
31	IRNA 3C ANAK	1	1	↓0%
32	NS NICU	1	3	↑66,66%
33	LAUNDRY	0	1	↑100%
34	LANTAI 6A,7A,8A	1	0	↑0%
35	DRIVER	1	2	↑50%
36	SIMRS	0	0	↓0%
37	ASURANSI CENTER	3	3	↓0%
38	DPW	0	0	↓0%
39	PIPP	0	0	↑0%
40	RS DH	4	2	↓100%
41	RSCK	3	3	↓0%
42	UPI MBG	0	0	↓0%

3.5.9.2 Grafik Jumlah Pengeluaran Barang Berdasarkan Asal Unit



Analisis :

Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa data barang paling banyak ada pada unit Mutiara sehat , dan Poli

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mendisiplinkan kepatuhan jadwal pengambilan barang
- 2. Memberi edukasi ke unit agar tidak salah input barang atau salah unit
- 3. Menyarankan ke seluruh unit agar punya data inventaris ATK secara terperinci

3.5.10 IT - SIMRS

1.3.5.10.1 Pemeliharaan PC Server

Tabel 6. Pemeliharaan PC Server

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2025	server SIMRS 2, CCTV, INACBG, SIMIPSRs, SYNOLOGY, FINGER, NYESHARE, SIDOKAR, FREENAS	
	FEBRUARI						
	MARET						
	APRIL	4x/tahun	1x	100%	30/01/2026	Selesai	Terlampir
	MEI						
	JUNI						
	JULI	4x/tahun	1x	100%	01/07/2026	Selesai	Terlampir
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER	4x/tahun					
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target. Selanjutnya bulan Juli 2026.

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.2 Pemeliharaan Mikrotik

Tabel Pemeliharaan Mikrotik

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	mikrotik IT (Ruang Server)	
	FEBRUARI	56x/bulan	56x	100%	Setiap hari	mikrotik IT (Ruang Server)	
	MARET	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	selesai	
	APRIL	60x/bulan	60x	100%	Setiap hari	selesai	Terlampir
	MEI	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	selesai	Terlampir
	JUNI	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	selesai	Terlampir
	JULI	62x/bulan	62x	100%	Setiap hari	selesai	Terlampir
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER						
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.3 Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV

Tabel 8. Pemeliharaan DVR dan Kamera CCTV

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	1x/bulan	1x	100%	16/01/2025	Gedung A1, A2, DPM, Gedung B, Gedung C, Maternitas, Gudang Farmasi, Poli sentral It1, It2, Ruang Server IT, Parkiran	

						Karyawan, Blok 3, Parkiran Belakang, Server IPCAM	
	FEBRUARI	1x/bulan	1x	100%	14/02/2025	Selesai	
	MARET	1x/bulan	1x	100%	09/03/2026	Selesai	
	APRIL	1x/bulan	1x	100%	24/04/2026	Selesai	Terlampir
	MEI	1x/bulan	1x	100%	20/05/2026	selesai	Terlampir
	JUNI	1x/bulan	1x	100%	22/06/2026	selesai	Terlampir
	JULI	1x/bulan	1x	100%	22/06/2026	selesai	Terlampir
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER						
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.4 Pemeliharaan Modem Internet

Tabel 9. Pemeliharaan modem internet

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2015	Modem Indibiz, D-NET, Biznet, Indihome	
	FEBRUARI						
	MARET						
	APRIL	4x/tahun	1x	100%	22/04/2026	Selesai	Terlampir
	MEI						
	JUNI						
	JULI	4x/tahun	1x	100%	07/07/2026	Selesai	Terlampir
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER	4x/tahun					
	NOVEMBER						
	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

1.3.5.10.5 Pemeliharaan Komputer Unit

Tabel Pemeliharaan Komputer unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	15PC/Bulan	4x	26%	26/01/2025	Gate Parkir, Server Gate Parkir, Server IPCAM, Irna lantai 2A	
	FEBRUARI	15PC/Bulan	7x	47%	17/02/2026	Belum selesai	
	MARET	15PC/Bulan	8x	54%	23 s/d 25 maret 2026	PC all Farmasi	
	APRIL	15PC/Bulan	21x	100%	19 s/d 26 april	Verif,rm, manajemen selesai	Terlampir
	MEI	15PC/Bulan	15PC/Bulan	21x	100%	14 s/d 17 mei	Poli Irja
	JUNI	15PC/Bulan	9	60%	21 s/d 28 Juni	Irna Gedung C	Terlampir
	JULI	15PC/Bulan	15PC/Bulan	7x	47%	8 s/d 28 juli	CSO,kasir,ki osk
	AGUSTUS	15PC/Bulan					
	SEPTEMBER	15PC/Bulan					
	OKTOBER	15PC/Bulan					
	NOVEMBER	15PC/Bulan					
	DESEMBER	15PC/Bulan					

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.6 Pemeliharaan Printer Unit

Tabel 11. Pemeliharaan Printer unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
	JANUARI	3 Printer /bulan	3x	100%	1/01/2025	PT, Rekam Medis (management), PDF IGD.	
	FEBRUARI	3 Printer /bulan	3x	100%	16/02/2026	Selesai	
	MARET	3 Printer /bulan	3x	100%	19/03/2026	Selesai	
	APRIL	3 Printer /bulan	3x	100%	22/04/2026	Selesai	
	MEI	3 Printer /bulan	3x	100%	22/04/2026	Selesai	Terlampir
	JUNI	3 Printer	3x	100%	22/04/2026	Selesai	Terlampir

		/bulan					
	JULI	3 Printer /bulan	3x	100%	08/07/2026	Selesai	Terlampir
	AGUSTUS						
	SEPTEMBER						
	OKTOBER						
	NOVEMBER						

Analisa :
 Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.7 Perapian Kabel Internet

Tabel Perapian kabel internet

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGA N	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/Tahu n	1x	25%	2/01/2025	Poli THT, Poli Syaraf 2, Poli Obgyn 2, SPI	
2	FEBRUARI						
3	MARET		1x	50%	19/03/2026		
4	APRIL						
5	MEI	4x/Tahu n	1x	50%		Selesai	Terlampir
6	JUNI						
7	JULI	4x/Tahu n	1x	100%	10/07/2026	Selesai	Terlampir
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBE R						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.8 Perapian Kabel Telepon

Tabel Perapian kabel telepon

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	31/01/2025	Ruang Server PABX	
2	FEBRUARI						
3	MARET		1x	50%	19/03/2026	Selesai	

4	APRIL						
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.9 Pemeliharaan Access Point

Tabel Pemeliharaan access point

NO	BULAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x		25%	04/01/2025	Gedung A 1-8 PT, Management, Gedung C 1-5, Gedung D 1-4. blok 3, Pdf Paru, Lounge laundry, Gudang farmasi, CSSD, Farmasi depo, Driver, DPM	
2	FEBRUARI							
3	MARET							
4	APRIL	4x/tahun	1x		50%	22/04/2026	Selesai	Terlampir
5	MEI							
6	JUNI							
7	JULI	4x/tahun	3x		80%	10/07/2026	Selesai	Terlampir
8	AGUSTUS							
9	SEPTEMBER							
10	OKTOBER							
11	NOVEMBER							
12	DESEMBER							

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.10 Pemeliharaan Switch Internet di Setiap Panel dan Unit

Tabel Pemeliharaan switch internet di setiap panel dan unit

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI					Gedung A 1-8 PT, Management, Gedung C 1-5, Gedung D 1-4. blok 3, Pdf Paru, Lounge laundry, Gudang farmasi, CSSD, Farmasi depo, Driver, DPM	
		4x/tahun	1x	25%	09/01/2025		
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL	4x/tahun	1x	50%	09/04/2025	Selesai	Terlampir
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI						
8	AGUSTUS						
9	SEPT						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5.10.11 Pemeliharaan Modem GSM

Tabel Pemeliharaan modem gsm

NO	BULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	JANUARI	4x/tahun	1x	25%	30/01/2025	Ruang Server PABX	
2	FEBRUARI						
3	MARET						
4	APRIL	4x/tahun	1x	50%	7/04/2026	1. modem mati (perlu	Terlampir

						Ganti baru)	
5	MEI						
6	JUNI						
7	JULI	4x/tahun	1x	50%	1/07/2026	Pergantian modem	Terlampir
8	AGUSTUS						
9	SEPTEMBER						
10	OKTOBER						
11	NOVEMBER						
12	DESEMBER						

Analisa : Sudah dilakukan maintenance sesuai target

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.5 10.12 Capaian Kegiatan Lainnya

No	Bulan	Kegiatan	Hasil	Petugas	Keterangan
1	Juli	Setting Server PACS	Tuntas	Internal	
2	Juli	Penarikan kabel untuk server PACS	Tuntas	Internal	
3	Juli	Melengkapi dokumen Akreditasi	Tuntas	Internal	
4	Juli	Penambahan kamera cctv area parkir mobil	tuntas	Internal	

3.3.5 10.13 Rencana Kegiatan Lainnya

	Kegiatan	Target (Bulan)	Hasil	Keterangan
	Instal aplikasi khanza di semua computer PT	Juli	Tuntas / Tidak Tuntas	SIM Khanza ALL MS Klinik
	Persiapan Survey Akreditasi	Juli	Tuntas / Tidak Tuntas	

3.3.6 Penanganan Keluhan

3.3.6.1 Keluhan Terkait Software

Tabel Keluhan Terkait Software

BULAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
Januari	51	51	100%
Februari	32	32	100%
Maret	72	72	100%
April	77	77	100%
Mei	64	64	100%

Juni	22	22	100%
Juli	6	6	100%
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.2 Keluhan Terkait Hardware

Tabel 17. Keluhan Terkait Hardware

BULAN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH TERSELESAIKAN	PROSENTASE (%)
Januari	69	69	100%
Februari	107	107	100%
Maret	54	54	100%
April	43	43	100%
Mei	34	34	100%
Juni	108	108	100%
Juli	76	76	100%
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.3 Jenis Keluhan

Tabel Keluhan Spesifik

SPESIFIK	JUMLAH											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
PC	13	30	16	24	25	21	9					

PRINTER	17	28	19	15	9	26	7					
SIMRS	4	6	10	3	2	4	1					
JARINGAN INTERNET	60	57	61	58	43	64	61					
TELPON PABX	5	5	1	4	4	5	1					
CCTV	3	3	3	3	3	3	1					
UPS	1	0	0	0	0	0	0					
HP / TAB	3	0	0	0	0	0	0					
CAMERA	2	0	0	0	0	0	0					
KEYBOARD DAN MOUSE	3	0	0	0	0	0	0					
LAINNYA	2	3	9	2	13	6	1					
TOTAL	113	132	119	109	99	129	81	0	0	0	0	0

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.4 Keluhan lain

No	Kegiatan	Jumlah	Hasil	Petugas	Keterangan
1	Komputer pdf igd konslet	1	Belum Tuntas	Internal	Vga Mati

Analisa : Sudah dilakukan penanganan

Tindak lanjut : Monitoring dan evaluasi

3.3.6.5 Progress Peremajaan

Tabel Data PC

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL PC RS	JUMLAH PC YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH PC YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	188	- RM - Verif	IRNA 2A (pakai pc ex pdf loket 6)		
2	Februari	188	- Verif - PC poli ipd perawat	IGD p2 IRNA 2A		Sudah Dilakukan peremajaan
3	Maret	188	- Verif - PC poli ipd perawat			
4	April	188	- Verif - PC poli ipd perawat - irna 2a			
5	Mei	198	-Pdf igd	-admin mutu		Pdf igd mati

				-Irna 2a Dokter		total karena konslet kesalahan user
6	Juni	198	-	-		-
7	Juli	198	-	-	-	-

Tabel Data CCTV

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL CCTV RS	JUMLAH CCTV YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH CCTV YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	100	1 (DPM Depan gerbang rumah 7b)			Pergantian power dvr yang konslet
2	Februari	100				
3	Maret	100	Power supply dvr cctv dpm			Pergantian power dvr yang konslet
4	April	101	Penambahan kamera cctv di area atm	Pindahan chanel dvr parkir ke dvr Gudang farmasi		Pemasangan baru
5	Mei	101	0	101	100%	
6	Juni	103		Penambahan kamera area parker mobil dpn igd		Pemasangan baru
7	Juli	103	-	-	-	-

Tabel Data Printer

NO	BULAN	JUMLAH TOTAL PRINTER RS	JUMLAH PRINTER YANG PERLU PEREMAJAAN	JUMLAH PRINTER YANG SUDAH DILAKUKAN PEREMAJAAN	PROSENTASE	KETERANGAN
1	Januari	44		1. Printer etiket parkir get in Jaminan		Untuk printer belum dilakukan permajaan dikarenakan akan proses ERM
2	Februari	44		1. Admin Jaminan (Ganti sensor head dengan kanibal unit printer yg		

				sudah rusak)		
3.	Maret	44	2 (printer hasil & pengantar laborat)			Head printer lx 310 sudah mulai bergaris
4.	April	44	2 (printer cso dan radiologi)	Pdf igd		Pergantian karet penarik kertas
5	Mei	44	3 (Poli jantung, cso, printer backup)			Pergantian karet penarik kertas
6	Juni	44	-			-
7	Juli	44	-			-

3.3.6.6 Downtime

Tabel Laporan Downtime

NO	TANGGAL KEJADIAN DOWNTIME	JENIS DOWNTIME (TERENCANA/TIDAK TERENCANA)	LAMA DOWNTIME	PENYEBAB DOWNTIME	RTL
1	04/07/2026	Tidak Terencana	Pendaftaran	30 Menit	Down Server BPJS
2	17/07/2026	Tidak Terencana	endaftaran	30 Menit	Down Server BPJS

3.5.11 Driver

Tabel Rekapitulasi Pengantaran Berdasarkan Keperluan

KEPERLUAN	JUMLAH											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
RUJUK PASIEN KE RS LAIN	47	44	31	36	35	28	21					
RUJUK PASIEN KE RSPHS	0	1	0	0	0	0	0					
JEMPUT RUMAH PASIEN	21	27	19	20	17	22	28					
ANTAR RUMAH PASIEN	22	21	15	25	18	20	24					
SAMPEL LAB	31	33	29	29	33	24	30					
SAMPEL SHK	3	4	3	2	1	2	3					
KEPERLUAN NONKLINIS STAF RSPHM	8	4	3	6	2	9	4					
KEPERLUAN NON KLINIS STAF PT	1	0	3	1	0	6	3					
PENGANTARAN JENAZAH	42	33	34	37	40	36	35					
RUJUK CT SCAN	0	5	0	12	6	1	67					

ANTAR MCU RSPHM	0	1	0	0	0	0	0					
LAIN-LAIN	16	17	18	11	28	9	12					
TOTAL	191	190	155	179	180	157	227					

Analisa :
Utilitas pada bulan Juli tertinggi selama 6 bulan. Rujuk CT Scan karena ada kerusakan CT Scan dalam satu bulan

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.5.12 PRIMANTARA

Tabel Jumlah Pengantaran Obat

BULAN	JUMLAH	RATA-RATA / BULAN
JANUARI	1024	40
FEBRUARI	1025	44
MARET	907	39
APRIL	1152	48
MEI	1086	47
JUNI	1117	47
JULI	1141	43
AGUSTUS		
SEPTEMBER		
OKTOBER		
NOVEMBER		
DESEMBER		
TOTAL		

Analisa :
Fluktuatif sesuai hari libur dan kenaikan pasien

Rencana Tindak Lanjut :
Monitoring dan Evaluasi

3.6 Komite dan Tim

3.6.1 Komite Mutu

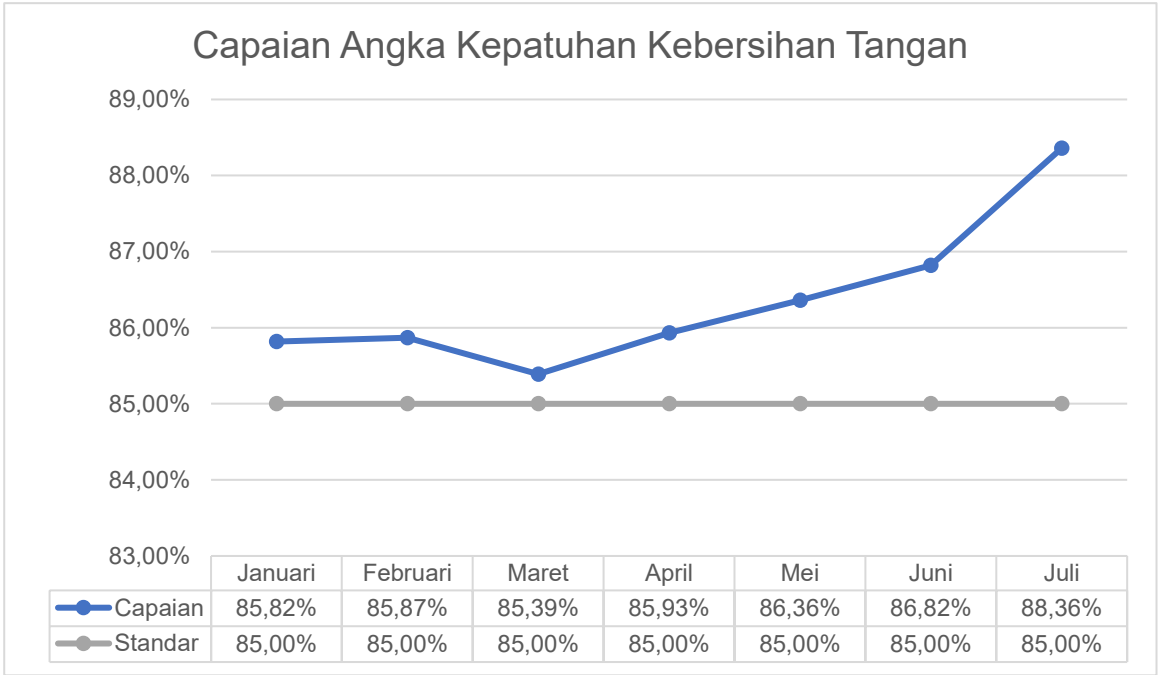
3.6.1.1 Indikator Mutu Nasional

NO	Judul Indikator	Bulan												Stan- dar	Rata- Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan	85,82%	85,87%	85,39%	85,93%	86,36%	86,82%	88,36%						≥ 85%	86,36%	Ditingkatkan
2.	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	96,82%	96,88%	96,40%	96,48%	97,13%	97,22%	96,58%						100%	96,79%	PDSA
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	99,96%	99,06%	99,89%	99,97%	99,85%	99,93%	99,77%						100%	99,78%	PDSA
4.	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%						≥ 80%	100,00%	Dipertahankan
5.	Waktu Tunggu Rawat Jalan	89,90%	86,30%	89,20%	95,04%	95,98%	93,80%	94,97%						≥ 80%	92,17%	Dipertahankan
6.	Penundaan Operasi Elektif	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						≤ 5%	0,00%	Dipertahankan
7.	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	66,75%	73,63%	68,35%	87,98%	88,55%	89,86%	84,94%						≥ 80%	80,30%	Dipertahankan
8.	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						100%	100,00%	Dipertahankan
9.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	86,13%	86,07%	86,45%	86,33%	85,81%	86,00%	86,21%						≥ 80%	86,14%	Dipertahankan
10.	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)	30,51%	16,11%	18,75%	53,33%	65,22%	87,50%	83,33%						≥ 80%	50,88%	PDSA
11.	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	91,4%	93,31%	95,60%	96,55%	91,99%	99,06%	97,12%						100%	95,35%	PDSA

12.	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							≥ 80%	100,00%	Dipertahankan
13.	Kepuasan Pasien	99,70%	99,89%	99,79%	99,88%	99,41%	99,82%	96,08%							≥ 76,61	99,22%	Dipertahankan

3.1.1 Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan

Gambar 1. Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



Analisis:

Capaian kepatuhan kebersihan tangan selama periode Januari–Juli 2026 menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten berada di atas standar minimal yang ditetapkan, yaitu 85%. Pada bulan Juli 2026, capaian kepatuhan kebersihan tangan mencapai 88,36%, dengan jumlah aksi kebersihan tangan yang dilakukan sebanyak 3.974 dari total 4.497 kesempatan yang terobservasi. Berdasarkan pengukuran Five Moments for Hand Hygiene, momen dengan tingkat kepatuhan terendah adalah sebelum kontak dengan pasien dan momen dengan tingkat kepatuhan tertinggi adalah setelah terkena cairan tubuh pasien. Secara keseluruhan, capaian kepatuhan kebersihan

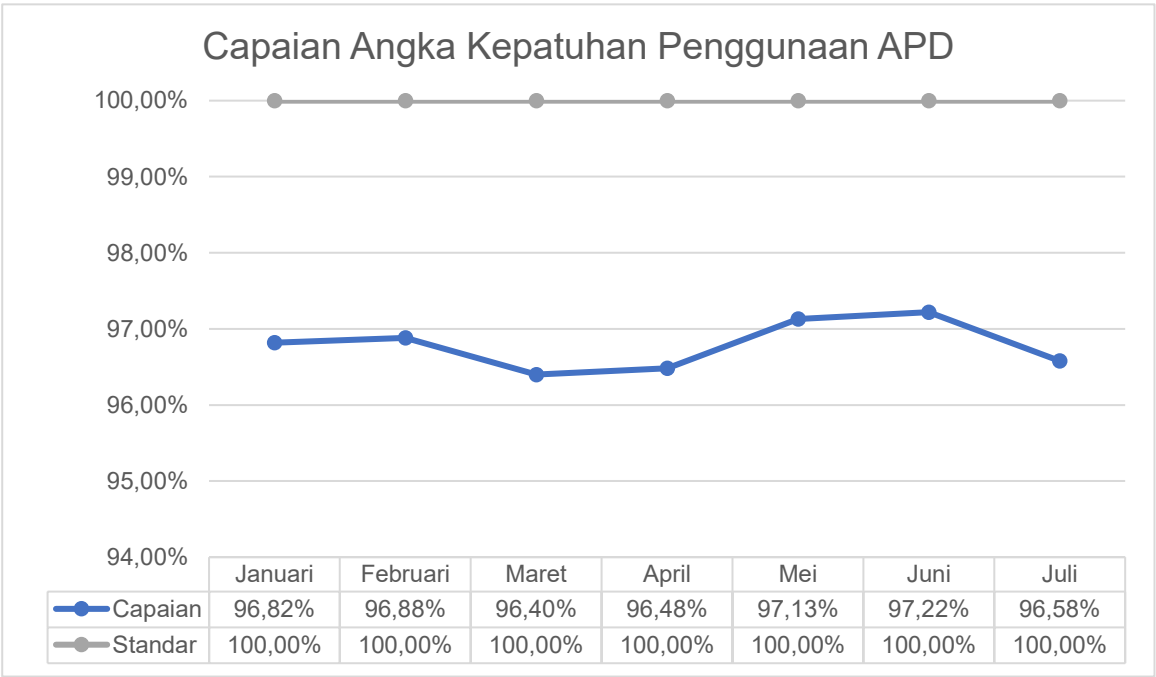
tangan pada bulan Juli mengalami peningkatan sebesar 1,54% dibandingkan dengan bulan Juni 2026.

Berdasarkan hasil pemantauan per unit, capaian kepatuhan kebersihan tangan terendah terdapat pada IRNA 8A sebesar 79,92%, diikuti oleh IRNA 7A sebesar 82,76%, dan Instalasi Laboratorium sebesar 83,00%. Sementara itu, capaian tertinggi diperoleh IRJA dan IRNA 3C dengan tingkat kepatuhan mencapai 100,00%, disusul oleh ICU sebesar 98,04%.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kepatuhan kebersihan tangan, perlu dilakukan monitoring dan supervisi secara lebih intensif oleh kepala ruangan, terutama pada unit-unit yang masih memiliki capaian di bawah standar. Selain itu, penguatan edukasi, sosialisasi, serta pemberian pengingat terkait pelaksanaan kebersihan tangan sesuai Five Moments for Hand Hygiene perlu terus dilakukan guna meningkatkan kepatuhan petugas dan mencegah terjadinya infeksi terkait pelayanan kesehatan.

3.1.2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



Analisis:

Capaian kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di RS Prima Husada Malang pada bulan Juli 2026 sebesar 96,58%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,64% dibandingkan bulan sebelumnya dan masih memiliki selisih sebesar 3,42% dari standar yang ditetapkan, yaitu 100%. Berdasarkan hasil observasi, dari total 3.949 petugas kesehatan yang dipantau, sebanyak 3.814 petugas (96,58%) telah patuh menggunakan APD sesuai ketentuan, sedangkan 135 petugas (3,42%) masih ditemukan tidak patuh dalam penggunaan APD.

Hasil pemantauan per unit menunjukkan bahwa sebanyak 16 unit telah mencapai kepatuhan penggunaan APD sebesar 100%. Namun demikian, masih terdapat 6 unit yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Capaian terendah ditemukan pada unit CSSD dengan tingkat kepatuhan sebesar 66,67%. Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh IPCN, ketidakpatuhan pada unit CSSD terutama disebabkan oleh petugas yang tidak menggunakan APD secara konsisten saat menjalankan tugas dan aktivitas pelayanan.

Untuk meningkatkan capaian kepatuhan penggunaan APD, perlu dilakukan monitoring dan supervisi secara berkelanjutan oleh kepala unit, khususnya pada unit yang belum mencapai standar. Selain itu, penguatan edukasi, sosialisasi, serta pemberian umpan balik hasil pemantauan kepada petugas perlu terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam penggunaan APD sesuai risiko pekerjaan.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Penggunaan APD pada bulan Juli tahun 2026

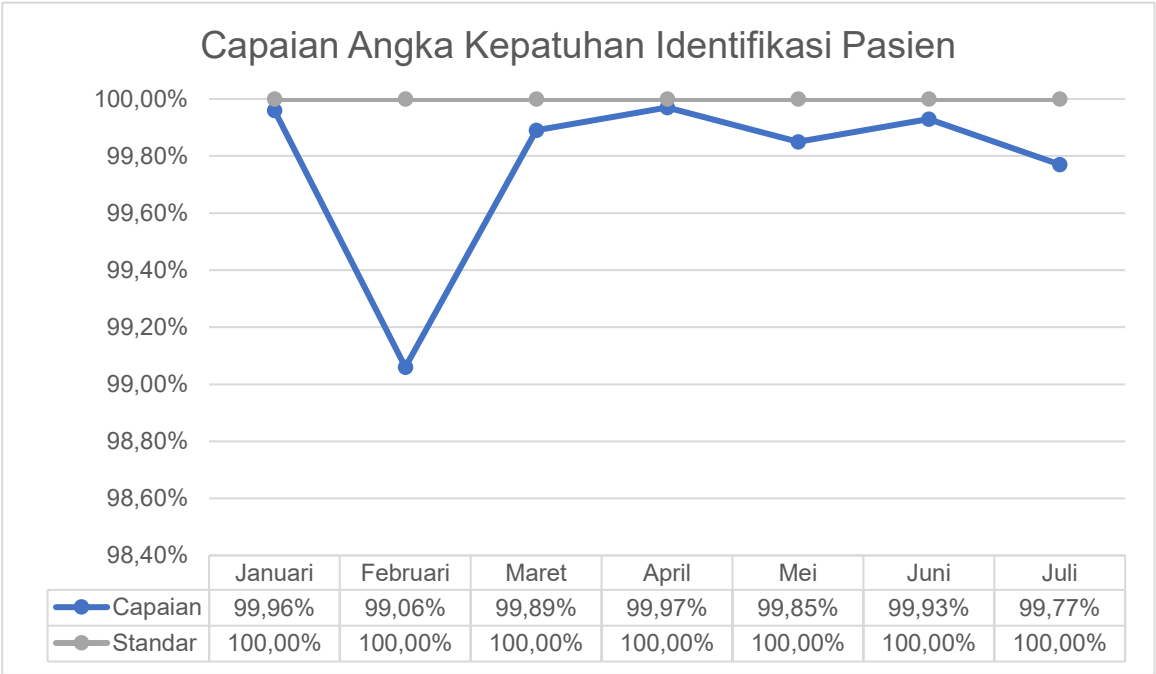
Problem	Capaian kepatuhan penggunaan APD selama Januari–Juli 2026 belum mencapai standar 100%. Meskipun capaian relatif tinggi, masih ditemukan ketidaktepatan penggunaan APD, baik penggunaan APD yang tidak lengkap maupun penggunaan APD berlebihan yang tidak sesuai indikasi, pemahaman staf mengenai indikasi penggunaan APD belum merata, kebiasaan kerja lama, dan belum meratanya monitoring dan audit kepatuhan APD.
Plan	Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD melalui penguatan edukasi mengenai penggunaan APD sesuai risiko pelayanan, supervisi oleh kepala unit, serta pemberian umpan balik terhadap hasil monitoring kepatuhan APD.
Do	• Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. • Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. • Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). • Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. • Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.
Study	Hasil monitoring menunjukkan adanya penurunan kepatuhan penggunaan APD dari 97,22% pada Juni menjadi 96,58% pada Juli. Adanya penurunan ini diharapkan menjadi pengingat untuk semakin meningkatkan pengawasan dan supervisi agar upaya peningkatan kepatuhan APD yang sebelumnya dilakukan tidak menurun lagi.
Action	Melanjutkan audit dan supervisi penggunaan APD secara rutin, mempertahankan ketersediaan APD di seluruh unit, memberikan pembinaan pada unit yang masih ditemukan ketidakpatuhan, serta mengupayakan peningkatan capaian menuju standar 100%.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Peningkatan Kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	Seluruh tenaga kesehatan	Sosialisasi ulang standar penggunaan APD sesuai indikasi	• Komite PPI, IPCN	1 bulan
2	Peningkatan pemahaman staf terkait APD	Meningkatkan pemahaman staf tentang penggunaan APD yang tepat	Perawat dan tenaga kesehatan	Edukasi dan refresh training terkait indikasi dan jenis APD	• IPCN • Kepala Ruangan	1–2 bulan
3	Peningkatan Konsistensi penggunaan APD yang benar	Meningkatkan konsistensi penggunaan APD	Seluruh staf unit pelayanan	Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback	• Komite PPI	Setiap bulan
4	Menurunkan kebiasaan penggunaan APD yang tidak sesuai	Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan)	Tenaga kesehatan di unit pelayanan	Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	• Kepala Ruangan • IPCN • Komite PMKP	Berkelanjutan
5	Kontroling ketersediaan APD	Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD	Unit pelayanan	Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi	• Komite PPI • Farmasi	Setiap bulan

3.1.3 Kepatuhan Identifikasi Pasien

Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



Analisis:

Capaian kepatuhan identifikasi pasien selama periode Januari–Juli 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten mendekati standar 100%. Pada bulan Juli, capaian kepatuhan identifikasi pasien menunjukkan angka 99,77%. Terdapat penurunan sebesar 0,13% dari bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengamatan unit, dari 17 unit yang dilakukan observasi, terdapat 4 unit yang belum mencapai standar dengan capaian terendah berasal dari unit IRNA 5C sebesar 82,00%

Secara umum capaian indikator menunjukkan stabilitas yang baik dengan rata-rata di atas 99%. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kejadian ketidaksesuaian dalam pelaksanaan identifikasi pasien yang menyebabkan capaian belum mencapai 100%. Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesalahan pemberian pelayanan, tindakan, obat, maupun pemeriksaan penunjang apabila tidak dilakukan pengendalian secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan seluruh petugas terhadap pelaksanaan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sesuai prosedur yang berlaku.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada bulan Juli tahun 2026

Problem	Capaian kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Juli 2026 sebesar 99,77% dan belum mencapai target 100%. Berdasarkan hasil observasi, masih terdapat 4 unit dari 17 unit yang dilakukan pemantauan belum mencapai standar, dengan capaian terendah terdapat pada IRNA 5C sebesar 82,00%. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan identifikasi pasien masih ditemukan sehingga berpotensi meningkatkan risiko kesalahan dalam pemberian pelayanan, tindakan, obat, maupun pemeriksaan penunjang.
Plan	Melakukan identifikasi penyebab ketidakpatuhan pada unit dengan capaian rendah melalui monitoring dan supervisi. Menyusun rencana perbaikan berupa penguatan edukasi kepada petugas, peningkatan pengawasan oleh kepala unit, pemberian umpan balik hasil capaian indikator, serta pengingat kembali terkait pelaksanaan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas sesuai standar prosedur operasional (SPO).
Do	Melaksanakan supervisi kepatuhan identifikasi pasien secara berkala pada unit pelayanan, terutama unit dengan capaian di bawah standar. Melakukan sosialisasi ulang kepada petugas terkait pentingnya identifikasi pasien sebelum pemberian pelayanan, tindakan, pemberian obat, dan pemeriksaan penunjang. Memberikan feedback hasil monitoring kepada kepala unit dan petugas terkait sebagai bahan evaluasi.
Study	Melakukan evaluasi hasil monitoring setelah pelaksanaan intervensi dengan membandingkan capaian kepatuhan sebelum dan sesudah perbaikan. Mengidentifikasi perubahan tingkat kepatuhan petugas serta mengevaluasi efektivitas edukasi dan supervisi yang telah dilakukan.
Action	Mempertahankan kegiatan monitoring dan supervisi secara rutin untuk memastikan kepatuhan identifikasi pasien tetap terjaga. Apabila masih ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan kepada unit terkait, penguatan edukasi, serta penyusunan strategi perbaikan lanjutan sesuai hasil evaluasi.

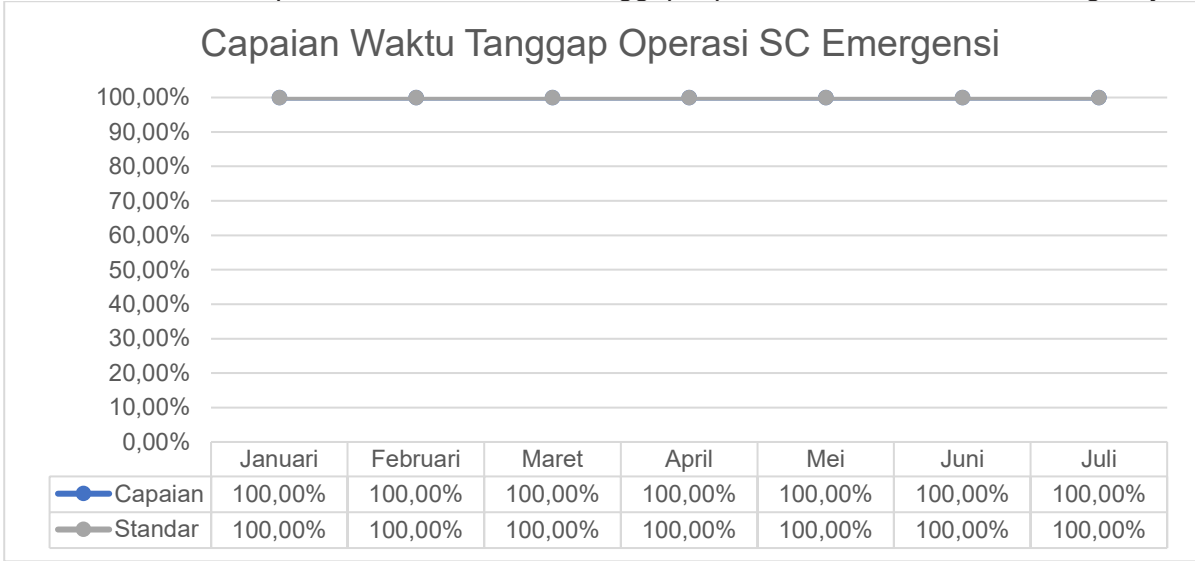
Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan pengawasan oleh kepala unit/ruangan	Meningkatkan kewaspadaan petugas untuk melakukan identifikasi pasien sesuai SOP	Seluruh tenaga kesehatan	Rumah sakit akan terus melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan identifikasi pasien secara berkala. Kepala ruangan diminta memberikan pengawasan secara langsung serta memberikan umpan balik kepada petugas yang belum patuh mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas pasien (nama lengkap dan tanggal lahir/nomor rekam medis). Edukasi terkait keselamatan pasien akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar kepatuhan identifikasi pasien	Kepala ruangan	Berkelanjutan

				dapat mencapai dan mempertahankan standar yang telah ditetapkan oleh rumah sakit.		
--	--	--	--	---	--	--

3.1.4 Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

Gambar 4. Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



Analisis:

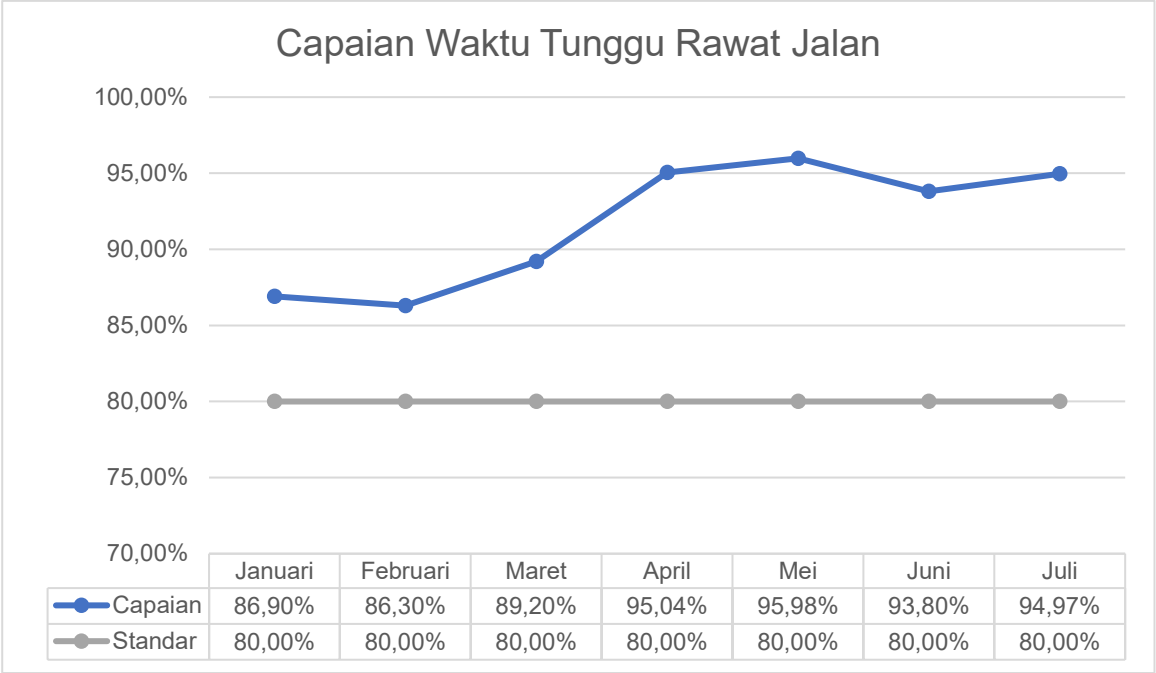
Capaian indikator waktu tanggap operasi seksio sesarea emergency pada bulan Juli 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus seksio sesarea emergency yang dilakukan selama periode pengukuran telah memenuhi standar waktu tanggap yang ditetapkan rumah sakit, sehingga pelayanan dapat diberikan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan klinis pasien.

Pencapaian 100% pada bulan Juli 2026 mencerminkan koordinasi yang efektif antara dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter anestesi, perawat kamar operasi, bidan, serta unit pendukung lainnya dalam penanganan kasus emergency. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, serta pelaksanaan alur pelayanan yang sesuai prosedur turut mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini.

Meskipun capaian telah memenuhi standar yang ditetapkan, kegiatan monitoring dan evaluasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan konsistensi mutu pelayanan serta memastikan kesiapan seluruh komponen pelayanan dalam menghadapi kasus seksio sesarea emergency di masa mendatang.

3.1.5 Waktu Tunggu Rawat Jalan

Gambar 5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan

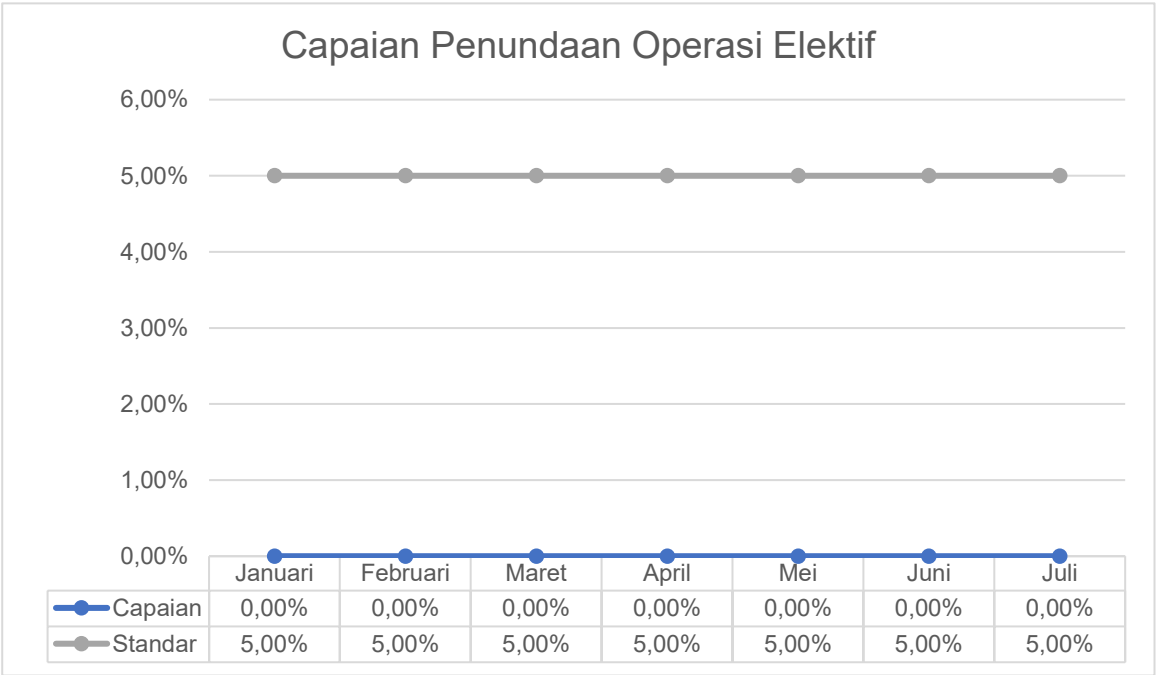


Analisis:

Capaian indikator waktu tunggu rawat jalan selama periode Januari–Juli 2026 menunjukkan hasil yang telah memenuhi standar $\geq 80\%$, namun masih mengalami fluktuasi. Capaian waktu tunggu rawat jalan bulan Juli sebesar 94,97%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,17% dari capaian bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi dari 9.867 pasien rawat jalan yang diobservasi, terdapat sebanyak 9.371 pasien rawat jalan dengan waktu tunggu ≤ 60 menit. Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan tren yang membaik dibandingkan awal tahun. Peningkatan yang terjadi mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan alur pelayanan rawat jalan, koordinasi antarunit, serta pengaturan jadwal pelayanan. Meskipun demikian, masih terdapat pasien yang mengalami waktu tunggu melebihi standar sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi capaian dan mencegah terjadinya penumpukan pasien pada jam-jam tertentu.

3.1.6 Penundaan Operasi Elektif

Gambar 6. Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



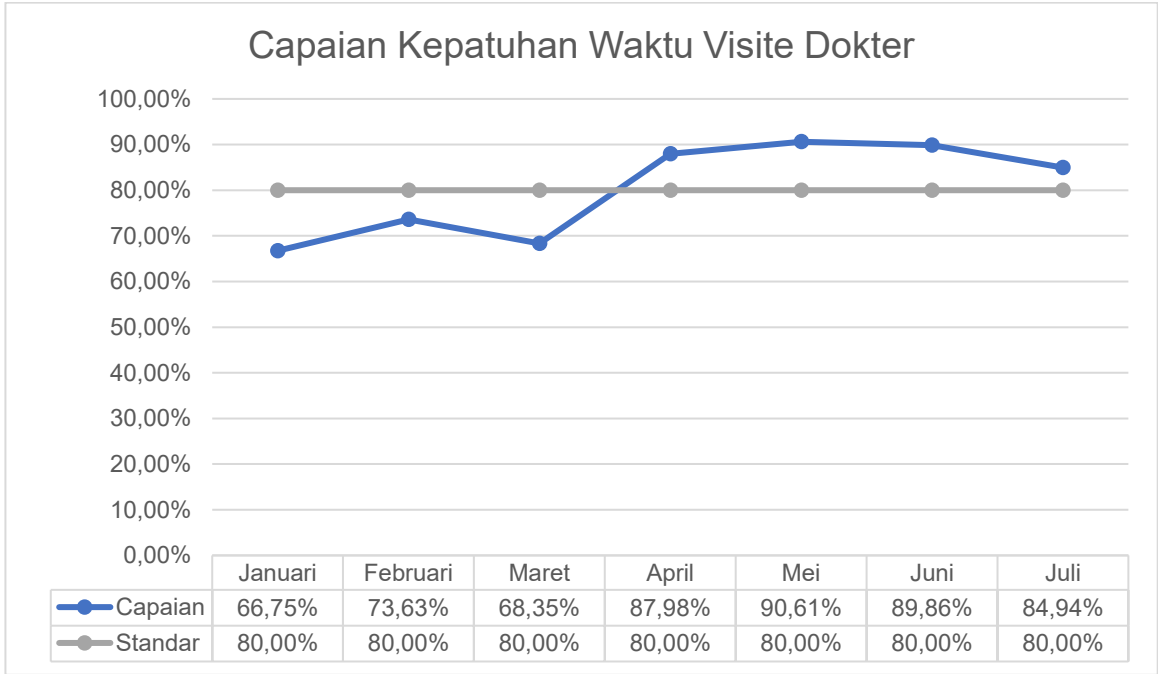
Analisis:

Capaian indikator penundaan operasi elektif selama periode Januari–Juli 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan angka penundaan sebesar 0,00% pada seluruh periode pengukuran. Dari total 189 tindakan operasi elektif yang telah dijadwalkan selama periode observasi, tidak terdapat kasus penundaan operasi, sehingga seluruh operasi dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan operasi, kesiapan pasien, ketersediaan dokter operator, dokter anestesi, ruang operasi, peralatan, bahan medis habis pakai, serta koordinasi antarunit telah berjalan dengan efektif. Tidak adanya penundaan operasi elektif juga mencerminkan pengelolaan pelayanan bedah yang baik sehingga dapat mendukung keselamatan pasien, efisiensi pelayanan, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan rumah sakit.

3.1.7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter

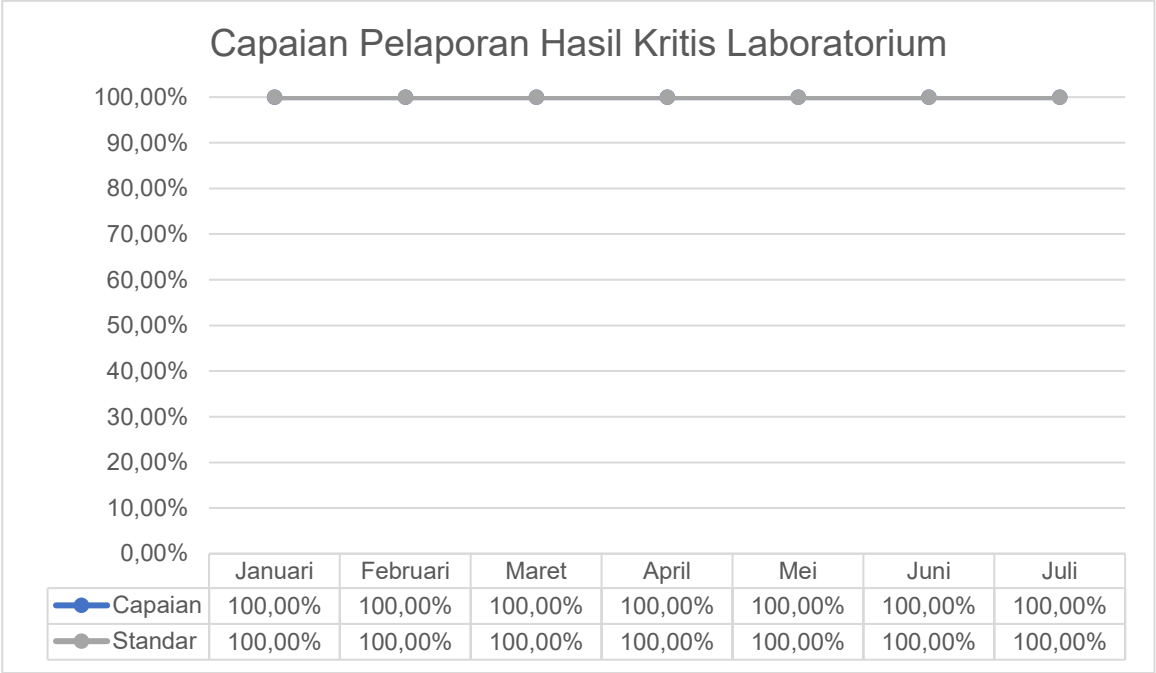


Analisis:

Capaian indikator kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Juli sebesar 84,94%. Secara kumulatif selama periode Juli 2026 dari total 1.846 pasien yang diobservasi, terdapat 1.568 pasien yang divisite dokter pukul 06.00-14.00. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dibandingkan awal tahun, namun masih terdapat 278 visite (15,06%) yang belum dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jadwal praktik dokter yang padat, keterlambatan kedatangan dokter, adanya tindakan atau pelayanan lain yang bersamaan, serta kewajiban praktik dokter di tempat lain.

3.1.8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Gambar 8. Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



Analisis:

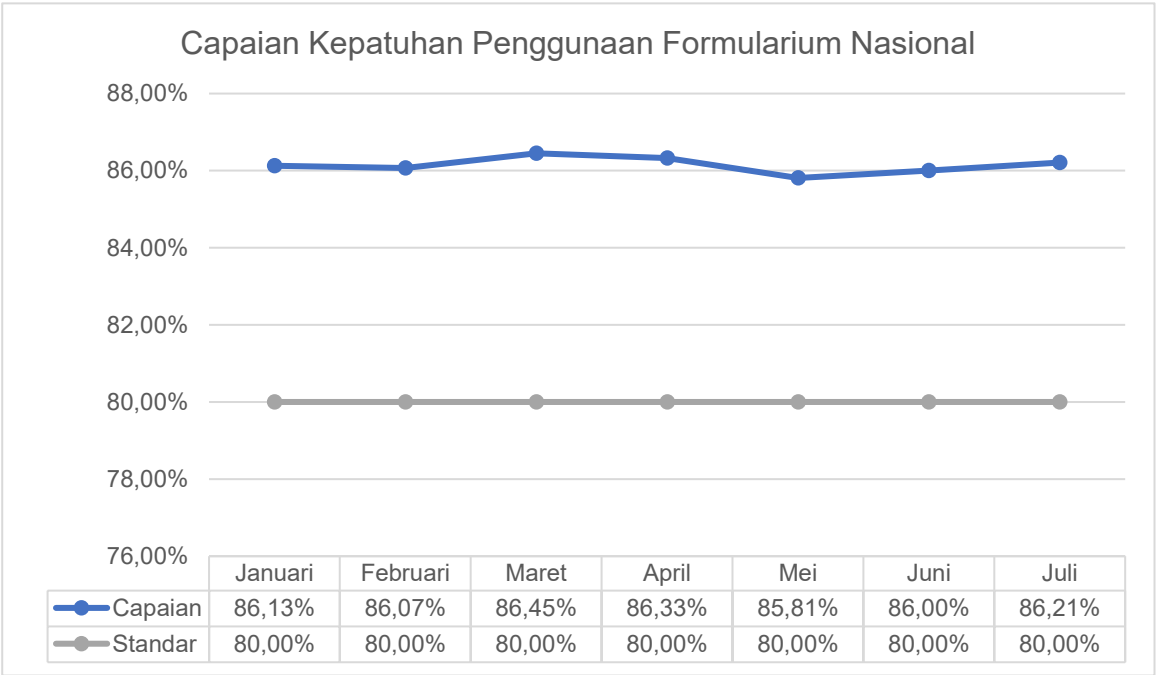
Capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Juli 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian sebesar 100%. Dari total 118 hasil kritis laboratorium yang teridentifikasi selama periode pengukuran, seluruhnya telah dilaporkan kepada dokter atau petugas yang berwenang sesuai dengan waktu yang ditetapkan, sehingga target indikator dapat tercapai secara optimal.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses identifikasi, komunikasi, dan pelaporan hasil kritis laboratorium telah berjalan dengan efektif sesuai prosedur yang berlaku. Koordinasi yang baik antara petugas laboratorium, dokter penanggung jawab pelayanan, serta unit terkait turut mendukung tersampainya informasi hasil kritis secara cepat dan tepat waktu sehingga dapat segera ditindaklanjuti dalam pengambilan keputusan klinis dan penanganan pasien.

Meskipun capaian telah memenuhi standar yang ditetapkan, kegiatan monitoring dan evaluasi perlu terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan konsistensi pelaksanaan pelaporan hasil kritis laboratorium serta mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan yang dapat berdampak terhadap keselamatan pasien.

3.1.9 Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Gambar 9. Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

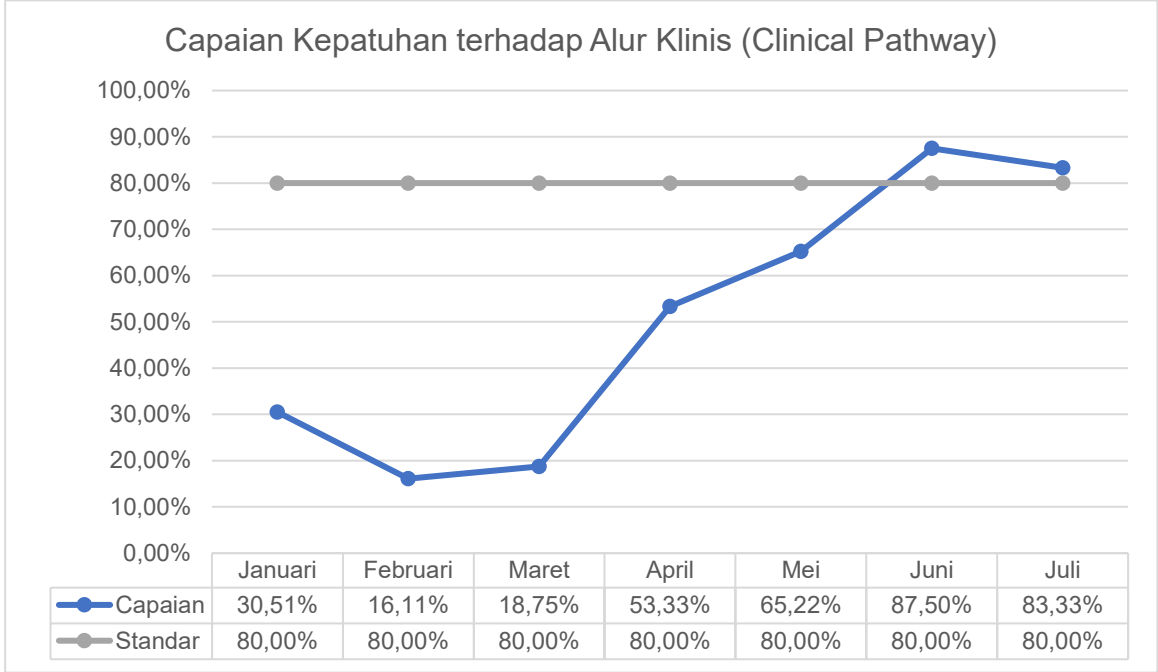


Analisis:

Capaian indikator kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas) selama periode Januari–Juli 2026 menunjukkan hasil yang stabil dan konsisten berada di atas standar yang ditetapkan yaitu $\geq 80\%$. Berdasarkan hasil pengamatan, dari total 290 resep yang diobservasi, terdapat 250 resep yang sesuai dengan formularium nasional. Secara keseluruhan, capaian indikator menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil dengan rentang nilai antara 0,21%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peresepan telah mengacu pada Formularium Nasional. Namun demikian, masih terdapat sekitar 13,79% peresepan yang belum sesuai dengan Fornas. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh kebutuhan terapi tertentu yang belum tercantum dalam Fornas, ketersediaan obat, pertimbangan klinis dokter, maupun kebiasaan peresepan yang belum sepenuhnya mengacu pada Formularium Nasional.

3.1.10 Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Gambar 10. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Analisis:

Jumlah pasien dan kepatuhan terhadap CP sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Diagnosis	Jumlah Pasien	Kepatuhan CP	
			Patuh	Tidak patuh
1	Hipertensi	2	2	0
2	DM (DM Ulkus)	9	6	3
3	Tuberkulosis	7	7	0
4	HIV	0	0	0
5	Keganasan (Ca Mammae)	0	0	0

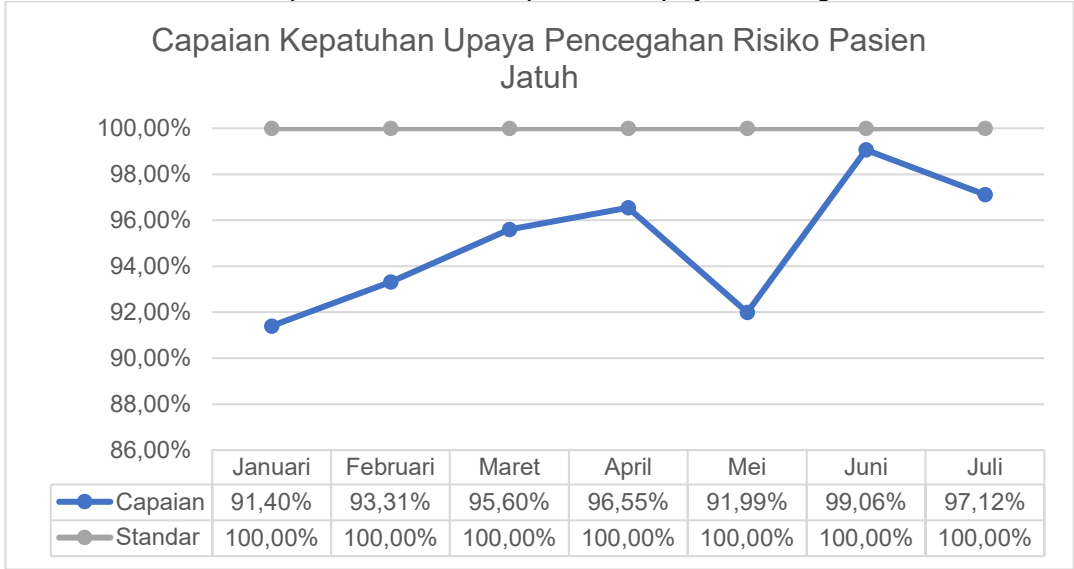
Capaian indikator kepatuhan terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) pada bulan Juli mencapai angka 83,33%. Capaian ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan ($\geq 80\%$) namun mengalami penurunan sebesar 4,17% dari bulan sebelumnya.

Pada bulan Juli, dari 18 rekam medis yang menjadi sampel evaluasi Clinical Pathway, sebanyak 15 rekam medis telah sesuai dengan alur klinis yang ditetapkan,

sehingga diperoleh capaian sebesar 83,33%. Berdasarkan diagnosis yang dievaluasi, terdapat 9 pasien Diabetes Melitus (DM Ulkus) dengan kepatuhan sebanyak 6 kasus (66,67%) dan ketidakpatuhan sebanyak 3 kasus (33,333=%). Pada diagnosis Tuberkulosis terdapat 7 pasien dan seluruhnya (100%) telah patuh terhadap Clinical Pathway. Sementara itu, pada diagnosis Hipertensi terdapat 2 pasien dan telah memenuhi kepatuhan Clinical Pathway (100%). Tidak terdapat pasien dengan diagnosis Keganasan (Ca Mammae) maupun HIV yang menjadi sampel evaluasi pada periode ini. Selanjutnya, perlu dilakukan rapat dengan SMF penyakit terkait untuk melakukan kesepakatan mengenai pelayanan yang diberikan.

3.1.11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Gambar 11. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Analisis:

Capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh pada bulan Juli 2026 sebesar 97,12%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,94% dibandingkan bulan sebelumnya dan masih memiliki selisih sebesar 2,88% dari standar yang ditetapkan, yaitu 100%. Berdasarkan hasil observasi, dari total 2.742 pasien yang dipantau, sebanyak 2.663 pasien telah mendapatkan upaya pencegahan risiko jatuh secara lengkap sesuai ketentuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar petugas telah melaksanakan upaya pencegahan risiko pasien jatuh dengan baik, meskipun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil pemantauan per unit, dari 13 unit yang dilakukan observasi, terdapat 4 unit yang masih belum mencapai standar. Capaian terendah ditemukan pada unit IRNA 4A dengan tingkat kepatuhan sebesar 79,12%. Selain itu, unit IRNA 2A, IRNA 5C, dan IRNA 6A juga masih memiliki capaian di bawah standar yang

ditetapkan. Penurunan capaian pada bulan Juli menunjukkan perlunya penguatan implementasi upaya pencegahan risiko pasien jatuh, terutama pada unit-unit dengan tingkat kepatuhan yang masih rendah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan monitoring dan supervisi oleh kepala ruangan, melakukan edukasi ulang kepada petugas terkait pelaksanaan asesmen dan intervensi pencegahan risiko jatuh, serta memberikan umpan balik hasil monitoring kepada unit terkait. Dengan pelaksanaan perbaikan yang berkesinambungan, diharapkan kepatuhan petugas dapat meningkat dan risiko kejadian pasien jatuh dapat diminimalkan.

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	
Problem	Capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh pada bulan Juli 2026 sebesar 97,12%, mengalami penurunan sebesar 1,94% dibandingkan bulan sebelumnya dan belum mencapai standar 100%. Dari 13 unit yang diamati, terdapat 4 unit yang masih berada di bawah standar, dengan capaian terendah pada IRNA 4A sebesar 79,12%. Ketidakpatuhan terutama ditemukan pada pelaksanaan intervensi pencegahan risiko jatuh yang belum dilakukan secara lengkap dan konsisten sesuai asesmen risiko pasien.
Plan	Mengidentifikasi penyebab ketidakpatuhan pada unit dengan capaian rendah melalui supervisi dan audit kepatuhan. Menyusun rencana perbaikan berupa penguatan edukasi kepada petugas, peningkatan monitoring oleh kepala ruangan, pemberian umpan balik hasil capaian indikator, serta pengingat kembali terkait pelaksanaan asesmen dan intervensi pencegahan risiko pasien jatuh sesuai SPO.
Do	Melaksanakan supervisi dan observasi langsung pada unit yang belum mencapai standar. Melakukan sosialisasi ulang mengenai asesmen risiko jatuh dan implementasi bundle pencegahan pasien jatuh. Memberikan feedback kepada kepala ruangan dan petugas terkait hasil monitoring serta temuan ketidakpatuhan yang masih terjadi.
Study	Terdapat penurunan capaian di bulan Juli menjadi pengingat perlunya penguatan audit dan supervisi rutin agar upaya yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditingkatkan dan tidak terjadi penurunan lagi.
Action	Mempertahankan pelaksanaan audit dan supervisi rutin, melakukan monitoring rutin pemasangan tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker) serta menjadikan kepatuhan pencegahan risiko jatuh sebagai salah satu fokus monitoring keselamatan pasien untuk mencapai dan mempertahankan capaian 100%.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga/penunggu pasien untuk pencegahan jatuh	Meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai upaya pencegahan risiko jatuh selama perawatan	Pasien risiko jatuh dan keluarga/penunggu pasien	- Memberikan edukasi secara langsung saat pasien masuk rawat inap - Menggunakan media edukasi seperti leaflet/poster - Mengingatkan keluarga untuk mendampingi pasien risiko jatuh	- Perawat ruangan - Kepala ruangan - Komite Mutu	Berkelanjutan

				• Melakukan dokumentasi edukasi pada rekam medis		
2	Monitoring pemasangan tanda risiko jatuh (gelang/label/stiker)	Meningkatkan kedisiplinan staf dalam pencegahan risiko pasien jatuh	Perawat dan tenaga kesehatan	• Melakukan monitoring harian pemasangan gelang/label/stiker risiko jatuh • Melakukan audit kepatuhan secara berkala • Memberikan umpan balik kepada petugas apabila ditemukan ketidaksesuaian • Mengingatkan petugas melalui briefing/safety morning	• Perawat ruangan • Kepala ruangan • Komite Mutu	Berkelanjutan

3.1.12 Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

Gambar 12. Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Komplain



Analisis:

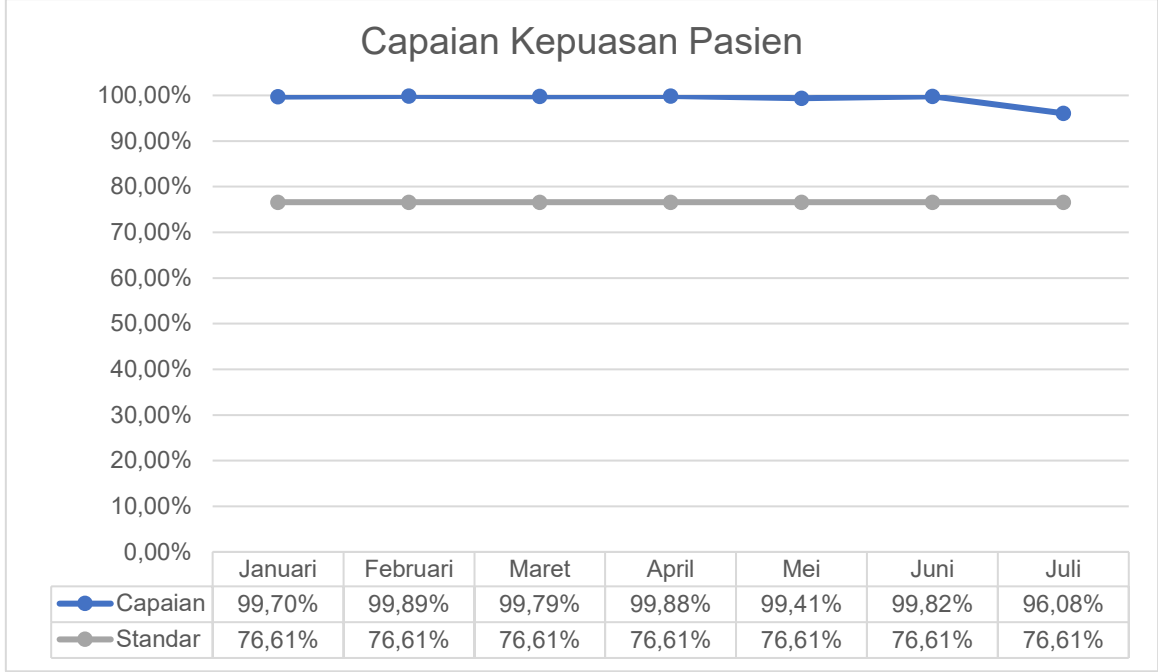
Capaian indikator kecepatan waktu tanggap komplain selama periode Januari–Juli 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 100% pada seluruh bulan pengukuran. Pada periode Juli 2026 terdapat 4 komplain yang diterima rumah sakit dan seluruhnya (4 komplain) telah ditindaklanjuti sesuai dengan standar waktu tanggap yang ditetapkan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

Capaian yang konsisten ini menunjukkan bahwa mekanisme penerimaan, pelaporan, koordinasi, dan penyelesaian komplain telah berjalan efektif. Respons yang cepat terhadap komplain merupakan salah satu bentuk komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan, sekaligus menjadi sarana untuk memperoleh masukan dalam upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Meskipun capaian telah memenuhi standar, evaluasi terhadap substansi komplain tetap perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area pelayanan yang masih memerlukan perbaikan sehingga tidak hanya berfokus pada kecepatan respons, tetapi juga pada efektivitas penyelesaian masalah yang dikeluhkan oleh pasien atau keluarga.

3.1.13 Kepuasan Pasien

Gambar 3.1.13 Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Analisis:
Capaian indikator kepuasan pasien selama periode Januari–Juli 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten berada di atas standar yang ditetapkan. Pada bulan Januari capaian sebesar 99,70%, meningkat menjadi 99,89% pada Februari, kemudian sedikit menurun menjadi 99,79% pada Maret. Pada bulan April capaian kembali meningkat menjadi 99,88%, menurun menjadi 99,41% pada Mei, dan meningkat kembali menjadi 99,82% pada Juni. Namun, capaian pada bulan Juli mengalami penurunan sebesar 3,74% dari bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi komplain, ketidakpuasan pasien terdapat pada informasi perubahan jadwal, kebersihan RS, fasilitas RS, dan sikap salah satu nakes. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum pelayanan rumah sakit telah mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pasien dengan sangat baik. Meskipun capaian indikator sangat tinggi dan stabil, evaluasi terhadap aspek pelayanan yang masih menjadi sumber ketidakpuasan tetap perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu berkelanjutan. Masukan dari pasien dapat menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, komunikasi petugas, maupun aspek fasilitas yang masih memerlukan penyempurnaan.

3.2 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien

No.	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (farmasi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100,00%	Dipertahankan
2.	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (radiologi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100,00%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan penempelan label obat LASA dan obat obatan High Alert dirawat inap	92,42%	92,14%	92,90%	92,83%	93,06%	93,00%	92,93%						100%	92,75%	PDSA
4.	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (IKO)	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%	100%						100%	98,50%	Dipertahankan
5.	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (PPI)	85,05%	85,70%	85,91%	86,59%	83,10%	84,15%	86,24%						100%	85,25%	PDSA
6.	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (IGD, IRNA, IKO)	-	87,11%	92,08%	98,42%	90,16%	99,11%	98,72%						100%	92,89%	PDSA

Analisis:

1. Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Juli 2026, capaian kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pada pasien rawat jalan mencapai 100%. Capaian tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit, yaitu 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh petugas secara konsisten melakukan proses verifikasi identitas pasien sebelum menyerahkan obat.

Capaian ini mencerminkan bahwa implementasi prosedur identifikasi pasien di unit pelayanan rawat jalan telah berjalan dengan baik dan menjadi bagian dari budaya kerja petugas. Kepatuhan yang optimal juga menunjukkan efektivitas sosialisasi, supervisi, serta pemahaman petugas terhadap pentingnya identifikasi pasien sebagai salah satu sasaran keselamatan pasien.

Keberhasilan mempertahankan capaian 100% berkontribusi dalam mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat akibat kesalahan identifikasi pasien, sehingga risiko insiden keselamatan pasien dapat diminimalkan. Meskipun target telah tercapai, kegiatan monitoring dan evaluasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan tetap terjaga dan mengantisipasi potensi penurunan capaian pada periode berikutnya

2. Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Juli 2026, capaian kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi mencapai 100%. Capaian tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit, yaitu sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh hasil pemeriksaan radiologi yang termasuk dalam kategori kritis telah dilaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Capaian yang konsisten selama periode Januari–Juli 2026 menunjukkan bahwa proses identifikasi, komunikasi, dan pelaporan hasil kritis radiologi telah berjalan secara efektif. Hal ini didukung oleh kepatuhan petugas terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO), koordinasi yang baik antarprofesi, serta mekanisme komunikasi hasil kritis yang telah dipahami dan diterapkan oleh seluruh petugas terkait.

Pencapaian indikator ini berperan penting dalam mendukung keselamatan pasien karena memastikan hasil pemeriksaan kritis yang membutuhkan tindak lanjut segera dapat diterima oleh dokter secara tepat waktu, sehingga keputusan klinis dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Meskipun capaian telah memenuhi target, kegiatan monitoring, evaluasi, dan penguatan komunikasi hasil kritis tetap perlu dipertahankan secara berkelanjutan untuk menjaga konsistensi mutu pelayanan serta mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan di masa mendatang.

3. Berdasarkan hasil pengukuran periode Januari–Juli 2026, capaian kepatuhan penempelan label obat LASA (Look Alike Sound Alike) dan obat High Alert di ruang rawat inap pada bulan Juli 2026 sebesar 92,93%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 0,07% dibandingkan dengan bulan Juni 2026 dan masih belum mencapai standar yang ditetapkan rumah sakit, yaitu 100%.

Secara tren, capaian indikator selama periode Januari–Juli 2026 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Pada bulan Februari terjadi penurunan sebesar 0,28% dibandingkan bulan Januari, kemudian mengalami peningkatan pada bulan Maret menjadi 92,90%. Pada bulan April capaian kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 92,83%, selanjutnya meningkat pada bulan Mei menjadi 93,06%, kemudian menurun menjadi 93,00% pada bulan Juni dan kembali mengalami sedikit penurunan pada bulan Juli menjadi 92,93%.

Belum tercapainya standar kepatuhan 100% menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pelabelan obat LASA dan High Alert di unit pelayanan. Berdasarkan hasil monitoring, ketidaksesuaian dapat disebabkan oleh masih adanya obat LASA dan High Alert yang belum diberikan label sesuai ketentuan, kurang konsistennya pelaksanaan pengecekan oleh petugas, serta adanya penambahan stok obat baru yang belum segera dilakukan pelabelan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kesalahan pengambilan maupun pemberian obat yang dapat berdampak terhadap keselamatan pasien.

Sebagai upaya perbaikan, diperlukan penguatan monitoring dan supervisi secara berkala terhadap kepatuhan pelabelan obat LASA dan High Alert, terutama pada unit dengan capaian rendah. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara Instalasi Farmasi dan unit perawatan, pelaksanaan inspeksi rutin terhadap penyimpanan obat, serta pemberian edukasi dan umpan balik kepada petugas terkait pentingnya kepatuhan pelabelan obat berisiko tinggi. Dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan capaian indikator dapat meningkat dan mencapai standar yang telah ditetapkan rumah sakit.

4. Capaian kepatuhan penandaan lokasi operasi pada bulan Juli mencapai 100%. Terdapat peningkatan sebesar 8,99% dari bulan sebelumnya. Capaian ini sudah mencapai standar yang ditetapkan. Untuk mempertahankan capaian, perlu dilakukan penguatan pelaksanaan Surgical Safety Checklist, serta peningkatan supervisi dan koordinasi dengan dokter operator dan tim bedah agar kepatuhan kembali mencapai standar 100%.
5. Berdasarkan hasil pengukuran bulan Juli, capaian kepatuhan petugas kesehatan melakukan 6 langkah cuci tangan sebesar 86,24%. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 2,09% dari bulan sebelumnya. Namun, capaian ini belum memenuhi standar yang ditetapkan. Belum tercapainya target menunjukkan bahwa pelaksanaan 6 langkah cuci tangan masih belum konsisten dilakukan oleh seluruh petugas kesehatan. Untuk meningkatkan capaian, perlu dilakukan penguatan edukasi, monitoring dan supervisi rutin, serta pemberian umpan balik kepada unit yang belum mencapai target guna mendukung upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Berdasarkan pengamatan unit, dari 19 unit yang diobservasi, terdapat 2 unit yang sudah mencapai standar yakni ICU dan IRNA 3C. Sementara itu, unit yang memiliki capaian terendah berasal dari instalasi gizi dengan capaian sebesar 58,72% dan instalasi farmasi sebesar 79,31%.
6. Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Juli 2026, capaian kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar mencapai 98,72%. Capaian

tersebut masih belum memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit, yaitu sebesar 100%.

Secara tren, capaian indikator menunjukkan peningkatan dari bulan Januari hingga April, kemudian mengalami penurunan pada bulan Mei, sedikit meningkat kembali pada bulan Juni, dan kembali menurun pada bulan Juli. Meskipun capaian masih tergolong tinggi, belum tercapainya target menunjukkan bahwa pelaksanaan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar sebagai upaya pencegahan risiko jatuh belum dilakukan secara konsisten oleh seluruh petugas kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian indikator, perlu dilakukan penguatan edukasi dan sosialisasi kepada petugas terkait pentingnya pemasangan handrail dan penguncian roda brankar sebelum transportasi pasien. Selain itu, perlu ditingkatkan kegiatan monitoring dan supervisi oleh kepala ruangan, pelaksanaan audit kepatuhan secara berkala, pemberian umpan balik terhadap hasil pemantauan kepada unit terkait. Dengan upaya tersebut diharapkan kepatuhan petugas dapat meningkat dan target indikator sebesar 100% dapat tercapai.

3.3 Indikator Mutu Pelayanan Klinis Prioritas

No.	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1.	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	-	7,08%	12,50%	11,9%	3,53%	71,43 %	90%						100%	64,36%	PDSA
2.	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Rawat Inap)	-	12,1%	21,48%	12,34%	3,5%	100,00 %	100%						100%	100,00%	Dipertahankan
3.	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Rawat Inap)	-	8,31%	12,05%	17,94%	4,94%	71,43 %	66,67%						100%	65,02%	PDSA

Analisis:

1. Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Juli, capaian kepatuhan pengisian form discharge planning pasien DM dengan ulkus sebesar 90%. Capaian ini merupakan yang tertinggi selama periode Januari-Juli. Selama periode tersebut, capaian indikator belum mencapai standar rumah sakit sebesar 100%.
Secara tren, capaian menunjukkan peningkatan dibanding awal tahun meskipun sempat mengalami fluktuasi pada bulan Maret dan Mei. Capaian tinggi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan dan dokumentasi *discharge planning*. Adanya peningkatan kepatuhan pengisian *discharge planning* terjadi karena penguatan supervisi untuk mengisi form. Adanya gap 10% dengan standar dikarenakan terdapat 4 dari 8 form discharge planning yang diobservasi belum dibubuhi tanda tangan MPP. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan monitoring, supervisi, dan kepatuhan petugas dalam pengisian form agar seluruh pasien DM dengan ulkus mendapatkan *discharge planning* yang terdokumentasi lengkap sesuai standar.
2. Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Juli 2026, capaian kepatuhan pengisian form edukasi pada pasien DM dengan ulkus mencapai 100%. Capaian tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit, yaitu 100%, dan konsisten tercapai selama periode Januari–Juli 2026.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa proses pemberian dan pendokumentasian edukasi kepada pasien DM dengan ulkus telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsistensi capaian selama periode pengukuran mencerminkan komitmen tenaga kesehatan dalam memastikan pasien dan keluarga mendapatkan edukasi yang diperlukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kesinambungan perawatan pasien.
eberhasilan mempertahankan capaian 100% menunjukkan bahwa pelaksanaan edukasi dan dokumentasi telah menjadi bagian dari proses pelayanan rutin. Meskipun target telah tercapai, kegiatan monitoring dan evaluasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan kepatuhan serta memastikan kualitas edukasi yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan pasien.
3. Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Juli 2026, capaian kepatuhan penerapan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) pasien Diabetes Melitus (DM) rawat inap mencapai 66,67%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 4,76% dibandingkan bulan Juni 2026 dan masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan rumah sakit. Secara tren, capaian kepatuhan PPK dan CP DM menunjukkan fluktuasi selama periode Januari–Juli 2026. Capaian terendah terjadi pada bulan

Februari sebesar 42,86%, sedangkan capaian tertinggi dicapai pada bulan Mei sebesar 83,33%. Meskipun secara keseluruhan terdapat peningkatan dibandingkan awal tahun, hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi dan dokumentasi PPK serta CP pada pasien DM rawat inap masih belum dilakukan secara konsisten.

Belum optimalnya capaian indikator dapat disebabkan oleh kurang optimalnya monitoring pelaksanaan PPK dan CP, serta belum konsistennya keterlibatan seluruh profesi dalam penerapan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat memengaruhi keseragaman pelayanan, efektivitas tata laksana pasien, serta evaluasi mutu pelayanan yang berbasis Clinical Pathway.

Untuk meningkatkan capaian indikator, perlu dilakukan penguatan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pengisian Clinical Pathway, peningkatan koordinasi antarprofesi dalam penerapan PPK dan CP, serta pemberian umpan balik secara berkala kepada unit dan DPJP terkait hasil capaian yang diperoleh. Selain itu, supervisi dan pendampingan terhadap petugas dalam pengisian dokumen Clinical Pathway perlu terus ditingkatkan agar implementasi pelayanan sesuai PPK dan CP dapat berjalan lebih optimal dan mencapai standar yang ditetapkan rumah sakit.

3.4 Tujuan Strategis

NO	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Juli '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26			
1.	Kejadian komplain pasien / keluarga di <i>google review</i>	5	1	3	11	7	4							0	5,17	PDSA

Analisis:

Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Juli 2026, terdapat 6 kejadian komplain pasien/keluarga yang disampaikan melalui Google Review. Capaian indikator ini masih belum memenuhi standar yang ditetapkan rumah sakit, yaitu 0 kejadian komplain. Selama periode Januari–Juli 2026, jumlah komplain menunjukkan pola fluktuatif dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan April sebanyak 11 komplain dan jumlah terendah pada bulan Februari sebanyak 1 komplain.

Adanya komplain yang disampaikan oleh pasien/keluarga menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara harapan pengguna layanan dengan pelayanan yang diterima selama proses perawatan maupun pelayanan di rumah sakit. Setiap komplain perlu menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi faktor penyebab, baik yang berkaitan dengan komunikasi petugas, proses pelayanan, waktu tunggu, fasilitas, maupun aspek lain yang memengaruhi pengalaman pasien.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperlukan penguatan pengelolaan komplain secara komprehensif melalui analisis akar masalah pada setiap keluhan yang masuk, percepatan respons dan penyelesaian keluhan, serta peningkatan komunikasi efektif antara petugas dengan pasien dan keluarga. Selain itu, penguatan budaya pelayanan prima melalui edukasi dan supervisi kepada petugas perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan meningkat dan kejadian komplain dapat diminimalkan.

Meskipun jumlah komplain mengalami penurunan dibandingkan bulan dengan kejadian tertinggi, upaya perbaikan tetap perlu dipertahankan untuk mencapai target indikator yaitu tidak adanya komplain pasien/keluarga serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien terhadap pelayanan rumah sakit.

3.5 Perbaikan Sistem

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26			
1.	Waktu tunggu obat racikan kurang dari 60 menit	89,62%	82,66%	83,15%	86,44%	90,75%	91,33%	90,23%						100%	87,74%	PDSA

Analisis:

Berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Juli 2026, capaian indikator waktu tunggu obat racikan <60 menit mencapai 90,23%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 1,10% dibandingkan bulan Juni 2026 dan masih belum mencapai standar yang ditetapkan rumah sakit, yaitu 100%.

Secara tren, capaian indikator selama periode Januari–Juli 2026 menunjukkan adanya fluktuasi. Capaian mengalami penurunan pada bulan Februari, kemudian meningkat secara bertahap hingga bulan Juni dengan capaian tertinggi sebesar 91,33%. Pada bulan Juli terjadi sedikit penurunan, namun secara umum capaian menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan awal periode pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan obat racikan telah mengalami peningkatan, tetapi masih terdapat sebagian pelayanan yang belum dapat memenuhi standar waktu tunggu yang ditetapkan.

Keterlambatan waktu tunggu obat racikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompleksitas proses peracikan obat, peningkatan jumlah resep pada waktu tertentu, kebutuhan verifikasi resep sebelum pelayanan, serta koordinasi antarpetugas dalam proses penyiapan dan penyerahan obat kepada pasien. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kepuasan pasien terhadap pelayanan farmasi apabila tidak dilakukan pengendalian secara optimal.

Untuk meningkatkan capaian indikator, perlu dilakukan evaluasi terhadap alur pelayanan obat racikan mulai dari penerimaan resep hingga obat diserahkan kepada pasien, optimalisasi pembagian tugas dan koordinasi antarpetugas farmasi, serta peningkatan monitoring terhadap waktu tunggu pelayanan. Selain itu, pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi dan identifikasi hambatan pada jam pelayanan dengan beban resep tinggi perlu dilakukan secara berkala agar waktu tunggu obat racikan dapat mencapai standar 100% yang telah ditetapkan rumah sakit.

3.6 Manajemen Risiko

No	Judul Indikator	Bulan												Standar	Rata-Rata	Keterangan
		Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	Mei '26	Jun '26	Jul '26	Agust '26	Sept '26	Okt '26	Nov '26	Des '26			
1.	Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat	50%	50%	50%	40,58%	70,65%	48,55%	59,06%						100%	52,69%	PDSA

Analisis :

Berdasarkan hasil pengukuran periode Januari–Juli 2026, capaian kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat menunjukkan hasil yang masih belum mencapai standar yang ditetapkan rumah sakit sebesar 100%, dengan capaian berturut-turut sebesar 50%, 50%, 50%, 40,58%, 70,65%, 48,55%, dan 59,06%.

Secara tren, capaian indikator menunjukkan adanya fluktuasi setiap bulan. Peningkatan capaian terjadi pada bulan Mei, namun kembali mengalami penurunan pada bulan Juni dan meningkat kembali pada bulan Juli. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan alat belum dapat dilakukan secara optimal dan konsisten pada seluruh peralatan yang tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu faktor yang memengaruhi belum tercapainya target adalah keterbatasan sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan alat. Saat ini kegiatan pemeliharaan dilakukan oleh satu orang petugas dengan jumlah alat yang harus dipantau dan dipelihara cukup banyak, sehingga pelaksanaan pemeliharaan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko keterlambatan pemeliharaan maupun terjadinya gangguan fungsi alat yang dapat berdampak pada kesinambungan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui evaluasi beban kerja petugas pemeliharaan, penyusunan prioritas pemeliharaan berdasarkan tingkat risiko alat, penguatan sistem monitoring jadwal pemeliharaan, serta koordinasi dengan manajemen terkait kebutuhan dukungan sumber daya agar pemeliharaan alat dapat berjalan lebih optimal.

3.6 Hasil Kegiatan Mutu Prioritas Unit

3.6.1 Instalasi Gawat Darurat

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Gawat Darurat bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Stand ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	86,05%	86,05%	82,67%	83,35%	83,55%	84,86%	84,89%						84,49%	Belum mencapai standar (Mar-Jul)
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	96,99%	100%	97,16%	100%	100%						99,16%	Belum mencapai standar (Maret, Mei)
4	Waktu tanggap operasi seksio	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	Sudah mencapai

	sesaria emergensi ≤ 30 menit															standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	97,16%	100%	100%						99,59%	Belum mencapai standar (Mei)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	86,05%	86,05%	86,05%	88,24%	87,95%	87,50%	84,42%						86,61%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakuka n perhitun gan	100%	96,59%	96,65%	77,86%	100%	100%						95,18%	Belum mencapai standar (Maret- Mei)
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidaklengkap an e-rm pengkajian awal IGD dan SPRI	0%	Blm dilakuka n perhitun gan	54,72%	1,41%	0,86%	1,27%	4,82%	4,15%						11,21%	Belum mencapai standar
2	Kejadian ketidakpatuhan staf medis dalam penempatan pasien dengan EWS	0 kejadi an	Blm dilakuka n perhitun gan	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar
3	Kejadian kesalahan asuhan medis dokter IGD	0 kejadi an	Blm dilakuka n perhitun gan	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar

1.6.2. IRNA 2A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 2A bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	85,86%	86,11%	86,21%	86,42%	86,28%	86,28%	86,28%						86,21%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	100%	98,78%	100%	100%	99,32%	99,17%						99,61%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	63,13%	78,21%	77,44%	72,38%	70,11%	100%	95,06%						79,48%	Belum mencapai standar (Jan-Mei)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	85,71%	85,96%	85,45%	85,19%	84,62%	84,62%	84,62%						85,26%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis	100%	15,29%	8,43%	5,63%	11,11%	7,07%	100%	Tdk ada pasien DM Ulkus						Tdk ada pasien DM Ulkus	Tdk ada pasien DM Ulkus

	Prioritas)															
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tdk ada pasien DM Ulkus						Tdk ada pasien DM Ulkus	Tdk ada pasien DM Ulkus
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	15,06%	8,82%	5,63%	11,11%	9,24%	100%	Tdk ada pasien DM Ulkus						Tdk ada pasien DM Ulkus	Tdk ada pasien DM Ulkus
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0						0,00%	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	0%	0%	0%	75%	0%	0%	0%						10,71%	Sudah mencapai standar
3	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	0%	0%	2,44%	3,81%	48,91%	6,37%	24,69%						12,32%	Belum mencapai standar

3.6.3 IRNA 2C

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 2C bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Stand ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keteranga n
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	85,11%	87,50%	86,41%	86,93%	86,94%	87,13%	87,13%						86,74%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00 %	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	96,53%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						99,50%	Sudah mencapai

																standar (Jan)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	83,45%	83,57%	76,06%	85,95%	87,59%	91,74%	82,47%						84,40%	Sudah mencapai standar (Mar)
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	95,62%	100%	98,46%	100%	100%	100%	100%						99,15%	Belum mencapai standar (Jan, Mar)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	86,28%	86,56%	84,78%	87,72%	87,04%	87,23%	87,32%						86,70%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakuka n penguku ran	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00 %	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM						100,00 %	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM						100,00 %	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM						100,00 %	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																

1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	0%	20%	24,29%	5.6%	0%	0%	0%						7,38%	Belum mencapai standar (Feb-Apr)
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	0%	34,34%	8,62%	0%	0%	14,05%	0%						8,14%	Belum mencapai standar (Feb, Mar, Jun)

3.6.4 IRNA 3A
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 3A bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien

	Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)															
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien	Tdk ada pasien							Tdk ada pasien

3.6.5 IRNA 3C

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 3C bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Stand ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterang an
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	83,74%	84,12%	83,43%	83,10%	83,20%	83,20%	100%						85,83%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	99,14%	100%	100%	100%						99,88%	Belum mencapai standar (Apr)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	96,39%	100%	100%	100%	100%	97,53%						99,13%	Sudah mencapai standar (Feb)
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	75,47%	77,36%	76,92%	78,43%	78,43%	78,43%	100%						80,72%	Belum mencapai standar (Jan-Jun)
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan	95,9%	100%	100%	100%	100%	100%						99,32%	Belum mencapai standar (Feb)
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Blm dilakukan	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar

2	Angka kejadian tidak dilaksanakan visite	0%	ran Blm dilakuka n penguku ran	20%	0%	0%	0%	0%	0%						3,33%	Belum mencapai standar (Feb)
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakuka n penguku ran	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0,00%	Sudah mencapai standar

3.6.6 IRNA 4A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 4A bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	85,34%	85,44%	85,44%	85,00%	85,00%	85,32%	85,32%						85,27%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%						99,86%	Belum mencapai standar (Jul)
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,46%						99,64%	Belum mencapai standar (Jul)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	93,62%	90,27%	95,76%	97,6%						96,75%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	59,36%	60,82%	63,42%	51,14%	93,33%	79,12%						72,46%	Belum mencapai standar (Feb-Jul)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas	100%	86,21%	87,72%	85,96%	88,89%	88,89%	87,23%	87,23%						87,45%	Belum mencapai

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)															standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	86,67%	86,19%	79,51%	99,62%	72,67%	96,54%	97,46%						88,38%	Belum mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM						100,00%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM						100,00%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM						100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0						0,00%	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	49,33%	28,8%	48,24%	8,7%	0%	0%	0%						19,30%	Belum mencapai standar (Jan-Apr)
3	Ketidaktuntutan asuhan pasien selama di	0%	14,44%	20,83%	15,12%	17,12%	9,58%	0%	32,39%						15,64%	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	rawat inap															(Jan-Mei)

3.6.7 IRNA 5C

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 5C bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	86,85%	88,17%	89,49%	85,94%	86,23%	87,53%	90,93%						87,88%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	86,77%	86,96%	86,67%	85,81%	90,97%	86,50%	85,65%						87,05%	Belum mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	99,06%	100%	89,23%	96,61%	82%						95,27%	Belum mencapai standar (Mar,mei-Jul)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	84,73%	89,47%	83,33%	83,7%	82,68%	90,6%	63,64%						82,59%	Belum mencapai standar (Jul)
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	98,51%	96,09%	98,41%	87,65%						97,24%	Belum mencapai standar (Apr-Jul)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	87,04%	88,33%	91,07%	91,67%	92,59%	94,44%	96,10%						91,61%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	96,52%	100%	100%	96,15%						98,78%	Belum mencapai standar (Apr,Jul)

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM						100,00 %	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM						100,00 %	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM						100,00 %	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0	0						0,00%	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakukan pengukuran	10,53%	16%	15,96%	10,62%	7,01%	19,57%						13,28%	Belum mencapai standar
3	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	3,08%	0%	4,27%	8,08%	26,36%						6,97%	Belum mencapai standar

3.6.8 IRNA 6A
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 6A bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan	≥ 85%	82,69%	82,79%	83,03%	82,64%	82,76%	83,06%	83,06						82,86%	Belum

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	kebersihan tangan								%							mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	95%	100%	100%	89,23%	100%	100%						97,75%	Belum mencapai standar (Feb, Apr)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	57,95%	70,91%	60,77%	63,03%	82,68%	69,63%	62,71 %						66,81%	Belum mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	94,29%	100%	100%	96,09%	100%	99,07 %						98,49%	Belum mencapai standar (Feb, Mei,Jul)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	84,44%	82,61%	84,09%	83,72%	85,37%	90,48%	90,48 %						85,88%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%	94,04 %						99,01%	Belum mencapai standar (Jul)
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM	Tidak ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	83,33 %						91,67%	Belum mencapai standar (Jul)
4	Kepatuhan Pengisian Form	100%	Blm dilakukan	Tdk ada pasien	100%	Tdk ada pasien	Tidak ada	Tdk ada pasien	100%						100,00%	Sudah mencapai

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)		pengukuran	DM		DM	pasien DM	DM								standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	100%	Tdk ada pasien DM	Tidak ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	96%						98%	Belum mencapai standar (Jul)
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0	96%						98%	Belum mencapai standar (Jul)
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakukan pengukuran	50%	0%	45,65%	21,67%	23,2%	1,28%						23,63%	Belum mencapai standar
3	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakukan pengukuran	37,5%	0%	0%	0%	0%	0,43%						6,32%	Belum mencapai standar (Feb,Jul)

3.6.9 IRNA 7A

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 7A bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	83,94%	84,17%	83,70%	83,94%	83,24%	82,76%	82,76 %						83,50%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100,00%	97,78%	100%	100%	100%	100%						99,68%	Belum mencapai standar (Mar)
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	92%	94,92%	100%	100%	95,36%	96,92 %						97,03%	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
																(Feb, Mar, Jun)
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	64,91%	82,94%	94,3%	86,7%	79,49%	59,31%	59,33 %						75,28%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	84,51%	84,72%	84,72%	84,51%	86,76%	87,14%	87,14 %						85,64%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	75%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM						93,75%	Belum mencapai standar (Mei)
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	75%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM						93,75%	Belum mencapai standar (Mei)
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	83,33%	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM						95,83%	Belum mencapai standar (Mei)
Indikator Mutu Prioritas Unit																

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakukan pengukuran	28,57%	41,48%	26,44%	24,89%	8,68%	8,57%						23,11%	Belum mencapai standar
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	18,93%	20,44%	26%	3,56%	1,16%						11,68%	Belum mencapai standar

3.6.10 IRNA 8A
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRNA 8A bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	84,18%	83,33%	83,92%	83,71%	84,45%	82,41%	79,92 %						83,13%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	79,84%	92,59%	75,83%	76,33%	89,52%	100,00%	100%						87,73%	Belum mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	53,12%	96,95%	75,38%	92,37%	88,73%	88,7%	94,37 %						84,23%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	90,8%	100%	100%	100%						98,69%	Belum mencapai standar (Apr)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas	100%	85,25%	88,00%	85,00%	87,93%	87,27%	87,50%	89,23 %						87,17%	Belum mencapai

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)															standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan Pengisian Form Discharge Planing pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%	80%						90,00%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Pengisian Form Edukasi pada pasien DM dengan ulkus (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan PPK dan CP Pasien DM (Pelayanan Klinis Prioritas)	100%	Blm dilakukan pengukuran	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	Tdk ada pasien DM	100%	33,33 %						66,67%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	24,31%	7,88%	11,27%	10,98%	5,38%						9,97%	Belum mencapai standar
3	Ketidakiengkapan e-rm asuhan pasien selama di	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	26,74%	9,66%	12,37%	11,74%	14,73 %						12,54%	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
	rawat inap															

3.6.11 ICU

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit ICU bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	86,80%	88,42%	86,58%	87,30%	91,33%	98,04%	98,04%						90,93%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						99,86%	Belum mencapai standar (Jan)
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	94,44%	100%	100%						99,21%	Belum mencapai standar
4	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	96,58%	90%	100%	100%	100%	100%	100%						98,08%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	93,1%	100%	94,87%	94,44%	100%	100%						97,49%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	87,10%	88,00%	86,89%	90,00%	89,77%	100,00%	100%						91,68%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	91,04%	100%	94,87%	100%	100%	100%						97,65%	Sudah mencapai standar

Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di ICU dan HCU	0%	Blm dilakukan pengukuran	70.45%	0%	0%	1,82%	0%	0%						0,36%	Belum mencapai standar
2	Kejadian kesalahan saat hand over (serah terima)	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar
3	Kejadian keterlambatan pemasangan intubasi pasien	0 kejadian	0	0	1	0	0	0	0						0	Belum mencapai standar (Mar)
4	Angka pasien kembali ke perawatan intensive dengan kasus yang sama <72 jam	<3%	0	4	0	1	0%	0%	0%						1%	Belum mencapai standar (Feb, Apr)

3.6.12 PICU

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit PICU bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	99%	100%	100%	100%	Tdk ada pasien	100%						99,83%	Belum mencapai standar (Feb)
2	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tdk ada pasien	100%						100%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan waktu visite dokter	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	Tdk ada pasien	100%						100%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tdk ada pasien	100%						100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																

1	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tdk ada pasien	100%						100%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	Tdk ada pasien	0						0	Sudah mencapai standar
2	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	0%	28,57%	0%	10%	0%	Tdk ada pasien	50%						14,76%	Belum mencapai standar (Feb, Apr,Jul)
3	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di rawat inap	0%	0%	18,75%	33,33%	0%	0%	Tdk ada pasien	0%						8,68%	Belum mencapai standar (Feb,Mar)

3.6.13 Instalasi Rawat Jalan

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IRJA bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Stand ar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	87,21%	88,17%	84,71%	86,67%	100%	100%	100%						92,39%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	94,63%	95,82%	96,31%	97,68%	97,51%	98,06 %	98,28 %						96,90%	Belum mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	96,09%	100%	99,9%	100%	100%	99,67 %						99,38%	Belum mencapai standar (Feb, Apr,Jul)
4	Waktu tunggu rawat jalan	≥ 80%	100%	86,29%	89,59%	95,04%	95,98%	93,8%	94,97 %						93,67%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																

1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	88,46%	88,89%	90,20%	88,24%	82,98%	90,74 %	89,80 %						88,47%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kepatuhan DPJP terhadap jadwal Praktek	100%	76,78%	87,6%	84,62%	85,31%	85,66%	84,28 %	84,67 %						84,13%	Belum mencapai standar
2	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di irja	0%	2,43%	2,55%	2,43%	2,14%	2,46%	1,83%	1,59 %						2,20%	Belum mencapai standar
3	Target Pasien PRB dan iterasi	100%	100%	100%	98,49% %	100%	100%	99,7%	100%						99,95%	Belum mencapai standar (Mar,Jun)
4	Kegagalan pelaksanaan layanan di rawat jalan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan) setiap hari	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar

3.6.14 Fisioterapi
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Fisioterapi bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kegagalan pelaksanaan layanan (pasien gagal pelayanan atas kesalahan)	0 kejadian	5	2	0	3	0	0	0						2	Belum mencapai standar (Jan, Feb, Apr)

	setiap hari															
2	Pelayanan tidak sesuai program terapi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0						0	Sudah mencapai standar

3.6.15 Maternitas

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Maternitas bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag t	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Keterangan
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	90,34%	90,21%	90,21%	89,93%	91,20%	91,80%	91,80 %						90,78%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
4	Waktu tanggap operasi seksio sesaria emergensi ≤ 30 menit	≥ 80%	Tdk ada op SC emergensi	Tdk ada op SC emergensi	Tdk ada op SC emergensi	Tdk ada op SC emergensi	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	53,38%	49,57%	47,76%	86,09%	87,27%	90,7%	95,21 %						72,85%	Belum mencapai standar
6	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	95,36%	95,45%	100%	100%						98,69%	Belum mencapai standar (Apr-Mei)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	86,30%	86,11%	86,11%	87,67%	88,24%	89,06%	89,06 %						87,51%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag t	Sep	Okt	Nov	Des	Rata- rata	Keteranga n
	pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)															mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidaklengkapan e-rm asuhan pasien selama di maternitas	0%	0%	0%	0%	11,92%	17,27%	20,45%	0%						7,09%	Belum mencapai standar
2	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0,00%	Sudah mencapai standar
3	Kejadian perdarahan post partum	0 kejadian	3	3	2	3	0	2	0						2	Belum mencapai standar
4	Angka kejadian partus macet	< 10%	18,5%	31,3%	33,3%	13,21%	4,7%	10%	18,9%						18,56%	Belum mencapai standar
5	Kejadian eklamsi	0 kejadian	3	0	0	0	0	0	0						0	Belum mencapai standar (Jan)
6	Kejadian pre eklamsi	0 kejadian	0	1	1	4	0	4	3						2	Belum mencapai standar
7	Kejadian infeksi nifas	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar
8	Angka kejadian pasien tidak dilaksanakan visite	0%	0%	0%	0%	13,91%	12,73%	6,82%	0%						4,78%	Belum mencapai standar (Apr-Jun)
9	Kejadian kesalahan asuhan medis DPJP	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar

3.6.16 Neonatologi

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Neonatologi bulan Julii Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	90,88%	89,47%	90,88%	91,03%	90,77%	91,82%	91,82%						90,95%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	≥ 80%	100%	93,33%	100%	95%	89,36%	97,67%	100%						96,48%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	98,25%	98,25%	98,25%	98,28%	98,08%	97,73%	97,73%						98,08%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	Blm dilakukan pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka Kematian Bayi	0%	0%	0%	1,59%	0%	1,18%	1,04%	1,35%						0,60%	Belum mencapai standar
2	Kejadian Keterlambatan pemasangan Intubasi pada	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
	pasien dengan indikasi															
3	Kejadian SHK yang di tolak Dinkes	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar

3.6.17 Instalasi Kamar Operasi (IKO)
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IKO bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	94,44%	94,11%	94,44%	94,80%	94,80%	94,80%	94,80%						94,60%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%	100%						98,40%	Belum mencapai standar (Mei-Jun)
4	Penundaan operasi elektif	≤ 5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0,00%	Sudah mencapai standar
5	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%	100%						98,40%	Belum mencapai standar (Mei-Jun)
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan penandaan lokasi operasi (SKP 4)	100%	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%	100%						98,50%	Belum mencapai standar (Mei-Jun)
2	Kepatuhan Petugas	100%	92,86%	95,35%	92,86%	92,68%	90,24%	90,24%	90,24%						92,07%	Belum mencapai

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
	Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)															standar
3	Kepatuhan pemasangan handrail dan penguncian roda brankar (SKP 6)	100%	100%	100%	100%	100%	97,78%	91,01%	100 %						98,40%	Belum mencapai standar (Mei-Jun)
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian re operasi	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar
2	Ketidakiengkapan pengisian e-rm laporan operasi dan anestesi sedasi pasien selama di IKO	0%	9,45%	9,32%	1,49%	3,83%	2,52%	0,56%	0%						3,88%	Belum mencapai standar
3	Kejadian kegagalan pembiusan SAB, sehingga prosedur dialihkan menjadi pembiusan GA	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar

3.6.18 Instalasi Laboratorium
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Laboratorium bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	83,26%	83,18%	83,26%	82,86%	83,00%	83,00%	83%						83,08%	Belum mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
4	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	79,07%	77,27%	79,07%	78,57%	77,50%	77,50%	77,50%						78,07%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Keterlambatan hasil patologi anatomi sesuai dengan regulasi	0 kejadian	48	24	27	12	69	53	3						34	Belum mencapai standar
2	Surveilans harian hemovigilance "Kejadian Reaksi Transfusi"	100%	Tdk ada kejdian	Tdk ada kejdian	Tdk ada kejdian	Tdk ada kejdian	100%	Tdk ada kejdian	Tdk ada kejdian						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Ketersediaan kantong darah sesuai golongan darah	100%	94,51%	92,71%	100%	96%	93,94%	96,83%	97,83%						95,83%	Belum mencapai standar

3.6.19 Instalasi Radiologi

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Radiologi bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	83,62%	83,88%	83,33%	83,04%	83,89%	83,88%	83,88 %						83,65%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00 %	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00 %	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan pelaporan hasil kritis radiologi (SKP 2)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00 %	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	89,66%	88,52%	89,47%	89,29%	90,74%	93,88%	93,88 %						90,78%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian ketidakcocokan hasil bacaan radiologi dengan klinis pasien	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	16	5	5	9	5	1						7	Belum mencapai standar
2	Kejadian keterlambatan hasil radiologi sesuai dengan regulasi	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	40	30	30	32	31	30						32	Belum mencapai standar

3.6.20 Instalasi Gizi

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Gizi bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-Rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	81,02%	81,25%	80,28%	81,94%	75,46%	78,83%	85,63%						80,63%	Belum mencapai standar (Jan-Jun)
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	94,64%	94,45%	93,46%	95,57%	93,46%	92,17%						94,82%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	73,61%	73,96%	82,61%	39,19%	33,33%	39,19%	58,72%						57,23%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	100%	Blm dilakukan pengukuran	91,09%	89%	60,64%	70%	87,18%	88,7%						81,10%	Belum mencapai standar
2	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	100%	100%	100%	99,17%	99,26%	100%	100%	100%						99,78%	Belum mencapai standar
3	Angka kelengkapan pengkajian gizi	100%	100%	100%	99,91%	100%	99,7%	100%	99,77%						99,91%	Belum mencapai standar
4	Kejadian kesalahan pemberian diet pada pasien rawat inap	0 kejadian	2	1	1	2	1	3	0						0	Belum mencapai standar
5	Kejadian adanya	0	0	0	0	0	1	0	0						0	Belum

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-Rata	Ket
	benda asing dalam makanan	kejadian														mencapai standar (Mei)
6	Kejadian makanan basi	0 kejadian	1	1	0	0	0	0	0						0	Belum mencapai standar (Jan-Feb)

3.6.21 Instalasi Farmasi
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Farmasi bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	86,73%	86,46%	86,60%	86,67%	86,20%	84,67%	84,67%						86,00%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
4	Kepatuhan penggunaan formularium nasional	≥ 80%	86,13%	86,07%	86,45%	86,33%	85,81%	86,00%	86,21%						86,14%	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan verifikasi identitas pasien sebelum pemberian obat pasien rawat jalan (SKP 1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan	100%	92,42%	92,14%	92,90%	92,83%	93,06%	93,00%	92,9						92,75%	Belum

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
	penempelan label obat LASA dan obat-obatan High Alert di rawat inap (SKP 3)								3%							mencapai standar
3	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	83,33%	85,94%	83,18%	82,18%	81,25%	79,31%	79,31%						82,07%	Belum mencapai standar
4	Waktu tunggu obat racikan < 60 menit (Perbaikan Sistem)	100%	89,62%	82,66%	83,15%	86,44%	90,75%	91,33%	90,23%						87,74%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka keterlambatan penyediaan obat jadi rawat jalan >30 menit	0%	Blm dilakukan pengukuran	43.56%	43.06%	43,33%	41,14%	7,5%	8,23%						25,05%	Belum mencapai standar
2	Kejadian ketidakpatuhan retur obat rawat inap	0 kejadian	0	0	0	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar
3	Kejadian Kesalahan Penyiapan Obat	0 kejadian	2	4	6	2	1	0	0						2	Belum mencapai standar
4	Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	0 kejadian	1	2	0	1	0	1	0						1	Sudah mencapai standar

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
5	Kejadian Kesalahan Penulisan Etiket Obat	0 kejadian	1	0	0	1	0	0	0						0	Sudah mencapai standar
6	Kejadian Kesalahan Input E-Resep	0 kejadian	1	4	0	0	1	1	1						1	Belum mencapai standar

3.6.22 Pengadaaan Farmasi
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Pengadaan Farmasi bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Keterlambatan sediaan farmasi datang	0%	Blm dilakukan pengukuran	20,6%	28%	32,8%	26,76%	40,88%	40,88%						31,65 %	Belum mencapai standar
2	Kesalahan pembelian sediaan farmasi	0%	Blm dilakukan pengukuran	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0,00%	Belum mencapai standar
3	Angka selisih stok opname	0%	Blm dilakukan pengukuran	0,88%	0,73%	0,99%	0,64%	0,55%	0,004 %						0,63%	Belum mencapai standar
4	Respon time memasukkan master barang baru 1X24 Jam	100%	Blm dilakukan pengukuran	93,75%	97,37%	100%	100%	100%	100%						98,52 %	Belum mencapai standar

3.6.23 Komite PPI
Tabel Capaian Indikator Mutu Komite PPI bulan Julii Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Komite																
1	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0,00%	Sudah mencapai

																standar
2	IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤ 3,5‰	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0,00%	Sudah mencapai standar
3	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0 ‰	0 ‰	1.82%	0%	0%	0%	0%						0,00%	Sudah mencapai standar
4	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0 ‰	0 ‰	0.81%	0%	0%	0%	0%						0,00%	Sudah mencapai standar
5	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0.35%	0.3%	0.17%	0.33%	0,32%	0,07%	0,33 %						0,24%	Sudah mencapai standar
6	Angka Decubitus	0%	0%	0%	9.09%	0%	2,5%	0%	1,85 %						0,73%	Belum mencapai standar
7	Kejadian petugas tertusuk jarum bekas pasien (pajanan)	0 kejadian	0	0	0	0	0	2	0						0	Belum mencapai standar (Jun)

3.6.24 SDM

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit SDM bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian keterlambatan pengurusan SIP/SIK	0 kejadian	0	0	0	1	0	0	0						0	Sudah mencapai standar
2	Angka turn over staf	0%	1,38%	0%	0,28%	0,55%	1,38%	0,55%	0,55 %						0,67%	Belum mencapai standar

3.6.25 Instalasi Rekam Medis (Pendaftaran)

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Instalasi Rekam Medis (Pendaftaran) bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kesalahan pendaftaran pasien	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	25	25	38	32	0	5						21	Belum mencapai standar
2	Kejadian pasien BPJS TK tidak memasukkan dalam system E-PLKK	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	4	1	1	0	0	0						1	Belum mencapai standar
3	Kejadian ketidaksesuaian tanggal pengunjungan pasien RI dengan SPRI	0 kejadian	Blm dilakukan pengukuran	0	1	5	0	1	1						1	Belum mencapai standar

3.6.26 K3RS

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit K3RS bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidakpatuhan pembuatan PCRA	0%	Blm dilakukan pengukuran	0	0	0	0	0								

3.6.27 IPSRS

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IPSRS bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan petugas dalam pemeliharaan alat (Manajemen Risiko)	100%	50%	50%	50%	40,58 %	70,6 5%	48, 55 %	59,06%							
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Waktu tanggap respon dan penanganan pelaporan kerusakan unit	100%	88,1%	99,35%	98,43%	97,72%	99,1 3%	96, 13 %	99,43%							
2	Kejadian kerusakan sarana prasarana	0 kejadian	10	25	13	16	21	19	16							

3.6.28 Asuransi Center

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Asuransi Center bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Ju l	Ag t	Se p	Ok t	No v	De s	Rat a-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Waktu Pengajuan Klaim	Tanggal 5 awal bulan	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5	Tgl 5								Sudah mencapai standar
2	Klaim pending RJTL	<0,1%	0	-	-	1.9%	11,4%	10,7%								Belum mencapai standar
3	Klaim pending RITL	<1%	0	-	-	8.3%	6,6%	7,1%								Belum mencapai standar
4	Klaim tidak	0%						0,03%								

	layak															
5	Nilai Pengembalian Audit Klaim RJTL	< Rp1.000.000														
6	Nilai Pengembalian Audit Klaim RITL	< Rp5.000.000														
7	Nilai selisih negatif klaim RJTL	< Rp50.000.000	251.175.040	232.420.655	151.929.783	251.293.106	209.944.684	Rp266.005.258								
8	Nilai selisih negatif klaim RITL	< Rp100.000.000	- 1.216.032.654	-	-	- 1.462.313.938		Rp- 557.824.591								
9	Persentase readmisi pasien rawat inap	0%	3,5%	1,83%	2,34%	3,51%	2,47%	3%								Belum mencapai standar
10	Angka kelengkapan berkas klaim di SIMRS	100%	66,4%	42,32%	61,43%	69,52%	66,6%	77,3%								Belum mencapai standar

3.6.29 PIPP

Tabel Capaian Indikator Mutu Unit PIPP bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100,00%	Sudah mencapai standar
2	Kepuasan Pasien	≥ 76,61%	99,70%	99,89%	99,79%	99,88%	99,41%	99,82%	96,08%						99,22%	Sudah mencapai standar

Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kejadian komplain pasien/keluarga di google review (Tujuan Strategis)	0 kejadian	5	1	3	11	7	4	6						5	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka Kepuasan Pasien Peserta BPJS	100%	99,89%	100%	100%	100%	99,91%	99,9%	100 %						99,97%	Belum mencapai standar
2	Angka terhubungnya display TT dengan mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %						100,00%	Sudah mencapai standar
3	Angka terhubungnya operasi dengan mobile JKN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %						100,00%	Sudah mencapai standar

3.6.30 Cleaning Service
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Cleaning Service bulan Juli Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	89,74%	87,82%	85,90%	84,72%	84,72%	86,90%	86,42%						86,60%	Sudah mencapai standar
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	90,95%	90,19%	90,21%	92,01%	92,42%	92,72%	91,04%						91,36%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit																
1	Kepatuhan Petugas Kesehatan Melakukan 6 langkah cuci tangan (SKP 5)	100%	69,23%	69,23%	69,23%	66,67%	66,67%	74,07%	74,07%						69,88%	Belum mencapai standar

Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Respon time menanggapi keluhan unit <10 menit	≥ 90%	90,91%	79,1%	84,62%	88,07%	92,39%	90%	92,73%						91,71%	Sudah mencapai standar

3.6.31 Kesekretariatan
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Kesekretariatan bulan Mei Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka ketidaklengkapan pengumpulan dokumen <i>meeting</i> RS (saat akhir rapat)	0%	25%	0%	0%	0%	Tidak ada rapat	28,57 %	50%						17,26%	Belum mencapai standar (Jan,Jun ,Jul)

3.6.32 CSSD & Laundry
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit CSSD & Laundry bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Nasional																
1	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD)	100%	84,41%	89,29%	87,22%	75,56%	79,03%	75,56%	66,67 %						81,85%	Belum mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry																
1	Kejadian linen ruang perawatan hilang	0 kejadian	0	16	38	0	0	0	0						9	Sudah mencapai standar
2	Kejadian tercampur benda asing	0 kejadian	1	0	4	0	0	0	0						1	Sudah mencapai standar
Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD																
1	Kejadian keterlambatan	0 kejadian	2	0	0	2	1	0	0						1	Belum mencapai

	penyediaan kasa steril															standar
2	Kejadian ditemukannya instrument hilang atau kurang	0 kejadian	0	0	2	0	0	0	0						0	Sudah mencapai standar

3.6.33 IT
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit IT bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian CCTV tidak terecord	0 kejadian	0	0	2	0	0	0	0						1	Sudah mencapai standar
2	Kejadian komputer dan internet lemot	0 kejadian	60	53	17	17	22	12	5						16	Belum mencapai standar

3.6.34 Kamar Jenazah
Tabel Capaian Indikator Mutu Unit Kamar Jenazah bulan Juni Tahun 2026

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidakpatuhan pencatatan buku transit jenazah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%	Sudah mencapai standar

3.6.35 Driver

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian permintaan driver yang bersamaan	0 kejadian	0	4	1	2	0	0	3						1	Sudah mencapai standar

2	Kejadian oncall driver	0 kejadian	3	5	2	2	3	2	3						3	Belum mencapai standar
3	Penggunaan ambulance luar RS	0 kejadian	12	11	10	5	2	2	7						7	Belum mencapai standar

3.6.36 Security

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kelolosan tamu tidak menggunakan kartu visitor	0 kejadian	1	0	1	1	0	0	0						0	Sudah mencapai standar
2	Kejadian ketidaktertiban pengunjung rawat inap	0 kejadian	15	14	13	26	29	22	23						20	Belum mencapai standar

3.6.37 Gudang Umum

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Ketidakpatuhan pengambilan barang oleh unit	0 kejadian	4	8	1	4	3	2	50 %						4	Belum mencapai standar

3.6.38 Kasir

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kesalahan pelunasan yang dilakukan	0 kejadian	2	5	5	7	1	0	5							Belum mencapai standar
2	Keterlambatan pelunasan	0 kejadian	1	1	0	0	0	0								Sudah mencapai

	pembayaran															standar
3	Kejadian pemulangan pasien rawat inap lebih dari 15 menit	0 kejadian	2	5	5	7	10	0								Belum mencapai standar

3.6.39 Humas

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Keterlambatan perpanjangan perjanjian kerja sama	0 kejadian	0	0	0	1	1	2	0						1	Belum mencapai standar

3.6.40 Primantara

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kejadian komplain keterlambatan pengantaran obat	0 kejadian	1	1	0	2	2	0	0						1	Belum mencapai standar

3.6.41 PKRS

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Kepatuhan PPA dalam pengisian form edukasi kolaborasi	100%	Blm dilakukan pengukuran	Blm dilakukan pengukuran	87%		66,67%	90%	100 %						88,13%	Belum mencapai standar
2	Angka Kelengkapan Dokumentasi Metode SBAR dan Konfirmasi “Read Back”	100%	Blm dilakukan pengukuran	Blm dilakukan pengukuran	93%		83,3%	100 %	85%						90,93%	Belum mencapai standar

	pada Instruksi Verbal															
3	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan edukasi Kelompok	100%	Blm dilakukan pengukuran	Blm dilakukan pengukuran	90%		47,06%									Belum mencapai standar

3.6.42 PROGNAS KB

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka capaian pelayanan KB per metode kontrasepsi, baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Non MKJP	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
2	Angka capaian pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	70%	20%	16,3 6%	22,4 3%	20,3 5%	27,4 5%	29, 27 %	18, 38 %							
3	Kejadian tidak dilakukannya KB Pasca Persalinan pada ibu baru bersalin dan KB Pasca Keguguran pada Ibu pasca keguguran	0	93	92	83	90	74	87	111							

3.6.43 PROGNAS TB

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka Pasien Terkonfirmasi Bakteriologis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	Sudah mencapai standar

3.6.44 PROGNAS HIV

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka kepatuhan petugas dalam melakukan skrining dan testing pasien dengan resiko HIV/AIDS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	Sudah mencapai standar

3.6.45 PROGNAS STUNTING

No	Judul Indikator	Standar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata-rata	Ket
Indikator Mutu Prioritas Unit																
1	Angka pelaksanaan kunjungan rumah dan PKM pasien Stunting & Wasting	100%	Blm dilakukan pengukuran	0%	0%	0%	0%	0%								Belum mencapai standar
2	Angka kepatuhan petugas dalam memberikan	100%	Blm dilakukan	100%	100%	100%	100%	100%								Sudah mencapai standar

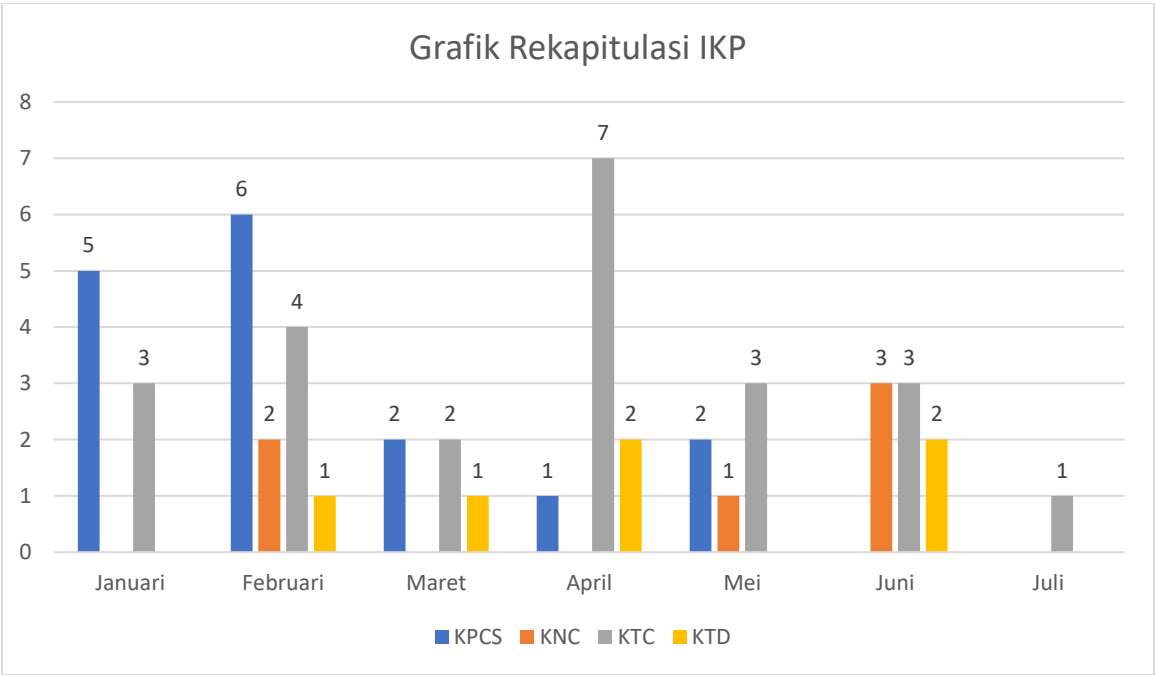
	edukasi kelompok sebagai upaya Pencegahan Stunting & Wasting (4x/bln)		pengukuran													
--	---	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.7 LAPORAN KEJADIAN IKP

Tabel Rekapitulasi IKP Berdasarkan Jenis Insiden

	KPC	KNC	KTC	KTD	SENTINEL	JUMLAH
JANUARI	5		3			8
FEBRUARI	6	2	4	1		13
MARET	2		2	1		5
APRIL	2		6	2		10
MEI	2	1	3			6
JUNI		3	3	2		8
JULI			1			1
AGUSTUS						
SEPTEMBER						
OKTOBER						
NOVEMBER						
DESEMBER						
JUMLAH	16	6	23	6		51

Grafik Rekapitulasi IKP Berdasarkan Jenis Insiden



Laporan IKP Bulan Juli 2026

NO.	TGL KEJADIAN	UNIT	GRADING	JENIS IKP	KRONOLOGI	TINDAK LANJUT
1	13 Juli	Instalasi Farmasi, Instalasi Rawat Jalan	Hijau	KTC	Pasien mendapatkan double medication untuk obat golongan yang sama, yaitu Allopurinol dan obat penurun kolesterol dari dua dokter berbeda.	1. Pasien dialihkan ke satu DPJP. 2. Memperbaiki KPO (Kartu Pengambilan Obat) agar tampilannya lebih bagus dan rapi dan dijadikan syarat kontrol. 3. Mengajukan pada programmer untuk melakukan perbaikan di billing pelayanan farmasi (SIMRS) agar obat dari DPJP lain akan muncul juga di billing pelayanan farmasi.

3.8 Indikator Mutu Pengelolaan Klaim Asuransi Kesehatan

NO	INDIKATOR MUTU	STANDAR	MEI	JUNI	JULI
1	Waktu pengajuan klaim	< 5 Setiap Bulan	5/6/2026	5/7/2026	
2	% Klaim pending RJTL	< 0,5%			
3	% Klaim pending RITL	< 0,1%			
4	Klaim tidak layak RJTL	0 (Nol)			
5	Klaim tidak layak RITL	0 (Nol)			
6	Audit pasca klaim RJTL	< 1.000.000			
7	Audit pasca klaim RITL	< 5.000.000			
8	Selisih klaim RS vs INACBGs IRJA	< 50.000.000	209.944.648	271.881.714	248.568.312
9	Selisih klaim RS vs INACBGs IRNA	<100.000.000	-170.866.338	- 175.909.551	-379.225.072

3.8 Indikator Mutu Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan

NO.	INDIKATOR MUTU	STANDAR	MEI	JUNI	JULI
1	Kesesuaian Jadwal Praktik Dokter atau Tenaga Kesehatan	Jadwal praktik 100% sesuai = 100	75	75	75
		Jadwal praktik 60% - 99% sesuai = 75			
		Jadwal praktik 40% - 59% sesuai = 50			
		Jadwal praktik 20% - 39% sesuai = 25			
		Jadwal praktik <20% sesuai = 0			
2	Tindak Lanjut dan Penyelesaian Pengaduan	Tidak ada kunjungan = 100	50	50	50
		Tidak ada pengaduan pada bulan penilaian = 100			
		Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & bukan merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 75			
		Pengaduan ditindaklanjuti sesuai SLA & merupakan Top 10 Pengaduan Nasional tahun sebelumnya = 50			
		Pengaduan tidak ditindaklanjuti atau tindak lanjut melebihi SLA = 0			
3	Umpan Balik Peserta (Customer Feedback)	Σ responden 100% target = 100	100	100	100
		Σ responden 75 - 99% target = 75			
		Σ responden 50 - 74% target = 50			
		Σ responden 25 - 49% target = 25			
		Σ responden <25% target = 0			
4	Update Data Ketersediaan Tempat Tidur	Σ update ≥ 25 hari dan tidak ada pengaduan terkait ketersediaan kamar rawat inap = 100	100	100	100
		Σ update ≥ 25 hari = 75			
		Σ update 15 - 24 hari = 50			
		Σ update 10 - 14 hari = 25			
		Σ update < 10 hari = 0			
5	Update Jadwal Tindakan Medis Operatif	Jadwal TMO terinput setiap bulan dan terhubung dengan sistem informasi BPJS Kesehatan = 100	100	100	100
		Tidak menginput jadwal TMO = 0			
6	Pemanfaatan Antrean Online terintegrasi MJKN dan Waktu Tunggu Rawat Jalan	Pemanfaatan MJKN 100% target dan WTL tercapai = 100	75	75	75

		Pemanfaatan MJKN 91% - 99% target = 75			
		Pemanfaatan MJKN 81% - 90% target = 50			
		Pemanfaatan MJKN 71% - 80% target = 25			
		Pemanfaatan MJKN ≤ 70% target = 0			
7	Penerbitan Surat Kontrol	Surat Kontrol terbit >90% sesuai = 100	100	100	100
		Surat Kontrol terbit 81% - 90% sesuai = 75			
		Surat Kontrol terbit 61% - 80% sesuai = 50			
		Surat Kontrol terbit 51% - 60% sesuai = 25			
		Surat Kontrol terbit ≤50% sesuai = 0			
8	Interoperabilitas Rekam Medis Elektronik	RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan, digunakan untuk dokumen pengajuan klaim dan waktu pengiriman data < 7 hari = 100	0	0	0
		RME terintegrasi dengan system informasi BPJS Kesehatan = 75			
		RME diimplementasikan untuk tingkat layanan rawat jalan dan rawat inap = 50			
9	% Approval SEP	<1%	0,3%		
10	Angka Capaian Iterasi	1854	63.00%		
11	Angka Capaian PRB	1370	90,68%	92,59%	93,59%

3.9 Aspek Analisis Mutu Pengelolaan Klaim Asuransi

3.9.1 Klaim Pending Rawat Jalan

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	-	-	-
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	-	-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	1. indikasi tidak layak pasien PRB iter tidak ditagihkan pelayanan 2. konsul internal jadi satu tagihan 3. indikasi Pre Operasi (PMK 26/2021 4. sesuai TKMKB terapi prosedur rehab > 3 bulan	1. sosialisasi dan koordinasi dengan dpjp terkait kriteria prb 2. sosialisasi dan koordinasi dengan dpjp terkait konsul internal 3. sosialisasi dan koordinasi dengan dpjp terkait kunjungan pre op	Dilakukan Sosialisasi pada Rapat Komite medik dan dilakukan diskusi lebih intens Per SMF secara berkala

				4. melakukan sosialisasi dan koordinasi ulang dengan dpjp dan perawat fisioterapi terkait tkmb tentang rehabmedik	
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	kode prosedur yang sesuai 40.11	koordinasi dengan dpjp terkait kesesuaian tindakan yang dilakukan dengan kode diagnosa yg akan di klaim kan	

3.9.2 Klaim Pending Rawat Inap

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis			
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	readmisi	melakukan konfirmasi pada DPJP terkait indikasi pasien dilakukan rawat inap kembali dan mengkaji kembali terkait penyebab terjadinya readmisi.	setiap hari
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	1. Indikasi pasien diranapkan, jika sejak awal anamnese indikasi rujuk klaim diajukan rajal. 2. Tidak ada pemeriksaan penunjang lanjutan untuk diagnosa A49.9 (Bacterial infection). Indikasi	1. screening pasien rujuk serta sosialisasi dan koordinasi dengan dpjp terkait kriteria indikasi pasien rawat inap 2. koordinasi dengan dpjp terkait pemeriksaan lanjutan	Setiap hari

			pasien MRS muntah reseleksi kode DU menjadi R11 (Vomiting)	untuk penagakan diagnosa bacterial infeksi	
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	- luka terbuka pada kepala dengan tindakan muscle suturing (83.65) gunakan kode prosedur 86.51 (suture or other closure of skin and subcutaneous tissue) - kode N17.9 (Aki) tidaksesuai, reselsksi N19 - Ukuran batu 0.3 tidak sesuai dengan PNPk, reseleksi kode prosedur 56.31 (Ureteroscopy) - Sesuai dengan ICD 10, kode K56 disertai dengan Hernia cukup di kode K40-K46	- koordinasi dengan dpjp terkait kesesuaian laporan operasi dan tindakan yang dilakukan. - koordinasi dengan dpjp terkait penegakan diagnosa aki sesuai dengan kriteria BA Kesepakatan - koordinasi dengan dpjp terkait kesesuaian laporan operasi dan tindakan yang dilakukan. - memahami kembali aturan icd 10 untuk pengkodean diagnosa yg terdapat include atau exclude	Setiap bulan

3.9.3 Klaim Tidak Layak Rawat Jalan

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	-	-	-
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	-	-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-

4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	-	-	-
---	--------	--	---	---	---

3.9.4 Selisih klaim RS vs INACBGs IRJA

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	1. Tarif tindakan Fisioterapi dan Rawat luka, angkat jahitan yang lebih besar dari pada Inacbg's 2. Pasien DM dengan penunjang dan persepan Insulin	1. Melakukan koordinasi dengan PT terkait dengan pengelompokan tarif tindakan dan koordinasi dengan DPJP terkait pasien dengan rawat luka tatalaksana apabila sudah bisa dilanjutkan di FKTP bisa dikembalikan ke FKTP dan pembatasan pemberian obatnya 2. Melakukan koordinasi dengan DPJP terkait kriteria pemberian insulin	Setiap bulan
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan	-	-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	-	-	-

3.9.5 Selisih klaim RS vs INACBGs IRNA

NO	ASPEK	DEFINISI	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAK LANJUT (TL)	WAKTU TL
1	Sistem	Klaim bermasalah karena tidak sesuai persyaratan mutlak dan teknis	Tarif tindakan yang lebih besar dari pada Inacbg's	Melakukan koordinasi dengan PT terkait dengan pengelompokan tarif tindakan, sudah ada perubahan terkait dengan pengelompokan tarif tindakan sehingga hasilnya turun tetapi terlihat menjadi selisih negatif yang sangat besar untuk tindakan naik kelas	Bulan Juni
2	Administrasi	Dokumen klaim yang tidak melampirkan administrasi peserta, administrasi pelayanan & penunjang, dan administrasi keuangan		-	-
3	Klinis	Ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan ketidaktepatan anamnesis, pemeriksaan fisik dan tatalaksana yang mendukung diagnosis sesuai peraturan yang berlaku	-	-	-
4	Koding	Kesalahan dalam melakukan koding penyakit, tindakan dan diagnostik sesuai aturan ICD 10, ICD 9 CM, ICD IM dan peraturan yang berlaku	-	-	-

3.10 Evaluasi Mutu APM

Tanggal	Jml. Kunjungan	Jml. Mobile JKN	Jml. APM	Pemanfaatan APM berdasarkan Kunjungan	Pemanfaatan APM berdasarkan Kunjungan MJKN
Januari	10.955	7.477	4.418	40%	59%
Februari	9.712	6.453	4.456	46%	69%
Maret	8.665	5.660	3.709	43%	66%
April	10.819	6.884	5.165	48%	75%
Mei	10.246	6.637	4.996	49%	75%
Juni	10.442	7.028	5.440	52%	77%
Juli	10.954	7.485	5.987	55%	80%

No.	Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	APM	40%	46%	43%	48%	49%	52%	55%
2	Petugas	60%	54%	57%	52%	51%	48%	45%
Jumlah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.6.1 Komite PPI

1.6.1.2 Hasil Surveilans dan Mutu PPI

1.6.1.2.5 IDO (Infeksi Daerah Operasi)

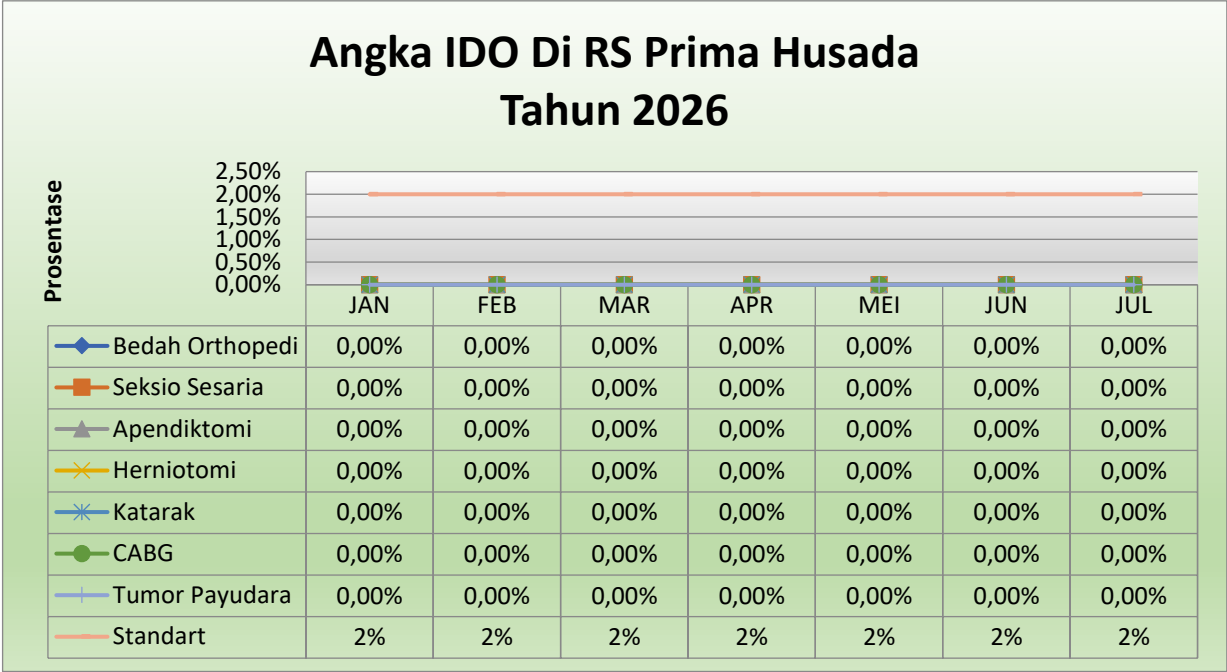
1.6.3.5.1 Tabel Data IDO berdasarkan Jenis Tindakan Operasi Sesuai Pelaporan

SIMAR (Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

SSI 2026	Bedah Orthopedi	Seksio Sesaria	Apendiktomi	Herniotomi	Katarak	CABG	Tumor Payudara
Januari							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	88	73	6	15	46	-	13
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Februari							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	66	67	16	8	51	-	15
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Maret							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	80	76	14	7	23	-	8
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
April							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	87	69	10	11	52		21
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Mei							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	59	76	6	11	36	-	26
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%
Juni							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	101	74	6	7	57	-	19
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%

Juli							
Jumlah Kasus	0	0	0	0	0	-	0
Jumlah Tindakan operasi	92	98	11	10	58	-	10
Insiden (%)	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%

1.6.3.5.2 Grafik Angka Infeksi Daerah Operasi (IDO)



Analisa	Secara keseluruhan angka IDO pada masing-masing jenis tindakan operasi adalah 0% dari jumlah operasi yang terjadi pada bulan ini sebesar 457, yang menunjukkan capaian indikator berada dalam kategori baik dan telah memenuhi standar mutu pelayanan rumah sakit. Namun masih perlu kewaspadaan terhadap kemungkinan under reporting.				
Masalah saat ini	Tidak ditemukan kasus IDO.				
Permasalahan sebelumnya	Tidak ditemukan kasus IDO sebelumnya.				
Tindakan yang dilakukan	- Monitoring rutin bundle/pencegahan SSI. - Monitoring kepatuhan Hand hygiene. - Monitoring pasien operasi dan dokumentasi rekam medis pasien.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Penguatan surveilans pasca operasi ≤ 30 hari (≤ 90 hari pada implan).	Mempertahankan angka IDO ≤2% serta menjamin kekakuratan sistem surveilans.	Tim Bedah, perawat kamar operasi, perawat IRNA/IGD/IRJA.	- Penguatan surveilans pasca operasi ≤30 hari (≤90 hari pada implan). - Menjalankan audit bundle SSI dengan baik. - Menjalankan kepatuhan pemberian antibiotik profilaksis. - Meningkatkan edukasi PPI kepada tenaga kesehatan dan kepada pasien/keluarga.	Komite PPI, Kepala ruang, dokter operator, dan manajemen mutu.	Monitoring bulanan

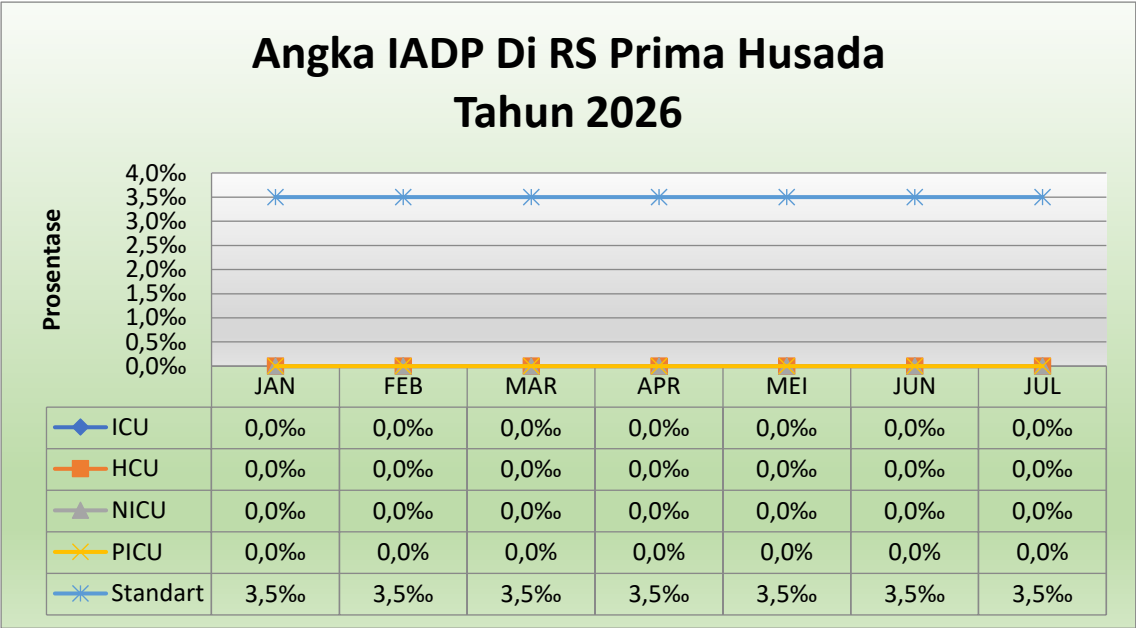
• Pertahan kan bundle IDO berjalan dengan baik.	• Resiko IDO pada pasien berkurang/ hilang.	• Pasien operasi	• Berkolaborasi dengan PPA terkait kondisi penyakit penyerta serta memberikan edukasi untuk mencegah agar risiko infeksi tidak menjadi aktual. • Memastikan bundle IDO (pre, durante, dan post op dilakukan dengan baik) • Melakukan monitoring persiapan pasien operasi khususnya pasien dianjurkan untuk mandi antiseptic/sabun untuk mengurangi resiko infeksi. • Penggunaan alat tetap diperhatikan proses sterilisasi central di CSSD terutama jika dilakukan operasi estafet dengan kasus yang sama (SC).	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IP CN	• Monitori ng bulanan
• Pertahan kan evaluasi pemaha man pemberia n edukasi perawata n pasien pasca operasi	• Meminimali sir kesalahpah aman penangkap an terkait edukasi perawatan pasien post operasi.	• Pasien post operasi.	• Koordinasi dengan perawat ruangan untuk memastikan pasien dan sudah mendapatkan edukasi terkait perawatan saat di rumah. • Pastikan pasien paham saat diedukasi dengan menanyakan kembali inti edukasi yang telah diberikan. (Memastikan komponen edukasi tersampaikan dengan baik/Komunikasikan-komunikasikan-pesan-media-feedback) • Berikan edukasi terutama terkait pemberian diit tinggi protein untuk membantu penyembuhan luka. • Lakukan edukasi pada saat pasien terdapat pendamping keluarga terutama yang satu rumah dengan pasien. • Berikan tambahan edukasi terkait kontrol pikiran pasien terutama terkait pantangan yang tidak perlu dipercaya di masyarakat.	• Perawat /Bidan • Karu • IPCLN/IP CN	• Monitori ng bulanan

3.6.1.1.2 IADP

3.6.1.1.2.1 Tabel Data IDP Berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR (Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes

IADP 2026	ICU	HCU	NICU	PICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Februari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Maret				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
April				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	15	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Mei				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	15	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Juni				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Juli				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian CVC	0	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

3.7.8 Grafik Angka Infeksi Aliran Darah Primer (IADP)



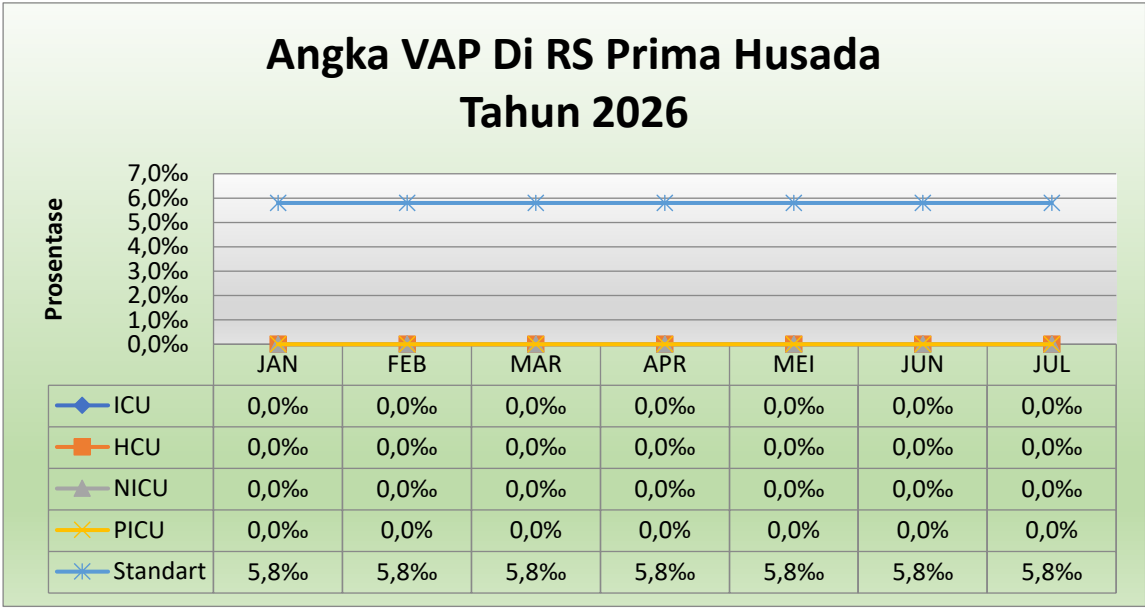
Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus IADP karena tidak ada pemasangan CVC pada bulan Juni ini.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi IADP				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi IADP				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan tindakan pemasangan CVC. • Melakukan evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. • Melakukan monitoring kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. • Melakukan monitoring • perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan bundle IADP.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle IADP.	• Pasien dengan pemakaian CVC.	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan CVC. • Monitoring evaluasi kepatuhan desinfeksi area penusukan dan lokasi yang tepat. • Monitoring evaluasi perawatan pemasangan CVC rutin, penggunaan spuit disposable, dan desinfeksi area penyuntikan.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan

1.6.1.1.3 VAP

1.6.1.1.3.1 Tabel Data VAP berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR
(Pelaporan INM dan HAls Kemenkes)

VAP 2026	ICU	HCU	PICU	NICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	86	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Februari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	78	0	12	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Maret				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	98	0	60	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
April				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	160	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Mei				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	170	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Juni				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	85	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Juli				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Ventilator Intubasi	107	0	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

1.6.1.1.3.2 Grafik Angka Pneumonia Akibat Penggunaan Ventilator (VAP)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus VAP pada 85 hari total lama pemasangan ventilator pada 15 pasien di ICU.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi VAP				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi VAP				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan evaluasi perawatan pasien dengan terpasang ventilasi mekanik. • Melakukan audit monitoring saat pemasangan ventilator. • Melakukan observasi tanda-tanda dehidrasi (bibir kering) pada pasien yang terpasang ventilator. • Melakukan evaluasi saat pasien dilakukan penghisapan lendir / suction. • Melakukan koordinasi dengan Kabid keperawatan terkait edaran kewajiban melakukan oral hygiene pada pasien yang terpasang ventilator dan mendokumentasikan di CPPT/Askep.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Tingkatkan kepatuhan bundle VAP, khususnya pelaksanaan oral hygiene.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle VAP (oral hygiene).	• Pasien yang terpasang ventilator mekanik	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan ventilator. • Monitoring evaluasi posisi tepat pasien <i>head of bed</i> >30°-45°. • Monitoring evaluasi tindakan pemasangan ventilator. • Monitoring kegiatan oral hygiene dan pendokumentasian di RM. • Pemberian tindakan oral hygiene dengan chlorhexidine dan juga diedukasikan pada keluarga pasien, agar keluarga ikut aktif mengingatkan petugas untuk melakukan tindakan tersebut.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCPN	• Satu bulan

1.6.1.1.4 ISK

1.6.1.1.4.1 Tabel Data berdasarkan Ruang sesuai Pelaporan SIMAR
(Pelaporan INM dan HAIs Kemenkes)

ISK 2026	ICU	HCU	PICU	NICU
Januari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	188	40	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Februari				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	168	78	6	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Maret				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	180	45	3	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
April				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	246	89	10	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Mei				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	293	61	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Juni				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaian Catheter	206	59	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰
Juli				
Jumlah Kasus	0	0	0	0
Jumlah Lama Hari pemakaianbb Catheter	208	132	0	0
Insiden (%)	0‰	0‰	0‰	0‰

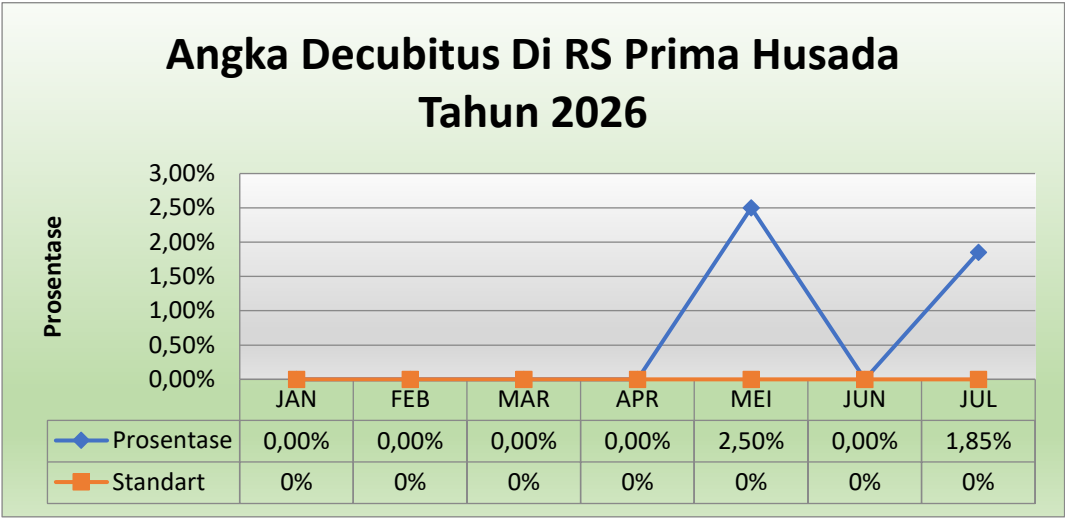
3.7.9 Grafik Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK)



Analisa	Pada bulan ini tidak ditemukan kasus ISK pada total 1450 hari lama pemakaian kateter pasien.				
Masalah saat ini	• Tidak terjadi ISK				
Permasalahan sebelumnya	• Tidak terjadi ISK				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan perawatan pasien. • Melakukan monitoring kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. • Melakukan monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. • Melakukan monitoring perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan bundle ISK.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle ISK.	• Pasien yang terpasang kateter	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi kepatuhan pemakaian APD saat penanganan pemasangan kateter. • Monitoring evaluasi teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan kateter. • Monitoring evaluasi perawatan pemasangan kateter, pemasangan sesuai indikasi, pemakaian fiksasi kateter, pengisian balon kateter yang sesuai dan penggantungan kantong urine.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCPN	• Satu bulan

1.6.1.1.5 Decubitus

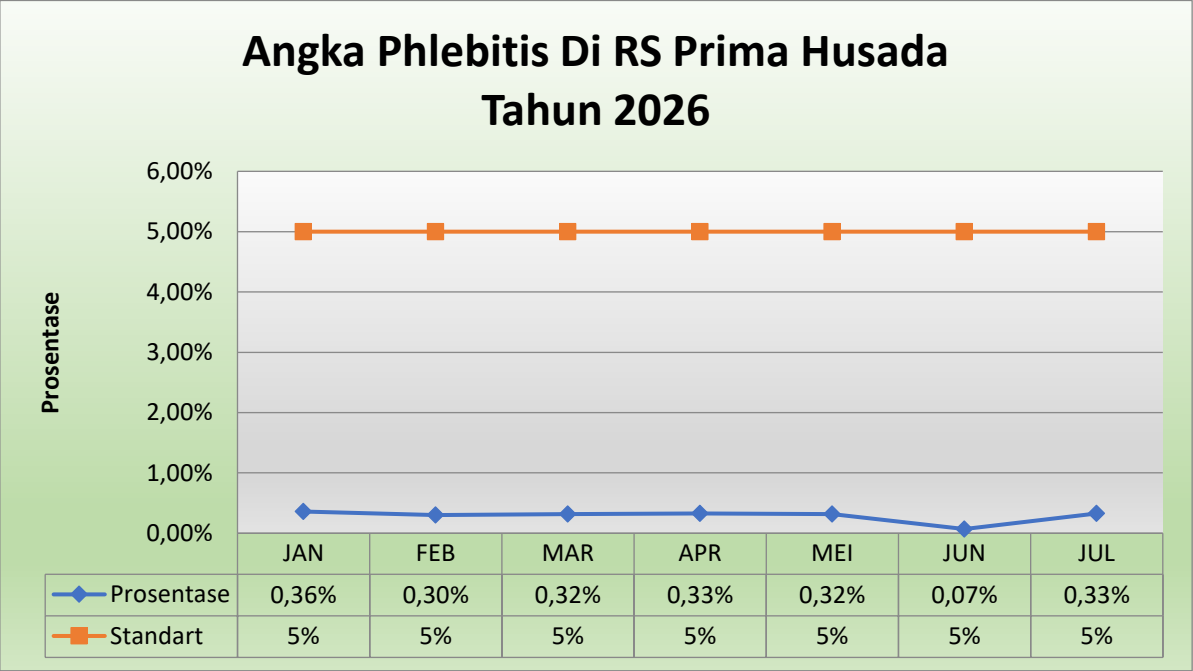
1.6.1.1.5.1 Grafik Angka Decubitus



Analisa	Pada bulan juli ini terjadi 1 kasus decubitus di unit HCU pada 54 pasien tirah baring lama. Hal ini disebabkan pasien sudah tirah baring lama yakni sejak MRS dengan diagnosa cva infark, sempat terpasang ETT dan ventilator sehingga membuat pasien tirah baringnya semakin lama dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pasien juga mendapat diagnosa hipoalbumin sehingga dengan kadar albumin yang rendah bisa memperparah kondisi.				
Masalah saat ini	Tidak ditemukan kasus decubitus				
Permasalahan sebelumnya	Tidak ditemukan kasus decubitus pada bulan juni				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan monitoring kepatuhan kebersihan tangan petugas saat melakukan proses perawatan pasien. • Melakukan monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). • Melakukan monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. • Memastikan personal hygiene dilakukan dengan rutin oleh petugas. • Memastikan pemenuhan nutrisi yang tepat.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan kepatuhan pencegahan dekubitus.	• Mempertahankan kepatuhan petugas dalam menjalankan pencegahan dekubitus.	• Pasien yang tirah baring lama (> 3x24 jam)	• Monitoring evaluasi kepatuhan kebersihan tangan petugas. • Monitoring evaluasi rutinitas petugas untuk melakukan imobilisasi pasien tiap 4 jam (mika-miki). • Anjurkan penggunaan kasur anti decubitus atau alternatif lain • Monitoring timbulnya lecet pada area tubuh yang menempel pada alas tidur dan penggunaan serta penggantian pampers secara rutin. • Lakukan perawatan luka rutin jika sudah terdapat luka supaya tidak melebar.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/PCN	• Satu bulan

1.6.1.1.6 Phlebitis

3.7.10 Grafik Angka Infeksi Jarum Infus (Phlebitis)

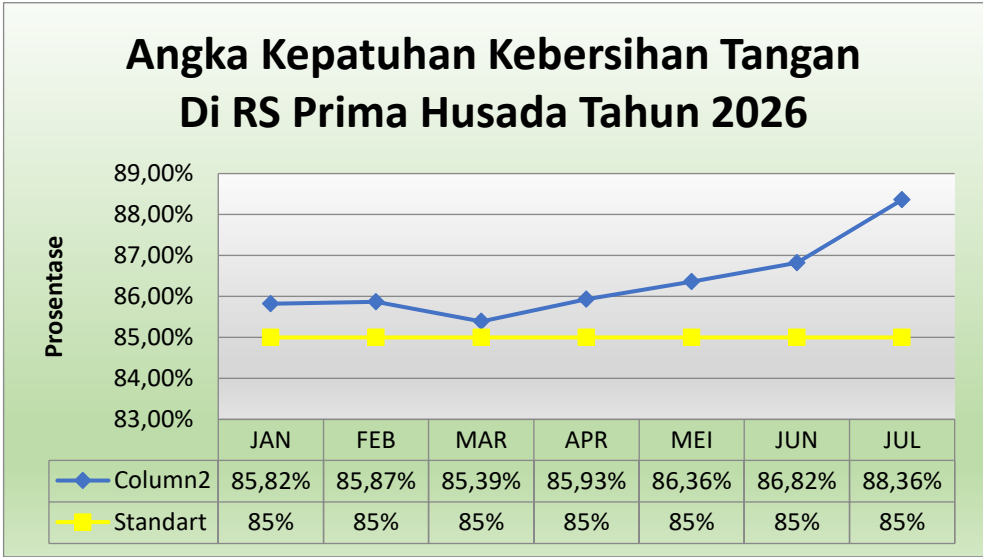


Analisa	Masih ditemukan kasus Phlebitis pada bulan ini dari total 2439 pasien yang terpasang infus setiap harinya dengan prosentase 0,33%, masih memenuhi standar nasional. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pasien pada bulan ini mengalami peningkatan sedikit dari sebelumnya dan upaya pencegahan infeksi dan perawatan akses intravena pada bulan berjalan belum optimal. Peningkatan angka phlebitis pada perawatan infus karena adanya pelaksanaan monitoring yang kurang rutin lokasi insersi. Selain itu, efektivitas kolaborasi antara Komite PPI dan Komite Keperawatan, dengan adanya pembinaan serta monitoring berkala turut berkontribusi terhadap penurunan angka phlebitis selain itu karena terjadi penurunan jumlah pasien yang terjadi pada bulan ini sehingga dengan denominator yang turun sedikit peningkatan kasus phlebitis akan menghasilkan prosentase yang tinggi. Kondisi pada bulan ini positifnya adanya peningkatan kepatuhan pelaporan untuk terjadinya phlebitis di ruangan. Dari data yang diperoleh terdapat 8 pasien yang mengalami phlebitis. Faktor penyebab kemungkinan besar: Obat pekat/iritatif/antibiotik, pemberian transfusi darah. Dari 12 pasien yang ditanyai, tidak ditemukan pasien yang rawat inap mengalami infus slong (cairan infus pada indikator selang infus habis).				
Masalah saat ini	Penggunaan cairan pekat, antibiotik masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah.				
Permasalahan sebelumnya	- Penggunaan cairan pekat masih menjadi penyebab terjadinya phlebitis, termasuk juga pemberian transfusi darah. - Faktor internal pasien seperti usia pasien yang beresiko phlebitis juga berpengaruh, perlunya edukasi lanjut terkait ini.				
Tindakan yang dilakukan	- Mengkoordinasikan dengan komite keperawatan terkait sosialisasi pemasangan infus yang benar dan penanganan phlebitis. - Memberikan edukasi pada pasien setelah pemasangan infus terutama pada pasien yang beresiko tinggi phlebitis karena faktor internal. - Menganjurkan perawat untuk melakukan monitoring luka tusukan infus terutama pada pasien yang terpasang cairan pekat setiap hari setelah melakukan injeksi. - Menyarankan petugas untuk memberikan kompres hangat pada pasien yang mendapatkan cairan pekat pada area tangan yang terpasang infus untuk merilekskan pembuluh darah dan cairan pekat/darah tidak gampang menggumpal. - Menganjurkan perawat untuk terus mengingatkan edukasi tambahan terkait perawatan saat terpasang infus.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
Perbaikan kepatuhan bundle phlebitis.	Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	Pasien yang terpasang infus	- Monitoring penyuntikan yang aman benar dilakukan. - Monitoring penggunaan cairan pekat maupun double antibiotic diberikan secara aman. - Monitoring kondisi luka tusukan infus setiap selesai melakukan injeksi. - Memberikan injeksi obat secara perlahan untuk mengurangi nyeri dan memperkecil resiko phlebitis. - Mengedukasi perawat unit untuk mengeset tetesan infus secara benar supaya hitungan jam habis infus dapat diperkirakan dan tidak sampai kehabisan. - Monitoring kepatuhan pemakaian APD terutama sarung tangan saat pemasangan infus dan kebersihan tangan sebelum memakai sarung tangan. - Monitoring teknik aseptik dan penggunaan alat steril pada saat pemasangan infus. - Tertibkan pencatatan petugas yang melakukan pemasangan infus pada plester infus pasien beserta tanggal pemasangan untuk mengontrol mutu skill dari perawat.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	Satu bulan

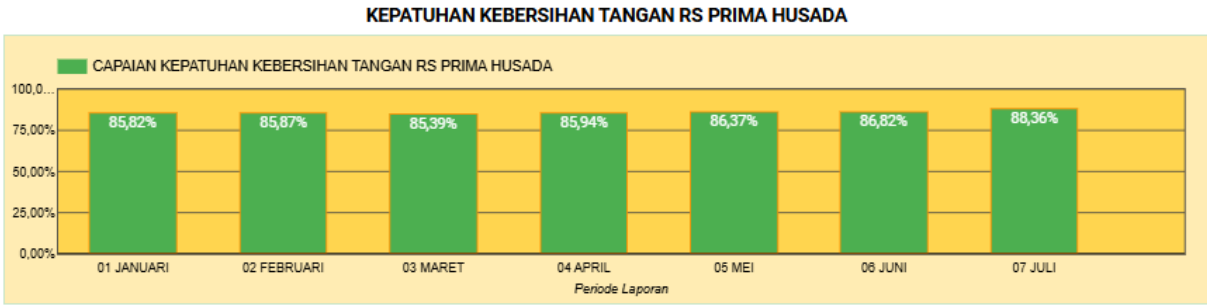
• Pengendalian Penggunaan Obat Iritatif.	• Mengurangi resiko phlebitis karena pemberian obat pekat/iritan.	• Perawat/bidan • Apoteker	• Mewajibkan pengenceran adekuat sesuai standar farmasi. • Laju infus dikontrol untuk antibiotik dan obat pekat. • Koordinasi dengan Instalasi Farmasi untuk memberikan label “Obat Iritatif – Perlu Pengenceran”.	• Perawat /Bidan • Apoteker • Karu • IPCLN/IPCN	• Satu bulan
• Perbaikan Proses Pemasangan & Perawatan Infus	• Memperbaiki kepatuhan petugas dalam menjalankan bundle phlebitis.	• Perawat/bidan	• Re-education SOP pemasangan infus (vena besar, hindari area fleksi). • Pelatihan ulang teknik aseptik untuk perawat yang belum mandiri memamsang infus. • Audit kepatuhan perawatan VAP & manajemen infus setiap bulan. • Checklist harian pemeriksaan lokasi infus oleh perawat jaga.	• Perawat /Bidan • Dokter • Karu • IPCLN/IPCN	• Tiga bulan

1.6.1.1.7 Kebersihan Tangan

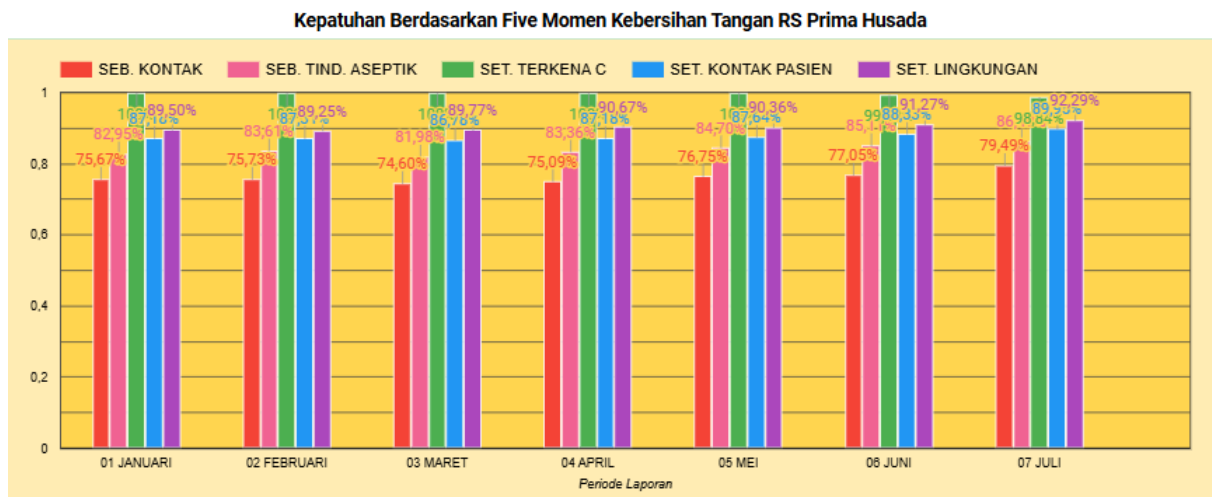
3.7.11 Grafik Angka Kepatuhan kebersihan Tangan (*Hand Hygiene*)



1.6.1.1.7.2 Grafik Kepatuhan 6 Langkah Kebersihan (Hand Hygiene)



1.6.1.1.7.3 Grafik Capaian Kepatuhan Kebersihan Tangan berdasarkan 5 Momen Cuci Tangan

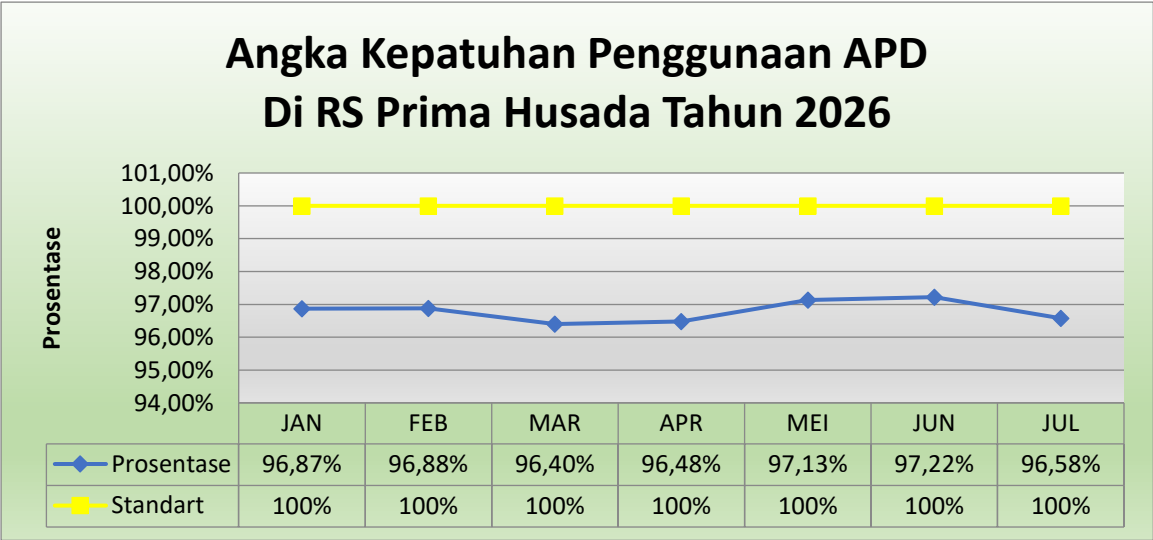


Analisa	Nilai kepatuhan hand hygiene bulan Juli 2026 berada sedikit di atas standar (selisih 3,36%). Meskipun sudah memenuhi standar peningkatan kepatuhan yang signifikan, berarti ada banyak peningkatan kedisiplinan atau konsistensi dalam penerapan cuci tangan, hal ini dikarenakan adanya pengawasan/audit rutin dari pic ppi sehingga kepatuhan meningkat. Tren ini mengindikasikan perlunya audit/monitor/penguatan pengawasan dan motivasi ulang kepada tenaga kesehatan agar tingkat kepatuhan terus meningkat. Nilai kepatuhan terhadap 6 langkah cuci tangan pada bulan ini: 86,24%. Nilai ini lebih tinggi sedikit dibanding bulan sebelumnya (Juni 2026: 86,82%). Artinya, meskipun tenaga kesehatan mencuci tangan, kemungkinan masih belum melakukan seluruh 6 langkah dengan benar. Peningkatan ini bisa mencerminkan peningkatan perhatian terhadap teknik yang benar dan peningkatan proses audit cuci tangan karena kebanyakan dari staf akan melakukan sesuai standar saat diamati, seharusnya sudah menjadi kebiasaan untuk budaya cuci tangan dengan 5 momen dan 6 langkah yang tepat, bukan hanya frekuensi mencuci tangan saja. Pelaksanaan 5 momen cuci tangan di bulan ini sudah cukup baik, namun perlu fokus peningkatan pada momen sebelum kontak pasien melalui edukasi dan reminder visual di area perawatan. Padahal juga sudah disiapkan handrub pada tiap bed pasien untuk menguatkan kepatuhan cuci tangan sebelum kontak ke pasiennya. Selain itu dengan adanya program "PPI Quick Tips" diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf di unit.				
Masalah saat ini	• Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata.				
Permasalahan sebelumnya	• Ketidakonsistenan dalam melakukan 5 momen cuci tangan. • Kedisiplinan dan kesinambungan praktik belum merata. • Teknik 6 langkah cuci tangan belum dilakukan secara sempurna. • Kepatuhan muncul karena pengawasan (observer effect). • Edukasi dan reminder visual belum optimal.				
Tindakan yang dilakukan	• Melakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. • Melakukan kontrol monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. • Mengajarkan cuci tangan yang benar saat melakukan audit di ruangan. • Mengingatkan perawat atau nakes lain untuk lebih mengutamakan upaya kebersihan tangan agar aman bagi petugas dan pasien. • Meningkatkan penerapan program "PPI Quick Tips" untuk meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Peningkatan kepatuhan 5 momen cuci tangan	• Meningkatkan kepatuhan 5 momen cuci tangan	• Seluruh perawat dan tenaga kesehatan di unit pelayanan	• Sosialisasi ulang 5 momen cuci tangan • Edukasi teknik 6 langkah melalui refresh training • Pemasangan poster & reminder visual di area strategis	• Komite PPI • Karu	• 1 bulan

• Peningkatan konsistensi praktik cuci tangan	• Meningkatkan konsistensi praktik kebersihan tangan	• Seluruh staf unit pelayanan	• Audit kepatuhan mingguan • Feedback langsung hasil observasi • Monitoring ketersediaan sarana (handrub, wastafel, sabun)	• Komite PPI • IPCN • Karu	• Mingguan
• Peningkatan kepatuhan 6 langkah cuci tangan	• Meningkatkan ketepatan teknik 6 langkah cuci tangan	• Perawat • Tenaga Kesehatan lainnya	• Simulasi praktik langsung saat supervisi • Supervisi saat jam pelayanan • Evaluasi melalui checklist observasi	• IPCN • IPCLN • Karu	• Mingguan
• Peningkatan kepatuhan kebersihan tangan saat tidak diamati.	• Mengurangi kepatuhan semu karena observer effect	• Seluruh staf	• Observasi acak tanpa pemberitahuan • Penguatan budaya keselamatan pasien koordinasi dengan komite PMKP • Kampanye internal "Hand Hygiene is Safety" jika diperlukan	• Komite PPI • Komite PMKP	• Berkala
• Peningkatan program kebersihan tangan	• Meningkatkan keberlanjutan program kebersihan tangan	• Unit pelayanan	• Implementasi rutin program "PPI Quick Tips" • Reward bagi unit dengan kepatuhan terbaik • Rapat evaluasi bulanan	• Komite PPI • Manajemen RS	• Setiap bulan

3.6.1.1.8 Kepatuhan APD

3.6.1.1.8 .1 Grafik Angka Kepatuhan Penggunaan APD oleh Petugas

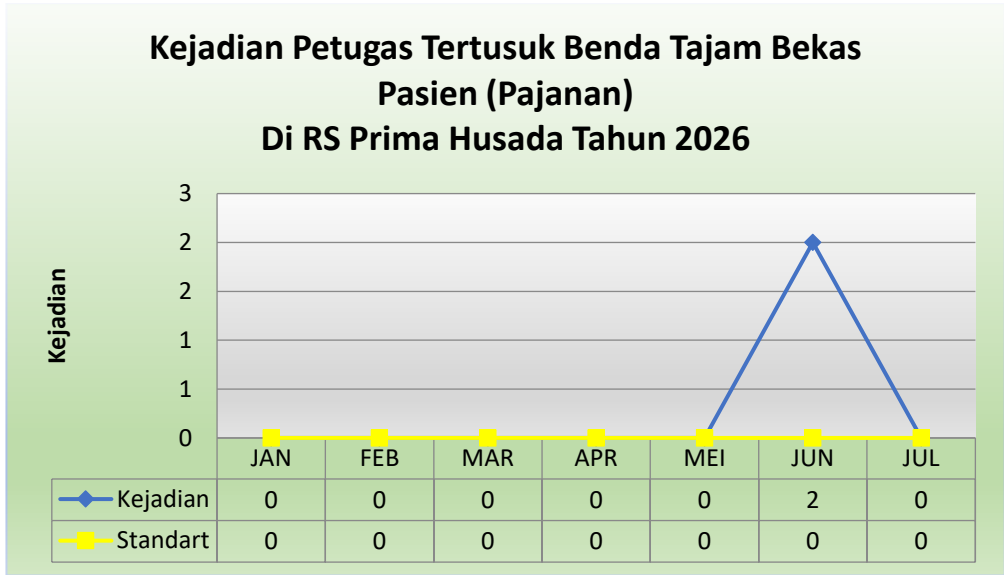


Analisa	Kepatuhan penggunaan APD masih berada di bawah standar 100%, dengan hasil pada bulan ini 96,58%. Artinya, meskipun staf menggunakan APD, masih terdapat petugas yang tidak tepat atau tidak sesuai indikasi pemakaian APD. Terjadi penurunan sedikit pada bulan ini dibandingkan bulan sebelumnya, menunjukkan adanya: penurunan perilaku penggunaan APD, menurunnya kesadaran staf, atau berkurangnya pengaruh dari pengawasan dan edukasi langsung yang dilakukan bulan sebelumnya. Nilai tetap belum mencapai standar 100%, sehingga masih ada: ketidakpatuhan dalam penggunaan APD lengkap dan juga pemakaian APD yang berlebihan saat melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan jenis tranmisi penularannya sehingga dianggap tetap tidak patuh. Perubahan perilaku belum konsisten penggunaan APD masih dipengaruhi faktor situasional, bukan kebiasaan yang terbentuk secara kuat. Untuk unit yang kurang patuh diantaranya : CSSD (ketidaksesuaian APD atau kurang penggunaan saat proses stelirisasi dan pencucian alat kotor, APD yang jarang digunakan adalah penutup kepala, masker), Instalasi Gizi (ketidaksesuai APD terutama saat memasak dengan alasan panas, APD yang jarang digunakan adalah penutup kepala, masker) CS (termonitor tidak secara langsung penggunaan APDnya tetapi mulai patuh untuk pemakaian APD saat bersih-bersih kamar mandi), IRNA 5C isolasi (APD yang jarang digunakan masker N95 dan terkadang lebih memilih memakai masker bedah secara dobel).
Masalah saat ini	Masih ditemukan ketidaktepatan penggunaan APD, baik penggunaan APD yang tidak lengkap maupun penggunaan APD berlebihan yang tidak sesuai indikasi.

	• Pemahaman staf mengenai indikasi penggunaan APD masih belum merata. • Kebiasaan kerja lama masih mempengaruhi perilaku penggunaan APD sehingga praktik belum konsisten. • Monitoring dan audit kepatuhan belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan di seluruh unit.				
Permasalahan sebelumnya	• Masih ada salah persepsi “tindakan ringan tidak perlu APD lengkap atau lupa tidak melepas APD”. • Audit belum merata.				
Tindakan yang dilakukan	• Mengingatkan kembali petugas yang memakai APD berlebihan terkait transmisi penyebaran penyakitnya. • Melakukan evaluasi penggunaan stok APD pada petugas koordinasi dengan pengadaan farmasi. • Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD, konfirmasi Karu dan SDM). • Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting. • Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. • Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. • Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Peningkatan Kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	• Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai standar	• Seluruh tenaga kesehatan	• Sosialisasi ulang standar penggunaan APD sesuai indikasi	• Komite PPI, IPCN	• 1 bulan
• Peningkatan pemahaman staf terkait APD	• Meningkatkan pemahaman staf tentang penggunaan APD yang tepat	• Perawat dan tenaga kesehatan	• Edukasi dan refresh training terkait indikasi dan jenis APD	• IPCN • Kepala Ruangan	• 1–2 bulan
• Peningkatan Konsistensi penggunaan APD yang benar	• Meningkatkan konsistensi penggunaan APD	• Seluruh staf unit pelayanan	• Audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala dan pemberian feedback	• Komite PPI	• Setiap bulan
• Menurunkan kebiasaan penggunaan	• Mengurangi penggunaan APD yang tidak sesuai (kurang/berlebihan)	• Tenaga kesehatan di unit pelayanan	• Supervisi langsung di ruangan dan penguatan budaya keselamatan kerja	• Kepala Ruangan • IPCN	• Berkelanjutan

APD yang tidak sesuai				• Komite PMKP	
• Kontroling ketersediaan APD	• Mengoptimalkan ketersediaan dan penggunaan APD	• Unit pelayanan	• Monitoring penggunaan dan stok APD serta koordinasi dengan instalasi farmasi	• Komite PPI • Farmasi	• Setiap bulan

3.6.1.1.9 Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam
3.6.1.1.9.1 Grafik Kejadian Petugas Tertusuk Benda Tajam Bekas Pasien (Pajanan)



Analisa	Pada bulan Juli ini tidak ditemukan kejadian tertusuk jarum.
Masalah saat ini	• Ditemukan 2 kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan ini.
Permasalahan sebelumnya	• Tidak ditemukan kejadian pajanan tertusuk benda tajam pada bulan lalu.
Tindakan yang dilakukan	• Mengingatkan untuk melakukan penyuntikan yang aman dan pengolahan benda tajam yang baik dan benar.

	• Menganjurkan untuk tidak memegang area badan safety box, untuk menghindari jika ada jarum yang tembus, disarankan memegang tali safety box saja. • Menyarankan membawa safety box atau wadah khusus untuk langsung membuang jarum/benda tajam setelah tindakan. • Melakukan pemilahan sampah yang benar, terutama benda tajam. • Menggunakan APD yang sesuai untuk meminimalisir resiko paparan.				
Rencana Tindak Lanjut	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
• Pertahankan proses penyuntikan yang aman dan pengelolaan benda tajam yang baik.	• Menurunkan kejadian paparan sesuai dengan standar 0 kejadian.	• Seluruh petugas pelayanan pasien	• Monitoring proses pemilahan sampah khususnya benda tajam saat melakukan tindakan. • Monitoring penggunaan safety box pada troli tindakan. • Biasakan petugas untuk membersihkan peralatan yang digunakan langsung tanpa mengoperkan pada shift berikutnya. • Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan untuk mencegah paparan. • Monitoring teknik recapping tutup jarum.	• Seluruh petugas pelayanan di RS.	• Satu bulan

3.6.3 Tim PKRS

3.6.3.1 Edukasi Kelompok Unit

Unit	Target	Mei	Jun	Juli	%	MANDOK	Keterangan
IRNA 2C	4x/Bulan	100%	50%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 2C Mencapai Target
ICU\HCU	4x/Bulan	0%	0%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	ICU/HCU Mencapai Target
IRNA 3C	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 3C Mencapai target
MATERNITAS	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	MATERNITAS Mencapai Target
PERINATOLOGI	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	PERINATOLOGI Mencapai Target
IRNA 5C	4x/Bulan	0%	0%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRNA 5C Mencapai Target
IRNA 2A,3A,4A	4x/Bulan	50%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 2A,3A,4A Mencapai Target
IRNA 6A,7A,8A	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IRNA 6A,7A,8A Mencapai target
IGD	4x/Bulan	100%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	IGD Mencapai Target
FARMASI	4x/Bulan	100%	75%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	FARMASI Mencapai Target
GIZI	4x/Bulan	50%	100%	100%	Tercapai	Lampiran B	Gizi Mencapai Target
IRJA	4x/Bulan	100%	75%	100%	Tidak Tercapai	Lampiran B	IRJA Mencapai Target

ANALISIS : Berdasarkan data edukasi kelompok unit pada bulan Juli Tahun 2026, Tim PKRS telah melaksanakan edukasi dan mencapai target.

RTL : -

3.6.3.2 Pembinaan Komunitas Berbasis RS Prima Husada

UNIT	TARGET	KEGIATAN	Mei	Jun	Juli	%	MANDOK	KET
Forum Kesehatan Usia Lanjut (F-KUL) Komunitas Geriatri	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Komunitas Ibu Hamil	2X/Bulan	Senam	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hypnoterapi						
		KIE						
Yoga Lansia	2xBulan	Yoga	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
		Hynoterapi						
		KIE						
Komunitas Shirothul Jannah Perempuan	2X/Bulan	Pengajian	100%	50%	100%	Tercapai	Ada	
		Karya wisata						
Komunitas Shirothul Jannah Laki Laki	2X/Bulan	Pengajian	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
Bimbingan Doa	8X/Bulan	Mendoakan Pasien	100%	100%	100%	Tercapai	Ada	
General Meeting Karyawan	1x/2Bulan		0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	

Pembinaan Fatayat	1X/Tahun		
-------------------	----------	--	--

3.6.3.3 KIE Upaya Preventif Promotif PROGNAS

Unit	Target	Mei	Jun	Juli	%	Bukti di Form Edukasi Terintegrasi atau kolaborasi	Ket
PONEK	4X/Bulan	25%	100%	100%	Tercapai	√	
HIV	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
STUNTING dan WASTING	4X/Bulan	0%	50 %	50%	Tidak Tercapai	√	
KELURAGA BERENCANA RUMAH SAKIT (KABERUSA)	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	
TB DOTS	4X/Bulan	0%	0%	0%	Tidak Tercapai	-	

ANALISIS : Bulan Juli PROGNAS belum tercapai.
 RTL : Koordinasi dengan Kepala Bidang Umum dan Pelayanan untuk dapat Meningkatkan produktivitas Tim Prognas.

3.6.4 Tim Prognas

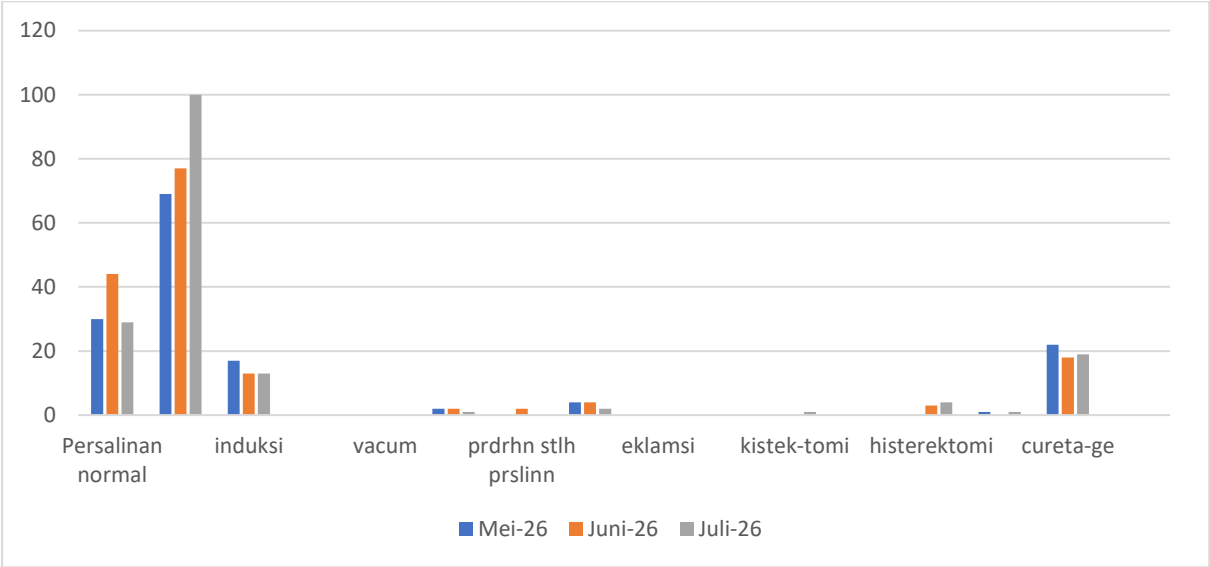
3.6.4.1 PONEK

3.6.4.1.1 Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Ponek Juli 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien		
		Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026	Bulan Juli 2026
1	Persalinan			
	a. Persalinan Normal	30	44	29
	b. <i>SectioCaesaria</i>	69	77	100
2				
	a. Induksi / Drip	17	13	13
	b. Sungsang	0	0	0
	c. Vacum	0	0	0
3				
	a. Perdarahan sebelum Persalinan	2	2	1
	b. Perdarahan setelah Persalinan	0	2	0
	c. Pre Eklamsi	4	4	2
	d. Eklamsi	0	0	0
	e. Infeksi	0	0	0
4				
	a. Curretage	22	18	19
	b. Kistektomi	0	0	1
	c. Miomektomi	0	0	0
	d. Histerectomy	0	3	4

e. KET	1	0	1
--------	---	---	---

3.6.4.1.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Maternal Di RS Prima Husada Bulan Juli 2026



Analisis :

- 1) Pada jenis persalinan normal pada bulan Juli 2026 yaitu 29 pasien menurun jika dibandingkan dengan bulan Juni 2026 yaitu 44 pasien, sedangkan bulan Mei 2026 yaitu 30 pasien.
- 2) Pada jenis pelayanan Persalinan secara Sectio Caesaria pada bulan Juli 2026 yaitu 100 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Juni 2026 yaitu 77, sedangkan bulan Mei 2026 yaitu 69 pasien
- 3) Pasien terbanyak yg dilakukan tindakan SC adalah pasien dari poli kandungan yang memang telah dijadwalkan untuk operasi dikarenakan ada diagnosa khusus sehingga harus dilakukan operasi SC, misalnya bekas SC, floating head, placenta previa, letak sungsang, dan lainnya,CPD atau pasien yang ada di ruang bersalin yang gagal untuk persalinan normal dikarenakan ada penyulit seperti prolong kala 1, kala 2 lama, fetal distres. Dan juga pasien dilakukan operasi sc adalah pasien rujukan dari bidan ataupun puskesmas yang harus dilakukan operasi dikarenakan adanya kegawatan pada ibu atau bayi dan akhirnya harus dilakukan operasi SC cito.
- 4) Tidak ada persalinan sungsang pada bulan Juli 2026 dan 2 bulan sebelumnya. Dan tidak ada persalinan dengan vacum pada bulan Juli 2026 dan 2 bulan sebelumnya.
- 5) Induksi/ Drip pada bulan Juli dan Juni sama, yaitu sebanyak 13 pasien, sedangkan pada bulan Mei sebanyak 17 pasien. Ini disebabkan kontraksi pasien inpartu sudah adekuat sehingga tidak perlu diberikan tambahan induksi/drip.
- 6) Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah pre eklamsi. Pada bulan Juli menurun, yaitu 2 kasus, sedangkan bulan Juni dan Mei 2026 yaitu 4 kasus.
- 7) Jenis pelayanan persalinan dengan komplikasi ialah eklamsi. Pada bulan Juli dan 2 bulan sebelumnya yaitu 0.
- 8) Jenis pelayanan curretage di bulan Juli 2026 yaitu 19 kasus, meningkat jika dibandingkan dengan Juni 2026 yaitu 18 kasus, sedangkan bulan Mei 2026 yaitu 22 kasus. *Curetage* dilakukan untuk Indikasi abortus, mola, blighted ovum, sisa plasenta dan pada kasus-kasus gynekology biasanya dengan indikasi menometroragi, hiperplasia endometrium, dan lainnya.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1) Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien obgyn salah satunya dengan mengadakan pelatihan bidan-bidan perujuk.

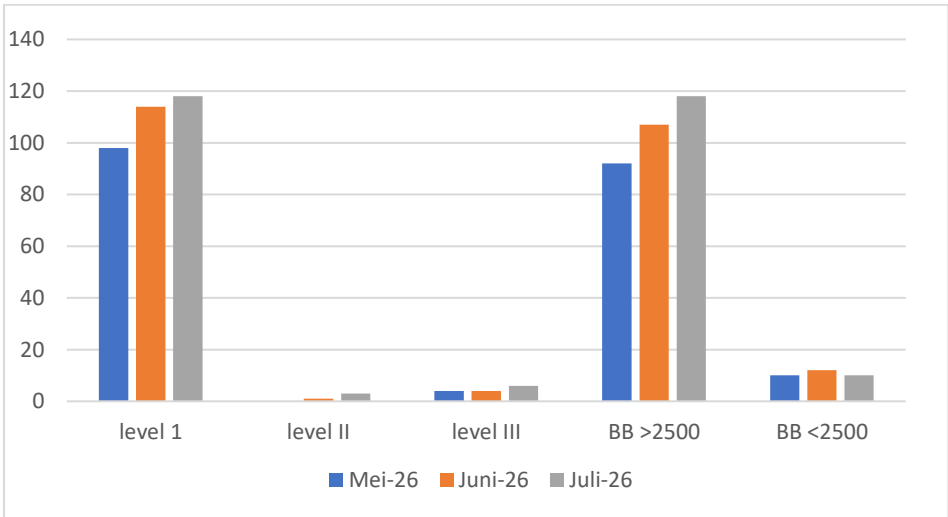
- 2) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang konsumsi makan makan yang mengandung garam terlalu tinggi, terutama pasien dengan riwayat darah tinggi.
- 3) Melakukan edukasi kepada pasien hamil saat ANC tentang tanda dan bahaya pada kehamilan.
- 4) Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 tentang tanda-tanda persalinan.
- 5) Melakukan edukasi kepada pasien ANC untuk melakukan senam hamil

3.6.4.1.3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal

3.6.4.1.3.1 Tabel Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Ponpek Juli 2026

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2026	BULAN JUNI 2026	BULAN JULI 2026
1				
	a. Level 1/ rawat gabung	98	114	118
	b. Level II/ rujukan dari luar	0	1	3
	c. Level III/NICU	4	4	6
2				
	a. BB ≥ 2500 gram	92	107	118
	b. BB ≤ 2500 gram	10	12	10

3.6.4.1.3.2 Grafik Jumlah Kegiatan Pelayanan Neonatal Di RS Prima Husada Juli 2026



Analisis :

1. Pada jenis pelayanan pasien neonatal level 1/ rawat gabung di bulan Juli 2026 yaitu 118 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Juni 2026 yaitu 114 pasien , sedangkan Mei 2026 yaitu 98 pasien.
2. Pada pelayanan level 2 / rujukan dari luar pada bulan Juni 3 pasien, meningkat dibandingkan bulan Juni 1 pasien, bulan Mei yaitu 0 pasien.
3. Pada pelayanan level 3 pada bulan Juli yaitu 3 pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Juni dan Mei yaitu 4 pasien.
4. Pada jenis pelayanan bayi lahir hidup ialah BB >2500 gram di bulan Juli 2026 yaitu 118 pasien meningkat jika dibandingkan dengan bulan Juni 2026 yaitu 107, sedangkan bulan Mei 2026 yaitu 92 pasien
5. Jumlah bayi lahir hidup <2500 gram (BBLR) di bulan Juli 2026 yaitu 10

pasien, menurun jika dibandingkan dengan bulan Juni 2026 yaitu 12 pasien, dan Mei 2026 yaitu 10 pasien. Ini disebabkan karena masih adanya kelahiran < 2500 gram dikarenakan kelahiran belum cukup bulan atau IUGR.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC untuk mengurangi kegiatan berat dan istirahat cukup agar tidak terjadi partus prematurus imminens (PPI) yang mengakibatkan kelahiran prematur.
- 2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil saat dilakukan ANC terkait asupan gizi saat ibu hamil, guna mencegah bayi lahir dengan IUGR.
- 3. Melakukan edukasi pada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kehamilan

3.7.12 Pelayanan Ante Natal Care (ANC)
Tabel Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Ponek April 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026	Bulan Juli 2026
1	ANC	371	482	466

Grafik Jumlah Pelayanan Ante Natal Care Di RS Prima Husada Juli 2026



Analisis :

- 1) Berdasarkan data kunjungan Ante Natal Care (ANC), Pada bulan Juni, jumlah kunjungan mengalami penurunan yang menjadi 466 kunjungan. Jika dibandingkan dengan bulan Juni, terjadi penurunan sebanyak 16 kunjungan atau sekitar 3,3%. Sedikit penurunan kunjungan pada bulan Juli kemungkinan dipengaruhi dari perubahan jadwal kunjungan ANC, yaitu pemeriksaan pada bulan selanjutnya.
- 2) Secara keseluruhan, tren kunjungan ANC pada periode Mei- Juli 2026 menunjukkan kecenderungan meningkat. Meskipun ada sedikit penurunan pada bulan Juli, evaluasi dan pemantauan secara berkala tetap perlu dilakukan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah kunjungan ANC sehingga seluruh ibu hamil memperoleh pelayanan sesuai standar.

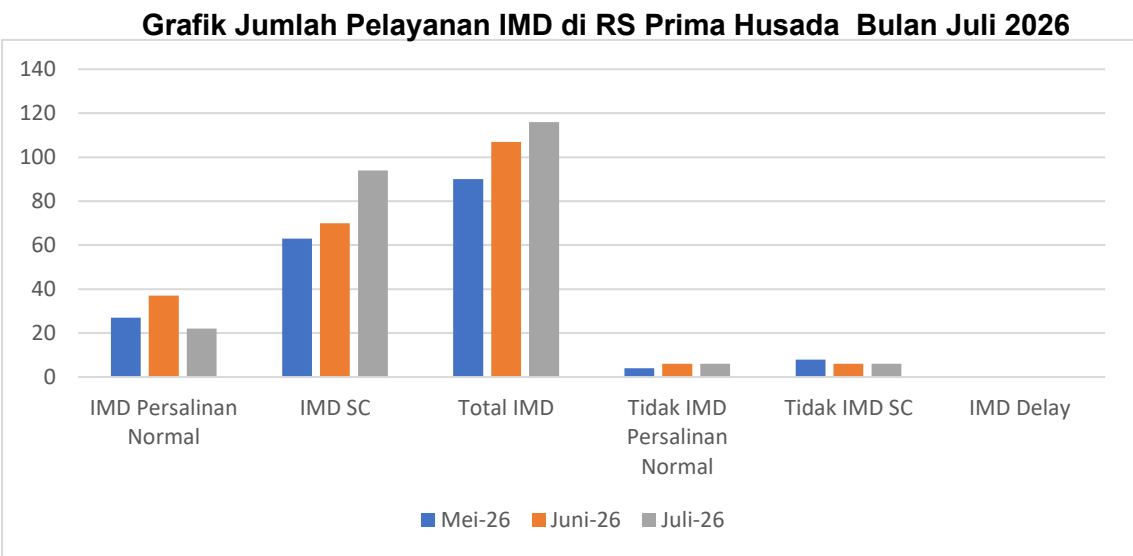
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan promosi kesehatan terkait pemeriksaan ANC di dokter spesialis Obgyn

- 2. Melakukan Promosi layanan ANC risiko tinggi
- 3. Melakukan Program kelas ibu hamil

3.7.13 Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Tabel Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Juli 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien					
		Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%	Bulan Juli 2026	%
1	IMD Persalinan Normal	27	87%	37	86,1%	22	78,6%
52	IMD SC	63	88,7%	70	92,1%	94	94%
3	Total IMD	90	88,2%	107	89,9%	116	90,6%
4	Tidak IMD Persalinan Normal	4	12,9%	6	13,9%	6	21,4%
5	Tidak IMD SC	8	11,2%	6	7,9%	6	6%
6	IMD Delay	0	0%	0	0%	0	0%
	Total Kelahiran Normal	31		43		28	
	Total Kelahiran SC	71		76		100	
	Total kelahiran	102		119		128	



Analisis :

- 1) Pada bulan Juli 2026 jumlah IMD persalinan normal yaitu 22 (78,6%) pasien, menurun di dibandingkan bulan Juni 37 (86,1%) pasien pasien sedangkan bulan Mei yaitu 27 (87%) pasien Bayi.
- 2) Sedangkan IMD pada kelahiran SC pada bulan Juli yaitu 94 (94%) pasien, meningkat dibandingkan dengan bulan Juni yaitu 70 (92,1%) pasien, dan bulan Mei yaitu 63 (88,7%) pasien.
- 3) Kejadian tidak dilakukan IMD pada persalinan normal bulan Juli yaitu 6 (21,4%) pasien, sama dengan bulan Juni yaitu 6 (13,9%) sedangkan bulan Mei yaitu 4 (12,9%),
- 4) Kejadian tidak dilakukan IMD pada kelahiran SC bulan Juli 2026 yaitu 6 (6%) pasien, sama dengan bulan Juni 2026 yaitu 6 (7,9%) pasien sedangkan bulan Mei 2026 yaitu 8 (11,2%)
- 5) Bayi yang tidak dilakuan IMD dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk dilakukannya IMD dikarenakan membutuhkan penanganan lebih lanjut seperti bayi BBL dengan perawatan infant warmer, bayi dengan pemakaian CPEP.
- 6) Berikut ini bayi yang tidak dilakukan IMD pada bulan Juli 2026

No	Nama Bayi	Diagnosa	Perawatan BBL
Persalinan Normal			
1	By Ny Noraina	NKB + BBLR	Inkubator + CPEP
2	By Ny Rinda	Imatur + BBLASR	Infarn Warmer
3	BY Ny Orlin	Imatur + BBLASR	Cuvis
4	By Ny Jumrotun	NCB + BBLR	Infarn Warmer
5	By Ny Rini Septianti	NKB, BBLR	Cuvis
6	By Ny Siti Nur yuda	NKB, BBLR	Cuvis
SC			
1	By Ny Nur Khofifah 1	RDS, Neonatal pneumonia, BBLSR, Neonatal Hematemesis	Inkubator + CPEP
2	By Ny Nur Khofifah 2	RDS, Neonatal pneumonia, BBLSR	Inkubator + CPEP
3	By Ny Ani Sulistyoarti	NKB + BBLR	Cuvis
4	By Ny Tri Wahyuningsih	NKB + BBLR	Cuvis
5	By Ny Shofia	NCB, susp PJB kritis, asfiksia	Inkubator + CPEP
6	By Ny Ita Novianti	NCB + Ibu HBSAG reaktif	Infarn Warmer

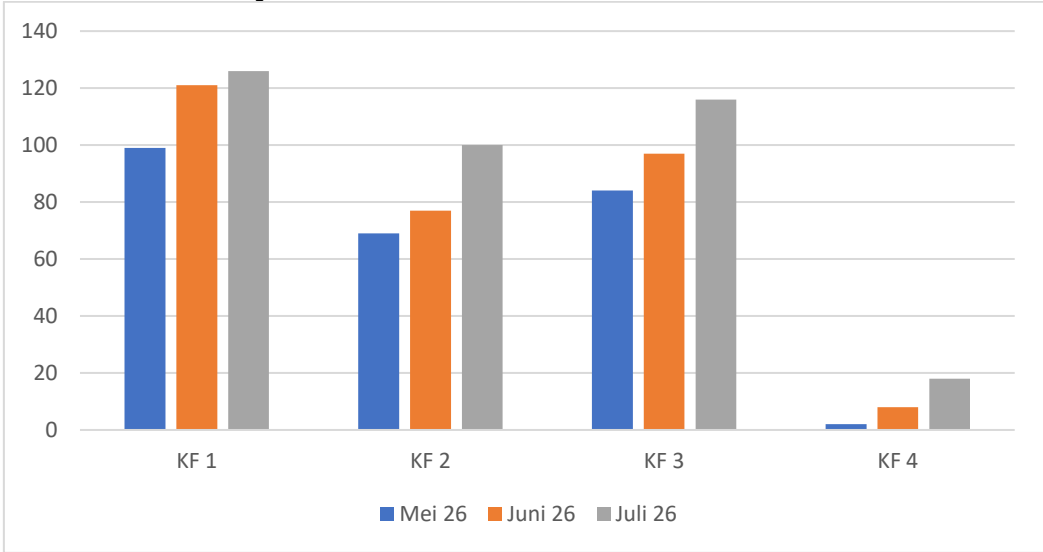
Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Melakukan skrining sebelum dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada bayi baru lahir, apakah sesuai dengan syarat ataukah tidak
2. Mempertahankan Konsistensi Pelaksanaan IMD
3. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan IMD
4. Edukasi sejak ANC tentang manfaat IMD dan ASI eksklusif.

3.7.14 Pelayanan Post Natal Care (PNC)
Tabel Pelayanan Post Natal (PNC) Ponek Mei 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah					
		Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%	Bulan Juli 2026	%
1	KF 1 (6-4 jam)	99	100%	121	100%	129	100%
2	KF2: 3–7 hari	69	69,6%	77	63,6%	100	77,5 %
3	KF 3 (8- 28 hari)	84	84,8 %	97	80,2%	116	89,9%
4	KF4: 29–42 hari)	2	2%	8	6,6%	18	14%
	∑ kelahiran Normal	30		44		29	
	∑ kelahiran SC	69		77		100	
	Total kelahiran	99		121		129	

Grafik Jumlah Pelayanan Post Natal Care di RS Prima Husada Bulan Juni 2026



Analisis :

- 1. Dari tabel dan grafik 3.3.6 Kunjungan PNC KF 1 pada bulan Juli yaitu 129 pasien (100%), pada bulan Juni yaitu 121 pasien (100%), sedangkan pada bulan Mei yaitu 99 pasien (100%), (100%), ini artinya semua pasien post partum melakukan kunjungan pada KF1
- 2. Pada kunjungan KF 2 pada bulan Juli yaitu 100 pasien (77,5%), pada bulan Juni yaitu 77 pasien (63,6%), sedangkan pada bulan Mei yaitu 69 pasien (69,6%), capaian KF 2 belum 100% di karenakan pasien post partum normal hari ke 2 sudah diijinkan pulang dan jadwal kontrol ulang hari ke 8 pasca rawat inap.
- 3. Pada kunjungan KF 3 pada bulan Juli yaitu 116 pasien (89,9%) pada bulan Juni yaitu 97 pasien (80,2%) pada bulan Mei yaitu 84 pasien (84,8%) capaian KF 3 belum 100% di karenakan masuk laporan bulan sebelumnya atau bulan setelahnya.
- 4. Pada kunjungan KF 4 pada bulan Juli yaitu 18 pasien (14 %), sedangkan pada bulan Juni yaitu 8 pasien (6,6%), dan bulan Mei dan Mei yaitu 2 pasien (2,1%), pada KF 4 cakupan hanya sedikit di karenakan pasien post partum dan post SC setelah kunjungan KF 3 pasien tidak ada komplikasi untuk pemantauan di kembalikan ke faskes 1, pasien KF 4 yang masih bisa di layani di faskes 2 dikarenakan ada masalah seperti infeksi luka operasi atau infeksi jahitan perineum, Tekanan Darah pasien tinggi, evaluasi sisa selaput ketuban.

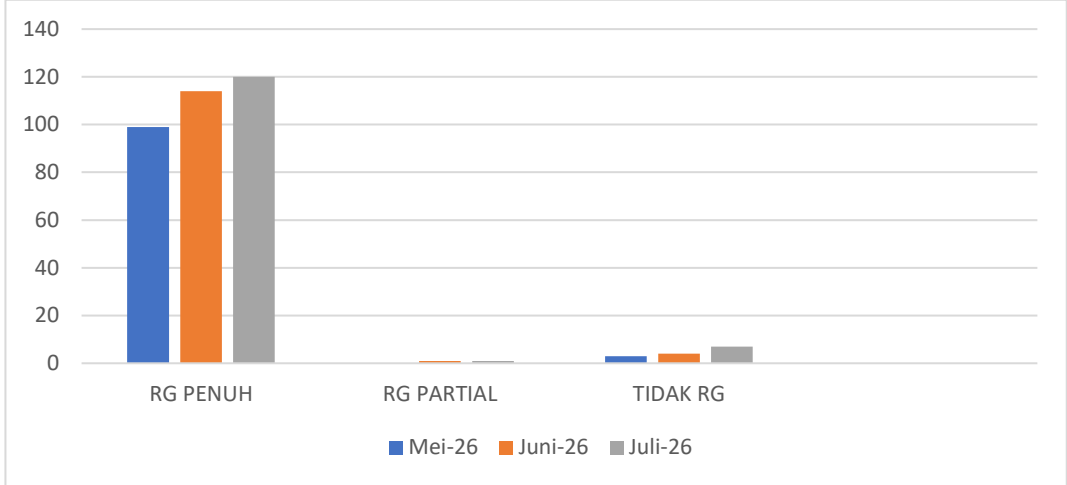
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Melakukan Edukasi pasien dan keluarga Jadwal kontrol nifas sesuai jadwal
- 2. Melakukan edukasi tanda bahaya nifas
- 3. Melakukan edukasi pentingnya KB pasca salin
- 4. Melakukan edukasi pemantauan nifas KF 4 di faskes 1

3.1.2.2.1.5 Pelayanan Rawat Gabung
Tabel Pelayanan Rawat Gabung Ponek Juli 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien					
		Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%	Bulan Juli 2026	%
1	Rawat gabung penuh	99	97%	114	95,8%	120	93,8%
2	Rawat gabung partial	0	10%	1	0,8%	1	0,8%
3	Tidak Rawat gabung	3	2,9%	4	3,4%	7	5,5%
Σ Kelahiran		110	102	-	119	-	128

Grafik Pelayanan Rawat Gabung di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2026



Analisis :

- 1. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung pada bulan Juli 2026 yaitu 120 (93,8%) bayi meningkat jika dibandingkan dengan bulan Juni 2026 yaitu 114 (95,8%) bayi, sedangkan bulan Mei 2026 yaitu 99 (97%) bayi. Jumlah bayi yang dilakukan rawat gabung dengan syarat bayi dan ibu dalam kondisi sehat
- 2. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung pada bulan Juli 2026 yaitu 7 (5,5%) bayi, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Juni 2026 yaitu 4 (3,4%) bayi bayi, dan Mei 2026 yaitu 3 (2,9 (3,6%).
- 3. Berikut bayi yang tidak dilakukan rawat gabung

No	Nama	Diagnosa	Perawatan BBL
1	By Ny Rinda	imatur + BBLASR	Infarn warmer
2	By Ny Orlin	Imatur + BBLASR	Infarn Warmer
3	By Ny Nur Khofifah 1	RDS, Neonatal pneumonia, BBLSR, Neonatal Hematemesis	Inkubator + CPEP
4	By Ny Nur Khofifah 2	RDS, Neonatal pneumonia, BBLSR	Inkubator + CPEP
5	By Ny Shofia	NCB, susp PJB kritis, Asfiksia	Inkubator + CPEP
6	By Ny Siti Eni	RDS Ok Susp neonatus pneumonia dd TTNB Susp PJB Kritis	Inkubator + CPEP
7	By Ny Hanifah	RDS Ok Susp neonatus dd TTNB	Inkubator + CPEP

- 4. Bayi yang tidak dilakukan rawat gabung adalah bayi yang membutuhkan perawatan khusus yaitu diletakkan di cuvis atau incubator karena berat bayi < 2500 gram atau masih belum memungkinkan dilakukan rawat gabung karena masih menggunakan alat bantu pernafasan dan observasi.

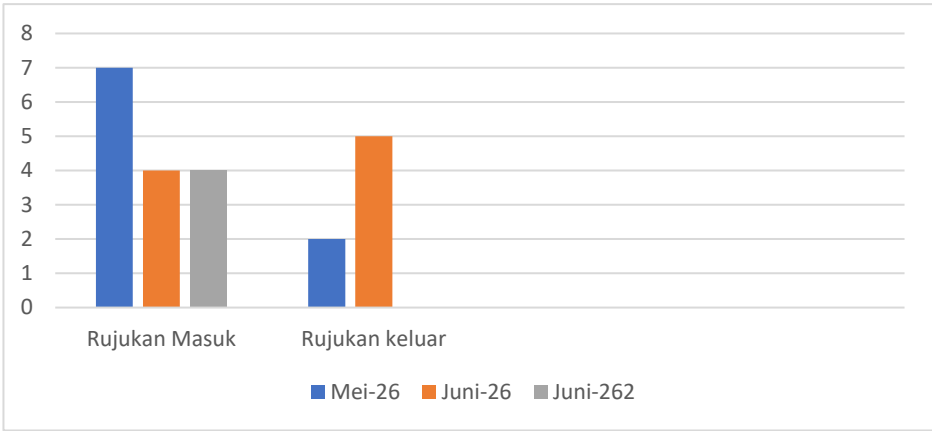
Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Setelah kondisi bayi stabil segera dilakukan rawat gabung atau kontak ibu-bayi.
- 2. Fasilitasi ibu untuk pemerah ASI sedini mungkin (1–2 jam setelah persalinan)
- 3. Kunjungan ibu ke ruang perinatologi / NICU (jika memungkinkan)
- 4. Pelaksanaan **Kangaroo Mother Care (KMC)** pada bayi BBLR yang sudah stabil.

3.1.2.2.1.6 Pelayanan Jejaring Rujukan
Tabel Pelayanan Jejaring Rujukan Ponék Juli 2026

Rujukan	Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026	Bulan Juli 2026
Rujukan Masuk	7	4	4
Rujukan keluar	2	5	0

Grafik Pelayanan Rujukan RS Prima Husada Bulan Juli 2026



Evaluasi :

- 1. Jumlah rujukan masuk pada bulan Juli dan Juni 2026 sama, yaitu yaitu 4 rujukan, sedangkan bulan Mei 2026 yaitu 7 rujukan
- 2. Jumlah rujukan keluar pada bulan Juli 2026 yaitu 0, sedangkan pada bulan Juni 2026 yaitu 5 rujukan, dan pada bulan Mei 2026 sebanyak 2 rujukan.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Bekerja sama dengan tim PKRS untuk melakukan promosi kesehatan dan mengajak BPM, Puskesmas, Klinik dan RS setempat untuk bekerja sama.
- 2. Menambah jumlah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meminimalisasikan untuk dilakukan rujukan keluar.

3.1.2.2.1.6.1 Rujukan Masuk
Tabel Rujukan Masuk Ponék Juli 2026

Bulan Mei 2026			
1	Ny Muspita Sari	G4 P2002 Ab100 UK 18-20 minggu dengan IUFD	KRI Putra Husada
2	Ny Sari Kurnia	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan KIFA	Klinik Mutiara Sehat
3	Ny Vio Eka	G1 P0000 Ab000 UK 40 minggu dengan impending ekamsia	Klinik Mutiara Sehat
4	Ny Siti Muyassaroh	G1 P0000 Ab000 UK 37-38 minggu dengan KPD	PMB Munawaroh
5	Ny Alfiah	G1 P0000 Ab000 UK 36-37 minggu dengan letsu + partus prematurus + KIFA + IUGR + PER	PMB Titik S
6	Ny Sofi Andini	G3 P1001 Ab100 UK 38-39 minggu dengan KPD + KIFA	PMB Lilik Agustina
7	Ny Anita	G5 P4004 Ab000 UK 10-12 minggu dengan abortus inkomplit	PMB Titik Idmawanti
Bulan Juni 2026			

1	Ny Cindy Lailia	G2 P1001 Ab000 UK 39-40 minggu dengan KPD	Klinik Mutiara Sehat
2	Ny Tanti W	G2 P0000 Ab100 UK 36-37 minggu dengan KPD	PMB Wahyu Dewi
3	Ny Hernindya	G2 P0000 Ab100 UK 37-38 minggu dengan KIFA	Klinik Divisi 2 kostrad
4	Ny Ananda Rahma	PMB Lilik Agustina	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 minggu dengan KIFA + CPD
Bulan Juli 2026			
1	Ny Siti Aminatuz Zuhriya	G1 P0000 Ab000 UK 38-39 minggu dengan kala 2 lama	PKM Singosari
2	Rizkha H	G1 P0000 Ab000 UK 40-41 mgg dg oligohidramnion	Wisma Husada
3	Ny Elizabet anggi P	G2 P1001 Ab000 Uk 35-36 minggu dengan Ppi + HT gestasional + BSC	PMB titik S
4	Ny Printari Nur Fauzia	G2 P1001 Ab000 uk 38-39 minggu dengan kala 2	PKM Ardimulyo

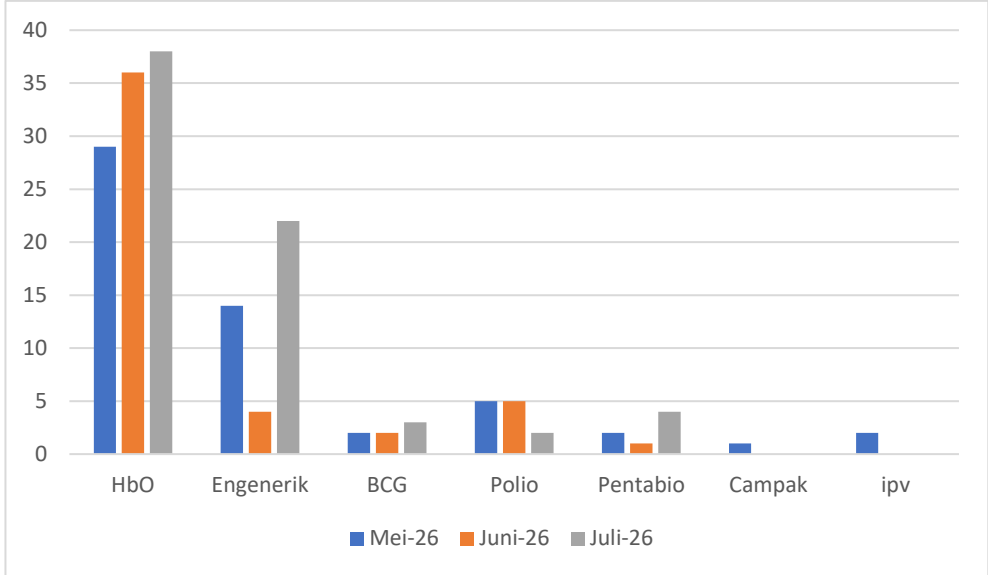
3.1.2.2.7.2 Rujukan Keluar
Tabel Rujukan Keluar Ponек Juli 2026

No	Nama	Usia	Unit	Diagnosa	Alasan Rujukan	Tujuan Rujukan
Bulan Mei 2026						
1	By Ny Miratus	0 hari	NICU	NKB + BBLR + RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi + pro surfaktan	RS Saiful Anwar
2	By Ny Hindun	4 hari	NICU	Obs distres nafas ok Neonatal Pneumonia dd MAS, susp congenital anomaly dd achondroplasia	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Saiful Anwar
Bulan Juni 2026						
1	Ny Syaidah	25 th	Maternitas	G2 P1001 Ab000 UK 10-12 minggu dengan HEG + Hematomesis	Pro Rawat bersama SP.PD-KGEH	RS Saiful Anwar
2	By Ny Endang	1 hari	NICU	NCB + RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi	RS Soepraoen
3	By Ny Weni	3 hari	NICU	NKB	Pro Sub Spesialistik Neonatologi + Spesialis bedah anak	RS Saiful Anwar
4	By Ny Eka Safitri	1 hari	NICU	NKB + BBLSR	Pro Sub Spesialistik Neonatologi + pro surfactan	RS Panti Nirmala
5	By Ny Putri	2 hari	NICU	NKB + BBLSR + RDS	Pro Sub Spesialistik Neonatologi + pro surfactan	RS Saiful Anwar

3.1.2.2.12.8 Pelayanan Imunisasi
Tabel Pelayanan Imunisasi Ponek Juni 2026

No	Jenis Pelayanan	Jumlah					
		Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%	Bulan Juli 2026	%
1	HbO	29	28,4%	36	30,2%	38	29,7%
2	Engerix Junior	14	13,7%	4	3,3%	22	17,2%
3	BCG	2	-	2	-	3	-
3	Polio	5	-	5	-	4	-
4	Pentabio	2	-	1	-	2	-
5	Campak	1	-	0	-	0	-
6	IPV	2	-	0	-	0	-
	Σ Kelahiran	102		119		128	

Grafik Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2026



Analisis :

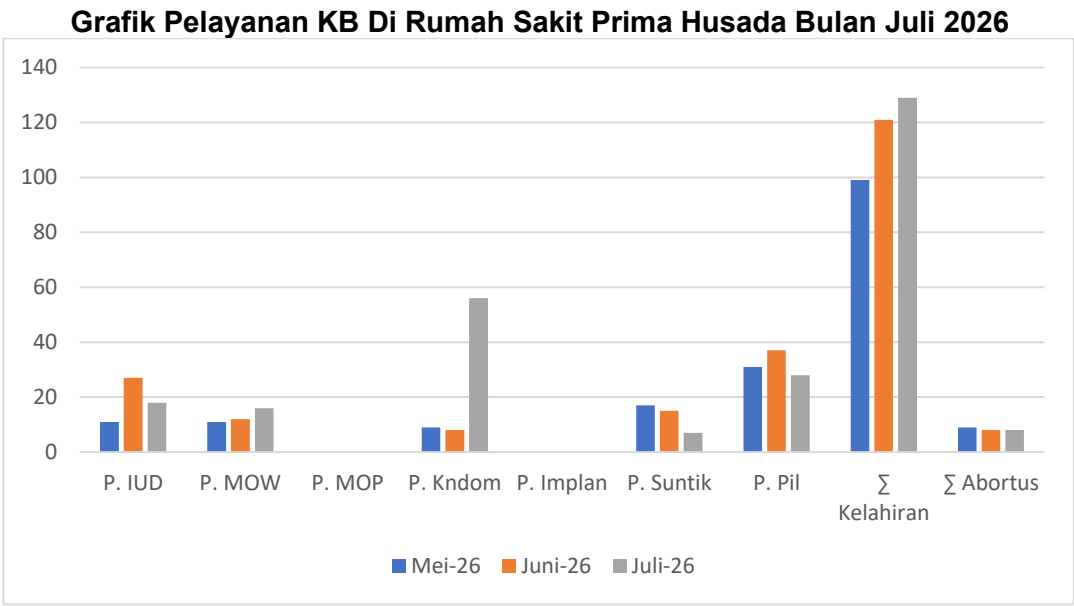
- 1) Bayi yang melakukan Imunisasi Hbo pada bulan Juli 2026 yaitu 38 (29,7%) pasien, meningkat jika dibandingkan dengan bulan Juni 2026 yaitu 36 (30,2%) %) pasien, sedangkan pada bulan Mei 2026 yaitu 29 (28,4%) pasien dikarenakan stok vaksin dari dinas Kesehatan kabupaten malang terbatas sehingga Puskesmas hanya bisa memberikan sedikit ke RS swasta, sehingga bayi yang baru lahir yang belum mendapat imunisasi HB0 diarahkan untuk imunisasi Hbo di Puskesmas wilayah masing-masing sebelum usia 7 hari atau pembelian vaksin Engerix Junior dengan edukasi Biaya Umum
- 2) Pada bulan Juli ada 22 (17,2%) bayi yang menggunakan vaksin Engerix Junior, meningkat dibandingkan pada bulan Juni ada 4 (3,3%) bayi, sedangkan bulan Mei ada 14 (13,7%) bayi. Penggunaan vaksin Engerix Junior ini dikarenakan banyak nya bayi baru lahir yang tidak mendapatkan vaksin Hbo disebabkan persediaan Hbo yang sedikit, sehingga ditawarkan untuk pembelian Vaksin Engerix Junior.
- 3) Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi IPV Pada bulan Juli dan Juni 2026, sedangkan bulan Mei 2026 sebanyak 2.
- 4) Ada 3 bayi yang melakukan Imunisasi BCG Pada bulan Juli, sedangkan pada bulan Juni dan Mei 2026 ada 2 bayi.
- 5) Tidak ada bayi yang Imunisasi Campak bulan Juli dan Juni 2026, sedangkan bulan Mei ada 1 bayi.
- 6) Ada 4 bayi yang melakukan Imunisasi Polio Pada bulan Juli , sedangkan pada bulan Juni dan Mei ada 5 bayi.
- 7) Ada 2 bayi yang melakukan imunisasi Pentabio pada bulan Juli dan Mei 2026, sedangkan pada bulan Juni ada 1 bayi. Imunisasi pentabio diberikan bersamaan dg rota dan PCV, sedangkan vaksin tersebut ada pembatasan dari puskesmas.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Membuat surat permintaan berupa laporan bulanan kepada puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan vaksin di rumah sakit.
- 2. Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit.

3.2.2.1.2.9 Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
Tabel Pelayan Keluarga berencana (KB) Ponek Juli 2026

No	Jenis	Jumlah Pasang					
		Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%	Bulan Juli 2026	%
1	IUD	11	11,1%	27	22,3%	18	14%
2	MOW	11	11,1%	12	9,9%	16	12,4 %
3	MOP	0	-	0	-	0	-
4	Kondom	9	100%	8	100%	56	100%
5	Implant	0	-	0	-	0	-
6	Suntikan	17	-	15	-	7	-
7	Pil	31		37		28	-
8	Σ Kelahiran	99		121		129	
9	Σ Abortus	9		8		8	



- Analisis :
- 1) Pemasangan KB IUD pada bulan bulan Juli 2026 menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 18 (14%) akseptor, pada bulan Juni yaitu 27 (22,3%) sedangkan pada bulan Mei yaitu 11 (11,1%). Pemakaian IUD pasca salin dengan cakupan sedikit dikarenakan ada biaya jasa dokter 400.000 untuk IUD coper T, dan biaya IUD nova T 850.000.
 - 2) Pasien yang menggunakan metode MOW pada bulan Juli 2026 meningkat, yaitu sebanyak 16 (12,4%) pasien, sedangkan pada bulan Juni 2026 sebanyak 12 (9,9%) dan bulan Mei 2026 sebanyak 11 (11,1%) pasien. Untuk pemasangan KB MOW dilakukan sesuai dengan indikasi pasiennya, seperti pada pasien grande multipara dan primi tua sekunder. Tindakan MOW dilakukan jika ada indikasi dari DPJP.
 - 3) Pasien yang menggunakan metode kondom pada bulan Juni 2026 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 56 pasien, sedangkan pada bulan Juni 2026 yaitu 8 pasien dan pada bulan Mei 2026 yaitu 9 pasien.
 - 4) Pasien yang menggunakan metode Pil pada bulan Juli 2026 menurun jika

- dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 28 pengguna, sedangkan pada bulan Juni 2026 yaitu 37 pengguna, dan bulan Mei 2026 yaitu 31 pengguna
- 5) Pasien yang menggunakan metode suntik pada bulan Juli menurun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 7 pengguna, sedangkan bulan Juni 2026 yaitu 15. Pengguna dan bulan Mei 2026 yaitu 17 pengguna.

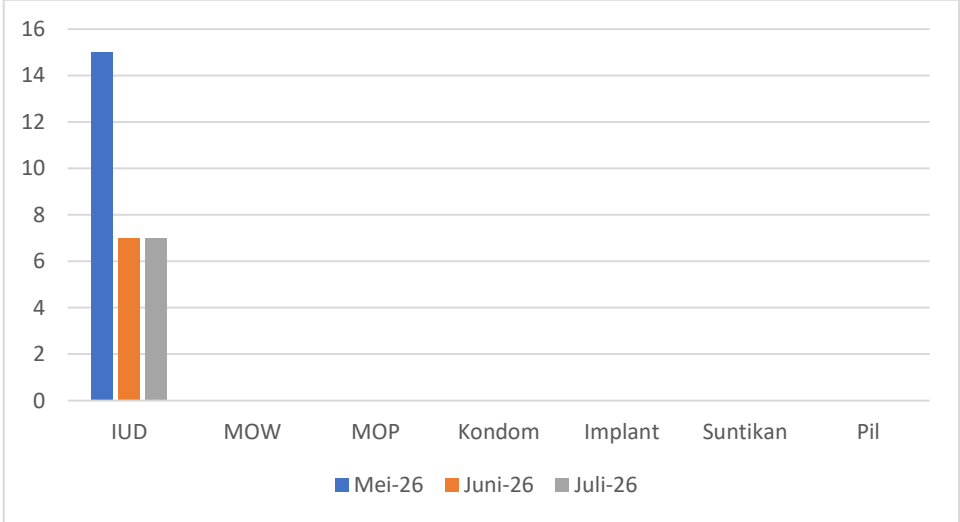
Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

Pelayanan Pelepasan KB di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2026

No	Jenis	Jumlah Lepas		
		Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026
1	IUD	15	7	7
2	MOW	0	0	0
3	MOP	0	0	0
4	Kondom	0	0	0
5	Implant	0	0	0
6	Suntikan	0	0	0
7	Pil	0	0	0

Grafik Pelayanan KB di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juli 2026



Analisis :

1. Pelepasan KB IUD pada bulan Juli dan Juni 2026 sama yaitu 7 Akseptor, sedangkan pada bulan Mei 2026 yaitu 15 Akseptor,
2. Pelepasan KB Implan pada bulan Juli 2026 dan 2 bulan sebelumnya tidak ada

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan KB baik dilakukan oleh bidan maupun dokter spesialis di rumah sakit.

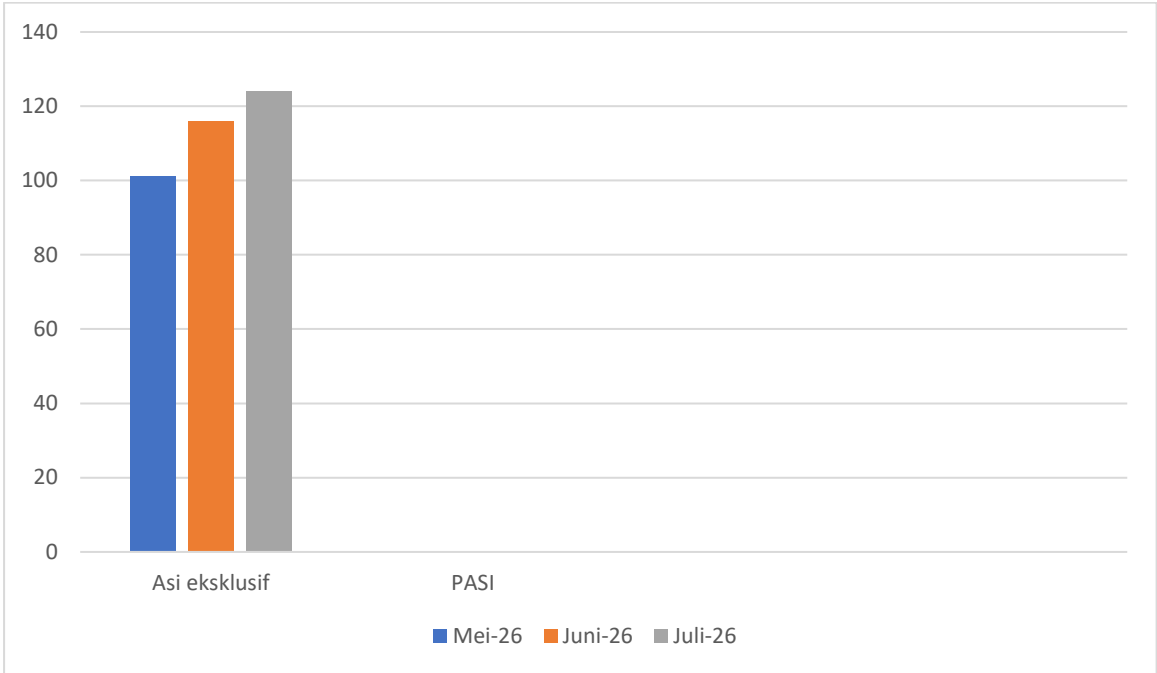
3.3 Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif

Tabel Pelayanan Pemberian ASI Eksklusif Juli 2026

No	Pemberian Asi	Jumlah Pasien					
		Bulan Mei 2026	%	Bulan Juni 2026	%	Bulan Juli 2026	%
1	Asi eksklusif	101	100%	116	97,5%	124	96,9%
2	PASI	0	0%	0	0%	0	0%

3	Puasa	1		3	2,5%	4	3,15
Σ kelahiran		110	102	-	119	-	128

Grafik Pelayanan Pemberian Asi Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Juli 2026



Analisis :

- Pelayanan pemberian ASI eksklusif pada bulan Juli yaitu 124 (96,9%) bayi, pada bulan Juni yaitu 116 (97,5%) bayi, sedangkan bulan Mei yaitu 101 (100%) bayi, Pemberian ASI belum memenuhi target yaitu 100% Hal ini dikarenakan ada bayi yang puasa dikarenakan
- Tidak ada bayi yang mendapat PASI pada bulan April dan 2 bulan sebelumnya. Bayi yang menggunakan susu formula pada bayi dengan kondisi tertentu, dan atas rekomendasi dari dokter spesialis anak.

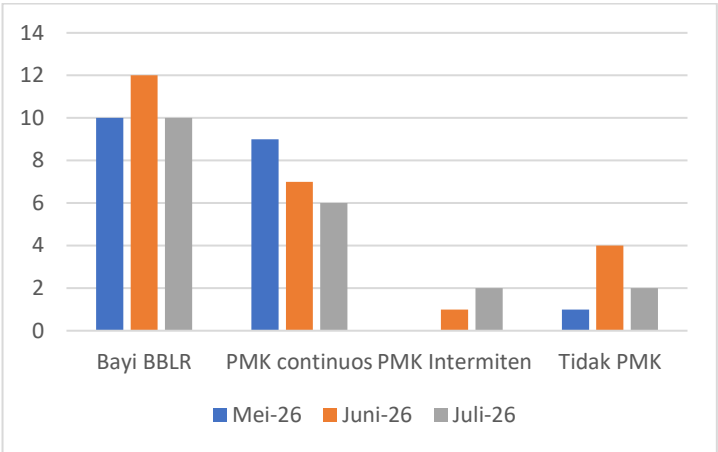
Rencana dan Tindak Lanjut :

- Edukasi ASI eksklusif sejak antenatal
- Melakukan konseling laktasi oleh dokter, bidan dan perawat

3.2.2.1.2.10 Pelayanan Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR
Tabel Pelayanan Perawatan metode kanguru (PMK) Pada BBLR di Ponek Juli 2026

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026	Bulan Juli 2026
1	Bayi BBLR	10	12	10
2	PMK continuos	9	7	6
3	PMK Intermiten	0	1	2
4	Tidak PMK	1	4	2

Grafik Perawatan Metode Kangguru (PMK) Pada BBLR di RS Prima Husada Juli 2026



Analisis :

- 1. Bayi yang dilakukan PMK continus dan PMK intermiten adalah bayi dengan berat badan <2500 gram.
- 2. Ada 2 pelayanan perawatan metode kangguru (PMK) dengan metode intermiten pada BBLR di bulan Juli 2026, sedangkan pada bulan Juni ada 1 bayi, dan bulan Mei 2026 tidak ada.
- 3. Sedangkan metode PMK continus pada bulan Juli 2026 sebanyak 6 bayi, sedangkan pada bulan Juni 2026 sebanyak 7 bayi, dan Mei 2026 sebanyak 9 bayi dengan BBLR kondisi bayi stabil.
- 4. Ada 2 bayi yang tidak dilakukan PMK pada bulan Juli 2026, sedangkan pada bulan bulan Juni 2026 ada 4 bayi, dan Mei ada 1 bayi. Hal ini dikarenakan bayi dengan diagnosa BBLASR dan Imatur, bayi meninggal.

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Perawatan Metode Kangguru sesuai dengan SPO yang berlaku
- 2. Memberikan edukasi kepada orang tua bayi untuk melakukan PMK

1.1.2.2. TB DOT'S

3.1.2.2.2 Skrining Pasien

NO	JENIS SKRINING	JUMLAH PASIEN			KET
		MEI	JUNI	JULI	
1.	Pemberian Masker pada Pasien Suspek TB/ Non TB	0	0	0	
2	Pemberian Masker pada Keluarga TB+	0	1	0	
3	Pemberian masker Pasien TB+ yang lupa membawa Masker/Perilaku tidak berubah	0	0	0	

Evaluasi :

- 1. Pada bulan Mei 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 2. Pada bulan Juni 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker
- 3. Pada bulan Juli 2026 terdapat 0 pasien yang diberikan masker

Rencana dan Tindak Lanjut:

- 1. Memfasilitasi ketersediaan masker
- 2. Edukasi pemakaian masker (meliputi fungsi, waktu penggunaan, dan siapa saja yang perlu menggunakan)

3.1.2.2.1 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi

**3.1.2.2.2 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis
Bulan Mei 2026**

No	Pelaksanaan	Usia	Px Mantoux	TCM Bakteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	04/05/2026	28th	-	Negatif	Negatif	Positif
2	06/05/2026	42th	-	Negatif	Positif	-
3	07/05/2026	74th	-	Positif	Positif	-
4	14/05/2026	1th	Negatif	-	Negatif	Positif
5	28/05/2026	20th	-	Positif	Negatif	-
6						
7						
8						
9						
10						
	Total			2	2	2

**3.1.2.2.2 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis
Bulan Juni 2026**

No	Pelaksanaan	usia	Px Mantoux	TCM Bakteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	02-06-2026	3th	Positif	-	Negatif	-
2	08-06-2026	50th	-	Positif	Negatif	-
3	09-06-2026	43th	-	Positif	Positif	-
4	16-06-2026	55th	-	Negatif	Positif	-
5	18-06-2026	58th	-	Positif	Positif	-
6	22-06-2026	28th	-	Positif	Positif	-
7	22-06-2026	25th	-	Negati	Negati	Positif
8	26-06-2026	20th	-	Positif	Positif	-
9						
10						
11						
12						
13						
	Total	8	1	5	5	1

**3.1.2.2.2 Proporsi Pasien (Terduga dan Baru) Tekonfirmasi Bakteriologis
Bulan Juli 2026**

No	Pelaksanaan	Usia	Px Mantoux	TCM Bacteriologis	Foto X Ray	Hasil PA
1.	06-07-2026	46th	Negatif	Negatif	Negatif	Positif
2	07-07-2026	46th	Negatif	Negatif	Negatif	Positif
3	08-07-2026	45th	-	Positif	Positif	-
4	10-07-2026	9th	Positif	-	Negatif	-
5	17-07-2026	17th	-	Positif	Positif	-
6	17-07-2026	65th	-	Negatif	Positif	-
7	19-07-2026	16th	-	Positif	Positif	-
8	21-07-2026	60th	-	Positif	Positif	-
9	23-07-2026	27th	-	Positif	Positif	-
10	27-07-2026	36th	-	Positif	Positif	-
11	30-07-2026	61th	-	Positif	Positif	-
12						
13						
	Total	11	1	7	8	2

Analisis :

1. Pada bulan Mei 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 5 pasien dan pasien negative 29 pasien
2. Pada bulan Juni 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negative 28 pasien
3. Pada bulan Juli 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 29 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 11 pasien dan pasien negative 18 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3.1.2.2.1 Penemuan Kasus TB

No	Unit	Jumlah Pasien		
		Mei	Juni	Juli
1.	Poli Paru	2	4	
2	Poli Bedah			
3	Poli IPD		1	1
4	Poli Anak	1	1	
5	Irna 2C			
6	ICU	1		
7	IGD			
8	Irna 2A			1
9	Irna 3C anak			
10	Irna 3A			
11	Irna 4A			

12	Maternitas 4C			3
13	Irna 5C	1	2	
14	Irna 6A			
15	Irna 7A			1
16	Irna 8A			
	Total	5	8	6

- Analisis :**
1. Pada bulan Mei 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 34 Pasien diambil data dari SITB. pasien positif sejumlah 5 pasien dan pasien negative 29 pasien
 2. Pada bulan Juni 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 36 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 8 pasien dan pasien negative 28 pasien
 3. Pada bulan Juli 2026 jumlah proporsi Pasien terduga TB 29 pasien diambil data dari SITB. Pasien positif sejumlah 11 pasien dan pasien negative 18 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut:
 Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasien untuk melakukan skrinning TB di faskes terdekat.

3.1.2.2.2 Jumlah Kunjungan Pasien TB

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			Jumlah Total Pasien TB
		Mei	Juni	Juli	Total
1.	Pasien TB kunjungan keseluruhan	49	47	52	148
2	Pasien RFC (OAT Protolan)	4	3	2	9
3	Pasien RFT	5	8	11	24

- Analisis:**
1. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien TBC di bulan Juli mencapai 52 pasien
 2. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFC di bulan Juli 2 pasien
 3. Jumlah keseluruhan kunjungan di poli pasien RFT di bulan Juli 11 pasien

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Meningkatkan kunjungan pasien

3.1.2.2.3 Pemberian Obat Pencegahan

No	Pemberian Obat Pencegahan	Jumlah Pasien		
		Mei	Juni	Juli
1.	Sasaran keluarga pasien yang kontak dengan pasien TB	5	8	11

Analisis :
 Tidak ada yang mendapat obat pencegahan (INH), hal ini dikarenakan kurang pengetahuannya pasien dan keluarga pasien mengenai pengobatan pencegahan (INH)

Rencana dan Tindak Lanjut

- 1. Memberikan edukasi kepada keluarga pasien bahwa jika ada salah satu keluarga yang terdiagnosa TB keluarga wajib melakukan skrining di faskes terdekat agar segera memeriksakan dan bersedia di berikan obat pencegahan (INH).
- 2. Pemberian obat INH ditujukan pada anak usia dibawah 5 tahun dan dewasa yang memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak terdiagnosa TB.

3.1.2.2.4 Pemberian Imunisasi BCG

NO	KEGIATAN	JUMLAH PASIEN		
		MEI	JUNI	JULI
1.	Pemberian imunisasi BCG	2	2	3

Evakuasi :

- 1. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan Mei
- 2. Pemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 1 bulan Terdapat 2 pasien yang diimunisasi pada bulan JuniPemberian kekebalan imunisasi TB diberikan dengan vaksin BCG pada bayi usia 0 bulan Terdapat 3 pasien yang diimunisasi pada bulan Juli.

Rencana dan Tindak Lanjut :

- 1. Dilakukan screening pasien dalam memberikan vaksin BCG
- 2. Setelah dilakukan vaksin BCG dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemberian vaksin yang akan dilakukan pencatatan dan pelaporan tiap bulanya

3.1.2.2.5 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Mei 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Ny.D	V		
		Tn. A	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Tn. NP	V		
		Tn. B	V		MENINGGAL SEBELUM PENGOBATAN
3.	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed				
4.	dr. Ratih.Sp.A.M.Biomed	An. A	V		

3.1.2.2.6 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Juni 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Ny. S	V		
		Ny. R	V		
		Ny. ET	V		
		Tn. A	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Ny. T	V		

		Ny. N	V		
3	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed	An. B	V		
4.	Dr. Farid, Sp.N	Ny. N	V		

3.1.2.2.7 Kepatuhan Dokter Terhadap PPK-CP Pasien TB Bulan Juli 2026

No	Kegiatan	Nama Pasien	Patuh	Tidak Patuh	Alasan
1.	dr. Andy, Sp. P(K)	Ny. N	V		
		Tn. Ca	V		
		Tn. A	V		
		Tn.D	V		
		Tn.P	V		
		Nn. N	V		
2.	dr. Catur Elvi p., Sp. P-ONK	Ny. S		V	MENINGGAL SEBELUM PENGOBATAN
		Ny. Dn	V		
3	dr. Dicky.Sp.A.M.Biomed	An. A	V		
		An. Az	V		

Analisis :

Semua dokter sudah patuh akan PPK (Panduan Praktek Klinis) TB, baik dari anamnesis, kriteria diagnosis, pemeriksaan penunjang, dan Edukasi. Akan tetapi pada *point* edukasi sosial (pencarian kontak serumah) tidak dilakukan

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.6Kepatuhan Staf Dan Petugas Terhadap APD

No	Kegiatan	Jumlah Pasien		
		Mei	Juni	Juli
1.	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker N95	100%	100%	100%
2	Kepatuhan staf dan petugas terhadap APD- Masker bedah	100%	100%	100%
3	Kepatuhan Staf menggunakan APD Gaun/Skort	100%	100%	100%

Analisis:

Semua staf sudah patuh dalam penggunaan APD, hal ini menunjukkan kesadaran bahwa sangat penting menjaga diri agar tidak tertular pasien.

Rencana dan Tindak Lanjut :

Mempertahankan kepatuhan dalam penggunaan APD di tiap bulanya

3.1.2.2.7 Penempatan Pasien TB

No	Penempatan Paien TB	Jumlah Pasien		
		Mei	Juni	Juli
1.	Penempatan pasien TB IGD	100%	100%	100%
2	Penempatan pasien TB Poli Paru	100%	100%	100%

3	Penempatan pasien TB di IRNA 5c	100%	100%	100%
---	---------------------------------	------	------	------

Analisis:
 Semua pasien TB sudah ditempatkan di ruang IGD isolasi untuk di ruang IGD, di Poli TB untuk pasien TB dan Ruang Isolasi 5c untuk Pasien irna isolasi. hal ini menunjukkan kesadaran staff medis agar antar pasien satu dengan lainnya tidak tertular.

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Mempertahankan penempatan dengan benar

3.1.2.2.8 Pasien TB yang dirujuk di Fasyankes / RS Lebih Tinggi di Bulan Juli 2026

No	Unit	Nama Pasien	Baru	Lama	Bulan Juli	Tempat Rujukan	Alasan
1.	Poli Paru	Ny. N	V	-	1	PKM Ardimulyo	Pasien Memilih Lebih Dekat Dengan Rumahnya
2	Poli Bedah						
3	Poli Saraf						
4	Poli Anak						
5	Irna 2C						
6	ICU						
7	IGD						
8	Irna 2A						
9	Irna 3C anak						
10	Irna 3A						
11	Irna 4A						
12	Maternitas 4C						
13	Irna 5C						
14	Irna 6A						
15	Irna 7A						
16	Irna 8A						
	Total						

Analisis :
 Pada bulan Juli 2026 terdapat 1 pasien yang dirujuk ke FKTP karena pasien memilih lebih dekat dengan rumahnya

Rencana dan Tindak Lanjut :
 Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.

3.1.2.2.9 Stok OAT

No	Kegiatan	Jumlah Pasien			ED
		Mei	Juni	Juli	
1.	OAT Anak	2	5	5	01/27
2.	OAT Harian Dewasa	4	7	3	11/26
3.	Ethambutol 250 mg	0	300	540	11/28
4.	Ethambutol 400 mg	0	0	0	0
5.	Pirazinamid 500 mg	632	632	628	05/27
6.	Isoniazid 300 mg	304	204	200	01/27
7.	Rimfapicin 450 mg	1082	620	200	04/28
8.	Rimfapicin 300 mg	0	0	450	03/28

Analisis :
Setiap 1 bulan sekali farmasi akan melakukan pengadaan obat terkait permintaan ke Dinkes

Rencana dan Tindak Lanjut :
Menetapkan pengambilan obat dengan sesuai jadwal.

3.1.2.2.10 Pasien Paru dan Ekstra Paru

No	Jenis TB	Jumlah Pasien					
		Mei		Juni		Juli	
		Anak	Dewasa	Anak	Anak	Dewasa	Anak
1.	Pasien paru	0	3	6	1	2	7
2.	Pasien Ekstra paru	1	1	1	0	0	2

Evaluasi :
1. Pada bulan Mei 2026 terdapat 2 pasien ekstra paru dan 3 pasien paru
2. Pada bulan Juni 2026 terdapat 1 pasien ekstra paru dan 7 pasien paru
3. Pada bulan Juli 2026 terdapat 2 pasien ekstra paru dan 9 pasien paru

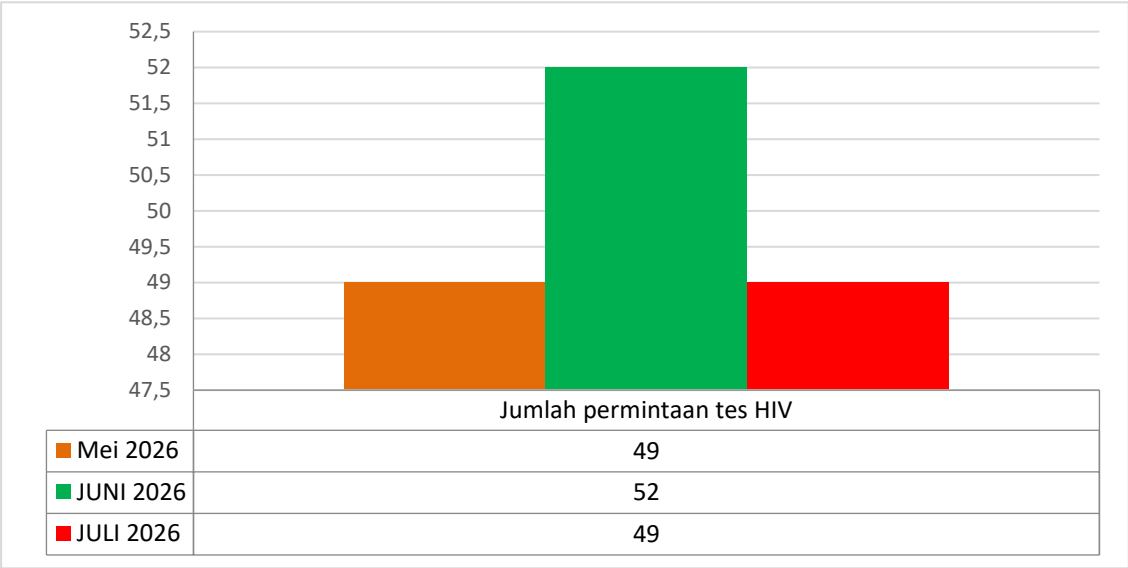
Rencana dan Tindak Lanjut :
Memberikan pengobatan yang sama pada ekstra paru meski pengobatannya akan lebih lama pada pasien ekstra paru

3.1.2.3 HIV

Jumlah Permintaan Tes HIV

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
1	Permintaan Test HIV	49	52	49

Grafik Jumlah Permintaan Tes HIV Di Rumah Sakit Prima Husada
Bulan Juli 2026



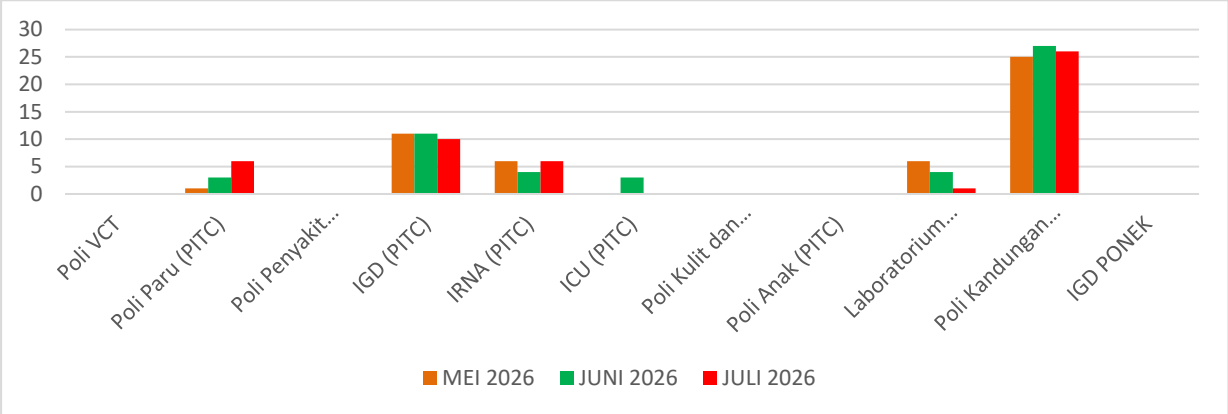
Analisis :
Jumlah permintaan pelayanan HIV mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Pada Bulan Mei 2026 sebanyak 49 pemeriksaan pada bulan juni 2026 sebanyak 52 pemeriksaan sedangkan Pada bulan Juli 2026 sebanyak 49 pemeriksaan yang berasal dari Asal permintaan test diantaranya dari poli paru, poli penyakit dalam, Poli kulit dan kelamin, Poli anak, Poli kandungan, IGD, IGD PONEK, IRNA, dan ICU.

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan skrining ulang pada pasien-pasien yang terduga HIV, pasien hamil trimester 3 dan juga pasien-pasien mandiri yang ingin dilakukan pemertiksaan HIV sesuai sukarela baik pasien IGD, rawat jalan maupun rawat inap.

3.7.15 Asal Permintaan Tes HIV

NO	UNIT / KLINIK ASAL PERMINTAAN	BULAN		
		MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
1	Poli VCT	0	0	0
2	Poli Paru (PITC)	1	3	6
3	Poli Penyakit Dalam (PITC)	0	0	0
4	IGD (PITC)	11	11	10
7	IRNA (PITC)	6	4	6
8	ICU (PITC)	0	3	0
9	Poli Kulit dan kelamin (PITC)	0	0	0
10	Poli Anak (PITC)	0	0	0
11	Laboratorium (PITC)	6	4	1
	Total PITC	24	25	23
12	Poli Obgyn (PMTCT)	25	27	26
13	IGD PONEK	0	0	0
	Total PMTCT	25	27	26
	Total PITC + PMTCT	49	52	49

Grafik Jumlah Asal Permintaan Tes HIV di RS Prima Husada Bulan Juli 2026



Analisis :

1. Unit Asal permintaan Yang meminta pelayanan HIV Pada Triwulan 2 tahun 2026 diantaranya dari poli paru, poli penyakit dalam, Poli kulit dan kelamin, Poli anak, Poli kandungan, IGD, IGD PONEK, IRNA, dan ICU.
2. Jumlah tertinggi permintaan pelayanan pemeriksaan HIV di triwulan 2 tahun 2026 yaitu dari poli Kandungan pada bulan juli 2026 sebanyak 26 pasien. Hal ini dikarenakan sudah tersdianya Reagen HIV dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk program ibu hamil sehingga pasien dengan kriteria hamil trimester II sudah bisa dilakukan screening HIV dan pemeriksaan triple eliminasi.
3. Jumlah terendah permintaan pelayanan pemeriksaan HIV di triwulan 2 tahun 2026 yaitu dari poli VCT yaitu 0 tidak ada permintaan. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS
4. Poli terendah permintaan pelayanan pemeriksaan HIV yaitu dari poli VCT bisa dilakukan peningkatan permintaan pemeriksaan pelayanan HIV dengan dilakukanya edukasi terkait pentingnya screening HIV
5. Unit yang masuk PITC diantaranya, poli paru, poli penyakit dalam, Poli kulit dan kelamin, Poli anak, IGD, IRNA dan ICU dengan jumlah total di di bulan Juli 2026 sebanyak 23 pasien. Sedangkan yang masuk PMTCT diantaranya poli kandungan dan IGD PONEK dengan jumlah total di di bulan Juli 2026 sebanyak 26 pasien

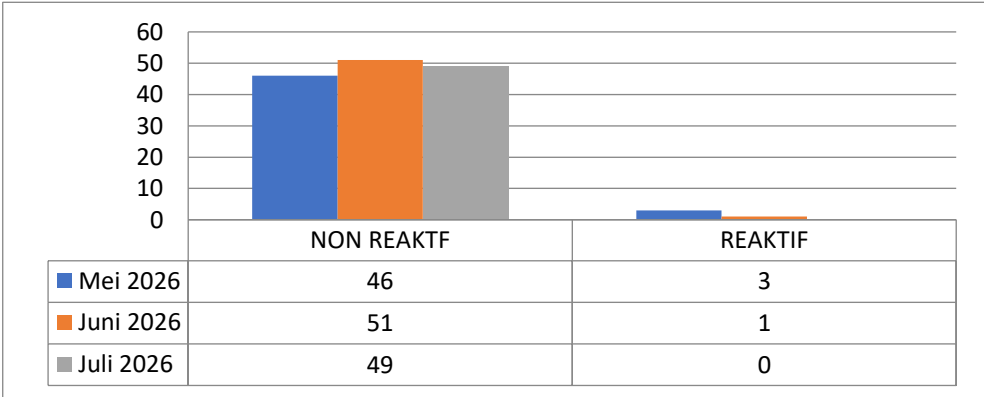
Rencana Tindak Lanjut :

Dilakukan sosialisasi terkait Permintaan testing HIV dilakukan baik di IGD, rawat jalan, maupun rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sehingga capaian permintaan testing HIV bisa berjalan.

3.1.2.3.2 Status HIV

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
1	Non Reaktif	46	51	49
2	Reaktif	3	1	0

Grafik Status HIV Juli 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan pasien dengan status HIV reaktif yang dilakukan pemeriksaan di RS prima Husada Malang pada bulan Mei terdapat 1 pasien dengan HIV reaktif yang berasal dari IRNA pada bulan Juni 2026 terdapat 1 pasien dengan HIV reaktif yang berasal dari IGD Sedangkan pada bulan Juni 2026 tidak terdapat pasien dengan Hasil HIV reaktif.

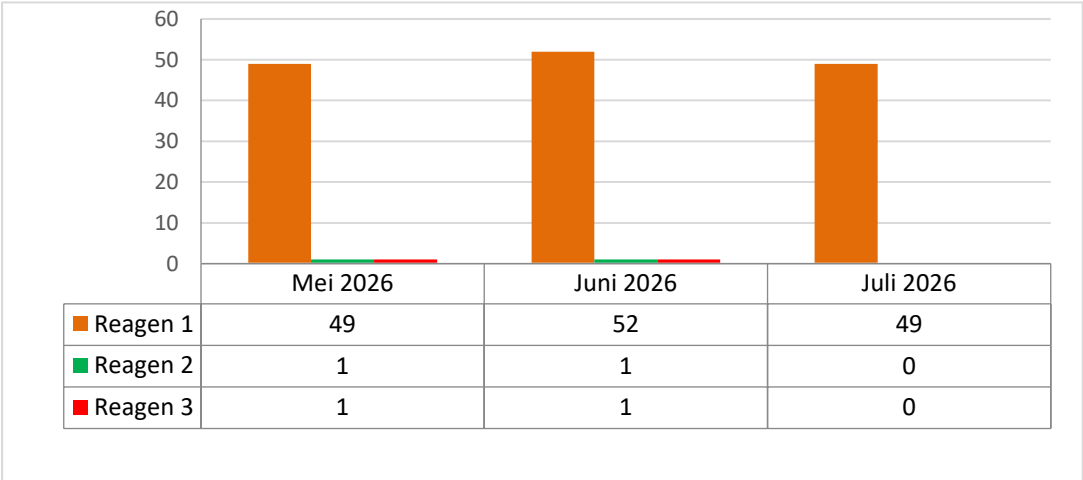
Rencana Tindak Lanjut :

Rumah sakt prima husada malang masih belum bisa melakukan pelayanan pasien dengan HIV/AIDS, apabila ditemukan pasien dengan HIV reaktif maka akan kami lakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah MOU dengan RS Prima Husada Malang.

3.7.16 Jumlah Pemakaian Reagen

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
1	Reagen 1	49	52	49
2	Reagen 2	1	1	0
3	Reagen 3	1	1	0

Grafik Jumlah Pemakaian Reagen Juli 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa pemakaian reagen pada bulan Mei 2026 memakai 3 reagen dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien. pada bulan Juni 2026 memakai 3 reagen dikarenakan ada pasien reaktif sebanyak 1 pasien Sedangkan pada bulan Juli 2026 memakai 1 reagen dikarenakan tidak ada pasien dengan hasil pemeriksaan HIV Reaktif

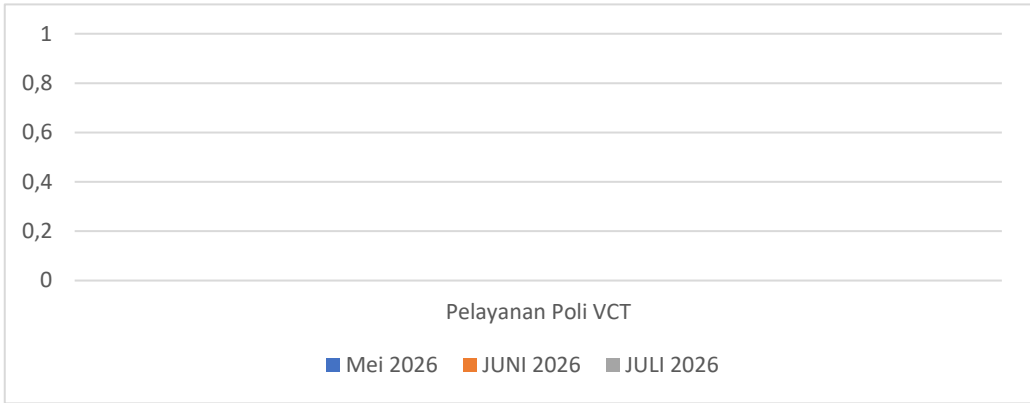
Rencana Tindak Lanjut :

Pemakaian reagen HIV tergantung dari hasil pemeriksaan dengan Reagen 1. Apabila dilakukan pemeriksaan dengan Reagen 1 hasil Non Reatif maka tidak dilanjutkan pemakaian Reagen 2 dan 3.
Tetapi apaila saat pemeriksaan dengan Reagen 1 ditemukan hasil Reaktif maka pemeriksaan dilanjutkan dengan penggunaan Reagen 2 dan Reagen 3

3.7.17 Pelayanan Poli VCT (Voluntary Conseling And Testing)

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
1	Pelayanan Poli VCT	0	0	0

Grafik Pelayanan Poli VCT Juli 2026



Analisis pelayanan Poli VCT

Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa tidak ada kunjungan di poli VCT di RS Prima Husada. Hal ini dikarenakan kurang tahunya masyarakat terkait pentingnya deteksi pemeriksaan HIV/AIDS

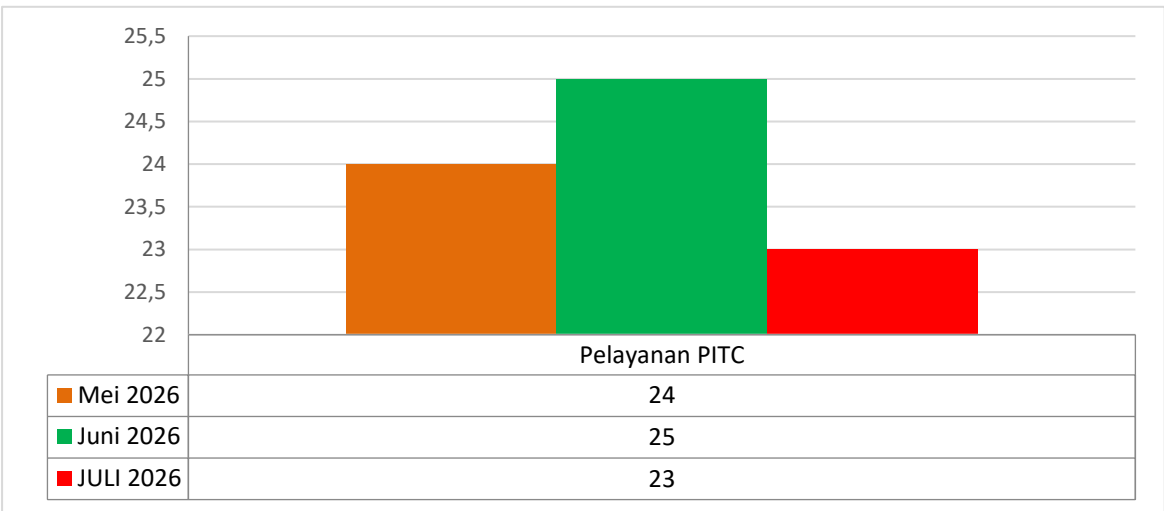
Rencana Tindak Lanjut

Pelayanan Poli VCT di Rumah Sakit Prima Husadabelum berdiri sendiri, melainkan masih bergabung dengan oli penyakit Dalam di Rawat jalan. Hal ini dikarenaka asih belum adanya kunjungan pasien ke poli VCT

3.7.18 Pelayanan PITC (Provider Initiated Testing and Counseling)

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
1	Pelayanan PITC	24	25	23

Grafik Pelayanan PITC Juli 2026



Analisis :

Dari data diatas terdapat keimpulan bahwa telah dilakukan edukasi pemeriksaan HIV oleh petugas kesehatan untuk dilakukan testing HIV pada bulan pada bulan Mei 2026 sebanyak 24 pasien pada bulan Juni 2026 sebanyak 25 pasien. sedangkan pada bulan

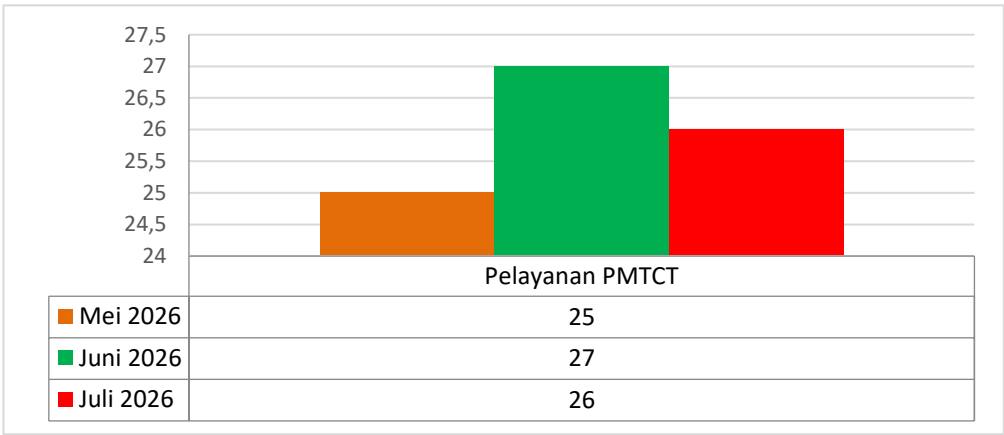
Juli 2026 sebanyak 23 pasien.
Hal ini dikarenakan testing dan konseling dilakukan saat pasien menunjukkan gejala HIV dan dilakukanya sreening baik di ruangan maupun IGD

Rencana Tindak Lanjut :
Dilakukan peningkatan terkait penjarangan pasien dengan dialkukanya edukasi pasien tentang testing HIV kepada pengunjung atau masyarakat sehingga pasien paham tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan HIV.

3.7.19 Pelayanan PMTCT (Prevention to Mother Of Child Transmision)

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
1	Pelayanan PMTCT	25	27	26

Grafik Pelayanan PMTCT Juli 2026



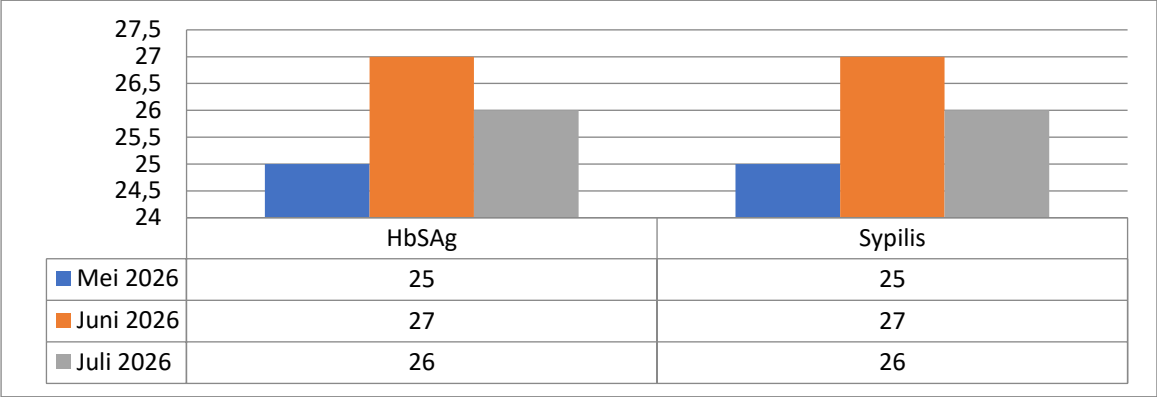
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HIV sebagai screening dan deteksi pencegahan penularan dari ibu ke Bayi. Pada bulan mei 2026 sebanyak 25 pasien. pada bulan Juni 2026 sebanyak 27 pasien. Sedangkan pada bulan Juli 2026 sebanyak 26 pasien.
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan PMTCT dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

Rencana Tindak Lanjut :
Reagen pemeriksaan HIV yang diperoleh dari dinas kesehatan sudah tersedia di RS Prima Husada Malang sehingga Sehingga pemeriksaan HIV di RS Prima Husada Malang untuk Prevention to Mother Of Child Transmision bias dilakukan.

3.7.20 Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
1	HbSAg	25	27	26
2	Sypilis	25	27	26

Grafik Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil
Juli 2026



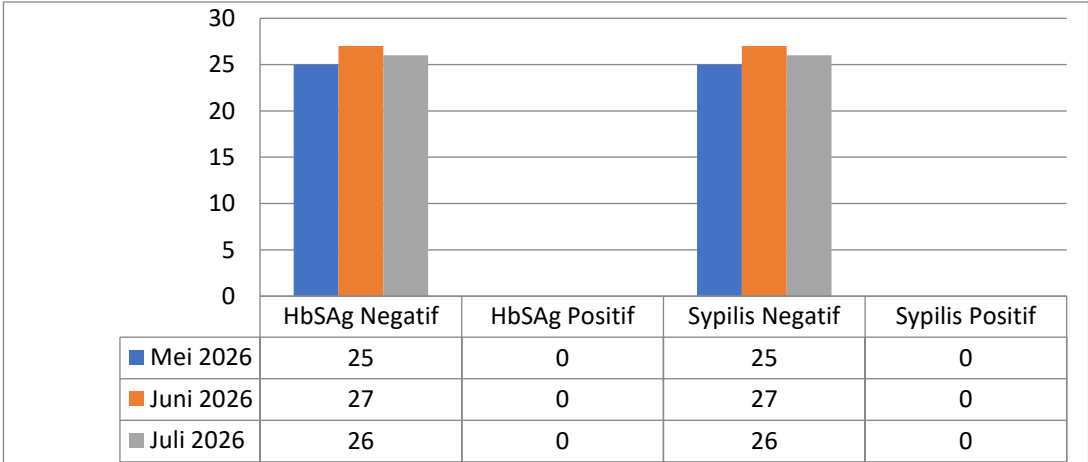
Analisis :
Dari hasil grafik diatas ditemukan data pasien hamil yang dilakukan pemeriksaan HbSAg dan Sypilis pada bulan Mei 2026 sebanyak 25 pasien pada bulan Juni 2026 sebanyak 27 pasien Sedangkan pada bulan Juli 2026 sebanyak 26 pasien
Hal ini dikarenakan pasien hamil yang sudah melakukan dan membawa hasil pemeriksaan triple eliminasi dari puskesmas domisili, sehingga saat kunjungan di poli kandungan RS Prima Husada Malang sudah tidak perlu lagi diulang pemeriksaanya. Sehingga pemeriksaan Triple eliminasi di RS Prima Husada Malang untuk pemeriksaan HbSAg dan Sypilis bisa dilakukan.

Rencana Tindak lanjut :
Pemeriksaan Triple eliminasi untuk ibu hamil bersifat wajib dan dilakukan 1 kali saat awal kehamilan. Di RS Prima Husada skrining pemeriksaan triple eliminasi sudah berjalan dan dilakukan saat kunjungan pada Trimester 2.

3.7.21 Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eiminasi Pada Ibu Hamil

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
1	HbSAg			
	Negatif	25	27	26
	Positif	0	0	0
2	Sypilis			
	Negatif	25	27	26
	Positif	0	0	0

Grafik Status Pelayanan Pemeriksaan Triple Eliminasi Pada Ibu Hamil Juli 2026



Analisis :

Dari hasil grafik diatas ditemukan data bahwa pada bulan mei, Juni dan Juli 2026 tidak ditemukan pasien dengan HbSAg maupun Shypilis dengan hasil positif.

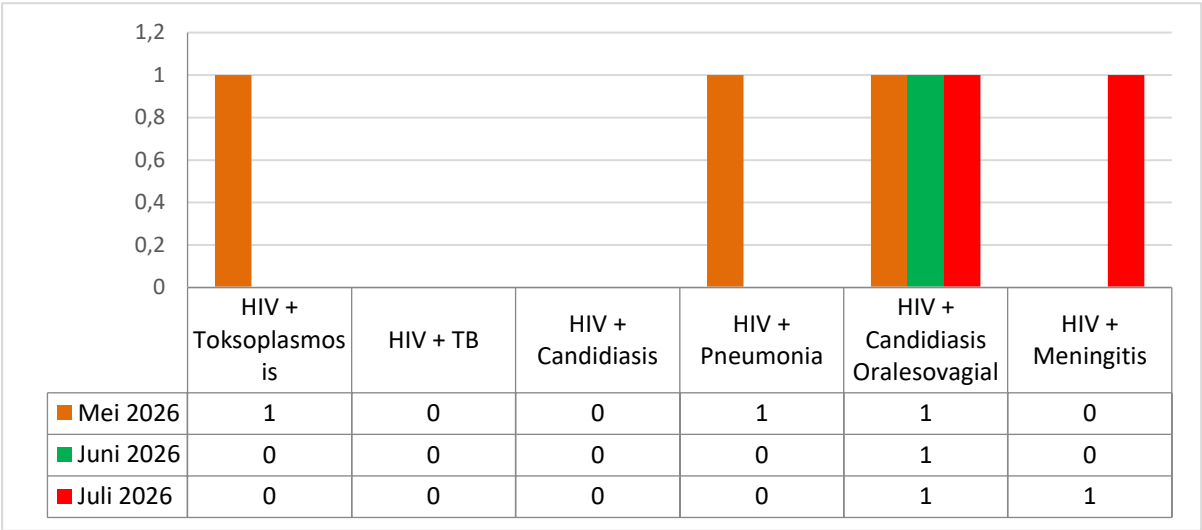
Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Pada pasien HbSAg
Saat kelahiran aka nada pemberian vaksin Hepatitis kepada bayi yaitu Hiper Heb dan juga Hb.O unijec yang diberikan saat bayi baru lahir sampai dengan maksimal 24 jam pemberian. Untuk ibu dengan HbSAg akan dilakukan pemberian vaksin hepatitis oleh Puskesmas sesuai domisili pasien.Penanganan pasien dengan HbSAg Rumah Sakit Prima Husada Malang Kolaborasi dengan puskesmas sesuai dengan domisili pasien.
- 2. Pada pasien Syphilis
Di rumah sakit Prima Husada Malang sudah bisa melakukan pengobatan pasien dengan syphilis positif. Sehingga tidak lagi melakukan rujuk keluar.

3.7.22 Pelayanan Odha Dengan Factor Resiko Infeksi Oportunistik

NO	URAIAN	BULAN		
		MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
1	HIV + Toksoplasmosis	1	0	0
2	HIV + TB	0	0	0
3	HIV + Candidiasis	0	0	0
4	HIV + Pneumonia	1	0	0
5	HIV + Candidiasis Oralesovagial	1	1	1

Grafik Pelayanan Odha dengan Faktor Resiko IO Juli 2026



Analisis :

- 1. Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Jumlah Pelayanan ODHA Dengan IO (Factor Resiko Infeksi Oportunistik) pada Triwulan 2 tahun 2026 sebanyak 6 pasien
- 2. Rincian pasien ODHA Dengan IO (Factor Resiko Infeksi Oportunistik) tahun 2026 sebagai berikut : Pasien dengan HIV + Toksoplasmosis sebanyak 1 orang, Pasien dengan HIV + TB sebanyak 0 orang, Pasien dengan HIV + Candidiasis sebanyak 0 orang, Pasien dengan HIV + Pneumonia sebanyak 1 orang, pasien dengan HIV +

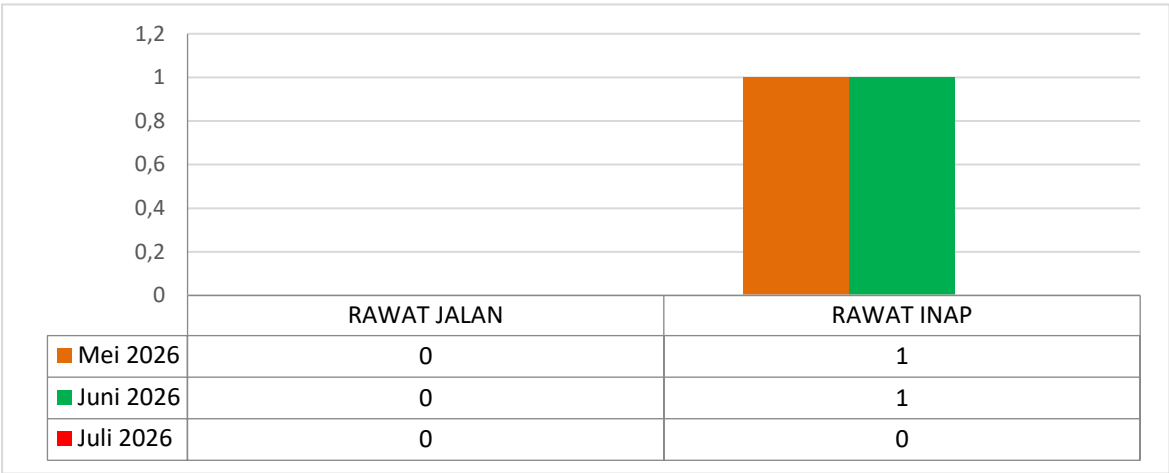
Candidiasis Oralesovagial sebanyak 3 pasien. sedangkan pasien dengan HIV + Meningitis sebanyak 1 orang

Rencana Tindak Lanjut :
ODHA Dengan IO (Factor Resiko Infeksi Oportunistik) dilakukan rujuk eksternal sebagai rencana pelayanan terkait rencana pengobatan lanjutan pasien

3.7.23 Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN		
		MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
1	Rawat Jalan	0	0	0
2	Rawat Inap	1	1	0

Grafik Pelayanan Rujukan Pasien Dengan HIV/AIDS Juli 2026



Analisis :

1. Dari hasil grafik diatas ditemukan data, bahwa Pada bulan Mei 2026 terdapat 3 pasien yang dirujuk dari IRNA. pada bulan Juni 2026 terapat 1 pasien yang dilakukan rujuk dari IGD dengan status rawat inap. Sedangkan pada bulan Juli 2026 tidak ada pasien yang dilakukan rujuk eksternal
2. Tempat rujukan :
 - Pada bulan Mei 2026 terdapat 1 pasien yang dilakukan rujuk ke RSSA dan sudah mendapatkan terapi ARV.
 - Pada bulan Juni 2026 terdapat 1 pasien yang dilakukan rujuk ke RSUD Dr.Soetomo Surabaya. Belum diberikan terapi ARV karena masih pengobatan Toxoplasma dan pasien sudah kontrol ulang ke RSSA Belum diberikan terapi ARV karena masih pengobatan Toxoplasma.

Pasien Dilakukan rujuk dikarenakan RS Prima husada malang belum bisa menangani pasien yang ditemukan positif HIV dengan kebutuhan perawatan lanjutan pengobatan dan pemberian terapi ARV.

Rencana Tindak Lanjut :
Pelaksanaan Rujukan dilakukan apabila hasil pemeriksaan HIV Reaktif. Rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

3.1.2.4 Stunting & Wasting

1.1.2.4.1 Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting

Tabel Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Juli 2026

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang
5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
7	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
8	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
9	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
10	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
11	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
12	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

- 1. Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di Rumah Sakit.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah sakit.

3.1.2.4.2 Kinerja Produktivitas
Tabel Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai 1000 hari pertama kehidupan	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1x	1x	0x
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1x	0x	0x
	2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	Ibu Hamil	Poli kandungan	371 pasien	483 pasien	466 pasien
Pemberian PMT Ibu Hamil	1.Pemberian PMT pemulihan dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Senam hamil	2x	2x	2x
	2.Pemberian PMT penyuluhan pada ibu hamil	Ibu Hamil	Senam hamil	1x	2x	2x
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	103 pasien	119 pasien	126 pasien
Pemberian Makanan Bayi dan Anak	1. Penyuluhan tentang stunting, ma	Pasien poli anak dan IRNA Anak	IRJA	1x	1x	1x

(PMBA)	kanan sehat pada bayi dan balita					
	2. Pemberian makanan Bayi dan Anak	Pasien IRNA Anak	IRNA	198 pasien	193 pasien	130 pasien
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan pencatatan dan pengukuran berat badan dan tinggi badan anak terdeteksi stunting/ wasting	Pasien IRNA Anak terdeteksi wasting/ stunting	IRJA anak	6 pasien	8 pasien	7 pasien
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	15 pasien	11 pasien	14 pasien
Pemberian vitamin A	Penyuluhan mengenai pentingnya pemberian vitamin A pada anak-anak	Pasien anak	IRJA anak	0x	0x	0x
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	6 pasien	4 pasien	3 pasien
Pemberian Taburia pada Baduta	Penyuluhan mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0x	0x	0x
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Penyuluhan mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	1x	0x	0x

Analisis :
 Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya

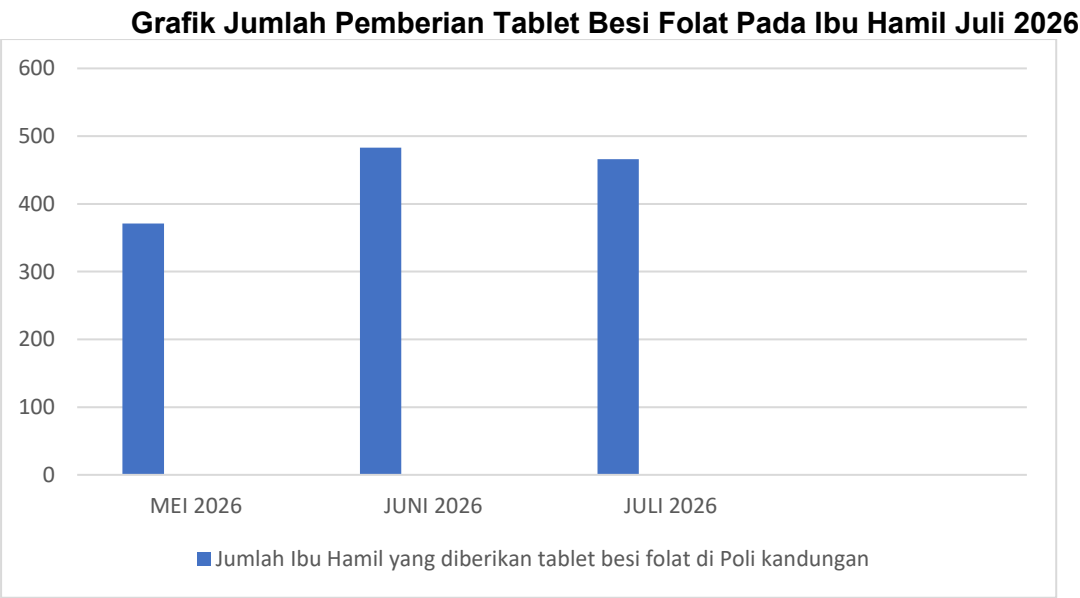
terdapat di puskesmas, Rumah Sakit hanya memberikan dalam bentuk PMT penyuluhan.

Rencana Tindak Lanjut :

Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

3.1.2.4.3 Pemberian Tablet Besi Folat Bagi Ibu Hamil
Tabel Distribusi Tablet Besi Folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

BULAN	MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	371	483	466



Analisis :

Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat menurun dari sebelumnya 483 di bulan Juni menjadi 466 pada bulan Juli yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

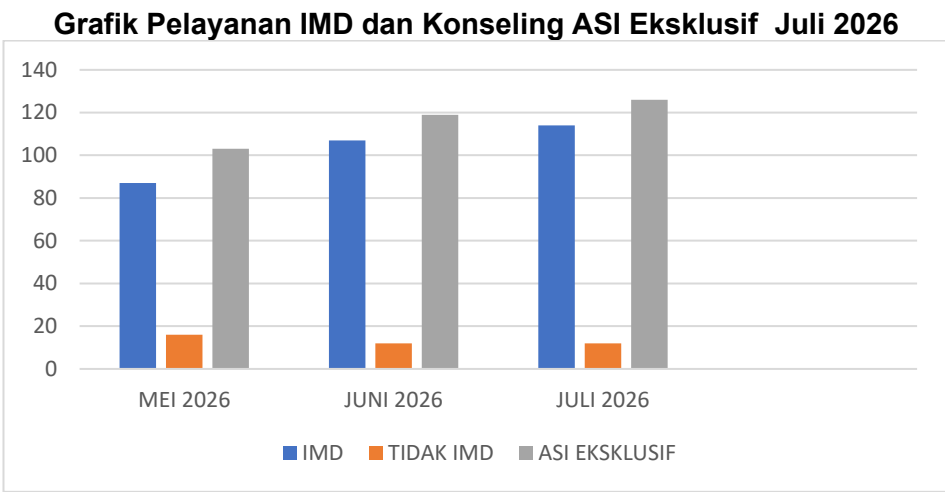
Rencana Tindak Lanjut:

- 1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
- 2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

3.1.2.4.4 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

NO	URAIAN	JUMLAH PASIEN		
		BULAN MEI 2026	BULAN JUNI 2026	BULAN JULI 2026
1	IMD	87	107	114
2	Tidak IMD	16	12	12
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	103	119	126



- Analisis :**
- 1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Juli sebanyak 114 bayi.
 - 2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Juli 2026 sama dengan bulan sebelumnya, yaitu 12 bayi.
 - 3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
 - 4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Juli 2026 yaitu sebanyak 126 pasien.

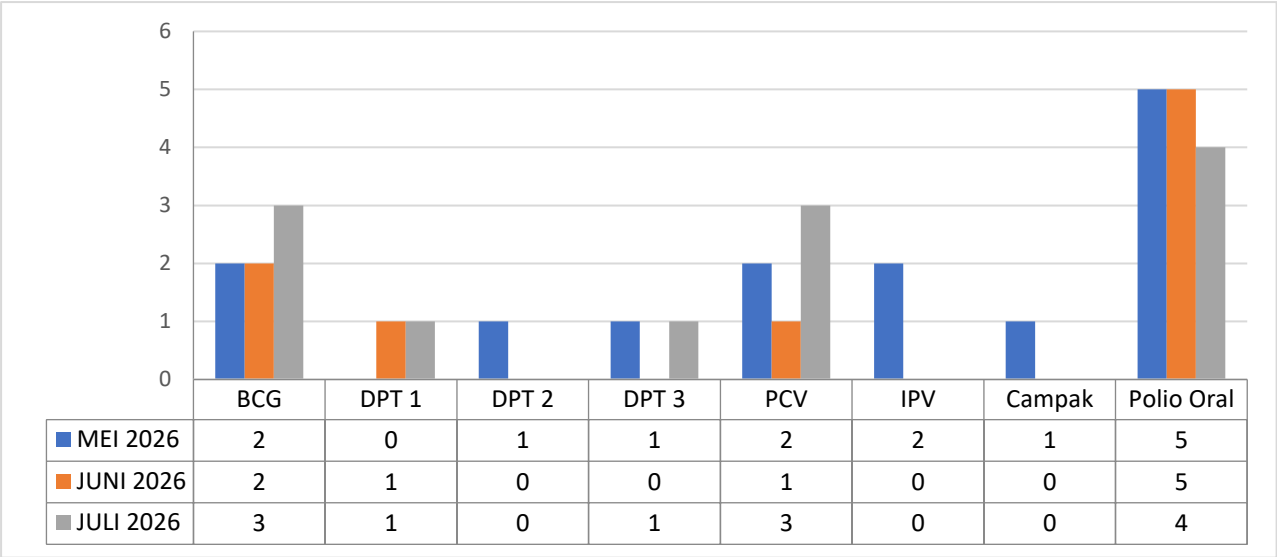
Rencana Tindak Lanjut:
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

3.1.2.4.5 Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

Tabel Jumlah Balita yang Mendapat Imunisasi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026	Bulan Juli 2026
1	BCG	2	2	3
2	DPT 1	0	1	1
3	DPT 2	1	0	0
4	DPT 3	1	0	1
5	PCV	2	1	3
5	IPV	2	0	0
6	Campak	1	0	0
7	Polio Oral	5	5	4
8	Rotavirus	1	2	2

Grafik Pelayanan Imunisasi di Rumah Sakit Prima Husada Juli 2026



Analisis:

- 1. Pada bulan Julii sebanyak 3 balita melakukan imunisasi BCG dan PCV.
- 2. Sebanyak 1 balita melakukan imunisasi DPT 1, DPT 3 di Prima Husada Malang pada bulan Juli.
- 3. Pada bulan Juli tidak ada yang melakukan imunisasi DPT 2, IPV, dan campak.
- 4. Terdapat 4 balita melakukan imunisasi polio oral pada bulan Juli 2026.
- 5. Terdapat 2 balita melakukan imunisasi rotavirus di bulan Juli.

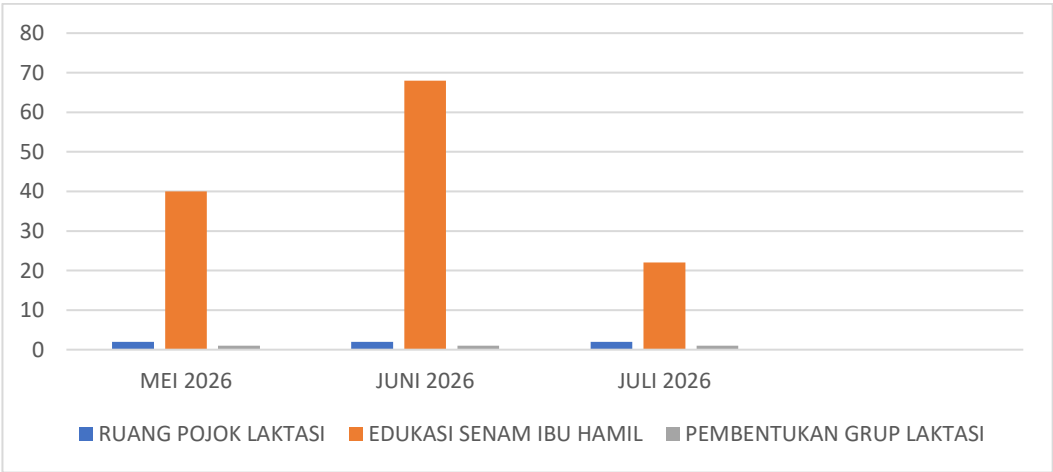
Rencana Tindak Lanjut :

Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk keersediaan vaksin di RS.

3.1.2.4.6 Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

KEGIATAN PENERAPAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI	MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Senam Hamil	40	68	22
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik Senam Hamil di Rumah Sakit Prima Husada Juli 2026



Analisis :

- 1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
- 2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
- 3. Pada bulan Juli edukasi pada ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan gizi seimbang, makanan tinggi energi tinggi protein sebanyak 22 peserta, penyuluhan dilakukan di ruang tunggu poli obgyn dan anak.

Rencana Tindak Lanjut :

- 1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
- 2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

3.1.2.4.7 Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting Dan Wasting
Tabel Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi

Rujukan Masuk				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Rujukan Keluar				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Mei	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-

Grafik Pelayanan Jejaring Rujukan Kasus Stunting dan Wasting Bulan Juli 2026



Analisis :

Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS pada bulan Juni. Rujuk masuk RS tidak ada karena Puskesmas sekitar lebih mengarahkan pasien langsung datang ke IGD tanpa menunggu rujukan dari puskesmas.

Rencana Tindak Lanjut:
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjangring pasien stunting dan wasting.

3.1.2.4.8 Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

Tabel Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis Dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan

BULAN	MEI 2026	JUNI 2026	JULI 2026
Jumlah Pasien Stunting	6	5	6
Jumlah Pasien Wasting	6	4	3

Grafik Rumah Sakit Sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen Serta Merupakan Jejaring Rujukan



Analisis :
Pada bulan Juli 2026 ditemukan sebanyak 2 balita berat badan kurang, 6 balita pendek, dan 1 balita gizi buruk. Permasalahan yang ditemukan rata-rata balita kurang bervariasi dalam pola makannya, dan porsi makan tidak adekuat namun balita aktif. Selain itu, terdapat balita yang sakit dalam kurun waktu lama sehingga mengalami BB turun

Pemberian makanan tinggi energi dan tinggi protein di rumah sakit. Edukasi terhadap orang tua bagaimana dalam memberikan makanan gizi seimbang sesuai usia. Dan kolaborasi terhadap Ahli Gizi dan DPJP terus dilakukan

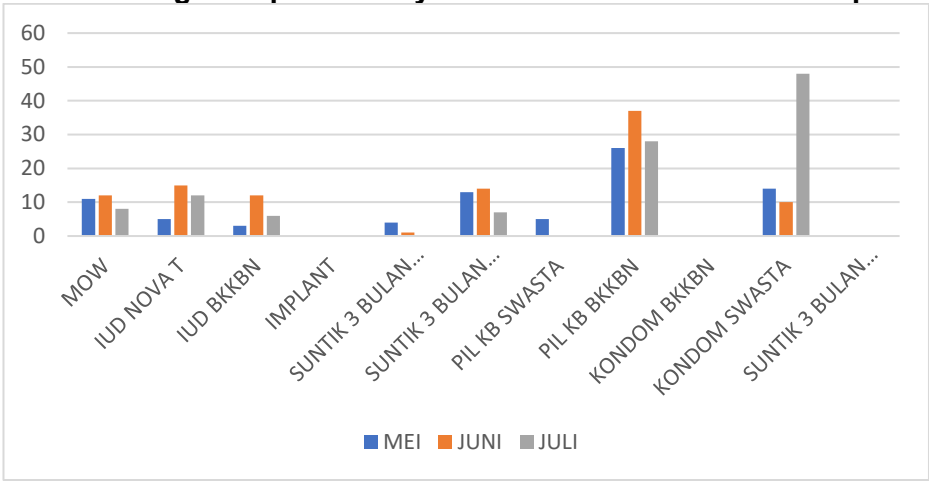
Rencana Tindak Lanjut :
Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada lebih gencar dalam melakukan pengukuran dan pelaporan pasien anak baik di rawat inap maupun rawat jalan. Penginputan pasien stunting dan wasting di aplikasi eppgbm. Pemberian diet Tinggi Kalori dan Tinggi Protein (TKTP). Kolaborasi antar ahli gizi, DPJP, serta Ahli gizi puskesmas balita.

3.1.2.5 KBRs

3.7.24 Angka Capaian Pelayanan KB per Metode Kontrasepsi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien			Target sasaran per metode kontrasepsi dalam satu tahun
		Bulan Mei 2026	Bulan Juni 2026	Bulan Juli 2026	
1	MOW	11	12	8	26
2	IUD Nova T	5	15	12	49
3	IUD BKKBN	3	12	6	
4	IMPLANT	0	0	0	111
5	SUNTIK 3 BULAN KOMBINASI	4	1	0	187
6	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN BKKBN	13	14	7	
7	SUNTIK 3 BULAN PROGESTIN SWASTA	0	0	0	
8	PIL KB BKKBN	26	37	28	135
9	PIL KB SWASTA	5	0	0	
10	KONDOM BKKBN	0	0	0	30
11	KONDOM SWASTA	14	10	48	

Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Per Metode Kontrasepsi



Evaluasi :

- 1. Peserta MOW pada bulan Mei naik (11) Juni naik (12) Juli turun (8)
- 2. Peserta IUD Nova T pada bulan Mei turun (5)Juni naik (15) Juli turun (12)
- 3. Peserta IUD BKKBN pada bulan Mei turun (3) Juni (12) Juli turun (6)
- 4. Peserta KB suntik 3 bulan kombinasi, pada bulan Mei turun (4) Juni turun (1) Juli turun (0)
- 5. Peserta KB suntik progestin bkkbn pada bulan Mei tetap (13) Juni naik (14) Juli turun (7)
- 6. Peserta KB pil kombinasi Mei naik (26) Juni naik (37) juli turun (28) karena sudah mendapat stok dari BKKBN
- 7. Peserta KB pil swasta Mei turun (5) Juni (0) karena sudah ada stok dari BKKBN

- 8. Peserta KB Kondom BKKBN pada bulan karena stok habis Mei (0) Juni (0) Juli (0) karena kosong dari BKKBN
- 9. Peserta KB Kondom swasta Mei turun (14) Juni (11) Juli naik (48) disediakan karena stok kondom dari BKKBN kosong

Analisis :

- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn dan poli KB salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
- 2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
- 3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
- 4. Melakukan edukasi individu kepada pasien bersalin tentang pentingnya KB

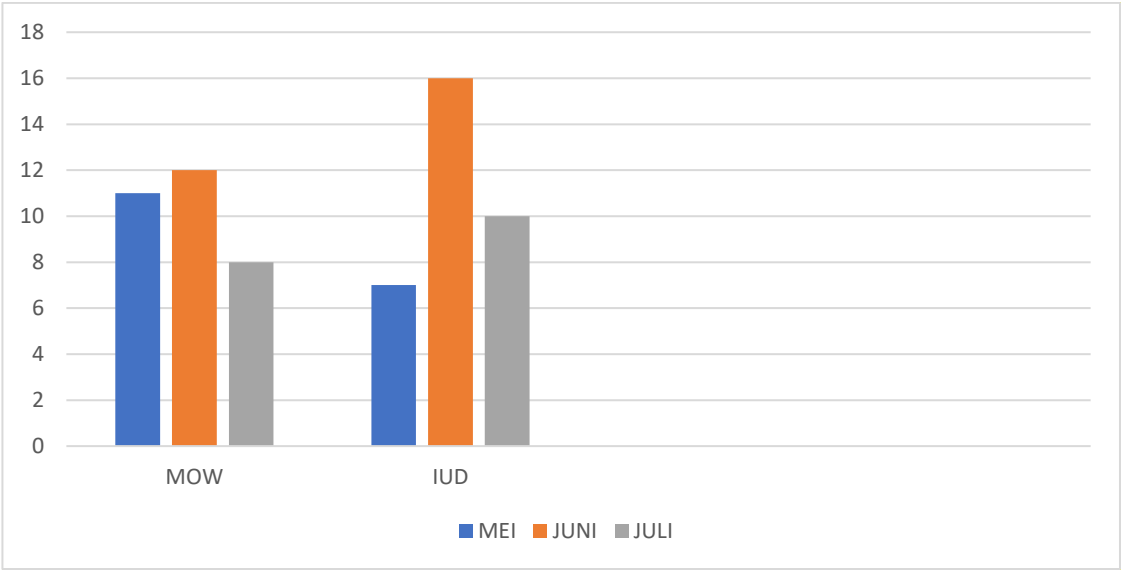
Rencana Tindak Lanjut :

Demi meningkatkan capaian KB maka rumah sakit akan melakukan pelatihan internal bagi para bidan dalam pemasangan IUD, Implan serta pemasangan IUD pasca plasenta, dan diadakan Pelayanan KB oleh bidan setiap hari Senin-Jumat

Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Persalinan

No	Jenis Pelayanan pasca persalinan	Jumlah Pasien KB Bulan Mei 2026	Jumlah pasien bersalin bulan Mei 2026	Jumlah Pasien KB Bulan Juni 2026	Jumlah pasien bersalin bulan Juni 2026	Jumlah Pasien KB Bulan Juli 2026	Jumlah pasien bersalin bulan Juli 2026
1	MOW	11	92	12	115	8	129
2	IUD	7	92	16	115	10	129

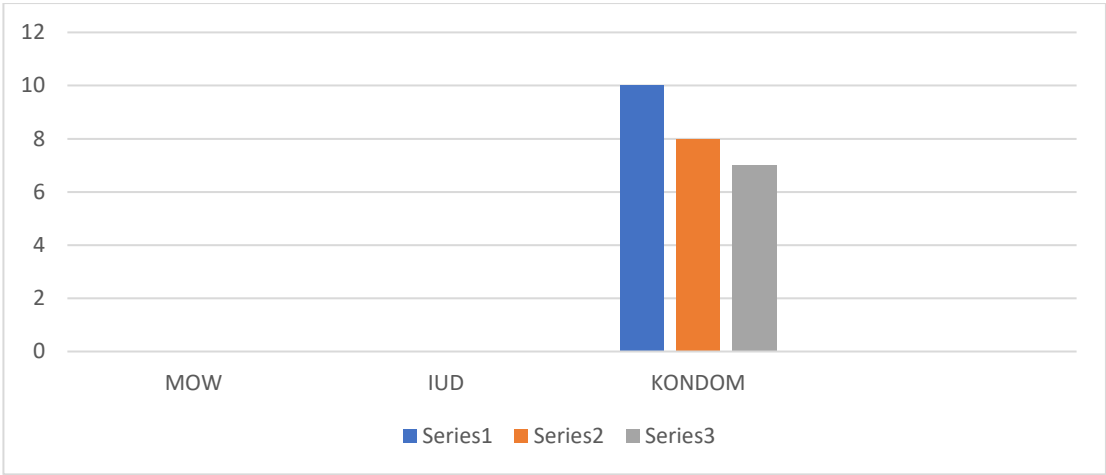
Grafik Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan



Angka Capaian Pelayanan KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran

No	Jenis Pelayanan pasca keguguran	Jumlah Pasien kb Bulan Mei 2026	Jumlah pasien abortus Bulan Mei 2026	Jumlah Pasien kb Bulan Juni 2026	Jumlah pasien abortus Bulan Juni 2026	Jumlah Pasien kb Bulan Juli 2026	Jumlah pasien abortus Bulan Juli 2026
1	MOW	0	10	0	8	0	7
2	IUD	0		0		0	
3	KONDOM	10		8		7	

Grafik Angka Capaian Pelayan KB Pasca Keguguran



Evaluasi :

1. Angka capaian pelayanan KB pasca persalinan pada bulan Mei-Juni-Juli menurun tapi belum memenuhi target dengan alasan pasien ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis
2. Angka capaian pelayanan KB pasca keguguran pada bulan Mei-Juni-Juli sudah memenuhi target dengan pemberian kondom dan bukan KB jangka panjang dengan alasan pasien ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis

Analisis :

1. Peningkatan jumlah sasaran pada triwulan pertama kemungkinan didapatkan karena sasaran KB sudah mengetahui pentingnya KB dari pengetahuan yang didapatkan saat sosialisasi yang dilakukan tim setiap bulannya.
2. Capaian pelayanan KB pasca keguguran menetap dikarenakan peserta mempunyai alasan ingin segera hamil lagi dan pasien ingin berKB difaskes satu yang gratis

Rencana dan Tindak Lanjut :

1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien poli obgyn salah satunya dengan mengadakan promosi lewat sosial media.
2. Melakukan edukasi tentang pentingnya KB pada pasangan usia subur dengan rutin melakukan penyuluhan.
3. Melakukan edukasi kepada pasien ANC trimester 3 poli kandungan tentang pentingnya KB lewat penyuluhan.
4. Melakukan edukasi individu kepada pasien bersalin diruang maternitas tentang pentingnya berKB

3.2.3 Tim PPRA

3.2.3.1 Audit Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif Triwulan 2026

3.2.3.1.1 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Mei 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Wilda Nurmala	P/24	dr. Humaira, Sp. OG	201062	Post Partum Normal	01/05/2026	02/05/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
2	Tri Lindah M	P/33	dr. Aida, Sp. OG	152777	Gravida SC + KPD	03/05/2026	05/05/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
3	Karlina	P/38	dr. Aida, Sp. OG	237457	Makrosomia + Gravida SC	12/05/2026	15/05/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
4	Siska Nurkhoirya	P/30	dr. Puti F, Sp. OG	063844	Kista Ovari	14/05/2026	17/05/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
5	Sekar Mastiti	P/30	dr. Humaira, Sp. OG	241444	Gravida SC + Mioma Uteri	15/05/2026	17/05/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
6	Agustina Dwi	P/38	dr. Humaira, Sp. OG	248958	Kista Bartolini	18/05/2026	19/05/2026	2	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
7	Virsa Novita	P/22	dr. Humaira, Sp. OG	240348	Gravida SC	20/05/2026	23/05/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
8	Paisri	P/39	dr. Humaira, Sp. OG	247736	Post SC + Oligohidramnion	21/05/2026	23/05/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
9	Mauliddya Sari	P/25	dr. Puti F, Sp. OG	139820	Post SC + BSC	22/05/2026	24/05/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
10	Tarisa Adinda	P/25	dr. Humaira, Sp. OG	247721	Post Partum Normal	26/05/2026	27/05/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1

11	M Afrizal Dwi	L/20	dr. Oka, Sp.OT.	246289	Union Phalank	01/05/2026	03/05/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
12	Iwan	L/44	dr. Oka, Sp.OT.	248995	Vulnus laceratum regio antebrachia sinistra	01/05/2026	03/05/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	4	3	1,33
13	Junaidi	L/33	dr. Zaki, Sp.B.	221724	Stt Temporo A	05/05/2026	07/5/2026	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
14	M Sururi	L/47	dr. Anton, Sp.OB	103822	Necrotizing Fascitis Frontalis	07/05/2026	09/05/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
15	Misnati	P/49	dr. Anton, Sp.OB	249183	Necrotizing Fascitis Pedis D	13/05/2026	15/05/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	7,5	6	1,25
16	Adi Wiyono	L/45	dr. Arianto, Sp.OT.	066470	Crush Injury Digiti 1 Manus Sinistra	22/05/2026	24/05/2026	3	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
17	Karsi'in	L/69	dr. Pradana, Sp. U	216168	Bt buli	19/05/2026	21/05/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
18	Elok Kusuma N	P/19	dr. Oka, Sp.OT.	249330	CF Clavicula Dextra	22/05/2026	24/05/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
19	Adinda N	P/20	dr. Oka, Sp.OT.	247674	Schapoid dislocation	22/05/2026	24/05/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
20	Atim	L/71	dr. Edi, Sp. U	249539	BPH	25/05/2026	27/05/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
21	Sariani	P/80	dr. Andy, Sp. JP	248668	Pneumonia	02/05/2026	05/05/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
22	Umi Prihatin T	P/50	dr. Zora, Sp. Pd	076079	GEA + Volume Depletion	04/05/2026	06/05/2026	3	Ciprofloxacin	1	2x0,5	2	1	2
23	Widarto	L/64	dr. Mira, Sp. JP	248736	NSTEMI + Lung edema	04/05/2026	07/05/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	3	2
24	Tabri	L/57	dr. Andy, Sp. P	236852	COPD AE + ALO	05/05/2026	08/05/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	3	2
25	Misdi	L/66	dr. Elvi, Sp. P	249047	Sepsis + Pneumonia	11/05/2026	14/05/2026	4	Meropenem	1	3x1	9	3	3
26	Fransiska C	P/86	dr. Heri, Sp. Pd	146544	Hematemesis + Cystitis	12/05/2026	14/05/2026	3	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,2	0,8	1,5
27	Asri	P/67	dr. Ira, Sp. JP	237276	NSTEMI + ALO + Tumor Abdomen	13/05/2026	16/05/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
28	Rokayatin	P/60	dr. Farid, Sp.N	101720	CVA Infark + Bronkitis	14/05/2026	17/05/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5

29	Suhartono	L/42	dr. Ardhi, Sp. Pd	248749	Cholelithiasis multiple	23/05/2026	26/05/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
30	Ngatiman	L/65	dr. Ardhi, Sp. Pd	249910	Colic Abdomen + Hydronefrosis	28/05/2026	30/05/2026	3	Ciprofloxacin	1	2x0,5	1	1	1

3.2.3.1.2 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juni 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Nurul Laily	P/25	dr. Humaira, Sp. OG	167262	Post Partum Normal	02/06/2026	03/06/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
2	Hera Marta	P/33	dr. Aida, Sp. OG	055697	Post SC + PEB	06/06/2026	08/06/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
3	Trainingtyas P	P/25	dr. Humaira, Sp. OG	167262	Post Partum Normal	09/06/2026	10/06/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
4	Zaeti Nur	P/29	dr. Humaira, Sp. OG	242550	Post SC + KPD	10/06/2026	12/06/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
5	Endang Budi A	P/57	dr. Humaira, Sp. OG	124573	Mypma Uteri	10/06/2026	13/06/2026	4	Ceftiaxone	2	1x2	2	2	1
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
6	Aulia Rahman	P/24	dr. Humaira, Sp. OG	211658	Post SC + BSC	11/06/2026	14/06/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
7	Karina Putri	P/29	dr. Aida, Sp. OG	183297	Post SC + KPD	11/06/2026	14/06/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
8	Dwi Hariyani	P/35	dr. Puti F, Sp. OG	234047	Post SC + Oligohidramnion	12/06/2026	14/06/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
9	Annisa Aprilia	P/27	dr. Puti F, Sp. OG	250997	KET + Anemia	19/06/2026	21/06/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,67
10	Putri Febrian	P/32	dr. Aida, Sp. OG	251427	Gravida SC	27/06/2026	29/06/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,67
11	Darsono Kaseri	L/63	dr. Anton, Sp. B	250266	Gangrene Anogenital	04/06/2026	06/06/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25

									Picyn		3x1,5	6	6	1
12	Laras Maya	P/23	dr. Anton, Sp.B	155514	Appendisitis Akut	04/06/2026	06/06/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
13	Aris Aji	L/35	dr. Sigit, Sp. BP	158367	Vullnus laceratum regio frontalis	04/06/2026	07/06/2026	4	Ceftriaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
14	Mustani Eko	P/56	dr. Oka, Sp.OT.	250372	CF sital tibia D	06/06/2026	08/06/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
15	Rastomo	L/61	dr. Edi, Sp. U	250128	BPH	08/06/2026	10/06/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
16	Yunifa Mei	P/31	dr. Zaki, Sp.B.	181653	Tumor Coli Posterior	09/06/2026	11/06/2026	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
17	Rahmat Hidayatullah	L/19	dr. Oka, Sp.OT.	250701	Vulnus laseratum regio cruris sinistra	13/06/2026	15/06/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
18	Ahmad Ari	L/24	dr. Oka, Sp.OT.	249290	Union phalank dextra	19/06/2026	21/06/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
19	Rastomo	L/67	dr. Pradana, Sp. U	074273	BPH	23/06/2026	25/06/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
20	Suminto	L/36	dr. Oka, Sp.OT.	038639	Open wound distal phalank	26/06/2026	28/06/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
21	Warisan	L/61	dr. Andy, Sp. P	250155	Efusi Pleura + Hipokalemi	02/06/2026	04/06/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2
22	Firda Ayu M	P/28	dr. Ardhi, Sp. Pd	233112	Cholelitis	07/06/2026	11/06/2026	5	Ceftriaxone	1	2x1	8	2	4
23	Ika Eny D	P/42	dr. Heri, Sp. Pd	157292	Cholelitis + Nefrolithiasis	16/06/2026	18/06/2026	3	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,2	0,8	1,5
24	Buang	L/59	dr. Ardhi, Sp. Pd	207764	DM Hiperglikemi + GEA	08/06/2026	11/06/2026	4	Ciprofloxacin	1	2x0,5	3	1	3
25	Suriyanto	L/48	dr. Heri, Sp. Pd	250884	DF + TF	18/06/2026	21/06/2026	4	Levofloxacin Tab	1	1x0,75	2,25	0,3	7,5
26	Saridan	L/81	dr. Andy, Sp. P	248668	Pneumonia Psi 81	19/06/2026	22/06/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
27	Ahmad Santoso	L/69	dr. Zora, Sp. Pd	130884	Bacterial Infection + AKI	20/06/2026	23/06/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
28	Rumini	P/59	dr. Fahima, Sp. N	251037	Syok Sepsis + ISK	22/06/2026	24/06/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	6	2	3
29	Ika Yulianti	P/38	dr. Elvi, Sp. P	251101	COPD Ae	22/06/2026	24/06/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
30	Samiatun	P/67	dr. Heri, Sp. Pd	204810	Anemia + Cystitis	22/06/2026	24/06/2026	3	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,2	0,8	1,5

3.2.3.1.3 Tabel Data Primer Audit Penggunaan Antibiotik Secara Kuantitatif Bulan Juli 2026

No.	Nama	Jenis Kelamin /umur	Dokter	No. RM	Diagnosis KRS	Tgl MRS	Tgl KRS	LOS (Hari)	Antibiotik	Jumlah Antibiotik	Dosis (gram)	Total Dosis (gram)	ATC	DDD
1	Siti Aminatuz	P/27	dr. Aida, Sp. OG	251774	Gravida SC	04/07/2026	06/07/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
2	Ninis Umi K	P/55	dr. Aida, Sp. OG	207348	Mioma Uteri	06/07/2026	09/07/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
3	Novita Sari	P/26	dr. Humaira, Sp. OG	225638	Post SC + Oligohidramnion	08/07/2026	11/07/2026	4	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
4	Wida Reni	P/32	dr. Humaira, Sp. OG	251247	Post SC + BSC	10/07/2026	12/07/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
5	Deti Indah	P/26	dr. Humaira, Sp. OG	169322	Post SC + PEB	11/07/2026	13/07/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
6	Vina Savitri	P/34	dr. Humaira, Sp. OG	065727	Gravida Post Partum Normal	14/07/2026	15/07/2026	2	Amoxicillin	1	3x0,5	1,5	1,5	1
7	Riska Melinda	P/22	dr. Puti F, Sp. OG	248201	Post SC + Oligohidramnion	14/07/2026	16/07/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
8	Elisa Putri	P/26	dr. Humaira, Sp. OG	155377	Post SC + KPD	15/07/2026	17/07/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
9	Iswatul A	P/22	dr. Aida, Sp. OG	252526	Post SC + KPD	19/07/2026	21/07/2026	3	Cefazoline	2	1x2	2	3	0,67
									Cefadroxile		2x0,5	1,5	2	0,75
10	Endah Dewi P	P/25	dr. Puti F, Sp. OG	253043	Post Partum + Kuret + KPD	30/07/2026	31/07/2026	2	Ceftiaxone	2	1x1	1	2	0,5
									Cefadroxile		2x0,5	1	2	0,5
11	Wariani	P/53	dr. Oka,Sp.OT	235354	Union Humerus	03/07/2026	05/07/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
12	Abdul Wakit	L/69	dr. Edi, Sp. U	070117	BPH post TURP	06/07/2026	08/07/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
13	Misnardi	L/40	dr. Anton,Sp.B	251267	STT Coli Mandibula S	08/07/2026	10/07/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25

									Picyn		3x1,5	6	6	1
14	Nelly E	P/31	dr. Oka,Sp.OT	087866	Union Distal Tibia Sin	10/07/2026	12/07/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
15	Kastin	P/71	dr. Oka,Sp.OT	228319	Post Orif Metatarsal	11/07/2026	13/07/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
16	Yulianto	L/52	dr. Anton,Sp.B	252132	Tumor Regtosicmoid DD Malignancy	12/07/2026	14/07/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	7,5	6	1,25
17	Andy Candra Y	L/42	dr. Sigit, Sp. BP	234517	CKR 456 + Fracture Maxillaris Sinistra	18/07/2026	21/07/2026	4	Ceftriaxone	2	1x2	2	2	1
									Ceftriaxone		2x1	5	2	2,5
18	Satin	P/70	dr. Zaki,Sp.B.	251072	Diabetic Foot D + Gangrene pedis D + Amputasi Digiti 2	21/07/2026	23/07/2026	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	3	2	1,5
19	Irza M	L/25	dr. Kuntadi, Sp. OT	252671	Union Fr. Clavicula D	23/07/2026	25/07/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	3	2	1,5
20	Suliat	P/47	dr. Oka,Sp.OT	214669	Union Radius + IP Join Contracture	24/07/2026	26/07/2026	3	Cefazolin	2	1x2	2	3	0,67
									Cefazolin		2x1	2	3	0,67
12	Laras Maya	P/23	dr. Anton,Sp.B	155514	Appendicitis Akut	04/06/2026	06/06/2026	3	Picyn	2	1x1,5	1,5	6	0,25
									Picyn		3x1,5	4,5	6	0,75
16	Yunifa Mei	P/31	dr. Zaki,Sp.B.	181653	Tumor Coli Posterior	09/06/2026	11/06/2026	3	Cefoperazone	2	1x2	2	4	0,5
									Ceftriaxone		2x1	2	2	1
19	Rastomo	L/67	dr. Pradana, Sp. U	074273	BPH	23/06/2026	25/06/2026	3	Ceftizoxime	1	1x2	2	4	0,5
21	Guruh Hadi	L/39	dr. Ardhi, Sp. Pd	146585	DM Hiperglikemi + Hidronefrosis	01/07/2026	03/07/2026	3	Ciprofloxacin	1	2x0,5	2	1	2
22	Vera Anggraeni	P/49	dr. Heri, Sp. Pd	251672	Cholelitis + ISK	02/07/2026	04/07/2026	3	Asam Pipemidat	1	2x0,4	1,6	0,8	2
23	Moh Wahyudi	L/42	dr. Mira, Sp. Jp	251689	ALO Kardiogenik + Efusi Pleura	02/07/2026	06/07/2026	5	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2
24	Saman	L/67	dr. Elvi, Sp. P	250231	Pneumonia + COPD Ae	04/07/2026	08/07/2026	5	Ceftriaxone	1	2x1	7	2	3,5
25	Na'imatul Q	P/24	dr. Ardhi, Sp. Pd	182187	Cholelitis	13/07/2026	16/07/2026	5	Ceftriaxone	1	2x1	3	2	1,5
26	Mistiwar	P/50	dr. Farid, Sp. N	252080	CVA Infark + Diabetic Polyneuropathy	14/07/2026	19/07/2026	6	Ceftriaxone	1	2x1	4	2	2

27	Riwono	L/74	dr. Andy, Sp. P	173002	COPD Ae + Efusi Pleura Bilateral	22/07/2026	25/07/2026	4	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
28	Ahmad Sa'roni	L/56	dr. Elvi, Sp. P	252745	DOC ec Susp COPD Ae	23/07/2026	25/07/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
29	Anis M	P/32	dr. Zora, Sp. Pd	111497	GEA + Cholelithiasis	27/07/2026	29/07/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	5	2	2,5
30	Nur Khotib	P/47	dr. Ardhi, Sp. Pd	252880	Arboviral Infection + Candidiasis	29/07/2026	31/07/2026	3	Ceftriaxone	1	2x1	3	2	1,5

3.6.6 Tim Review RM (E-RM)-IT

3.6.6.1 Tabel Audit Harian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap 2026

KELENGKAPAN																
DPJP																
BULAN	Ringkasan Keluar Masuk				Pengkajian Awal Medis				CPPT				Ringkasan Pulang			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	-	-	-	-	1090	93,70	61	6,30	1080	93,37	69	5,16	1147	99,66	4	0,34
Februari	-	-	-	-	920	84	119	16%	929	86,4	110	13,6	1005	97	34	3
Maret	-	-	-	-	1001	95,30	54	16	1000	94,93	55	5,07	1031	96,67	24	,33
April	1244	99	12	1	1070	88	149	12	1113	89	142	11	1162	93	94	7
Mei	14	100	0	0	996	85	179	15	1039	87	157	13	1087	93	81	7
Juni	1149	99	7	1	790	70	345	30	1007	87	156	13	701	60	462	40
Juli	967	99	10	1	765	77	227	23	925	91	96	9	777	76	244	24
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
PERAWAT																
BULAN	Pengkajian Keperawatan				CPPT				Asuhan Keperawatan				Resume Keperawatan / SBAR			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	1013	97,18	38	2,82	-	-	-	-	1051	100	0	0	1051	100	0	0
Februari	1008	98	27	2	-	-	-	-	1034	100	2	0,3	1036	100	0	0
Maret	1047	100	7	0	-	-	-	-	1043	100	11	0	1054	100	0	0
April	1148	91	107	9	1203	96	52	4	1203	96	52	4	1220	97	35	3
Mei	1112	93	84	8	1154	96	42	4	1171	98	25	2	1080	90	116	10
Juni	1099	95	62	6	1113	96	48	4	1140	98	21	2	1093	94	68	6
Juli	982	96	39	4	978	96	43	4	988	97	33	3	963	94	58	6
Agustus																
September																
Oktober																

KELENGKAPAN																
BULAN	AHLI GIZI								APOTEKER							
	Pengkajian Awal Gizi				CPPT				Rekonsialisasi Obat				CPPT			
	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%	Σ L	%	Σ TL	%
Januari	556	52	484	48	1040	100	0	0	1133	100	0	0	1010	91	123	9
Februari	528	61	398	39	926	100	0	0	1027	100	0	0	965	94	62	6
Maret	587	65	341	35	927	100	1	0,07	1034	90	13	10	291	33	756	67
April	564	99	99	3	1130	99	11	1	1206	97	42	3	1171	99	13	1
Mei	517	98	8	2	1061	99	14	1	1121	94	72	6	1067	98	21	2
Juni	522	98	12	2	994	96	40	4	1117	96	42	4	1043	97	33	3
Juli	557	99	2	1	867	99	9	1	860	98	16	2	862	98	14	2
Agustus																
September																
Oktober																

Analisis :

1. Kelengkapan Dokumen oleh DPJP

Pada Juli 2026, kelengkapan dokumen DPJP menunjukkan perbaikan dibandingkan Juni, ditandai dengan meningkatnya Pengkajian Awal Medis dari 70% menjadi 77%, CPPT dari 87% menjadi 91%, dan Ringkasan Pulang dari 60% menjadi 76%. Meskipun demikian, Pengkajian Awal Medis dan Ringkasan Pulang masih belum memenuhi target mutu sehingga perlu menjadi fokus perbaikan.

2. Kelengkapan dokumen keperawatan

Kelengkapan dokumentasi keperawatan pada Juli 2026 tetap baik dan stabil, dengan seluruh indikator berada pada kisaran 94–97%, menunjukkan kepatuhan pengisian dokumen yang sudah konsisten.

3. Kelengkapan dokumen oleh ahli gizi dan apoteker

Kelengkapan dokumentasi Ahli Gizi dan Apoteker pada Juli 2026 sangat baik, dengan seluruh indikator mencapai 98–99%, menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan telah memenuhi target mutu rumah sakit.

Rencana Tindak Lanjut :

1. Kelengkapan Dokumen oleh DPJP:

- Monitoring kelengkapan dokumen setiap hari.
- Reminder kepada DPJP sebelum pasien pulang.

- c) Evaluasi hasil audit pada rapat Komite Medis.
- 2. Kelengkapan dokumen oleh perawat:
 - a) Mempertahankan monitoring harian dokumentasi.
 - b) Memberikan umpan balik atas dokumen yang belum lengkap.
 - c) Melakukan pembinaan kepada petugas yang belum patuh.
- 3. Kelengkapan dokumen oleh ahli gizi dan apoteker:
 - a) Mempertahankan audit dan monitoring rutin.
 - b) Memberikan umpan balik terhadap ketidaklengkapan dokumen.
 - c) Mempertahankan kepatuhan pengisian sesuai standar.

3.7 Permasalahan Rumah Sakit

1.7.1 Permasalahan Instalasi Kamar Operasi (IKO)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Unit			
1	Water heater bermasalah saat digunakan malam hari (operasi cito jam 00.30)	P	Mengidentifikasi penyebab gangguan water heater, melakukan pemeriksaan oleh IPSRS, serta memasukkan pengecekan water heater dalam checklist kesiapan kamar operasi.
		D	IPSRS melakukan perbaikan dan uji fungsi water heater serta menerapkan pengecekan rutin setiap pergantian shift.
		S	Setelah perbaikan, water heater berfungsi normal dan dapat digunakan kembali pada pelayanan operasi malam/cito
		A	Menjadwalkan preventif maintenance berkala dan memastikan pengecekan water heater dilakukan sebelum pelayanan 24 jam
2	Kedisiplinan dalam menginputkan permintaan barang ke Gudang farmasi sebelum penyerahan lembar pemakaian alat konsinyasi yang sudah dipakai unit IKO	P	Melakukan evaluasi alur permintaan barang konsinyasi dan mengingatkan petugas agar menyerahkan lembar pemakaian alat konsinyasi sebelum menginput permintaan ke gudang farmasi.
		D	Melakukan sosialisasi kepada petugas IKO mengenai alur yang benar serta menerapkan pengecekan kelengkapan dokumen sebelum permintaan diproses.
		S	Setelah sosialisasi, kepatuhan petugas meningkat dan permintaan barang lebih sesuai dengan alur yang ditetapkan sehingga proses pengadaan berjalan lebih tertib
		A	Melakukan monitoring kepatuhan secara berkala dan memberikan umpan balik apabila masih ditemukan ketidaksesuaian alur.
3	Form operasi ada beberapa yang masih belum ERM	P	Mengidentifikasi form operasi yang masih menggunakan format manual dan menyusun rencana integrasi ke dalam ERM.
		D	Berkoordinasi dengan progammer, rekam medis, dan kamar operasi untuk trial dan mencoba kendala yang ada terkait implementasi form operasi di ERM.
		S	Dilakukan evaluasi penggunaan form ERM. Masih ditemukan beberapa form operasi yang belum tersedia sehingga pendokumentasian belum sepenuhnya elektronik.
		A	Melanjutkan pengembangan form ERM yang belum tersedia, melakukan sosialisasi kepada staf IKO, serta monitoring implementasi hingga seluruh form sudah bisa diimplementasikan tanpa menggunakan hardcopy

1.7.2. Permasalahan Instalasi Gawat Darurat (IGD)

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan Dari Kabid/ Komite Terhadap Unit			
1	Alkes (thermogun, SpO ₂ monitor)	P	Mengidentifikasi kerusakan thermogun dan SpO ₂

	IGD rusak, sudah pengajuan ke Gudang farmasi, barang belum datang		monitor IGD serta melakukan pengajuan penggantian ke Gudang Farmasi.
		D	Pengajuan telah disampaikan dan dilakukan koordinasi dengan Gudang Farmasi terkait status pemenuhan alat. Selama menunggu, digunakan alat cadangan yang tersedia.
		S	Hingga periode evaluasi, alat pengganti belum diterima sehingga berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan apabila alat cadangan tidak tersedia
		A	Melakukan tindak lanjut (follow up) secara berkala kepada Gudang Farmasi untuk percepatan pemenuhan alat serta memastikan ketersediaan alat cadangan sampai penggantian diterima.
2	Pasien menunggu rujukan diterima, sehingga lama menunggu di IGD	P	Mengidentifikasi penyebab lamanya proses penerimaan rujukan serta menyusun upaya percepatan koordinasi dengan rumah sakit tujuan.
		D	Meningkatkan koordinasi aktif dengan rumah sakit rujukan dan melakukan pemantauan berkala terhadap status penerimaan pasien
		S	Waktu tunggu pasien di IGD masih dipengaruhi oleh lamanya konfirmasi penerimaan dari rumah sakit tujuan, terutama terkait ketersediaan tempat tidur dan persetujuan rujukan.
		A	Memperkuat komunikasi dengan jejaring rumah sakit rujukan, memperbarui daftar alternatif rumah sakit tujuan, serta melakukan monitoring waktu tunggu rujukan secara berkala.
3	Pasien rencana rujuk yang tidak diperkenankan menunggu di IGD	P	Pasien advice rujuk dari awal dan DPJP minta untuk tidak boleh pindah ruangan karena takut klaim menjadi rawat jalan
		D	Koordinasi antara dokter casemix dan DPJP agar pasien diidentifikasi permasalahan yang bisa diatasi oleh RS
		S	Koordinasi agar pasien distabilkan dan tidak terburu-buru rujuk karena pertimbangan tidak langsung diterima atau bisa dirujuk penuh per poli
		A	Koordinasi dengan Dokter casemix dan PIPP dilibatkan karena pasien termasuk dalam kriteria kompleks
4	Ketidaksesuaian pengkajian awal IGD dengan anamnesa dan TTV pasien, sehingga berpotensi klaim pending atau tidak dilayakkan bpjs kesehatan	P	Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pengkajian awal IGD, anamnesis, dan TTV serta menyusun langkah perbaikan dokumentasi sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
		D	Melakukan sosialisasi kepada dokter dan perawat IGD mengenai kelengkapan serta kesesuaian pengkajian awal, anamnesis, TTV, dan indikasi kegawatdaruratan.
		S	Hasil evaluasi masih ditemukan ketidaksesuaian dokumentasi yang berpotensi menyebabkan klaim BPJS pending atau tidak layak
		A	Melakukan audit rekam medis secara berkala,

			atau dilakukan morning report dengan memberikan umpan balik kepada staf, serta monitoring kepatuhan dokumentasi sesuai kriteria kegawatan IGD
--	--	--	---

3.7.3 Permasalahan Rawat Inap

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Ketidakseragaman pengisian CPPT di rawat inap	P	Mengidentifikasi ketidaksesuaian penulisan CPPT perawat, khususnya belum tercantumnya sasaran dan tolok ukur yang jelas pada rencana asuhan.
		D	Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada perawat mengenai penulisan CPPT yang mencantumkan sasaran dan tolok ukur sesuai standar dokumentasi keperawatan.
		S	Hasil monitoring menunjukkan masih terdapat CPPT yang belum memuat sasaran dan tolok ukur secara lengkap dan terukur.
		A	Melakukan supervisi secara berkala, memberikan umpan balik kepada perawat, serta memastikan kepatuhan pengisian melalui supervisi kepala ruangan
2.	Masih ditemukan ketidaksesuaian anamnesa dan tanda-tanda vital yang tertulis di form pengkajian awal medis DPJP	P	Mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian antara anamnesis dan tanda-tanda vital (TTV) pada form pengkajian awal medis DPJP serta menyusun langkah perbaikan dokumentasi.
		D	Melakukan sosialisasi kepada DPJP mengenai pentingnya konsistensi dokumentasi dan melakukan review sebelum rekam medis diselesaikan
		S	Hasil supervisi masih ditemukan ketidaksesuaian antara anamnesis dan TTV pada pengkajian awal medis yang berpotensi memengaruhi mutu pelayanan dan proses klaim.
		A	Melakukan supervisi ERM secara berkala, memberikan umpan balik kepada DPJP, serta monitoring kepatuhan pengisian sesuai standar rekam medis
3.	Pasien terganggu karena pengunjung yang masih banyak diluar jam besuk	P	Pasien terganggu karena pengunjung yang masih banyak diluar jam besuk
		D	Koordinasi dengan security untuk penertiban secara halus pada keluarga pasien yang besuk di rawat inap
		S	Ada warning atau himbauan yang terdengar di rawat inap
		A	KIE pada pasien yang akan istirahat, bahwa kondisi kamar akan steril sesuai jam minum obat dan istirahat malam jam 19.00 keatas

3.7.4 Permasalahan Rawat Jalan

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Kedisiplinan dalam pengisian form PRMRJ (profil ringkas medis rawat jalan)	P	Mengidentifikasi penyebab rendahnya kepatuhan pengisian Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) dan menyusun langkah

			peningkatan kepatuhan.
		D	Melakukan sosialisasi kepada DPJP mengenai kewajiban dan tata cara pengisian PRMRJ serta mengingatkan pengisian pada pasien yang memenuhi kriteria.
		S	Hasil monitoring masih ditemukan PRMRJ yang belum diisi secara lengkap dan tepat waktu sehingga informasi klinis pasien belum terdokumentasi secara optimal.
		A	Melakukan audit kepatuhan pengisian PRMRJ secara berkala, memberikan umpan balik kepada DPJP, serta monitoring tindak lanjut pada unit rawat jalan.
2	Terdapat temuan pasien masih ada protokol terapinya tetapi di sistem v-claim sudah terhitung habis	P	Mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian antara protokol terapi pasien dan jumlah sesi yang tercatat pada sistem V-Claim BPJS.
		D	Melakukan verifikasi data bersama unit pelayanan, casemix, dan petugas V-Claim sebelum pengajuan klaim atau pembuatan SEP lanjutan.
		S	Hasil evaluasi masih ditemukan pasien yang secara klinis masih memiliki protokol terapi, namun pada sistem V-Claim jumlah sesi telah habis sehingga pelayanan dan proses klaim berpotensi terhambat.
		A	Meningkatkan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan unit terkait untuk penyelesaian kasus, melakukan monitoring berkala, serta memastikan kesesuaian data protokol terapi dengan V-Claim sebelum pelayanan berikutnya.
3	Peningkatan kepatuhan pengisian Form Pemberian Informasi tindakan (terutama pasien operasi elektif)	P	Mengidentifikasi penyebab rendahnya kepatuhan pengisian Form Pemberian Informasi Tindakan, terutama pada pasien operasi elektif
		D	Melakukan sosialisasi kepada DPJP dan tim kamar operasi mengenai kewajiban pengisian form sebelum tindakan serta melakukan pengecekan kelengkapan dokumen praoperasi.
		S	Hasil monitoring masih ditemukan form pemberian informasi tindakan yang belum terisi lengkap sebelum operasi elektif dilaksanakan.
		A	Melakukan audit kepatuhan secara berkala, memberikan umpan balik kepada DPJP, dan menjadikan kelengkapan form sebagai bagian dari verifikasi praoperasi.

3.7.5 Permasalahan Unit Laboratorium

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Keterlambatan hasil PA menyebabkan keterlambatan berkas klaim.	P	Mengurangi keterlambatan hasil Patologi Anatomi (PA) agar tidak menyebabkan keterlambatan penyelesaian berkas klaim. Target: ≥90% hasil PA diterima sesuai target waktu yang ditetapkan.
		D	Melakukan koordinasi dengan laboratorium PA rujukan terkait estimasi waktu penyelesaian hasil, membuat monitoring status spesimen PA, serta

			melakukan reminder secara berkala terhadap pemeriksaan yang mendekati batas waktu klaim.
		S	Menganalisis jumlah kasus keterlambatan hasil PA, rata-rata waktu penyelesaian hasil, serta dampaknya terhadap keterlambatan pengajuan klaim. Mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan, baik dari proses pengiriman spesimen maupun proses pemeriksaan di laboratorium rujukan.
		A	Menyusun mekanisme monitoring dan eskalasi untuk hasil PA yang belum selesai, memperbaiki alur komunikasi dengan laboratorium rujukan, serta melakukan evaluasi berkala agar keterlambatan hasil PA tidak menghambat proses klaim rumah sakit.

3.7.6 Permasalahan Unit Gizi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	E-RM poli rawat jalan gizi masih belum terlaksana	P	Pemberian asuhan gizi harus dilakukan secara terintegrasi melalui penulisan CPPT
		D	Kolaborasi antara ahli gizi, programmer, dan pihak management RS dalam realisasi penulisan E-RM Poli gizi
		S	Risiko pemberian asuhan gizi tidak terintegrasi dan tidak adanya bukti ahli gizi telah melakukan edukasi kepada pasien rujukan poli dokter spesialis
		A	Tim gizi, programmer, dan pihak manajemen RS dalam realisasi penulisan ERM Gizi
2	Masih terdapat kehilangan sendok karena sendok dibawa pulang pasien.	P	Pemeriksaan sarana prasarana rumah sakit harus berjalan pada pasien rencana KRS
		D	Kolaborasi antara ahli gizi dengan perawat dan CS ruangan
		S	Risiko kehilangan alat makan (sarana prasarana RS)
		A	Perawat ruangan dan CS ruangan memeriksa kelengkapan fasilitas yang telah digunakan pasien sebelum pasien KRS

3.7.7 Permasalahan Rekam Medis dan Pendaftaran

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Ketidaklengkapan pengisian form rekam medis oleh PPA	P	Mengajukan sosialisasi ke PPA terkait pengisian DRM yang baik dan benar
		D	Karu koordinasi dengan KABID
		S	Mengecek ulang setiap DRM yang akan di setor ke RM dan melengkapi yang kurang sehingga DRM sudah lengkap waktu di setor ke RM
		A	Sosialisasi ke semua PPA tentang ketepatan dan kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sehingga tidak ada lagi DRM yang tidak lengkap
2.	Belum optimalnya penggunaan APM (Anjungan Pasien Mandiri):	P	Melakukan upaya peningkatan pemanfaatan APM dan aplikasi Mobile JKN untuk mempercepat proses pendaftaran pasien, mengurangi antrean

	- Masih minim penggunaan aplikasi JKN mobile pasien.		loket, serta mendukung transformasi digital pelayanan rumah sakit.
		D	Melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai penggunaan APM dan aplikasi Mobile JKN melalui petugas pendaftaran, media informasi, banner, serta pendampingan langsung bagi pasien yang mengalami kesulitan saat registrasi.
		S	Hasil monitoring menunjukkan penggunaan APM dan aplikasi Mobile JKN masih belum optimal karena sebagian pasien belum memahami cara penggunaan aplikasi, belum mengaktifkan akun Mobile JKN, serta lebih memilih melakukan pendaftaran secara langsung melalui loket.
		A	Meningkatkan sosialisasi penggunaan Mobile JKN dan APM secara berkelanjutan, menyediakan petugas pendamping pada jam sibuk, memasang petunjuk penggunaan yang mudah dipahami, serta melakukan monitoring jumlah pendaftaran melalui APM dan Mobile JKN sebagai indikator keberhasilan implementasi digitalisasi pelayanan.
3	Form-form yang sudah ERM masih ada yang belum muncul di billing validasi Rekam Medis	P	Mengajukan koordinasi dengan tim SIMRS/programmer untuk menelusuri penyebab form ERM belum terbaca di validasi RM.
		D	Karu berkoordinasi dengan KABID dan tim SIMRS/programmer, untuk sinkronisasi data ERM dengan sistem validasi RM.
		S	Melakukan uji coba penginputan ERM dan memastikan semua form muncul di billing serta tervalidasi di Rekam Medis
		A	Melakukan evaluasi berkala terhadap integrasi ERM dan billing. Memberikan laporan hasil evaluasi ke KABID dan programmer untuk perbaikan sistem jika masih ditemukan kendala.
4	Kendala efektivitas broadcast WhatsApp CSO akibat akun sering terblokir dan ketidaksesuaian status terkirim pada aplikasi Wazup dengan penerimaan pesan oleh pasien, sehingga menyebabkan komplain informasi pelayanan.	P	Mengurangi risiko kegagalan penyampaian informasi pasien akibat akun WhatsApp terblokir dan ketidaksesuaian status pengiriman pesan pada aplikasi broadcast.
		D	Menambahkan aplikasi tambahan sebagai media backup apabila diperlukan broadcast penting, membatasi jumlah pengiriman maksimal 40 pesan per proses broadcast , memberikan jeda setiap 20 pesan , memastikan koneksi aplikasi dan WhatsApp terhubung sebelum melakukan broadcast, serta memastikan keamanan server aplikasi.
		S	Melakukan monitoring keberhasilan pengiriman pesan, kejadian akun WhatsApp terblokir, kesesuaian status delivered dengan penerimaan pasien, serta jumlah komplain pasien terkait informasi yang tidak diterima.
		A	Menetapkan batasan dan alur penggunaan broadcast sebagai standar CSO, melakukan

			evaluasi berkala terhadap efektivitas aplikasi, serta melakukan perbaikan apabila masih ditemukan kendala penyampaian informasi kepada pasien.
--	--	--	--

3.7.8 Permasalahan Radiologi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Respon Time Pelayanan Radiologi >3 jam. Akar masalah: Diluar jam praktek dokter pembacaan foto masih lebih dari 3 jam, terlebih diatas jam 22.00.	P	Menurunkan angka response time pelayanan radiologi >3 jam menjadi ≤3 jam pada hasil pemeriksaan yang dilakukan di luar jam praktik dokter radiologi.
		D	Melakukan sosialisasi kepada dokter spesialis radiologi mengenai penggunaan dan akses link PACS yang telah diperbarui, termasuk pemberitahuan otomatis apabila terdapat pemeriksaan yang belum dibaca.
		S	Melakukan monitoring jumlah pemeriksaan dengan response time >3 jam setiap bulan, khususnya pemeriksaan yang selesai setelah pukul 22.00. Mengevaluasi kepatuhan dokter dalam membuka link PACS dan menganalisis penurunan rata-rata waktu pembacaan setelah sosialisasi dilakukan.
		A	Apabila masih ditemukan response time >3 jam, dilakukan evaluasi ulang mekanisme pembacaan di luar jam praktik, penyempurnaan sistem notifikasi PACS, serta penyusunan kebijakan pembacaan on-call/teleradiologi untuk pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari.
2	DPJP terutama Syaraf belum terbiasa dengan adanya sistem PACS untuk pelayanan CT-Scan dan tetap minta print bagian-bagian hasil CT.	P	Meningkatkan pemanfaatan sistem PACS oleh DPJP dalam melihat hasil CT-Scan serta mengurangi permintaan print film/gambar CT dengan melakukan edukasi dan sosialisasi penggunaan PACS.
		D	Melakukan sosialisasi kepada DPJP, terutama dokter Spesialis Saraf, terkait akses dan manfaat PACS, memberikan panduan penggunaan, serta mendampingi pengguna saat mengakses hasil CT-Scan melalui sistem.
		S	Melakukan evaluasi jumlah permintaan print hasil CT-Scan setelah sosialisasi dan mengidentifikasi kendala DPJP dalam penggunaan PACS.
		A	Menetapkan penggunaan PACS sebagai media utama akses hasil CT-Scan, melakukan refresh sosialisasi secara berkala, serta memberikan dukungan teknis apabila terdapat kendala penggunaan sistem.
3	Belum optimalnya pemanfaatan sistem RIS-PACS oleh salah satu dokter radiologi, dimana tidak bisa menggunakan sistem secara konsisten sehingga terjadi ketidakseimbangan distribusi beban kerja dan	P	Mengatasi ketidakseimbangan beban kerja dokter radiologi akibat belum optimalnya pemanfaatan RIS-PACS oleh salah satu dokter radiologi serta keterbatasan jumlah dokter radiologi. Menjalankan proses pencarian dokter radiologi tambahan dan menyusun strategi pemerataan beban kerja sementara.

	penumpukan pembacaan hasil radiologi pada dokter lainnya.	D	Melakukan evaluasi waktu tunggu hasil ekspertise, jumlah pemeriksaan yang terbagi antar dokter, serta hambatan dalam penerapan RIS-PACS untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.
		S	Melakukan evaluasi terhadap waktu penyelesaian ekspertise, jumlah pemeriksaan yang dibaca masing-masing dokter, tingkat pemanfaatan RIS-PACS, dan dampak penambahan dokter terhadap penurunan antrean pembacaan.
		A	Melakukan monitoring berkala terhadap kebutuhan SDM radiologi, melanjutkan proses pemenuhan dokter radiologi tambahan, serta menetapkan strategi kerja sementara sampai dokter baru tersedia.

3.7.9
Permasalahan Farmasi

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Hasil stok opname farmasi yang sudah stabil pada akhir tahun 2025 dan belum mencapai target selisih 0.	P	Pertanggungjawaban Selisih Hasil Stok Opname
		D	Berdasarkan Surat Edaran dari PT. Disa Prima Medika Nomor 103/DPM/I-SE/DIR/II/2026 tentang Pembebanan Selisih Stok Opname (SO)
		S	Evaluasi hasil stok opname belum mencapai target 0
		A	Berdasarkan Surat Edaran dari PT. Disa Prima Medika Nomor 103/DPM/I-SE/DIR/II/2026 tentang Pembebanan Selisih Stok Opname (SO) : Terhitung mulai Januari 2026, setiap selisih stok opname (SO), baik positif maupun negatif, wajib dianalisis penyebabnya. Apabila terbukti melibatkan unit lain, maka pembebanan selisih ditanggung oleh unit terkait bersama PJ Rak, Kepala Instalasi, dan Kepala Bidang. Jika tidak ditemukan keterlibatan unit lain, maka selisih SO langsung dibebankan kepada PJ Rak, Kepala Instalasi, dan Kepala Bidang.
2	Obat tertinggal rawat 2x24 jam dan obat RF rawat inap	P	Perbaiki kebijakan obat tertinggal.
		D	Menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal.
		S	1. Obat tertinggal bulan Mei mengalami penurunan namun masih ditemukan pasien mengambil obat lebih 2x24 jam. 2. Menghubungi pasien agar obat tertinggal dikirim oleh primantara namun banyak pasien menolak karna obat diambil sendiri ke farmasi. 3. RF banyak yang menumpuk tidak diambil oleh pasien krs
		A	1. Setiap hari menghubungi pasien jika sudah melewati 1x24 jam obat ditinggal untuk mengurangi penumpukan obat tertinggal. 2. Kebijakan pengambilan obat maksimal 2x24 jam menghindari penumpukan obat tertinggal

			yang mengakibatkan retur penjualan. 3. Mengadakan promo pelayanan pengantaran obat untuk pengguna baru. 4. PJ shift irna dan apoteker irna mengecek resep RF jika ada pasien yang belum mengambil RF, konfirmasi ruangan pasien tsb kenapa belum mengambil resep RF melalui WA, bias diambil atau meggunakan primantara
3	Penambahan daftar obat near ED	P	Mempercepat pengeluaran barang near ED.
		D	Membuat surat edaran untuk DPJP supaya membantu mengeluarkan barang near ED dari Depo Farmasi maupun Gudang Farmasi.
		S	Obat near ED yang tidak segera dikeluarkan akan mejadi death moving dan menyebabkan kerugian terhadap rumah sakit.
		A	1. Kolaborasi dengan Komite Medik untuk membantu pengeluaran barang near ED. 2. Melakukan negoisasi dengan DPJP untuk menggunakan barang near ED sesuai dengan kebutuhan. 3. Kolaborasi dengan Pengadaan PT untuk melakukan retur
4	Klaim bpjs kesehatan : 1. Pasien iter 2x datang tidak sesuai tanggal. 2. Petugas input kadang terlewat centang kronis pada resep kronis	P	Sosialisasi ke tim farmasi
		D	Menjelaskan ke tim farmasi saat rapat internal farmasi
		S	1. Jika ada pasien iter yang terlambat dan harus mengubah tanggal iter kedua di bulan depan. 2. Petugas input terlewat tidak centang kronis pada resep kronis, 4. baru diketahui pada saat diverif oleh admin farmasi, beberapa resep harus dibatal verif dulu baru bisa diedit
		A	1. Jika ada pasien iter yang terlambat dan harus mengubah tanggal iter kedua di bulan depan, pastikan tanggal kontrol selanjutnya. di bulan depan sesuaikan dengan jadwal dokter di screenshot di bagian iter 2x nya. 2. Untuk meminimalkan batal verif oleh admin farmasi, pada saat klik ambil obat diperhatikan jika muncul data lab maka resep tersebut sudah dicentagn kronis, tetapi bila di klik ambil obat tidak muncul data lab maka resep kronis tersebut belum tercentang.

3.7.10 Permasalahan CSSD-Laundry

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT
1	Hasil stok opname Laundry belum optimal karena tidak semua petugas unit perawatan bisa diajak kerja sama untuk mengecek linen yang tidak	P Meningkatkan akurasi stok opname linen dengan melibatkan kepala ruangan/PJ shift dalam pengecekan linen yang belum tercatat serta menyusun jadwal stok opname yang disepakati bersama.

	tercatat.	D	Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh unit perawatan, melaksanakan stok opname bersama petugas laundry dan perwakilan unit, serta membuat daftar linen yang belum tercatat untuk diverifikasi.
		S	Mengevaluasi jumlah selisih stok sebelum dan sesudah pelaksanaan, tingkat partisipasi unit, serta kendala yang masih ditemukan selama proses stok opname.
		A	Menetapkan mekanisme stok opname bersama sebagai prosedur rutin, menunjuk PIC linen di setiap unit, dan melakukan monitoring serta tindak lanjut terhadap unit yang belum melaksanakan pencatatan dengan baik.
2	Mesin pengering meledak dan menimbulkan kerusakan bangunan (pintu dan dinding) karena overhear.	P	Mencegah kejadian overhear pada mesin pengering dengan memperkuat pemeliharaan preventif, inspeksi komponen, dan kepatuhan terhadap kapasitas penggunaan mesin.
		D	Melakukan perbaikan mesin dan bangunan yang rusak, pemeriksaan menyeluruh oleh teknisi, menyusun jadwal preventive maintenance, serta memberikan edukasi kepada petugas mengenai batas kapasitas dan prosedur pengoperasian mesin.
		S	Mengevaluasi hasil pemeliharaan, kepatuhan petugas terhadap SOP penggunaan mesin, serta memantau apakah masih terjadi peningkatan suhu atau gangguan pada mesin pengering.
		A	Menetapkan preventive maintenance dan inspeksi keselamatan sebagai kegiatan rutin, melengkapi checklist harian kondisi mesin, serta melakukan evaluasi berkala untuk mencegah kejadian serupa.

3.8 Profil SDM

3.8.3 Ketenagaan (Distribusi Tenaga, Kualifikasi, Jabatan dan Kebutuhan)

NO	UNIT	PENDIDIKAN	TOTAL	JUMLAH	TETAP	TIDAK TETAP	RESIGN
1	Direktur	Dokter Umum	1	1	1	0	0
2	Kabid Pelayanan Medis	D3 Kebidanan	1	1	1	0	0
3	Kabid Penunjang Medis	Profesi Ners	1	1	1	0	0
4	Kabid Keperawatan	Profesi Ners	0	0	0	0	0
5	Kabid Umum	Dokter Gigi Umum	1	1	0	1	0
6	Casemix Manager	SMK	1	1	1	0	0
7	Farmasi	Profesi Apoteker	39	12	6	6	0
		S1 Farmasi		3	2	1	0
		D3 Analis Farmasi dan Makanan		1	1	0	0
		D3 Farmasi		22	14	8	0
		SMK		0	0	0	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
8	Asuransi Center	D3 Asuransi Kesehatan	10	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		8	7	1	0
		SMK		0	0	0	0
		SMA		1	1	0	0

9	CSSD	D3 Keperawatan	3	2	1	1	0
		SMA		1	1	0	0
		SMK		0	0	0	0
10	Fisioterapi	S1 Fisioterapi	5	1	0	1	0
		D3 Fisioterapi		3	2	1	0
		D3 Terapi Wicara		1	0	1	0
11	Gizi	S1 Ilmu Gizi	14	1	1	0	0
		D4 Gizi dan Dietetika		2	2	0	0
		D3 Ahli Gizi		1	1	0	0
		SMK		6	0	6	0
		SMA		1	0	1	0
		SMP		3	2	1	0
12	Humas & Marketng	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	2	1	0	1	0
		S1 Teknik Informatika		1	0	1	0
13	ICU dan HCU	Profesi Ners	10	5	5	0	0
		D3 Keperawatan		4	2	2	0
		D3 Kebidanan		1	1	0	0
14	IGD	Profesi Ners	23	10	8	2	0
		D3 Keperawatan		9	7	2	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
15	IKO	Profesi Ners	11	7	7	0	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
16	IPCN	Profesi Ners	1	1	1	0	0
17	IPSRs	S1 Teknik Elektro	6	1	1	0	0
		D3 Rekam Medis		1	1	0	0
		D3 Teknik Elektromedis		1	0	1	0
		SMK		3	3	0	0
18	IRJA	Profesi Ners	27	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		14	13	1	0
		D4 Keperawatan Gigi		1	0	1	0
		Profesi Kebidanan		1	0	1	0
		D3 Kebidanan		3	3	0	0
19	IRNA 2C	Profesi Ners	7	5	4	1	0
		D3 Keperawatan		2	2	0	0
20	IRNA 2A, 3A, & 4A	Profesi Ners	17	8	7	1	0
		D3 Keperawatan		9	6	3	0
21	IRNA 3C Anak	Profesi Ners	12	4	2	2	0
		D3 Keperawatan		8	7	1	0
		D3 Kebidanan		0	0	0	0
22	IRNA 5C	Profesi Ners	9	3	1	2	0
		D3 Keperawatan		6	4	2	0
23	IRNA 6A, 7A, & 8A	Profesi Ners	22	9	4	5	0
		D3 Keperawatan		13	10	3	0
24	Maternitas	Profesi Kebidanan	10	1	0	1	0
		D4 Kebidanan		2	2	0	0
		D3 Kebidanan		7	7	0	0
25	Neonatologi	Profesi Ners	8	3	2	1	0
		D3 Keperawatan		4	4	0	0

		D3 Kebidanan		1	1	0	0
26	Keuangan & Akuntansi	S1 Ekonomi	8	2	2	0	0
		S1 Akuntansi		1	0	1	0
		S1 Manajemen		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
27	Laboratorium	D4 Analis Kesehatan	9	1	0	1	0
		D3 Analis Kesehatan		8	6	2	0
28	Laundry	SMK	5	2	1	1	0
		SMA		2	1	1	0
		SMP		1	0	1	0
29	Rekam Medis	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	7	7	7	0	0
30	Pendaftaran	S1 Sastra Inggris	12	0	0	0	0
		S1 Kesehatan Masyarakat		0	0	0	0
		D3 Asuransi Kesehatan		1	0	1	0
		D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		6	5	1	0
		D1 Administrasi Perkantoran		1	1	0	0
		SMK		1	1	0	0
		SMA		3	3	0	0
31	PIPP & MPP	Profesi Ners	4	0	0	0	0
		D4 Kebidanan		1	1	0	0
		D3 Keperawatan		1	1	0	0
		D3 Kebidanan		2	2	0	0
32	PMKP	Profesi Ners	1	1	1	0	0
33	Radiologi	D3 Radiodiagnostik & Radioterapi	6	6	4	2	0
34	SDM	S1 Sosial	1	1	1	0	0
35	Sekretaris	S1 Administrasi Publik	1	1	1	0	0
36	SIMRS & IT	S1 Teknik Informatika	3	3	3	0	0
37	Umum & Rumah Tangga	S1 Ekonomi	1	1	1	0	0
38	Cleaning Service	SMK	40	12	7	5	1
		SMA		23	18	5	1
		SMP		5	5	0	0
39	Security	SMK	10	4	2	2	0
		SMA		6	6	0	0
40	Driver	D1 Administrasi Perkantoran	6	1	1	0	0
		SMA		4	3	1	0
		SMP		1	1	0	0
41	Gudang Umum	SMP	1	1	1	0	0
42	Staf Orientasi	SMK	6	2	0	2	0
		D3 TVF		1	0	1	0
		D3 Perawat Gigi		1	0	1	0
		D3 Gizi		1	0	1	0
		D4 Dizi		1	0	1	0
Total Karyawan			362	362	268	94	2
43	Dokter IGD	Dokter Umum	8	8	0	8	1
44	Dokter Casemix	Dokter Umum	2	2	0	2	1
45	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	1	3	0

46	Dokter Spesialis Anak	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
47	Dokter Spesialis Bedah Umum	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
48	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
49	Dokter Spesialis Bedah Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
50	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
51	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
52	Dokter Spesialis Mata	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
53	Dokter Spesialis THT	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
54	Dokter Spesialis Paru	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
55	Dokter Spesialis Saraf	Pendidikan Dokter Spesialis	4	4	0	4	0
56	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
57	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatology	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	0	3	0
58	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
59	Dokter Spesialis Urologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
60	Dokter Spesialis Anestesi	Pendidikan Dokter Spesialis	3	3	1	2	0
61	Dokter Spesialis Radiologi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
62	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Pendidikan Dokter Spesialis	2	2	0	2	0
63	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
64	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
65	Dokter Spesialis Gigi Periodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
66	Dokter Spesialis Gigi Pedodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
67	Dokter Spesialis Gigi Orthodontis	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
68	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Pendidikan Dokter Spesialis	1	1	0	1	0
Total Dokter			64	64	2	62	2
Total Keseluruhan			426	426	270	156	4

Keterangan :

Pada bulan Juli terdapat 2 staf dan 2 dokter resign.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

RS Prima Husada Malang yang selalu berbenah untuk meningkatkan pelayanan baik dari sisi Sumber Daya Manusia ataupun dari sisi sarana dan prasarannya. Dimana masih terdapat beberapa Sumber Daya manusia yang masih belum tertib baik dari kelompok tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang masih belum tertib secara administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dengan penataan SDM yang disesuaikan dengan alur dan tata letak Gedung yang baru, maka dilakukan juga penambahan tenaga khususnya perawat untuk memenuhi kebutuhan setelah dilakukan evaluasi dan Analisa beban kerja. Proporsi antara karyawan kontrak/tidak tetap dengan karyawan tetap, dimana masih banyak karyawan kontrak/tidak tetap di RS Prima Husada Malang diperkirakan bisa mempengaruhi kualitas pelayanan di Rumah sakit

Kepatuhan DPJP dalam memvisite pasien dan melengkapi dokumen Rekam medis yang masih jauh dari standar juga mempengaruhi kualitas pelayanan di RS Prima Husada Malang dan menghambat proses klaim. Kinerja RS dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Rumah Sakit. Jumlah kunjungan di RS Prima Husada Malang masih didominasi oleh kunjungan pasien lama dari BPJS Kesehatan. Pelayanan di beberapa unit yang belum optimal dikerenakan salah satu dampak kekurangan tenaga kerja membawa akibat pada pelayanan.

B. SARAN

1. Meningkatkan ketertiban administrasi di Unit SDM terutama ketertiban absensi dengan memanfaatkan SIM SDM yang baru
2. Membentuk dan mengoptimalkan kinerja dari komite – komite yang ada di RS Prima Husada Malang
3. Meningkatkan kepatuhan visite DPJP dengan mencatat dan melaporkan waktu visite DPJP serta mentertribkan DPJP dalm pengisian Dokumen Rekam Medis
4. Memperbaiki proses rekrutmen staf sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
5. Meningkatkan skill dan pengetahuan SDM dengan giat mengaktifkan diklat dan pelatihan internal serta mengikuti pelatihan secara eksternal
6. Meningkatkan marketing dan promosi untuk meningkatkan kunjungan ke RS Prima Husada Malang
7. Menjalin lebih banyak kerjasama dengan stakeholder dari luar RS Prima Husada Malang

BAB V
PENUTUP

Demikian laporan bulan Juli 2026 ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Malang pada Agustus 2026, masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin.

Malang, 10 Agustus 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN

NO	NAMA PKS	JENIS INSTANSI	MULAI BERLAKU	TANGGAL EXPIRED	KETERANGAN	NOMOR PKS RUMAH SAKIT	NOMOR PKS INSTANSI
1	ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/I/2015
2	Batas Media 99	PERUSAHAAN	05 Juni 2024	05 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	158/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	-
3	BPJS KESEHATAN	ASURANSI	01 Januari 2025	31 Desember 2025	Pelayanan Kesehatan	2035/E-PKS/DIR/XII/2024	651/KTR/VII-05/1224
4	CV AUMERTA ANGGUN	PERUSAHAAN	28 Agustus 2023	28 Agustus 2026	PELAYANAN KESEHATAN	164.1/DPM/E-PKS/DIR/VIII/2023	-
5	ESWEJE Aesthetic Center	INSTANSI KESEHATAN	01 Maret 2024	01 Maret 2027	Sterilisasi alat kesehatan	079/DPM/E-PKS/DIR/III/2024	9,1202E+12
6	Pelayanan Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Bimbingan Rohaniawan Agama Hindu	1754/E-PKS/DIR/XII/2022	-
7	Indonesia Smelting Technology	PERUSAHAAN	01 Juni 2024	01 Juni 2026	Rujukan Pelayanan	194/DPM/E-PKS/DIR/VI/2024	005/HRGA-IST/V/2024
8	Instruktur Zumba	AKRE	23 Februari 2024	23 Februari 2025	Instruktur Zumba	067/DPM/E-PKS/DIR/II/2024	-
9	Klinik Mutiara Sehat (Karanglo, Lawang, Karangploso)	INSTANSI KESEHATAN	02 Agustus 2021	02 Agustus 2026	Pelayanan Laboratorium	429.77/I-PKS/DIR/VIII/2021	069/PKS/PDP/VIII/2021
10	Klinik Endisa Husada	INSTANSI KESEHATAN	01 Agustus 2023	01 Agustus 2026	Rujukan Pelayanan	148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023	PK/01/VII/2023-KEH
11	Klinik Losari Medika	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2027	Rujukan Pelayanan	-	021/DPM/E-PKS/DIR/II/2024
12	Klinik Pratama Beauty Medika Singosari	INSTANSI KESEHATAN	25 Mei 2024	25 Mei 2027	Rujukan Pelayanan	145/DPM.E-PKS/DIR/V/2024	001/PKS/12/2024
13	Klinik Rawat Jalan Mitra Prima Care	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2027	Pelayanan Kesehatan	346/DPM/E-PKS/DIR/XII/2024	025/MPC/E-PKS/KA/XII/2024
14	Klinik Utama Medika	INSTANSI	24	24 September	Rujukan Pasien	299/DPM/E-	-

		KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/IX/2024	
14	Klinik Utama Rawat Jalan Akasia	INSTANSI KESEHATAN	25 April 2024	25 April 2027	Pelayanan Kesehatan	116/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	011/KUA/E-PKS/HMS/III/2024
15	Penerjemah Bahasa Isyarat untuk Difabel	AKRE	14 September 2022	13 September 2025	Penerjemah Bahasa Isyarat Untuk Difabel	1378/E- PKS/DIR/X/2022	-
16	Penerjemah Bahasa Madura	AKRE	01 Agustus 2022	02 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Madura	1305/E- PKS/DIR/IX/2022	-
17	Penerjemah Bahasa Asing	AKRE	01 Agustus 2022	01 Agustus 2025	Penerjemah Bahasa Inggris	1288/E- PKS/DIR/IX/2022	-
18	Persada Hospital	INSTANSI KESEHATAN	10 Oktober 2022	10 Oktober 2027	Pelayanan Kesehatan	152.45//DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	1083.b.HS/MOU/X/PH-2022
19	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	19 Agustus 2024	19 Agustus 2026	Penyediaan Darah	246/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0904/02.06.28/UTD/VIII/2024
20	PMI Kabupaten Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Juni 2023	30 Juni 2023	Rujukan Pelayanan	-	768/E-PKS/DIR/V/2023
21	PMI Kota Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	01 Desember 2025	Penyediaan Darah	1790/E- PKS/DIR/XI/2023	2214/02.06.27/UTD/XI/2023
22	PRAKTEK BIDAN MANDIRI NIA IRAWATI, S.TR.KEB	INSTANSI KESEHATAN	07 Februari 2024	26 Februari 2027	Rujukan dan Pelayanan Penunjang	081/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	-
23	PT AA International Indonesia	ASURANSI	02 September 2019	02 September 2020	Pelayanan Kesehatan Grab	-	-
24	PT Administrasi Medika	ASURANSI	01 Juli 2024	01 Juli 2027	Asuransi		071/PKS/AdM/ManagedCare/VII2024
25	PT AIA Financial	ASURANSI	04 November 2020	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	No.069/DPM/E- PKS/DIR/X/2020	No. 639/AIA/-DPM/XI/2020
26	PT AJ Central Asia Raya	ASURANSI	02 Juni 2017	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	277/RSPH/E- IKS/DIR/VI/2017	DIR/PKS-RS/1455/VI/2017
27	PT AJINOMOTO SALES	PERUSAHAAN	01 Mei	30 APRIL 2013	PELAYANAN KESEHATAN		

	INDONESIA		2012	(selanjutnya perpanjang otomatis)			
28	PT Alfiza Medika Utama	INSTANSI KESEHATAN	07 Maret 2024	07 Maret 2028	Pelayanan Kesehatan	090/DPM/E- PKS/DIR/III/2024	018/MOU/KAMU/07/III/2024
29	PT Aloita Prima (Harris Hotel Malang)	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
30	PT ANTARMITRA SEMBADA CAB. MALANG	PERUSAHAAN	01 Desember 2024	01 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	304.1.DPM/E- PKS/DIR/X/2024	344/MLG/AMS/XII/2024
31	PT APLIKANUSA LINTASARTA	ASURANSI	25 Februari 2015	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/100/II/2015	095/LA/MOU/00300/2015
32	PT ASABRI	ASURANSI	13 Desember 2023	12 Desember 2026	PELAYANAN KESEHATAN	1902/E- PKS/DIR/XII/2023	PEFJ-182/HK.02.01/HBL.H/XII/2023
33	PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA	ASURANSI	12 Oktober 2023	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	PH/E- PKS/171/X/2013	499B/AAD-LEG-AGR/X/2013
34	PT Asuransi Allianz Life Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2017	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	729/AZLI-LGL/AG/XII/2017
35	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA	ASURANSI	18 November 2024	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	698.21/DPM/I- PKS/DIR/IX/2024	391/ALLISYA-LGL/AG/XI/2024
36	PT ASURANSI ASTRA BUANA	ASURANSI	01 September 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN KESEHATAN	1033/RSPHS/E- PKS/DIR/VIII/2020	26/HID-PM/ASURANSIASTRA/IX/2020
37	PT ASURANSI DAYIN MITRA	ASURANSI	05 Februari 2015	05 Desember 2017	PELAYANAN KESEHATAN	PH/IKS/269/XII/2014	003/MKT/HLT/PKS/II/2015
38	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	ASURANSI	01 Oktober 2023	01 Oktober 2028	Asuransi	183.3/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	157/GI/OPS/Prov-PKS/X/2023
39	PT Asuransi Jiwa In Health Indonesia (Mandiri Inhealth)	ASURANSI	01 Februari 2023	31 Januari 2025	Asuransi	028.2/DPM/E- PKS/DIRR/11/2023	0.32/AJII.KOP-SBY/PKS/0123
40	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA	ASURANSI	01 Desember	01 Desember 2025	PELAYANAN KESEHATAN	361/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	331-11/EB-CONT/2024

			2024				
41	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK (ASURANSI MAG)	ASURANSI	28 Januari 2020	27 Januari 2024	RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN	015/DPM/E- PKS/DIR/XI/2019	PKS-0097/XI/2019/MAG-R2
42	PT Asuransi Reliance Indonesia	ASURANSI	06 November 2024	06 November 2027	Asuransi	338/DPM/E- PKS/DIR/XI/2024	024/LGL-ARI/PKS-RS-IB/XI/2024
43	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	ASURANSI	07 September 2020	07 September 2025	PELAYANAN KESEHATAN	368/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	163/LGL-ARI/PKS-RS-COB/IX/2020
44	PT ASURANSI SINARMAS	ASURANSI	01 September 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	010/DPM/E- PKS/DIR/IX/2019	364/PKS-RS/PH.RI.ASM/IX/2019
45	PT ASURANSI SINARMAS MSIG	ASURANSI	10 September 2012	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		063/PKS-AJSMSIG-RS/IX/2012
46	PT ASURANSI TAFAKUL KELUARGA	ASURANSI	02 Januari 2017	01 Januari 2020	PELAYANAN KESEHATAN	508/RSPH/E- IKS/DIR/XI/2016	0642/PKS-RS-01/I/2017
47	PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA	ASURANSI	30 Oktober 2021	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	612/RSPHS/E- PKS/DIR/X/2019	300/PKS/DIR/TKP/X/2019
48	PT AXA SERVICES INDONESIA (ADMEDIKA)	ASURANSI	15 Agustus 2013	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		067/AGR-LEG/ASI/VIII/2013
49	PT Bestari Murni Anugrah	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	rujukan pelayanan	159/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
50	PT BNI LIFE INSURANCE	ASURANSI	25 Juli 2016	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	082/RSPH/E- IKS/DIR/II/2016	274.PKS.BL.DIR.0716
51	PT CAKRA SURYA HUSADA	PERUSAHAAN	02 Agustus 2022	02 Agustus 2025	ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG	112.1/DPM/E- PKS/DIR/VII/2022	138/MOU/VIII/CSH/2022
52	PT Citra Karsa Dinamika	PERUSAHAAN	01 Juli 2024	01 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	196/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
53	PT Docdoc Healthcare Indonesia	ASURANSI	12 Desember 2024	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	-
54	PT Equity Life Indonesia	ASURANSI	14 Oktober	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	091/ELI/LGL/X/19

			2019				
55	PT EQUITY LIFE INDONESIA	ASURANSI	14 Oktober 2019	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		090/ELI/LGL/X/19
56	PT Fullerton Health Indonesia	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis		-	640/IP-OP/PKS/FHI/VIII/2019
57	PT Global Assistance & Healthcare	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	-	640/IP-OP/PKS/GAH/VIII/2019
58	PT Green Mountains Natural Food	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	225/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	01/GMN/KS/VI/2024
59	PT HANWA LIFE INSURANCE INDONESIA	ASURANSI	16 Maret 2015	15 Maret 2016	PELAYANAN KESEHATAN		0088/HLI-GH/PKS-RS/03-2015
60	PT Indo Aneka Atsiri	PERUSAHAAN	07 Agustus 2024	06 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	222/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	066/IAA/HRGA/VI/2024
61	PT INDOLAKTO PANDAAN	PERUSAHAAN	10 Januari 2014	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN		
62	PT Indonesia Marine	PERUSAHAAN	10 September 2024	10 September 2027	Pelayanan Kesehatan	-	-
63	PT INTERNATIONAL SERVICES PASIFIC CROSS	VENDOR	03 Oktober 2022	Perpanjangan Otomatis	PELAYANAN KESEHATAN	150/DPM/E- PKS/DIR/X/2022	953/ISPC/PKS/X/2022
64	PT JASA RAHARJA	ASURANSI	04 Juli 2022	04 Juli 2027	PENAGANAN DAN PENYELESAIAN SATUNAN KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DAN LALU LINTAS JALAN	912.1/E- PKS/DIR/VII/2022	P/13/SP/2022
65	PT Java Smartindo	PERUSAHAAN	01 Agustus 2020	Perpanjangan Otomatis	Jasa Pengelolaan Administrasi Kesehatan	364/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	PKS.TPA- JSMART.290/VIII/20/RS.SW.C
66	PT JAYA OBAYASI	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	360/DPM/I- PKS/DIR/VIII/2020	
67	PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza)	ASURANSI	17 Juli 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	034/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	092/KBM-DPM/PKS/VII/2020
68	PT LABBIOGEN ARTHA	INSTANSI	02	01 September		262/DPM/E-	B-MKT 01/001/623/VII/2024

	MEGA	KESEHATAN	September 2024	2027		PKS/DIR/VIII/2024	
69	PT MALANG INTERMEDIA PERS	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	025/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	103.1/PKS/DIR/JPRM/VIII/2020
70	PT Medilink Digital Media	ASURANSI	22 Maret 2024	22 Maret 2027	Pelayanan Kesehatan	09/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	229/L/PKS/MDM-DPM/III/2024
71	PT MEDLINX ASIA TEKNOLOGI	ASURANSI	28 November 2016	Perpanjangan Otomatis	APLIKASI LAYANAN KESEHATAN	150/PKS- RSPRIMAHUSADA- MAT/DIR/XI/2016	
72	PT MOOR SUKSES INTERNASIONAL	ASURANSI	08 Juli 2024	08 Juli 2027	PELAYANAN KESEHATAN	200/DPM/E- PKS/DIR/2024	001/MSI/VI/2024
73	PT PAN PACIFIC INSURANCE	ASURANSI	31 Agustus 2020	31 Agustus 2023	PELAYANAN PERAWATAN DAN PENGOBATAN	017/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	0593-01/PKS/PRV-PANFIC/RS- PHMS/VIII/2020
74	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	12 Juni 2024	12 Juni 2027	Pelayanan Kesehatan	172/DPM/E- PKS/DIV/VI/2024	-
75	PT PANCAMAS ELITE	PERUSAHAAN	01 Juli 2020	01 Juli 2025	PELAYANAN KESEHATAN	032/DPM/E- PKS/DIR/VII/2020	
76	PT PLN (Persero)	ASURANSI	02 Juli 2024	31 Desember 2025		261/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	0017.Add/HKM.02.01/F010800300/2022
77	PT Prima Sarana Jasa - Asuransi SOS	ASURANSI	17 September 2018	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	735/E- PKS/DIR/IX/2018	296/GAN/PT-6/HOSP/SEP/2018
78	PT Prudential Life Assurance	ASURANSI	28 Januari 2021	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	047/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2020	1578/PMN-PLA/XI/2020
79	PT Suprima Mitra Adihusada	ASURANSI	26 Agustus 2019	Perpanjangan Otomatis	Asuransi	-	640/IP-OP/PKS/TIRTA/VIII/2019
80	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	11 Juni 2024	10 Juni 2026	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	110/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	JAN-09/C.5.1/2024
81	PT TASPEN (PERSERO)	ASURANSI	01 Januari 2023	31 Desember 2025	Program Jaminan Kecelakaan Kerja	008/E- PKS/DIR/II/2023	JAN-01/DIR/2023
82	PT TIRTA INVESTAMA	PERUSAHAAN	31 Agustus 2020	31 Agustus 2025	PELAYANAN KESEHATAN		
83	PT Tonggak Ampuh	PERUSAHAAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	263/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	-

84	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA	PERUSAHAAN	01 Agustus 2023	31 Juli 2026	Pelayanan Kesehatan	150.2/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2023	050/AK/2/VII/TBINA-Kenaf/2023
85	PT TOYOTA BOSHOKU INDONESIA PASURUAN PLANT	PERUSAHAAN	27 Oktober 2020	Perpanjangan Otomatis	Pelayanan Kesehatan	1076/RSPHS/E- PKS/DIR/IX/2020	002/AK/10/V/TBINA-Kenaf/2020
86	PT Unggul Anugrah Sejahtera	PERUSAHAAN	04 Juni 2024	04 Juni 2027	Rujukan Pelayanan	160/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	-
87	PT Uniplastindo Interbuana	PERUSAHAAN	29 Juli 2024	29 Juli 2027	Pelayanan Kesehatan	224/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	-
88	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	04 Januari 2021	04 Januari 2024	PELAYANAN KESEHATAN	303/DPM/I- PKS/DIR/VI/2021	002/PKS-COB/I/2021
89	PT YAMAHA ELECTRONICS MANUFACTURING INDONESIA	PERUSAHAAN	22 Maret 2024	22 Maret 2027	PELAYANAN KESEHATAN	183/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	014/PKS-COB/III/2024
90	PT YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA (YMPI)	PERUSAHAAN	01 Juni 2022	01 Juni 2025	PELAYANAN KESEHATAN	004/DPM/E- PKS/VI/2022	/YMPI/II/PKS/VI/2022
91	PT Yanmar Diesel Indonesia	PERUSAHAAN	15 April 2024	15 April 2027	Pelayanan Kesehatan	108/DPM/E- PKS/DIR/IV/2024	107/YADIN/Pdn/Pga/IV/2024
92	PT Zurich Asuransi Indonesia TBK	ASURANSI	25 Juni 2024	24 Juni 2029	Asuransi	151/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	268/ZAI-LEG-AGR/VI/2024
93	RS Islam UNISMA Malang	INSTANSI KESEHATAN	01 Januari 2024	31 Desember 2026	Rujukan Pelayanan	222.11/DPM/E- PKS/DIR/XI/2023	08/PKS/RSI-4/I/2024
94	RS Lavalette	INSTANSI KESEHATAN	07 Agustus 2024	07 Agustus 2027		236/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	DA01-ADDNM-BB/P-B/24-07-16/138
95	RS Prima Husada Sukorejo	INSTANSI KESEHATAN	01 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pelayanan Kesehatan	1376/E- PKS/DIR/X/2022	1608/RSPJS/E-PKS/DIR/X/2022
96	RS Siti Miriam Lawang	INSTANSI KESEHATAN	31 Agustus 2024	31 Agustus 2027	Pelayanan Kesehatan	264/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	566/HMS/RSSM/VIII/2024
97	RSIA Puri Bunda	INSTANSI KESEHATAN	06 Februari 2024	06 Februari 2026	Rujukan Pelayanan	020/DPM/E- PKS/DIR/II/2024	001/PKS/PB/II/2024

98	RSUD Bangil	INSTANSI KESEHATAN	22 Juli 2024	22 Juli 2027	Rujukan Pelayanan	222/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	400.7.5.2/1531.1/424.072.01/2024
99	Yayasan Bhakti Luhur	AKRE	05 Desember 2022	04 Desember 2025	Pelayanan Rohaniawan Agama Kristen	1753/E- PKS/DIR/XII/2022	-
100	RS PANTI NIRMALA	INSTANSI KESEHATAN	07 Oktober 2022	06 Oktober 2025	PELAYANAN RUJUKAN	152.44/DPM/E- PKS/DIR/XI/2022	3740/069/RSPN/X/2022
101	PKM SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	12 April 2022	12 April 2027	TUBERKULOSIS DENGAN STRATEGI DOTS	593/I- PKS/DIR/IV/2022	440/894/35.07.103.135.2022
102	KLINIK IDAMAMUK	INSTANSI KESEHATAN	16 Juni 2021	PERPANJANG OTOMATIS	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	347/DPM/I- PKS/DIR/VII/2021	/005/VI/2021
103	KLINIK RAWAT INAP MUSLIMAT SINGOSARI	INSTANSI KESEHATAN	15 April 2023	15 April 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG	107.1/DPM/E- PKS/DIR/IV/2023	031.A/A.1/M/RSMS/02/IV/2023
104	KLINIK TIRTO HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	18 September 2023	18 September 2026	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	176.3/DPM/E- PKS/DIR/IX/2023	015.004/KTH/IX/2023
105	KLINIK UTAMA JANTUNG HUSNA MEDIKA MALANG	INSTANSI KESEHATAN	01 Desember 2023	32/11/26	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	241.2/DPM/E- PKS/DIR/XII/2023	023/PKS/DIR-HMMMALANG/XII/2023
106	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR NIA ANITA	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	347/DPM/E- PKS/DIR/2024	
107	DOKTER PRAKTEK MANDIRI DR INDRAWAN DWANTORO	INSTANSI KESEHATAN	02 Desember 2024	02 Desember 2029	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	348/DPM/E- PKS/DIR/XII/2024	
108	RSJ DR RADJIMAN WEDIODONONGRAT LAWANG	INSTANSI KESEHATAN	30 Oktober 2023	30 Oktober 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	220.1/DPM/E- PKS/DIR/X/2023	HK.03.01/D.XXXVII/12226A/2023
109	RSUD DR SAIFUL ANWAR	INSTANSI KESEHATAN	01 November 2024	01 November 2026	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	234/DPM/E- PKS/VIII/2024	400.14.5/7499.1/102.7/2024
110	KLINIK PRATAMA RAWAT JALAN MAWAR WASKITHA HUSADA	INSTANSI KESEHATAN	23 Januari 2024	22 Januari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	001.34/DPM/E- PKS/DIR/I/2024	
111	PRAKTEK BIDAN MANDIRI RIZA KHUTMI, S.S.T	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	05 Februari 2027	RUJUKAN ASUHAN PASIEN DAN PELAYANAN PENUNJANG	221/DPM/E- PKS/DIR/VII/2024	

112	RSU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	INSTANSI KESEHATAN	05 Agustus 2024	22 Agustus 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	248/DPM/E- PKS/DIR/VIII/2024	081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024
113	IBAZZ AESTHETIC MEDICAL CENTER BY DR UMMAH	INSTANSI KESEHATAN	14 Juni 2024	14 Juni 2027	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	180/DPM/E- PKS/DIR/VI/2024	
114	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MALANG	INSTANSI KESEHATAN	02 Januari 2025	02 Januari 2026	PELAYANAN KELUARGA BERENCANA IUD & IMPLANT	2053/E- PKS/DIR/XII/2024	100-3-7/103/35-07-313/2025